



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN FEBRUARI
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Tujuan 1

Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang 2

2.1 Visi 2

2.2 Misi..... 2

2.3 Motto 2

2.4 7 Nilai Budi Utama 2

2.5 Struktur Organisasi 3

Bab III Laporan Kinerja Pelayanan..... 4

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI) 4

3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 4

3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 4

3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut 4

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan 5

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada 6

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan 16

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik 16

3.3.2 Rawat Inap 19

3.3.3 Intensive Care Unit (ICU) 27

3.3.4 High Care Unit (HCU) 28

3.3.5 Instalasi Gawat Darurat (IGD) 29

3.3.6 Instalasi Kamar Operasi (IKO) 31

3.4 Kinerja Bidang Penunjang 32

3.4.1 Instalasi Farmasi 32

3.4.2 Laboratorium 51

3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran..... 55

3.4.4 Radiologi 61

3.4.5 Gizi 66

3.4.6 CSSD - Laundry 73

3.5 Kinerja Bidang Umum dan Keuangan 80

3.5.1 SDM 80

3.5.2 MFK dan K3RS 88

3.5.3 Security 92

3.5.4 Parkir..... 95

3.5.5 Humas Marketing 95

3.5.6 Penjaminan 100

3.5.7 PIPP – MOD - MPP..... 100

3.5.8 *Cleaning Service* 108

3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum..... 109

3.6 Komite dan Tim 111

3.6.1 Komite Mutu 111

3.6.2 Komite PPI 165

3.6.3 Tim PKRS..... 179

3.6.4 Tim Prognas..... 181

3.6.5 Tim PPRA..... 219

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT 225

3.7 Permasalahan Rumah Sakit 228

3.8 Profil SDM 240

Bab IV Kesimpulan dan Saran..... 244

Bab V Penutup..... 245

Lampiran 247

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan Februari Tahun 2025 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

2.1 VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3 MOTTO

Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur Dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai berikut :



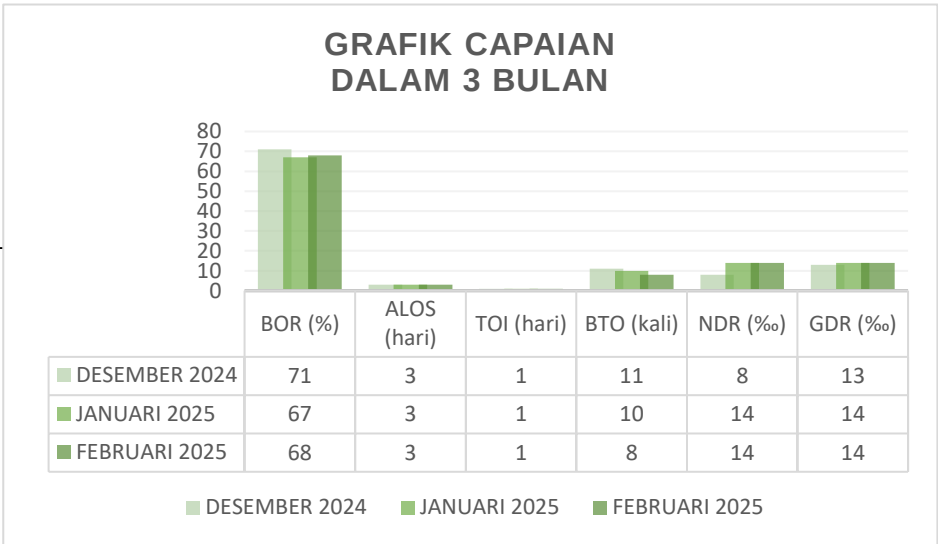
BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)

3.1.1 Tabel Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

NO	INDIKATOR	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025
1	BOR	71	67	68
2	ALOS	3	3	3
3	TOI	1	1	1
4	BTO	11	10	8

3.1.2 Grafik Capaian BOR, LOS, TOI, BTO



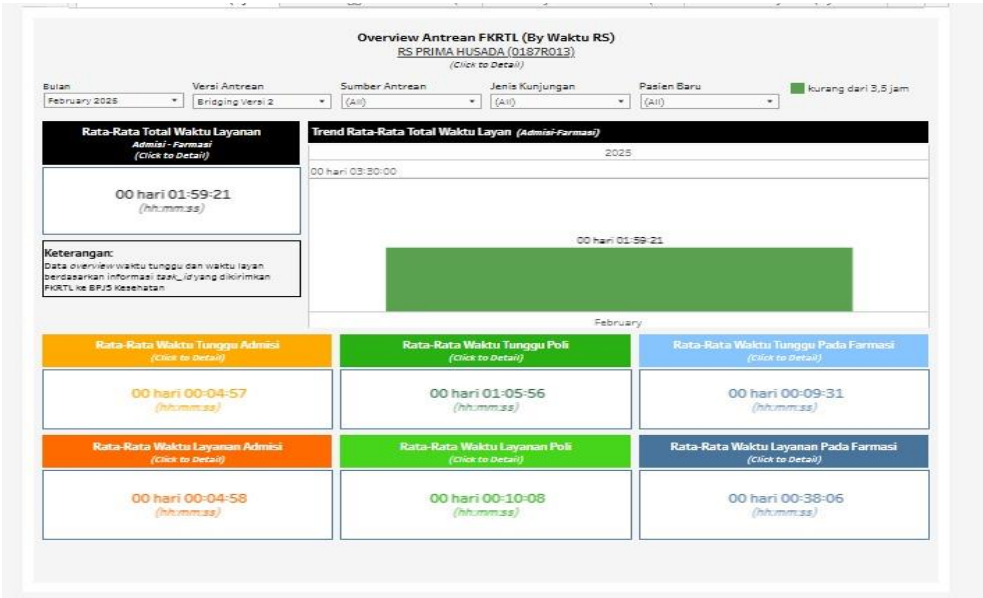
3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil perhitungan statistik rumah sakit pada Bulan Januari Tahun 2025, kinerja RSPHM didapatkan hasil nilai indicator :

- BOR sebesar 68% (standar : 60-85%) sesuai standar.
- LOS sebesar 3 hari sesuai dengan standard RSPHM terkait SE dari PT.DPM khusus pasien BPJS (standar pasien umum : 6-12 hari)
- TOI sebesar 1 hari (standar : 1-3 hari)
- BTO sebesar 8 kali (standar : 4-5 kali)

BOR Bulan Februari Tahun 2025 di bandingkan dengan Bulan Januari Tahun 2025 mengalami kenaikan. BOR tersebut menjadi bukti bahwa penggunaan tempat tidur di Bulan Februari sudah standar. Hal tersebut menandakan bahwa penggunaan tempat tidur sudah efisien dari segi ekonomi menghasilkan pemasukan bagi rumah sakit.

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan



NO	KETERANGAN		BULAN (2024)	
	Waktu Rata-Rata	Rata-Rata Tahun 2024	Januari	Februari
1	Total Waktu Layanan	2:12:37	02:07:27	01:59:21
2	Waktu Tunggu Admisi	0:11:52	00:07:37	00:04:57
3	Waktu Layanan Admisi	0:07:49	00:05:49	00:04:58
4	Waktu Tunggu Poli	1:03:51	01:06:01	01:05:56
5	Waktu Layanan Poli	0:14:56	00:09:41	00:10:08
6	Waktu Tunggu Farmasi	0:14:47	00:11:17	00:09:31
7	Waktu Layanan Farmasi	0:54:42	00:44:57	00:38:06

Analisis :
Pada bulan ini jika dibandingkan rata-rata tahun 2024 maka bulan ini masih lebih baik dilihat dari waktu total layanan. Progres positif terlihat pada waktu tunggu admisi, waktu tunggu farmasi, waktu layanan farmasi yang berada dibawah waktu layanan rata-rata 2024 dan bulan Januari 2025

Plan	Menyampaikan hasil evaluasi ke programmer PT Disa Prima Medika
Do	Koordinasi dengan unit terkait dan factor yang mempengaruhi.hasil dari identifikasi programmer
Study	Data rekap bulan sebelumnya yang menjadi acuan dalam perbandingan perbaikan.
Action	1. Menghubungi programmer 2. Monitoring evaluasi 3. Lakukan Tindak lanjut sesuai hasil Monev

NO	JENIS	TARGET	JANUARI	FEBRUARI
1	Sumber antrian melalui mobile JKN	>30%	45,98%	46,43%
2	Capaian pemanfaatan antrian (onsite dan online Mobile JKN)	>90%	96,72%	95.11%

Analisis :
Pemanfaatan antrian online sudah mencapai target yang disyaratkan (>30%) dan (>90%)

Plan	Mempertahankan hasil > 30% dan meningkatkan untuk kinerja di bulan selanjutnya
Do	Sosialisasi ke unit terkait
Study	Data bulan-bulan sebelumnya sebagai acuan dari data yang sudah diperbaiki
Action	1. Memanfaatkan aplikasi https://dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/ untuk monitoring 2. Monitoring evaluasi <i>feedback</i> 3. Supervisi kabit

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
BIDANG PELAYANAN DAN KEPERAWATAN				
1	IRNA	Bimbingan Doa pada pasien IRNA	Sudah berjalan rutin 3x seminggu	Berjalan dengan baik dan respon pasien baik
2	IRNA	Senam hamil	Senam hamil berjalan rutin	-
		Penambahan TT rawat inap,untuk VIP kelas 1 dan kelas 2	Sudah selesai	Fasilitas seperti tv masih belum terpasang
		Foto bayi	Sudah berjalan	Fasilitas dari unit sendiri
		ERM rawat inap	Belum berjalan sama sekali ,sudah trial 2x dengan perawat	Masih banyak yang eror
3	IRJA	Poli Eksekutif	Sudah berjalan mulai dari 2024 untuk bulan januari 2025 ada 17 pasien,16 pasien di dominasi oleh pasien obgyn	Pasien anak menurun karena pasien anak yang ke poli Sakura hanya pasien yang mencari dr Dicky bukan karena tertarik akan layanannya. Pasien dewasa (IPD dan Neuro) tidak tertarik pada poli Sakura karena merasa sudah cukup dengan poli regular dengan jaminan

				BPJS
4	IGD	Edukasi mengenai kriteria kegawatan menurut BPJS	Membuat video edukasi, sudah terpasang poster di IGD tentang pelayakit yang tidak terkafer bpjs	Sudah terpasang di IGD
BIDANG PENUNJANG				
1	Depo Farmasi	1. Website Primantara	2. Presentasi MOCKUP oleh Programmer PT sudah dilakukan pada tanggal 23-09-2024 3. Proses penyelesaian oleh Programmer PT.	Permintaan dihold menunggu kenaikan pasien PRIMANTARA. Monitoring dan Evaluasi.
		2. Jasa pengantaran obat	1. Pendataan pasien masih menggunakan google spreadsheet dan kitir manual, belum ada fitur yang bridging dengan SIMRS sebagai penanda resep bahwa obat dikirim serta diperlukan marking agar terdapat penanda bahwa obat sudah siap. 2. Promo Lifetime diskon 50% untuk pengguna baru berjalan mulai Bulan Desember 2024. 1. Subsidi promo untuk obat tertinggal menggunakan pengantaran gratis.	Pendataan secara manual, belum bridging dengan SIMRS. Sementara menggunakan spreadsheet dan perubahan alur pembayaran di Kasir.
		3. Pengambilan obat dengan TTD elektronik	1. TTD elektronik untuk pengambilan obat rawat jalan sudah berjalan dan memudahkan untuk mengecek retriksi kelengkapan obat kronis, namun terkendala pada jaringan yang lemah. 2. TTD elektronik untuk pengambilan obat IGD rawat jalan dan pasien pulang rawat inap masih belum bisa dan tahap koordinasi dengan progamer.	Dalam antrian programmer. Monitoring dan evaluasi sistem elektronik.
		4. KPO elektronik (e-KPO)	1. Penulisan Kartu Pengambilan Obat (KPO) menulis manual sehingga memperlama waktu tunggu obat rawat	Dalam antrian programmer.

			jalan. Pengajuan ke progamer untuk dibuatkan fitur e-KPO yaitu data obat di print dengan printer thermal kemudian di tempel ke KPO pasien. 2. DPJP bisa mengakses e-KPO di SIMRS. 3. Jumlah KPO tertinggal : 408.	
		6. Pengadaan LAF sesuai dengan pedoman dasar dispensing sediaan steril.	1. Koordinasi dengan Kains Farmasi untuk melakukan pengajuan proposal ke PT terkait pemindahan ruang LAF, yaitu rencana diajukan di Lantai Maternitas (ex IKO Covid). 2. Proposal pengajuan sudah diterima PT → ACC	Dalam proses renovasi sebagai persiapan AKRE pada akhir Tahun 2026.
		7. Rencana pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis	1. Sudah dilakukan pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis namun masih terkendala tenaga TTK kurang (jika ada staf yang sakit). 2. Meminimalisir waktu tunggu pasien non kronis dengan obat yang tidak banyak. 3. Masih ada komplain pasien terkait waktu tunggu. 4. Belum ada fitur pemisahan resep masuk kronis dan non kronis.	Monitoring dan Evaluasi
		8. Resep Manual IGD	1. Permintaan obat menggunakan resep manual di IGD. 2. Resep akan diarsipkan oleh Petugas Farmasi dan dilakukan double crosscheck, jika ada yang belum terinput maka akan dishare di Grup dan meminta bukti inputan.	Berjalan awal Tahun 2025. Hasil SO membaik, yaitu +5.439.289, dari +25.820.296

			3. Perubahan alur untuk meminimalisir selisih SO.	
2	Gudang Farmasi	Scan Barcode	1. Proposal scan barcode sudah diajukan ke PT. 2. Sudah dilakukan presentasi pada tanggal 04-10-2024. 3. Pendataan master barcode sudah diserahkan ke Programmer PT. Tindak lanjut untuk barang yang tidak memiliki barcode yaitu dibuatkan barcode internal oleh progamer 4. Alat scanner barcode, barcode printer, thermal paper sudah tersedia 5. Software aplikasi barcode dalam tahap dikerjakan oleh progamer	Rencana trial menunggu Programmer PT
		Perluasan Gudang Farmasi	1. Mengajukan perluasan Gudang Farmasi di Lantai 2, karena pallet buffer sudah tidak cukup. 2. Penurunan buffer dari lantai 2 menggunakan katrol yang tidak terpakai di Laundry.	Sudah berjalan
		Perbaikan mutasi barang	1. Sudah dilakukan koordinasi dengan petugas IKO dan programmer terkait sistem floorstok IKO. 2. Fitur Floorstok unit IKO sudah tersedia dan sudah dijalankan. 3. Fitur minta barang floor stock sudah tersedia dan sudah dijalankan. 4. Sistem stok IKO sudah dikunci. 5. Ada petugas farmasi di IKO untuk	Monitoring dan Evaluasi. Supervisi Kabis.

			monitoring stok. 6. Membuat alur dan kesepakatan terkait penggunaan sediaan sharing dose. Contoh : Isonest. Menggunakan tabel penggunaan isonest. 7. Admin IKO	
3	Rekam Medis	1. Mengaplikasikan E-RM (IRJA dan IRNA).	1. Sudah terealisasi E-RM Rawat Jalan IGD dan IRJA. Rehab sudah berjalan mulai tanggal 01-05-2024. IRNA dalam proses tahap akhir, target pada Bulan Juni 2025. 2. Melakukan pendataan fitur yang dibutuhkan pada SIMRS, lalu diserahkan kepada Programmer PT.	Kurang sinkron antara fitur perawat dan rekam medis, seperti : TTD tidak terisi, belum muncul pengkajian fisioterapis di fitur rekam medis. Permasalahan E-RM dan layanan Poli yang belum masuk E-RM sudah disampaikan kepada Programmer PT sekaligus flow chart.
		2. Penggunaan ERM Rawat Inap	1. Kolaborasi dengan Programmer PT. 2. Melakukan trial pada awal Bulan Maret 2025.	Follow up. Monitoring dan Evaluasi.
		3. Kirim ke Satu Sehat untuk Pasien Rawat Jalan (Baik ERM ataupun Non ERM)	Pengiriman data ke satu sehat (untuk data kunjungan dan diagnosis) dilakukan setiap hari. Temuan dan TL : 1. ERM yang belum lengkap dan valid. TL : Koordinasi dengan Tim Pendaftaran terkait identitas pasien yang tidak lengkap. 2. Bayi baru lahir yang belum mempunyai NIK. TL : Kie ke keluarga pasien agar segera pengurusan KK. 3. Pasien yang tidak	Monitoring dan Evaluasi.

			membawa identitas dengan lengkap. TL : KIE ke keluarga pasien untuk mengirimkan identitas melalui chat WA.	
		4. Dokumentasi DRM lama.	1. Melakukan scanning form kedalam SIMRS. 2. Tarikan data bisa diambil pada rekap kunjungan di SIMRS. 3. Menunggu programmer membuat fitur scanning.	Koordinasi dengan Programmer. Pengajuan ke PT.
		5.Retensi DRM	1. Data DRM yang akan diretensi menunggu Programmer PT sebelum dilakukan pemilahan dan pemusnahan DRM. 2. Pemusnahan terakhir dilakukan pada Tahun 2018.	Follow up Programmer PT.
		6. Rekap Data Laporan Dinkes	1. Data yang dibutuhkan tidak semua bisa ditarik oleh system. 2. Pengajuan fitur ke Programmer PT. 3. RM membuat Google Spreadsheet untuk diisi oleh unit-unit terkait setiap harinya. 4. Tujuannya untuk memudahkan Karu RM dalam pelaporan RL ke Dinkes tepat waktu.	Dalam Proses.
4	Pendaftaran	1. Anjungan Pasien Mandiri.	1. Melakukan studi banding atau mencari informasi terkait penggunaan APM di RS lain. 2. Membuat flowchart dan diajukan ke Programmer PT.	Dalam proses dan diajukan ke Program Kerja Tahun 2025.

		2. Penetapan petugas jaga.	1. Melakukan penetapan PJ disetiap divisi, Pendaftaran Central, CSO dan Pendaftaran IGD dengan personil tetap, dengan tujuan supaya petugas menguasai permasalahan dan fokus pelayanan, memudahkan telusur dan perbaikan jika ada komplain dan masalah.	PJ Pendaftaran Central : Tyas PJ Pendaftaran IGD : Riri Pendaftaran CSO : Shinta Bella
		3. Pendaftaran pasien	1. Reservasi pasien umum dan asuransi melalui web, disertai pembayaran melalui VA. 2. Kolaborasi dengan IT dan SIMRS.	Proses mengerjakan TOR
4	Radiologi	1. Menambahkan fitur hasil radiologi di SIMRS supaya hasil JPEG dapat diakses.	Sudah dirapatkan dengan Programmer untuk dibuatkan fitur tersendiri.	Dalam antrian programmer.
		2. Menambah jam pelayanan supaya pelayanan maksimal.	Melakukan close recruitmen untuk mengisi jam kosong pada siang hari.	Surat pemberitahuan kebutuhan Sp.Rad sudah diterima oleh Ketua Kolegium.
		3. Respon Time Radiologi	Kolaborasi dengan perawat untuk melakukan pencatatan di Google Spreadsheet secara real time.	Mulai dijalankan awal Tahun 2024.
5	Laboratorium	1. Pengadaan LIS.	1. Hardware sudah terpasang di Laboratorium. 2. Software proses dikerjakan oleh Programmer dan Vendor.	Dalam antrian programmer.
		2. Stok Opname BDRS	BDRS berjalan mulai 29 November 2024.	SO akan dilakukan Pada hari Sabtu, 22 Maret 2025.
		3. Penambahan fitur	1. Penambahan fitur upload hasil laboratorium rujukan dari luar RS. 2. Penambahan fitur centang otomatis hasil pemeriksaan yang abnormal, batas atas dan batas bawah sudah dicatat dan diajukan ke	Dalam antrian Programmer PT.

			Programmer PT.	
6	Gizi	1. Pengaktifan Poli Gizi di Rawat Jalan.	1. Kolaborasi dengan Humas&Marketing. 2. Kolaborasi dengan pelayanan antar obat (PRIMANTARA), free MCU Gizi.	Monitoring dan evaluasi setiap bulan.
		2. Prima Healthy Meal.	Sudah pengajuan TOR ke PT.	Menunggu ACC.
		3. Daftar Menu Makanan Penunggu VIP.	Book Menu sudah proses dikerjakan oleh PKRS.	Dalam proses.
		4. Registrasi alat makan	1. Kolaborasi dengan penyaji untuk melakukan pencatatan keluar masuknya sendok di Google Spreadsheet. 2. Perbaikan alur saat mengambil peralatan makan di ruangan, jika ditemukan sendok hilang maka dicatat di Google Spreadsheet dan dioperkan ke perawat ruangan untuk ditagihkan ke saat pasien KRS. 3. Dilakukan stok opname setiap bulan untuk menghitung peralatan makan. 4. Membuat SPO Pengecekan Fasilitas RS Sebelum Pasien KRS.	Registrasi alat makan sudah berjalan sejak Bulan Januari 2024 Proses dibuatkan SPO kehilangan alat makan, penggantian biaya dilakukan di Kasir, jika tidak tertagihkan maka tanggungjawab unit bersama.
		5. Pemesanan diet melalui SIMRS	1. Memastikan proses pemesanan diet lebih efisien dan mengurangi kesalahan pemesanan diet dari DPJP ke perawat, perawat ke ahli gizi. 2. Ahli gizi mengkonfirmasi diet di SIM-RS jika ada penambahan diet/ganti diet saat selesai visitasi di ruangan. 3. Proses cetak label langsung efisien tanpa harus mengetik ulang dan tidak menulis	Monitoring dan evaluasi.

			manual di label. 4. Koordinasi dengan bagian SIM-RS supaya segera di realisasikan ke unit.	
		6. QC sesuai sistem HACCP	1. Pelatihan HACCP dilakukan oleh seluruh Ahli Gizi. 2. Memastikan proses quality control makanan sesuai standar. 3. Memastikan 7 prinsip HACCP. 4. Koordinasi dengan SDM jika ada informasi terkait pelatihan tersebut.	Menunggu jadwal pelatihan.
7	Dapur	Perbaiki menu makanan dan plating.	1. Sudah dilakukan supervisi oleh Direktur Utama PT DPM pada hari Senin, 18 November 2024. 2. Kebijakan penggunaan alat makan dan SPO plating sudah dibuatkan sebagai pedoman penyaji dalam melakukan pekerjaan.	Monitoring dan Evaluasi. Revisi tampilan sedang diproses oleh PKRS (Eriko).
		Menu makanan buka puasa senin-kamis.	Program PT berjalan mulai tanggal 09 Desember 2024. Yang sudah disiapkan : 1. Daftar siklus menu makanan. 2. SPO pemesanan makanan buka puasa (+). 3. Link google form untuk pemesanan (+). 4. Kebijakan pemesanan makanan H-1 maksimal pukul 13.00 WIB.	Monitoring dan Evaluasi.
8	Pantry	Food Waste	Perbaiki pencatatan sisa makanan berdasarkan menu makanan untuk mengetahui makanan yang kurang diminati.	Dimulai awal Bulan Maret 2025.
7	CSSD	1. Mengajukan mesin sterilitator (steam plasma).	Belum terealisasi.	Monitoring dan evaluasi permintaan sterilisasi alat semi critical sesuai kebutuhan sterilisasi

				instrument bedah syaraf.
		2. Perbaikan serah terima menggunakan digital form.	Sudah berjalan di Bulan Juli.	1. Kolom tidak terisi lengkap. 2. Monitoring Evaluasi oleh Karu dan Kabid.
		3. Perbaikan jam kerja	Pelayanan mulai pukul 06.30-21.00 WIB, jika ada alat yang akan disetor diatas jam pelayanan maka dilakukan pre-cleaning di unit masing-masing.	Berjalan per Bulan Desember 2024. Monitoring Evaluasi oleh Karu dan Kabid.
8	Laundry	1. Mengajukan mesin cuci industry dengan kapasitas 30kg.	Belum terealisasi.	Monitoring dan evaluasi penggunaan mesin cuci industry utama.
		2. Membuat digital form untuk permintaan linen.	1. Rencana permintaan sehari 2 kali oleh unit sesuai dengan kebutuhan. 2. Belum terealisasi.	Dalam proses.
		3. Pengadaan Bedcover untuk pasien VIP dan LINEN IKO.	Rencana diajukan ulang dengan melampirkan keluhan pasien VIP, kerusakan linen IKO.	Dalam Proses.
		4. Perbaikan jam kerja	Pelayanan ada 3 shift, shift malam dimulai pukul 22.00-04.00 WIB tanpa jam istirahat, dan memenuhi stok di unit.	Berjalan per Bulan Desember 2024.
9	Lain-lain	Rapat Bulanan masing-masing Unit dengan Kabid.	Dilakukan per Bulan November 2024. Supervisi pemahaman pelaksana tentang pedoman pelayanan, pengorganisasian, dan pelayanan sesuai dengan akreditasi. Pelaksanaan : 1. Tanya Jawab 2. Role Play	1. RM dan Pendaftaran Hari : Senin, 24-03-2025. Waktu : 13.00 WIB sd selesai. Tempat : Hall Sakura Lt 5 (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom). 2. Farmasi Hari : Selasa, 18-03-2025 Waktu : 13.00 WIB sd selesai Tempat : Hall Sakura Lt 5 (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 3. Gizi Hari : Rabu, 05-03-2025 Waktu : 11.00

				WIB sd selesai Tempat : Lokasi Dinas (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 4. Laboratorium Hari : Senin, 17-03-2025 Waktu : 14.00 WIB sd selesai Tempat : Lokasi Dinas (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 5. Radiologi Hari : Kamis, 20-03-2025 Waktu : 14.00 WIB sd selesai Tempat : Lokasi Dinas (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 6. CSSD dan Laundry Hari : Jum'at, 21-03-2025 Waktu : 13.00 WIB sd selesai Tempat : Laundry (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 7. Rapat All Karu Penunjang Hari : Selasa, 25-03-2025 Waktu : 15.00 WIB sd selesai Tempat : Ruang Direktur RS
--	--	--	--	---

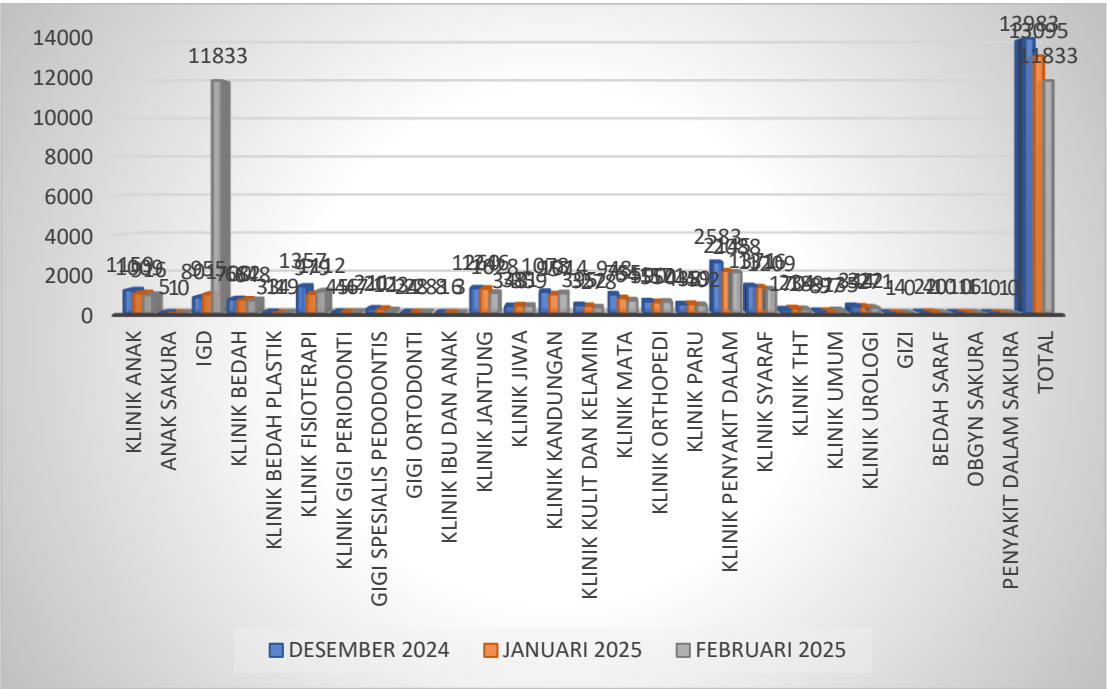
3.3 Kinerja Bidang Pelayanan

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik

3.3.1.1 Kunjungan Pasien Lama dan Baru

NO	NAMA UNIT	DESEMBER 2024			JANUARI 2025			FEBRUARI 2025		
		BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL
1	Klinik Anak	54	1105	1159	49	960	1009	49	867	916
2	Anak sakura	2	3	5	1	0	1	0	0	0
3	IGD	277	524	801	355	600	955	900	10933	11833
4	Klinik Bedah	60	640	700	58	624	682	47	601	648
5	Klinik Bedah Plastik	1	32	33	2	12	14	1	18	19
6	Klinik Fisioterapi	4	1353	1357	5	974	979	5	117	1112

7	Klinik Gigi Periodonti	5	40	45	6	40	46	9	38	47
8	Gigi spesialis pedodontis	20	191	211	20	181	201	18	105	123
9	Gigi Ortodonti	3	21	24	3	25	28	5	23	28
10	Klinik Ibu dan Anak	0	8	8	0	16	16	0	3	3
11	Klinik Jantung	25	1235	1260	37	1209	1246	25	1003	1028
12	Klinik Jiwa	15	320	343	9	372	381	8	351	359
13	Klinik Kandungan	133	945	1078	108	849	957	116	898	1014
14	Klinik Kulit dan Kelamin	24	371	395	45	307	352	27	251	278
15	Klinik Mata	64	884	948	42	713	755	47	594	641
16	Klinik Orthopedi	31	559	590	35	515	550	21	550	571
17	Klinik Paru	15	423	438	15	444	459	8	394	402
18	Klinik Penyakit Dalam	52	2531	2583	60	2085	2145	54	2034	2088
19	Klinik Syaraf	47	1324	1371	39	1277	1316	35	1174	1209
20	Klinik THT	37	133	170	56	178	234	38	151	189
21	Klinik Umum	67	20	87	69	28	97	122	13	135
22	Klinik Urologi	49	295	344	36	286	322	32	239	271
23	Gizi	0	1	1	3	1	4	0	0	0
24	Bedah Saraf	0	22	22	2	38	40	3	7	10
25	Obgyn Sakura	10	0	10	4	12	16	2	9	11
26	Penyakit dalam sakura	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Total		995	12980	13983	988	12107	13095	900	10933	11833



Analisis :

- Kunjungan di bulan febuari turun dari bulan sebelumnya,sebanyak 9,6% dari bulan januari 2025. Analisnya karena DPJP ada yang cuti seperti dokter zorida sp.pd dan untuk bulan febuari 2025 28 hari ,dan karena ada BA dari bpjs dengan peraturan rujuk internal sehingga dari FKT juga membatasi kunjungan ke FKTRL
- Jumlah pasien terbanyak ada di Poli penyakit dalam sebanyak 2088 pasien. Kunjungan tersebut menurun dari bulan sebelumnya sebanyak 57 pasien,
- Kunjungan poli bedah saraf sangat menurun 75% dari bulan sebelumnya, sebesar 30 pasien, karena dr bedah saraf masuk 10 hari dan cuti panjang selama 3 bulan
- Untuk poli pedodonti anak menurun dari bulan sebelumnya di karenakan pembatasan pasien setiap praktek dibatasi 10-12 pasien karena membutuhkan waktu lebih lama dari pasien dewasa

- Kunjungan poli eksekutif adalah 11 kunjungan. Kunjungan terbanyak adalah dari Obgyn sakura 11 pasien, Anak sakura , Klinik IPD dr Zoraida, SpPD, dr Dewi, SpS dan dr Syahrir, SpN masih belum ada kunjungan bulan ini.

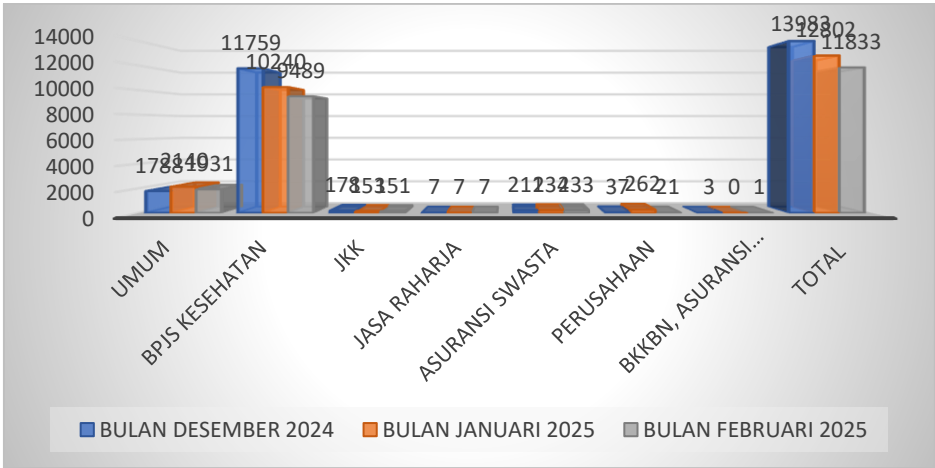
Rencana Tindak Lanjut :

- Koordinasi dengan pendaftaran penjangkaran pasien umum dan asuransi untuk memperkenalkan pelayanan poli sakura
- Menginformasikan kepada seluruh unit rawat inap wajib edukasi saat krs untuk pasien umum,asuransi tentang pelayanan poli sakura
- Menambah jam HFIS untuk poli pedodonti sehingga akan menambah jumlah pasien
- Memisahkan pasien BPJS dengan pasien non BPJS. Pasien Non BPJS di daftarkan di poli Sakura.
- Koordinasi dengan Humas dan Marketing untuk penjangkaran asuransi dan perusahaan.
- Sosialisasi pada faskes dengan pelayanan baru yang ada di rumah sakit prima husada
- Koordinasi dengan humas marketing untuk rutin menampilkan promo di media sosial
- Koordinasi dengan pendaftaran untuk sellau menanyakan pasien yang mendaftar apakah memiliki asuransi komersil.
- Sosialisasi pada komunitas pasien geriatri maupu prolanis klinis MS,bahwa dokter gigi ortodonti (perawat gigi) dan poli sakura
- Sosialisasi pada perusahaan dan stakeholder bahwa ada poli sakura yang menyediakan layanan one stop service
- Mengajukan pelayanan baru otho,bedah,uro dan kulit di Poli Sakura

1.3.1.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran

NO	STATUS PEMBAYARAN	BULAN DESEMBER 2024	%	BULAN JANUARI 2025	%	BULAN FEBRUARI 2025	%
1	Umum	1788	12,79%	2140	16,72%	1931	16,32%
2	BPJS Kesehatan	11759	84,09%	10240	79,99%	9489	80,19%
3	JKK	178	1,27%	153	1,20%	151	1,28%
4	Jasa raharja	7	0,05%	7	0,05%	7	0,06%
5	Asuransi swasta	211	1,51%	234	1,83%	233	1,97%
6	Perusahaan	37	0,26%	28	2,05%	21	0,18%
7	BKKBN, Asuransi Pemerintah	3	0,02%	5	0%	1	0,01%
	Total	13983	100%	12802	100%	11833	100%

1.3.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran



Analisis :

Kunjungan pasien bulan Februari 2025 berdasarkan cara pembayaran menurun 7,5% dari bulan januari 2025 . Kunjungan terbanyak adalah pasien dengan penjamin BPJS Kesehatan sebesar 80,19%. Kunjungan bpjs menurun di bandingkan bulan januari 2025 dikarenakan

banyaknya rujukan menurun dan banyaknya dokter yang cuti dan bulan Februari 28 hari

Kunjungan terendah berdasarkan cara pembayaran kunjungan asuransi pemerintah dengan 0,01% karena sudah bisa di lakukan di faskes pertama

Rencana Tindak Lanjut :

Untuk meningkatkan kunjungan pasien rawat jalan adalah dengan meningkatkan pelayanan terbaik serta berkoordinasi dengan marketing untuk melakukan kunjungan dan menawarkan beberapa pelayanan baru seperti poli sakura yang bisa bekerjasama dengan berbagai asuransi, poli bedah saraf dan poli gigi anak. bekerjasama dengan humas marketing terutama MCU haji dan vaksin internasional.

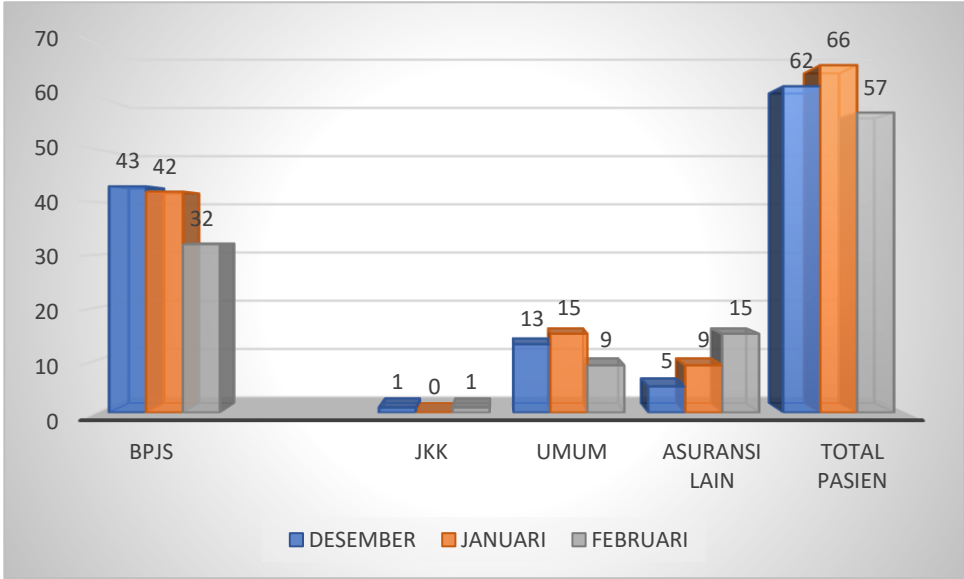
3.3.2 Rawat Inap

3.3.2.1 Kunjungan Rawat Inap 2C

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Desember 2024- Februari 2025)

NO	HAL	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	43	42	32	↓ 23,8%
2	JKK	1	0	1	↑ 100%
3	Umum	13	15	9	↓ 40%
4	Asuransi Lain	5	9	15	↑ 66,67%
Total Pasien		62	66	57	↑ 13,63%

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar (Desember 2024- Februari 2025)



3.3.2.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Februari 2025	32	9	1	15	57
	Analisa	Pasien BPJS dalam 3 bulan	Pasien umum dalam 3 bulan	Pasien JKK dalam 3 bulan	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir belum mengalami	Total pasien bulan februari 2025 mengalami

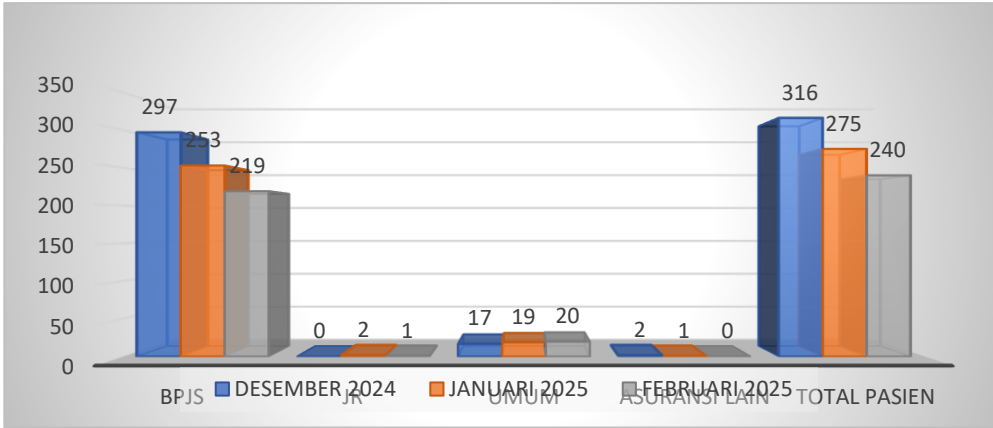
		terakhir mengalami penurunan untuk bulan februari menurun 23,80% dari bulan sebelumnya di sebabkan kunjungan dari di IGD juga menurun dan lodingan juga menurun	terakhir belum stabil untuk bulan februari mengalami penurunan 40% dari bulan sebelumnya di sebabkan kunjungan dari di IGD juga menurun dan lodingan juga menurun	terakhir belum stabil untuk bulan februari mengalami peningkatan	peningkatan untuk bulan februari 2025 mengalami peningkatan 66,67% dari bulan sebelumnya	penurunan 13,63% (11 pasien)
	RTL	1. Meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran 2. Rencana penambahan VVIP 1 TT 3. Memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti paket alat, mandi, baju pasien khusus VIP/VVIP 4. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap 5. Bekerjasama dengan marketing untuk meningkatkan pasien pasien asuransi terutama perusahaan perusahaan yang baru 6. Meningkatkan pelayanan yang lebih ekstra kepada pasien 7. Mempromosikan ruangan vip/vvip lewat sosial media				

3.1.1.1 Kunjungan Rawat Inap 3C Anak

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar
(Desember 2024 - Februari 2025)

NO	HAL	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	297	253	219	↓ 15%
2	JR	0	2	1	↓ 50%
3	Umum	17	19	20	↑ 5%
4	Asuransi Lain	2	1	0	↓ 100%
Total Pasien		316	275	240	↓ 15%

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(Desember 2024- Februari 2025)



3.3.2.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

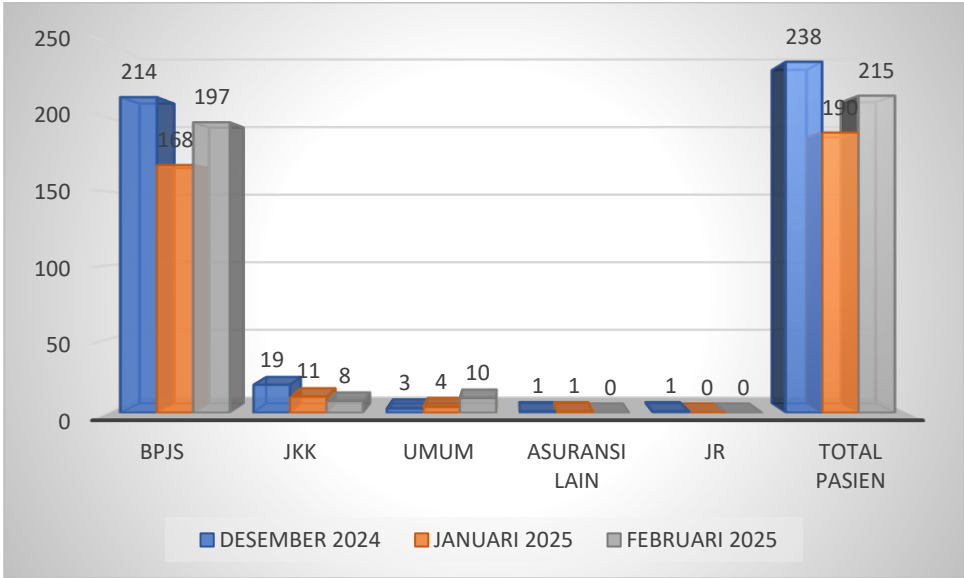
NO.	BULAN FEBRUARI 2025	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JR	ASURANSI	
1	Analisis	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan februari 2025 mengalami penurunan 15% dari bulan januari 2025 disebabkan oleh ketatnya peraturan pasien bpjs yang terbaru	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan, untuk bulan februaru 2025 mengalami peningkatan 5% dari bulan sebelumnya disebabkan dengan adanya peraturan BPJS yang tidak emergency memakai umum	Pasien JR dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan februari 2025 mengalami penurunan 100% dari bulan sebelumnya	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan februari 2025 mengalami penurunan 100% dari bulan sebelumnya	Total keseluruhan n bulan februari mengalami penurunan 15% dari bulan januari 2025 (35 pasien)
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulanya 2. Memperbaiki setiap fasilitas yang ada di unit jika ada yang rusak 3. Promosi ruangan anak lewat media sosial ,tiktok dan IG 4. Program taman anak-anak harus di terealisasikan di irna anak untuk tahun ini 5. Berkoordinasi dengan Marketing untuk kunjungan ke TK atau paud tentang pelayanan gigi anak baru				

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap 2,3,4 A

3.1.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Desember 2024- Februari 2025)

NO	HAL	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	214	168	197	↑ 17,26%
2	JKK	19	11	8	↓ 27,27%
3	Umum	3	4	10	↑ 60%
4	Asuransi Lain	1	1	0	↓ 100%
5	JR	1	0	0	0%
Total Pasien		238	190	215	↑ 13,15%

3.1.1.2.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Desember 2024- Februari 2025)



3.1.1.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN FEBRUARI	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian februari 2025	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan februari mengalami peningkatan 17,26% dari bulan sebelumnya disebabkan banyaknya kunjungan kelas 2	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan februari mengalami peningkatan 66,66% dari bulan sebelumnya disebabkan peraturan bpjs yang terbaru	Pasien JKK 3 dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan kunjungan untuk bulan februari mengalami penurunan 27,27% dari bulan sebelumnya di sebabkan kunjungan rujukan dari perusahaan juga menurun	Pasien JR/Asuransi dalam 3 bulan terakhir stagnan	Total pasien di lantai 2,3,dan 4 mengalami peningkatan 13,15% (25 pasien)
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap				

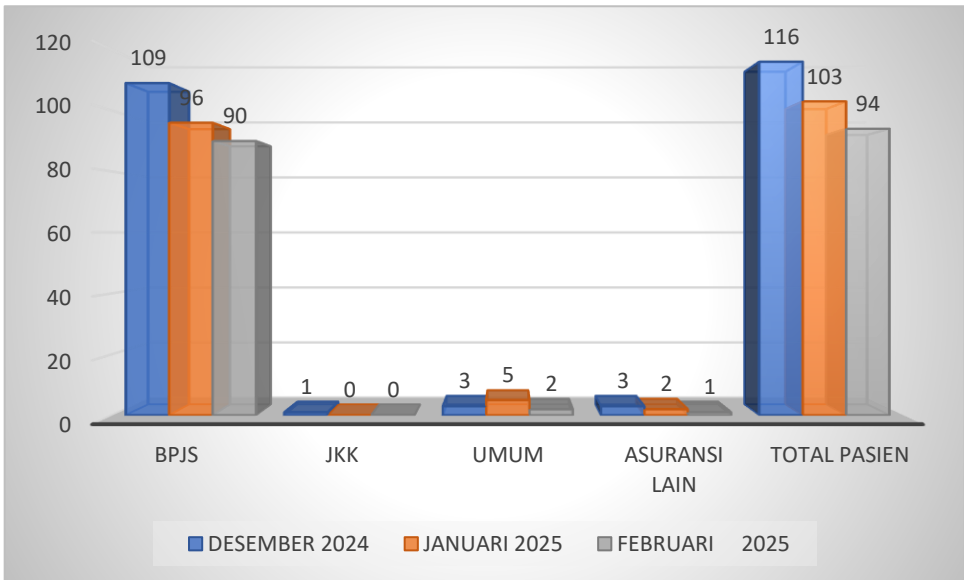
		3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 6. Pemberian edukasi yang baik 7. Berkoordinasi dengan bagian humas marketing untuk melakukan kunjungan di perusahaan-perusahaan untuk melakukan pendekatan ke HRD
--	--	--

3.1.1.3 Kunjungan Rawat Inap 5C

3.1.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(Desember 2024-Februari 2025)

NO	HAL	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	109	96	90	↓ 6,6%
2	JKK	1	0	0	0%
3	Umum	3	5	2	↓ 150%
4	Asuransi Lain	3	2	1	↓ 100%
Total Pasien		116	103	94	↓ 9,57%

3.1.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(Desember 2024-Februari 2025)



3.1.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN FEBRUARI	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan februari menurun 6,6% dari bulan sebelumnya	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan februari mengalami penurunan 150% dari bulan sebelumnya	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir hanya 1 pasien yang ada di desember 2024	Pasien Asuransi dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan februari 2025 mengalami penurunan 100% dari bulan sebelumnya	Pada bulan february 2025 total pasien mengalami penurunan 9,57% dari bulan sebelumnya
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat				

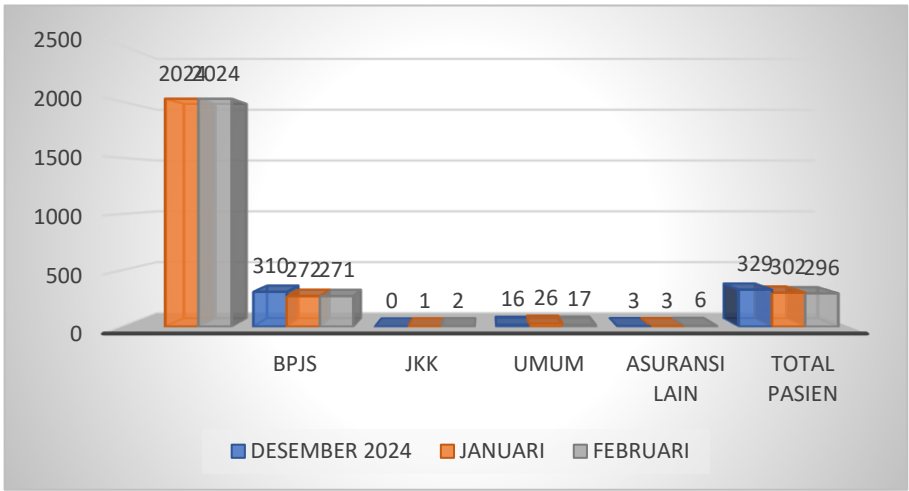
		inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 6. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya dan berkoordinasi dengan marketing untuk selalu koordinasi dengan faskes tentang pelayanan pasien TB di rumah sakit prima husada	
--	--	--	--

3.1.1.4 Kunjungan Rawat Inap 6, 7, 8 A

3.1.1.4.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Desember 2024- Februari 2025)

NO	PENJAMIN	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	310	272	271	↓0,3%
2	JKK	0	1	2	↑ 100%
3	Umum	16	26	17	↓ 34,61%
4	Asuransi Lain	3	3	6	↑ 50%
Total Pasien		329	302	296	↓ 1,98%

3.1.1.4.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Desember 2024- Februari 2025)



3.1.1.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN FEBRUARI	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan februari 2025 mengalami penurunan 0,03% dari bulan sebelumnya di sebabkan kunjunga di IGD juga menurun dengan adanya BA	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan februari 2025 mengalami penurunan 34,61% di bandingkan bulan sebelumnya	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan februari 2025 mengalami peningkatan 100% dibandingkan bulan sebelumnya	Pasien Asuransi / JR dalam 3 bulan mengalami peningkatan untuk bulan februari 2025 mengalami peningkatan 50%	Total semua pasien mengalami penurunan pasien 1,98% dari bulan sebelumnya

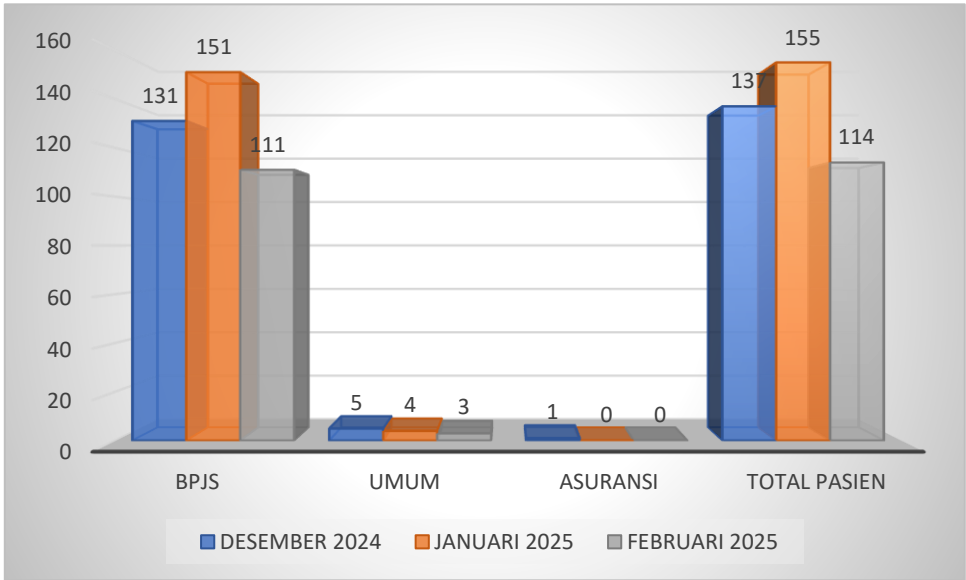
		dari BPJS yang 144 pasien bisa dilakukan di faskes pertama dan juga lodingan yang ada di rawat jalan juga menurun				
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 6. Berkoordinasi dengan bagian humas marketing untuk melakukan kunjungan di perusahaan-perusahaan untuk melakukan pendekatan ke HRD				

3.1.1.5 Kunjungan Rawat Inap Maternitas

3.1.1.5.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Desember 2024- Februari 2025)

NO	HAL	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	131	151	111	↓ 26,49%
2	Umum	5	4	3	↓ 25%
3	Asuransi	1	0	0	0%
Total Pasien		137	155	114	↓ 26,46%

3.1.1.5.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Desember 2024- Februari 2025)



3.1.1.5.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO	BULAN FEBRUARI	RAWAT INAP			KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian	Pasien BPJS dalam 3 bulan	Pasien umum dalam 3 bulan	Pasien asuransi dalam 3 bulan	Total pasien bulan februari

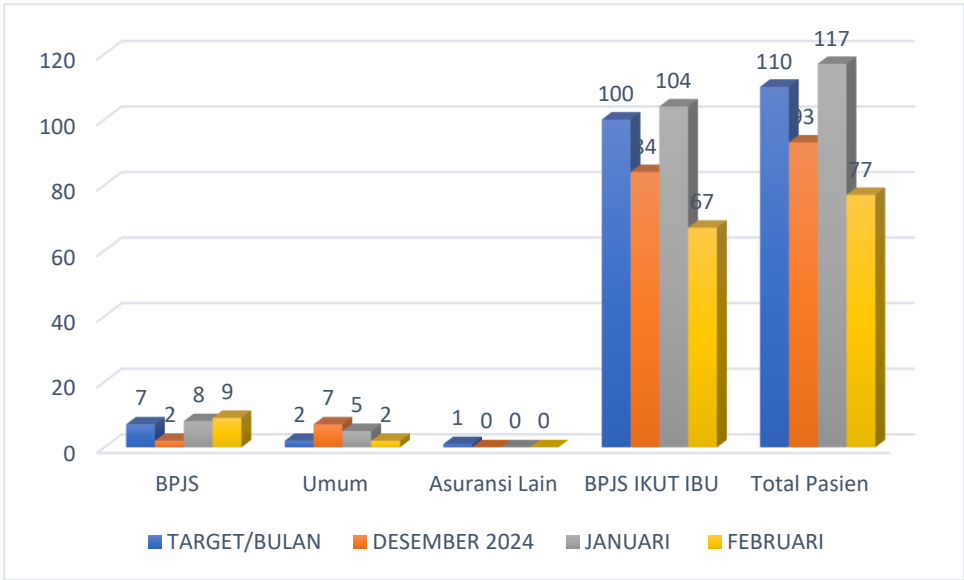
	Desember 2024- Februari 2025	terakhir belum stabil untuk bulan februari 2025 mengalami penurunan 26,49% dari bulan sebelumnya disebabkan kunjungan dan rujukan yang masuk di IGD menurun	menurun untuk bulan februari 2025 mengalami penurunan 25% dari bulan sebelumnya	terakhir mengalami penurunan untuk bulan februari 2025 tidak ada pasien	2025 mengalami penurunan 26,49%
2	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan bekerja sama dengan humas marketing terutama untuk kunjungan ke bidan bidan praktek yang mempunyai BPJS	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan ,bekerjasama dengan humas marketing untuk posting di ig tentang pelayanan di maternitas	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan ,dan mengadakan corporate gatreing dengan perusahaan setiap 1 tahun sekali	

3.1.1.6 Kunjungan Rawat Inap Neonatologi

3.3.2.7.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Desember 2024- Februari 2025)

NO	HAL	TARGET/BULAN	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	7	2	8	9	↑ 12,5%
2	Umum	2	7	5	2	↓ 60%
3	Asuransi Lain	1	0	0	0	0%
4	BPJS IKUT IBU	100	84	104	67	↑ 18,7%
Total Pasien		110	93	117	78	↑ 23,4%

3.3.2.7.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Desember 2024- Februari 2025)



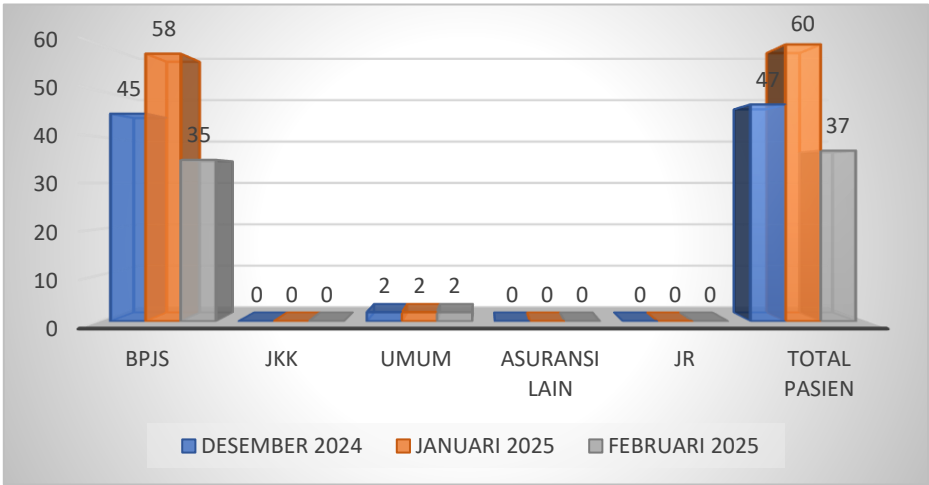
3.3.2.7.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	UMUM	ASURANSI	BPJS IKUT IBU	Total Pasien
1	Februari 2025	9	2	0	67	78
	Analisa	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan februari 2025 meningkat 12,5% di bandingkan bulan sebelumnya	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan februari menurun 60% di bandingkan bulan sebelumnya	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan februari 2025 tidak ada pasien sama sekali	Pasien BPJS ikut ibu dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan februari 2025 mengalami penurunan 18,7% dibandingkan bulan sebelumnya	Total pasien dalam bulan februari 2025 mengalami penurunan 23,4% di bandingkan bulan sebelumnya
	RTL	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, dan berkoordinasi dengan marketing untuk menginformasikan ke bidan bidan jejaring	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya,kerjasama dengan marketing, membuat program pelayanan baru seperti pijat bayi sehingga menarik banyak pasien	Meningkatkan pelayanan dan koordinasi dengan bagian marketing untuk meningkatkan pasien asuransi	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya,kerjasama dengan marketing	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya,kerjasama dengan marketing,membuat program foto bayi dari unit neo

3.1.2 Intensive Care Unit (ICU)
3.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(Desember 2024- Februari 2025)

NO	PENJAMIN	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	45	58	35	↓ 39,65%
2	JKK	0	0	0	tetap
3	Umum	2	2	2	tetap
4	Asuransi Lain	0	0	0	tetap
5	JR	0	0	0	tetap
Total Pasien		47	60	37	↓ 38,33%

3.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(November 2024-Januari 2025)



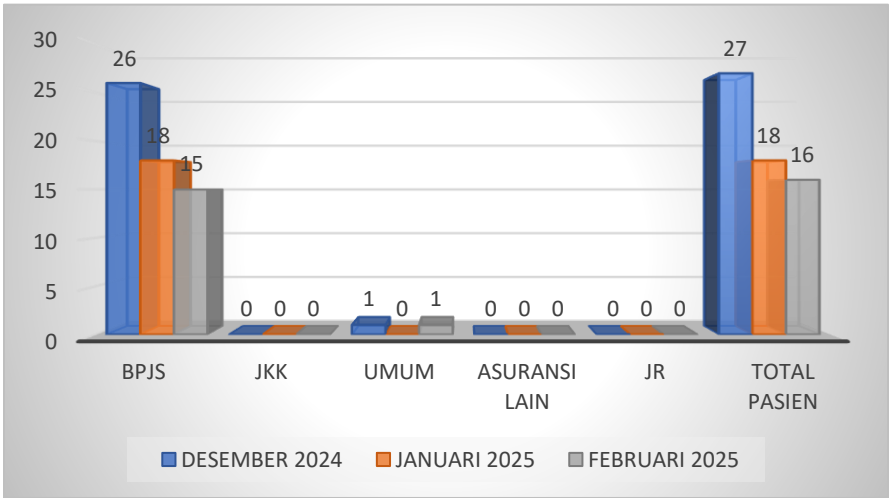
3.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN FEBRUARI	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan februari 2025 mengalami penurunan 39,65% dibandingkan bulan sebelumnya	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan februari 2025 jumlah kunjungan icu sama tetap dengan bulan sebelumnya	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir tidak ada pasien 0	Pasien JR/ Asuransi dalam 3 bulan terakhir tidak ada pasien	Pada 3 bulan terakhir jumlah total pasien belum stabil untuk bulan februari total pasien menurun 38,33% diabndingkan bulan sebelumnya
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama ICU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat 5. Meningkatkan kualitas SDM yang ada di ICU				

3.1.2 High Care Unit (HCU)
3.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(Desember 2024- Februari 2025)

NO	HAL	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	26	18	15	↓16,66%
2	JKK	0	0	0	tetap
3	Umum	1	0	1	↑ 100%
4	Asuransi Lain	0	0	0	0%
5	JR	0	0	0	0%
Total Pasien		27	18	16	↓ 11,11%

3.1.2.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(Desember 2024- Februari 2025)



3.1.2.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

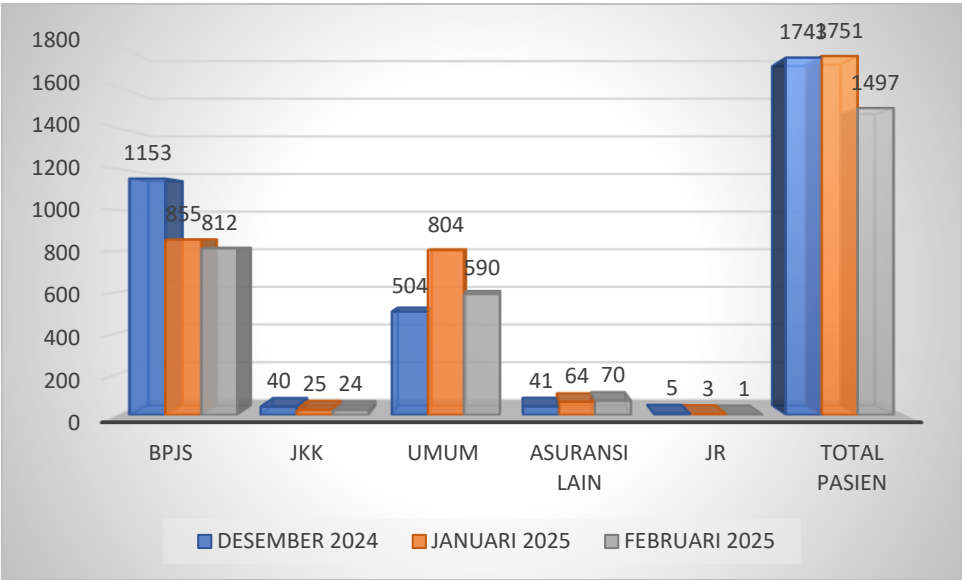
NO.	BULAN FEBRUARI	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan,u ntuk bulan februari 2025 mengalami penurunan 16,66% di bandingkan bulan lalu	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan februari 2025 mengalami peningkatan 100% dari bulan sebelumnya	Tidak ada pasien JKK selama 3 bulan	Pasien JR/ Asuransi dalam 3 bulan terakhir masih belum ada pasien	Pada 3 bulan terakhir jumlah total pasien bulan februari 2025 mengalami penurunan 11,11%
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama HICU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat				

3.1.3 Instalasi Gawat Darurat (IGD)

3.1.2.3 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Desember 2024- Februari 2025)

NO	HAL	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	1153	855	812	↓5,29%
2	JKK	40	25	24	↓4,16%
3	Umum	504	804	590	↑36,27%
4	Asuransi Lain	41	64	70	↑8,57%
5	JR	5	3	1	↓ 66%
Total Pasien		1743	1751	1497	↓ 17%

3.1.2.4 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Desember 2024-Februari 2025)



3.1.3.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN FEBRUARI 2025	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis	Kunjungan pasien BPJS dari 3 bulan terakhir belum mengalami penurunan untuk bulan februari 2025 mengalami penurunan 5,29% dari bulan sebelumnya di sebabkan oleh dengan peraturan bpjs 144 penyakit yang tidak di cover bpjs sehingga di IGD skrining lebih ketat untuk false emergencyn ya dan bulan februari sampai 28 hari	Kunjungan pasien dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan februari 2025 mengalami penurunan 36,27% dari bulan sebelumnya disebabkan kunjungan di IGD juga menurun	Kunjungan pasien dengan jaminan JKK dari 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan februari 2025 mengalami penurunan 4,16% dari bulan sebelumnya	Kunjungan pasien dengan jaminan JR dan asuransi dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan februari 2025 mengalami peningkatan 5,6%	ToTotal Kunjungan pasien IGD semua jaminan bulan februari 2025 mengalami penurunan 17% dari bulan sebelumnya
2	RTL	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan pasien BPJS IGD dengan memperbaiki pelayanan	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan jaminan UMUM dengan memberikan	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan jaminan JKK dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan marketing	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan Asuransi swasta IGD bekerjasama dengan	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan memperbaiki pelayanan dan bekerjasama

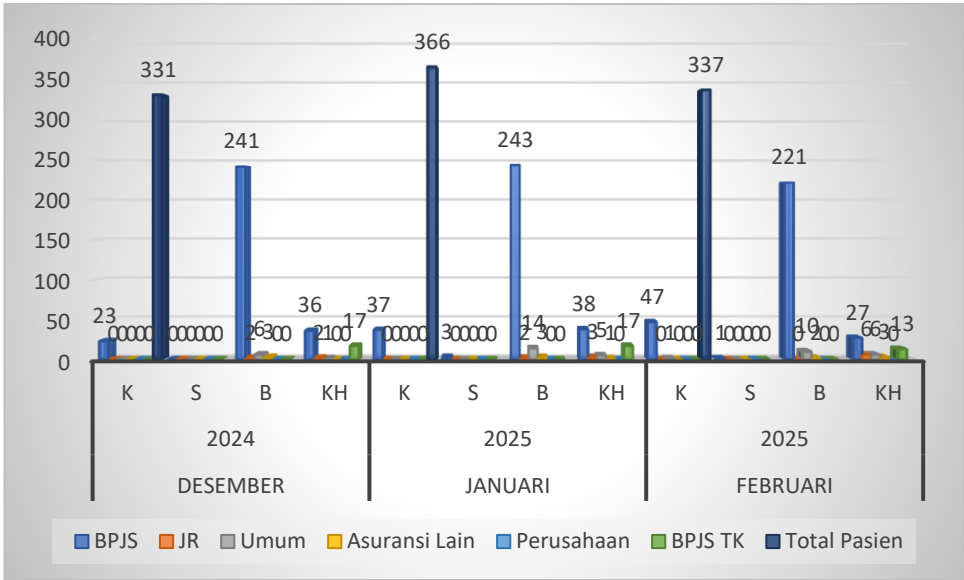
		dan mengurangi komplain serta bekerjasama dengan marketing untuk menambah kerja sama dengan beberapa faskes I area kabupaten Malang	pelayanan kesehatan yang prima dan maksimal	untuk memperluas kerjasama dengan beberapa Perusahaan Kabupaten Malang	marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi	dengan pihak terkait (marketing, asuransi centre)
--	--	---	---	--	---	---

3.1.4 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

3.1.2.5 Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Desember 2024- Februari 2025)

NO	HAL	DESEMBER 2024				JANUARI 2025				FEBRUARI 2025				PROSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
		k	s	b	kh	k	s	b	kh	k	s	b	kh	
1	BPJS	23	0	241	36	37	3	243	38	47	1	221	27	Penurunan 7,9%
2	JR	0	0	2	2	0	0	2	3	0	0	0	6	
3	Umum	0	0	6	1	0	0	14	5	1	0	10	6	
4	Asuransi Lain	0	0	3	0	0	0	3	1	0	0	2	3	
5	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	BPJS TK	0	0	0	17	0	0	0	17	0	0	0	13	
	Total Pasien	331				366				337				

3.1.2.6 Grafik Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Desember 2024- Februari 2025)



3.1.4.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN FEBRUARI	IKO					KESIMPULAN
		BPJS	BPJS TK	UMUM	PERUSAHAAN	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan	Pasien BPJS TK dalam 3 bulan	Pasien Umum operasi dalam 3	Pasien perusahaan dalam 3 bulan terakhir	Pasien Asuransi / JR dalam 3 bulan terakhir belum stabil	Total pasien untuk bulan januari 2025 meningkat

		terakhir pasien operasi yang menggunakan BPJS meningkat untuk bulan januari 2025 meningkat 6,5% dari bulan sebelumnya	operasi menggunakan a bpjs TK menurun untuk bulan januari 2025 tetap angka operasi yang ada di iko di bandingkan bulan sebelumnya	bulan terakhir belum stabil untuk bulan januari 2025 mengalami peningkatan 63,1 % dibandingkan bulan sebelumnya	mengalami penurunan untuk bulan januari 2025 belum ada pasien operasi dengan jaminan perusahaan	untuk bulan januari 2025 mengalami peningkatan 22,2 % di bandingkan bulan sebelumnya	9,5%
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya dan mengurangi pasien IDO sehingga pasien puas dengan pelayanan operasi di prima husada 2. Berkoordinasi dengan bagian marketing untuk ekspos ruangan IKO yang sudah di ganti vinyl 3. Mengikuti pelatihan yang terbaru sehingga menunjang pelayanan yang terbaik di IKO 4. Berkoordinasi dengan humas marketing,terutama kunjungan ke perusahaan-perusahaan dan psc untuk mengirim ke prima husada malang 5. mengirimkan pelatihan asisten bedah saraf 6. Memberikan edukasi yang bagus untuk pasien pasien operasi					

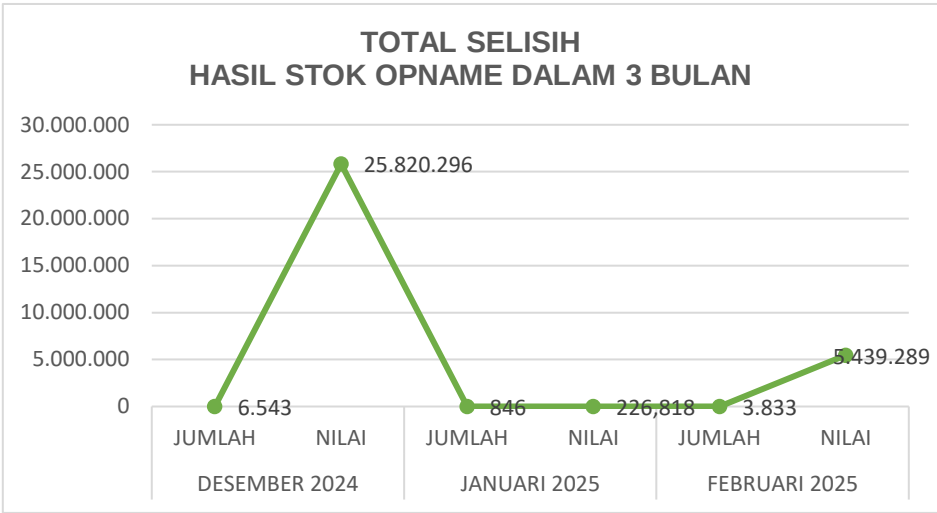
3.2 Kinerja Bidang Penunjang

3.2.1 Instalasi Farmasi

3.2.1.1 Tabel Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Bulan Desember 2024 – Februari 2025

UNIT	JUMLAH STOK	JUMLAH PERSEDIAAN					
		DESEMBER 2024		JANUARI 2025		FEBRUARI 2025	
		JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
GUDANG	FISIK	717.819	1.984.154.958	987.821	1.975.733.953	915.745	1.761.987.563
	SISTEM	717.782	1.984.197.437	987.822	1.975.808.953	915.745	1.761.987.563
	SELISIH	37	-42.479	1	-75.000	0	0
DEPO FARMASI	FISIK	142.908	492.912.632	154.951	485.480.619	157.013	480.400.038
	SISTEM	142.238	486.169.397	154.207	485.122.849	153.182	474.904.947
	SELISIH	670	+6.743.243	745	+357.772	3.832	+5.495.099
IKO	FISIK	2.455	99.561.444	2.031	81.909.892	1.905	89.600.086
	SISTEM	2.351	93.530.564	1.929	81.965.847	1.904	89.655.896
	SELISIH	104	+6.030.879	102	-55.954	1	-55.810
GUDANG RETURE	FISIK	0	0	0	0	0	0
	SISTEM	0	0	0	0	0	0
	SELISIH	0	0	0	0	0	0
TOTAL SELISIH		6.543	+25.820.296	846	+226.818	3.833	+5.439.289

3.2.1.2 Grafik Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Bulan Desember 2024 – Februari 2025



3.2.1.3 Analisis dan Tindak Lanjut

Hasil stok opname pada Bulan Februari 2025 sudah mendekati target (0), analisisnya sebagai berikut :		
NO	ANALISA	RENCANA TINDAK LANJUT
GUDANG FARMASI Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname sudah mencapai target (0). Analisa :		
1.	Dilakukan random cek pada seluruh rak sudah sesuai antara fisik dan system.	Monitoring dan evaluasi kinerja Gudang Farmasi.
2.	Kartu stok berjalan.	
3.	Hasil laporan SO ditemukan selisih Rp - 989.756. Setelah di telusur FOLEY CATH NO 14 – RUSCH, PD PLATE-M2 (BIPOLAR) – ProDevice, EYE DOP, CVC SET TRIPLE LUMEN. 7FR (CERTOVIX) ditemukan hasil verifikasi SO oleh auditor PT. DPM tidak ditemukan selisih sehingga tidak ada arahan dari auditor untuk di cek perhitungan ulang jadi hanya dilakukan random stok barang lain. Namun setelah dilakukan tarikan laporan SO ditemukan selisih dan sudah dilakukan pehitungan ulang besok harinya stoknya sesuai dan ternyata petugas salah input jumlah SO.	Membuat berita acara penyesuaian stok opname dan koordinasi dengan progamer untuk penyesuaian stok.
DEPO FARMASI Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar + Rp 5.495.099, hal ini disebabkan karena :		
1.	Cendo Conver MDS F00170 (barang ED Feb 2025) terdapat fisik 40 pcs sedangkan di system sudah 0; setelah ditelusur ditemukan salah release barang ke IKO pada tanggal pelaksanaan SO.	Penyesuaian stock pada saat Stock Opname serta meningkatkan ketelitian petugas dalam release barang.
2.	METHYLPREDNISOLONE INJ 125 MG/2 ML PHAPROS, selisih kurang 26 vial, stok di system sudah 0, sedangkan kode F00481 METHYLPREDNISOLONE INJ 125 MG/2 ML Mahakam selisih lebih 6 vial. Indikasi salah input resep dan selisih dari SO bulan sebelumnya.	Jika ada 2 nama master sama dan beda pabrik maka menghabiskan stok yang lama.
3.	F00572 ONDANSETRON INJ 8 MG/4 ML BERNOFARM, selisih kurang 30 vial sedangkan F00570 ONDANSETRON INJ 4 MG/2 ML OGB Novel, terdapat selisih lebih 30 vial. Indikasi terdapat salah input nama barang sama beda pabrikan.	
4.	ASAM ASETILSALISILAT TAB 80 MG (INZANA); selisih kurang 30 tab.	Meningkatkan ketelitian petugas saat simpan penjualan resep.

5.	F00425 LAFALOS CR 20 G SANBE, selisih kurang 10 tub.	
6.	Kertas Kerja Alkes: Terdapat ketidaksesuaian perhitungan antara kertas kerja dan fisik saat perhitungan ulang oleh petugas farmasi.	Meningkatkan ketelitian petugas saat verifikasi hitung ulang.
7.	Kartu stok belum berjalan.	Menegur dan mengingatkan petugas pentingnya menulis kartu stok, agar selisih dapat ditelusur.
8.	Inputan resep dan yang digunakan tidak sesuai.	Perbaikan prosedur inputan resep dari ruangan sesuai master barang dan jumlah yang akan digunakan.
9.	Selisih lebih di depo farmasi dikarenakan retur barang dari ruangan yang masih belum ada inputan di simrs selama sistem distribusi ODD.	Perbaikan prosedur retur barang yang tidak terinput di sistem maka Karu wajib membuat berita acara yang diketahui oleh Kabid Keperawatan kemudian diserahkan ke Kains untuk dilakukan penerimaan barang disertai ke direktur. Retur barang ke depo farmasi wajib sesuai di hari yang sama dengan inputan retur penjualan.
10.	IGD masih sering permintaan resep manual dan belum ada inputan resep di SIMRS.	Farmasi akan cc resep manual yang belum terinput dan IGD wajib screenshot hasil inputan di grup.
FLOORSTOK IKO Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar - Rp 55.810, hal ini disebabkan karena :		
1.	F01353 ETT CUFF NO 7.0 - WORK selisih lebih stok 1 pc, sedangkan F01363 ETT NON KING NO 7.0 - WORK selisih kurang 1 pc. Indikasi salah input master barang hampir sama beda ukuran.	Meningkatkan ketelitian petugas saat menulis dilembar kerja dan input SO.
2.	Inputan resep dan yang digunakan tidak sesuai.	Perawat wajib memastikan barang yang diresepkan harus sesuai dengan yang digunakan.
GUDANG RETUR Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname sudah sesuai dengan target (0).		
1.	Tidak terdapat rak Gudang Retur	Sentralisasi master barang PT. DPM dan mengajukan gudang retur kembali dimunculkan.

3.2.1.4 Tabel Daftar Obat-obat Near ED <6 bulan (Bulan Februari 2025- Juli 2025)

No	Kode	Nama Barang	Satuan	Harga Beli	Tanggal Expired	No Batch	Jumlah Fisik Baik (BULAN)			Total Harga	Laporan Penjualan 1 Tahun Terakhir
							12/24	01/25	02/25		
1.	F01348	Ett cuff no 4.5 - work	Pcs	36.500	30/03/2025	200321	12	12	12	483.000	1
2.	F00320	Fludis inf 100 ml - bernofarm	Flash	165.000	30/03/2025	EID19350	17	17	7	1.155.000	13
3.	F02025	Suction cath no. 16	Pcs	7.000	30/03/2025	2022806	5	2	2	14.000	16
4.	F03261	Koni e caps 400 - konimex	Caps	4.000	30/04/2025	23ADI	202	202	202	808.000	13
5.	F00687	S-omevell inj 40 mg - novell	Vial	143.000	30/04/2025	250138	2	2	1	143.000	3
6.	F00812	Vaksin vaxigrip tetra -	Vial	169.575	31/04/2025	Y3D471V	5	1	5	847.875	78

		sanofi									
7.	F00963	Benang t-vio 0 v11 - triton	Pcs	93.500	30/05/2025	220507OM	69	64	59	5.516.500	51
8.	F00173	Cendo lyteers mds - cendo	PCS	3.850	30/05/2025	SS60512	100	100	100	385.000	865
9.	F01393	Foley cath no 8 - rusch	Pcs	61.765	30/05/2025	20F28	5	5	4	247.060	23
10.	F00385	Inviclot inj 5000 iu 5 ml - fahrenheit	Vial	66.000	30/05/2025	3HB578	10	10	10	660.000	1
11.	F00546	Nutrisi lactogen lactose free 400 g - Nestle	Kalen g	116.036	30/05/2025	L33120346AB	1	1	1	116.036	2
12.	F00582	Ostovell caps 0.25 mcg - novell	Caps	6.500	30/05/2025	25K327	314	310	92	598.000	485
13.	F00914	Benang advalene blue 3-0/70 cm single 25 mm 3/8 circle cutting	Pcs	47.415	30/06/2025	V20198	27	27	25	1.185.375	30
14.	F00455	Lovenox 60 mg/06 ml - sanofi	Amp	120.000	30/06/2025	4HS495FB	46	37	19	2.280.000	267
15.	F00550	Nuvision tab - guardian	Tab	5.800	30/06/2025	2306083	650	650	626	3.630.800	1.665
16.	F00972	Benang t-vio 5-0 v38 - triton	Pcs	85.000	30/07/2025	220712BZ	37	32	32	2.720.000	33
17.	F00276	Epexol syr 120 ml - sanbe	Btl	18.200	30/07/2025	DG9786	24	24	24	436.800	10
18.	F00542	Ntg inj 1 mg/ml - ferron	Vial	65.000	30/07/2025	BN4832412A	17	17	16	1.040.000	31
19.	F00580	Oseltami vir caps 75 mg (hibah dinkes) - indofarma	Caps	10.010	30/07/2025	210V2062	1.100	1.100	1.100	11.011.000	0
20.	F00638	Prohepar kaps - yarindo	Caps	6.500	30/07/2025	CO210664	1.037	994	553	3.041.500	1..372
21.	F00701	Sequest susp 40 g - novell	Sach	19.250	30/07/2025	25G263	11	8	8	154.000	30

22.	F03256	Frixitas tab 1 mg - novell	TAB	3.848	30/07/20 25	23F297	94	94	94	361.712	96
23.	F00517	Neostigm ine inj 05 mg/ml - ethica	AMP	10.90 1	30/07/20 25	E23H0 142A	17	17	15	163.515	2
24.	F00500	Mikaject inj 250 mg/2 ml - mahaka m	VIAL	80.75 0	30/07/20 25	A2321 31B	52	68	42	3.391.500	438
25.	F00307	Ferriprox tab 500 mg - apotex inc	TAB	35.1 00	30/08/20 25	ry1625	194	194	194	6.809.400	0
26.	F01400	Foley cath silicon no 8 - rusch	PCS	222.0 00	30/08/20 25	KME20 J1263	4	4	4	888.000	1
27.	F00603	Perossal 2x6 - dipa pharmala b	PCS	231.0 00	30/08/20 25	22HA1 4780	17	17	16	3.696.005	59
Total										51.783.078	

3.2.1.5 Analisis Obat Near ED < 6 bulan (Bulan Februari 2025 - Juli 2025)

Analisis	Tindak Lanjut
Rekap Near ED < 6 bulan (Bulan Februari 2025 - Juli 2025) karena obat dan alkes slow moving : Rekap Near ED < 6 bulan (Bulan Februari 2025 - Juli 2025 karena obat dan alkes slow moving: 1. Ett cuff no 4.5 - work, dimasukkan ke dalam trakea untuk memastikan tidak tertutupnya trakea sebagai saluran pernapasan dan udara pernapasan dapat masuk kedalam paru-paru. Faktur pembelian terakhir tanggal 19/07/2024 dari distributor sejumlah 8 pcs, penerimaan alkes dengan ed < 1 tahun dari distributor. 2. Fludis inf 100 ml - bernofarm, pengobatan infeksi non-sistemik oleh jamur candida pada vagina, tenggorokan, dan mulut. Faktur pembelian terakhir tanggal 26/08/2021 dari distributor sejumlah 15 flash. 3. Suction cath no. 16, digunakan untuk mengeluarkan sekresi tubuh. Penggunaan slow moving, faktur pembelian terakhir tanggal 09/07/2022 dari distributor sejumlah 10 pcs. 4. Koni e caps 400 - konimex digunakan untuk suplemen memelihara kesehatan kulit. Penggunaan slow moving, faktur pembelian terakhir tanggal 31/10/2023 dari distributor sejumlah 90 kapsul. 5. S-omevell inj 40 mg - Novell, di gunakan untuk gerd, helicobacter pylori eradication, gastric ulcer, Zollinger-ellison syndrome. Faktur pembelian terakhir tanggal 31/08/2024 dari RS Prima Husada Sukorejo sejumlah 2 vial. 6. Vaksin vaxigrip tetra - Sanofi, digunakan untuk melindungi tubuh dari penyakit akibat virus influenza. Faktur pembelian terakhir tanggal 31/01/2025 dari distributor sejumlah 11 vial karena adanya program harga promo dari PT. Sanofi dan penyediaan stok di RS untuk paket vaksin dengan harga promo. 7. Benang t-vio 0 v11 - triton, digunakan untuk operasi. Penggunaan alkes death moving, faktur pembelian terakhir tanggal 31/07/2023 dari distributor sejumlah 12 pcs. 8. Foley cath no 8 - rusch, dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Faktur pembelian terakhir tanggal 09/12/2021 dari distributor sejumlah 30 pcs. 9. Inviclot inj 5000 iu 5 ml - Fahrenheit, digunakan untuk antikoagulan. Penggunaan obat death moving faktur pembelian terakhir tanggal 23/09/2023 dari distributor sejumlah 10 vial. 10. Nutrisi lactogen lactose free 400 g - Nestle merupakan susu formula bayi yang tidak mengandung laktosa dan digunakan pada bayi usia 0-12 bulan yang mengalami intoleransi terhadap laktosa dan diare. Faktur pembelian terakhir tanggal 18/04/2024 dari distributor sejumlah 3 kaleng. 11. Ostovell caps 0.25 mcg - novell, digunakan untuk antikoagulan. Penggunaan obat death moving faktur pembelian terakhir tanggal 30/09/2023 dari distributor sejumlah 240 caps.	1. Sediaan farmasi near ED akan dilakukan koordinasi dengan PHS jika barang lebih berjalan di PHS akan diberikan ke PHS untuk lainnya akan dilakukan koordinasi dengan DPJP untuk peresepan. 2. Membuat surat edaran ke DPJP untuk meresepkan obat/ alkes yang near ed. 3. Koordinasi dengan karu untuk menggunakan alkes yang near ed. 4. Koordinasi dengan PT. DPM untuk melakukan retur ke distributor. 5. Koordinasi dengan DPJP obat yang <i>death moving</i> di <i>stop order</i> dan dikeluarkan dari Formularium RS.

12. Benang advalene blue 3-0/70 cm single 25 mm 3/8 circle cutting, digunakan untuk operasi. Penggunaan alkes death moving, faktur pembelian terakhir tanggal 27/03/2023 dari distributor sejumlah 12 pcs.
13. Lovenox 60 mg/06 ml - Sanofi, digunakan sebagai antikoagulan. Faktur pembelian terakhir tanggal 19/12/2024 dari distributor sejumlah 30 amp, penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor.
14. Nuvision tab - guardian, digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk memelihara kesehatan mata. Faktur pembelian terakhir tanggal 23/10/2023 dari distributor sejumlah 1980 tab.
15. Benang t-vio 5-0 v38 - triton, digunakan untuk operasi. Penggunaan alkes death moving, faktur pembelian terakhir tanggal 29/11/2022 dari distributor sejumlah 24 pcs.
16. Epexol syr 120 ml - sanbe, sebagi sekretolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis khususnya untuk eksaserbasi bronkitis kronis dan bronkitis asmatik serta asma bronkial. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 20/09/2023 dari distributor sejumlah 15 botol.
17. Ntg inj 1 mg/ml - ferron, indikasi untuk mengontrol hipertensi dengan cepat selama pembedahan jantung, Menurunkan tekanan darah dan menjaga hipotensi yang terkontrol selama prosedur pembedahan, Mengontrol iskemia miokard selama dan setelah pembedahan, Gagal jantung kongestif yang tidak responsif karena infark miokard akut, Angina tidak stabil yang sulit disembuhkan dengan beta blocker dan nitrat sublingual. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 25/06/2024 dari distributor sejumlah 10 amp.
18. Oseltamivir caps 75 mg (hibah dinkes) – indofarma, untuk mengatasi infeksi virus influenza tipe A atau B. Penggunaan obat death moving. Penerimaan obat dari dinas kesehatan tanggal 06/08/2021 sejumlah 700 tablet untuk pengobatan covid-19.
19. Prohepar kaps - yarindo, digunakan untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral dalam tubuh, memelihara kesehatan fungsi hati. Faktur pembelian terakhir tanggal 28/12/2023 dari distributor sejumlah 1500 tablet. Peresepan terakhir pada tanggal 23/07/2024, penggunaan obat slow moving.
20. Sequest susp 40 g - novell, untuk kadar kolesterol pada pasien hiperkolesterolemia primer yang tidak menunjukkan respon terhadap makanan. Faktur pembelian terakhir tanggal 30/09/2023 dari distributor sejumlah 40 sachet. Penggunaan obat slow moving.
21. Frixitas tab 1 mg – novell, untuk mengatasi kegelisahan berlebihan dan agoraphobia. Faktur pembelian terakhir tanggal 11/11/2021 dari distributor sejumlah 120 tablet. Penggunaan obat death moving peresepan terakhir tanggal 24/07/2024.
22. Neostigmine inj 05 mg/ml – ethica untuk meringankan gejala myasthenia gravis, pengobatan ileus paralitik, retensi urin pasca operasi. Faktur pembelian terakhir tanggal 28/11/2024 dari distributor sejumlah 10 ampul. Penggunaan obat slow moving.
23. Mikaject inj 250 mg/2 ml – Mahakam sebagai antibiotik. Faktur pembelian terakhir tanggal 03/01/2025 dari distributor sejumlah 40 vial, penerimaan alkes dengan ed < 1 tahun dari distributor.

24. Ferriprox tab 500 mg - apotex inc untuk terapi kelebihan Fe (zat besi) pada pasien talasemia mayor. Faktur pembelian terakhir tanggal 21/02/2021 dari distributor sejumlah 300 tablet. Penggunaan obat death moving karena obat tidak bisa di klaim obat kronis di FKRTL. 25. Foley cath silicon no 8 – rusch dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Faktur pembelian terakhir tanggal 26/03/2024 dari distributor sejumlah 10 pcs. 26. Perossal 2x6 - dipa pharmlab merupakan material sintetis pengganti tulang yang resorbable, digunakan untuk pengisian atau rekonstruksi tulang pada tulang yang rusak. Faktur pembelian terakhir tanggal 15/01/2025 dari distributor sejumlah 12 pcs, penerimaan alkes dengan ed < 1 tahun dari distributor.	
--	--

3.2.1.6 Managemen Resiko dan Aksi Mitigasi

No Risk	Divisi	Spesialis terkait	Pemilik Risk	Tipe Risk	Deskripsi Risk	Pengendalian yang sudah ada	Skor Risk Sebelumnya	Dampak	Kemungkinan	Status Perubahan Rating Risiko	Mitigasi yang sedang dijalankan	Target Penyelesaian	Target Skor Risk	Indikator Kunci Mitigasi	Rencana Review
1	Komite medik	Dokter/ Dokter spesialis	Pasien	Klinis	Kesalahan input e-resep	Kontrol dan supervisi	9	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	SPO penulisan dan input resep serta supervisi	Meninjau ulang setiap tahun terkait kompetensi dokter
2	IFRS	Apoteker/ TTK	Pasien	Klinis	Kesalahan penyiapan obat	Kontrol dan supervisi	14	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi serta pelatihan berkelanjutan	3 bulan - 6 bulan	6	SPO alur pelayanan resep rawat jalan dan resep pulang pasien rawat inap. Jumlah TTK/ apoteker terpenuhi sesuai dengan kebutuhan tenaga. Terdapat diklat dan motivasi kerja	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
3	IFRS	Apoteker/ TTK	Pasien	Klinis	Kesalahan penulisan pada etiket obat	Kontrol dan supervisi	7	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	Motivasi dan kinerja petugas meningkat. SPO penulisan etiket di Instalasi Farmasi	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas

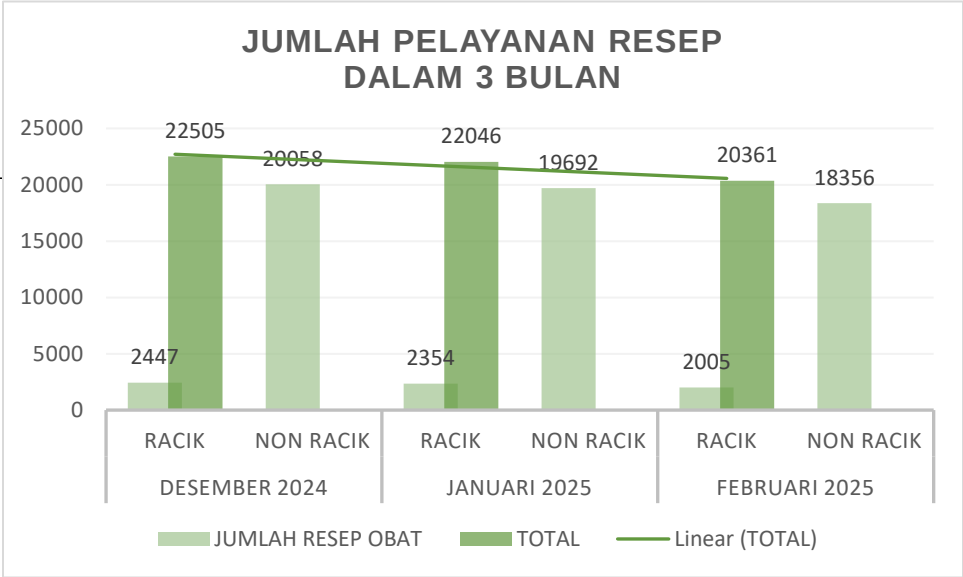
4	IFRS	Apoteker/ TTK	Pasien	Klinis	Obat tidak dilengkapi <i>expired date/ beyond use date</i>	Kontrol dan supervisi	7	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	Motivasi dan kinerja petugas meningkat. SPO penulisan etiket di Instalasi Farmasi	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
5	IFRS	Apoteker/ TTK	Pasien	Klinis	Kesalahan identifikasi pasien	Kontrol dan supervisi	5	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	2	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
6	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Kesalahan pemberian obat pada pasien	Kontrol dan supervisi	14	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	SPO telaah obat, SPO verifikasi pemberian obat rawat inap. Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
7	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Insiden kelebihan/ kekurangan penyerahan obat pada pasien rawat jalan	Kontrol dan supervisi	5	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	3	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
8	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Insiden kelebihan/ kekurangan penyerahan obat pada pasien rawat inap	Kontrol dan supervisi	3	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	2	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
9	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Insiden reaksi alergi obat	Kontrol dan supervisi	11	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas

10	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Insiden kesalahan dosis obat	Kontrol dan supervisi	8	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
----	------	-------------------	--------	--------	------------------------------------	-----------------------------	---	---------	----------------------	-------	--------------------------	----------------------	---	--	--

3.2.1.7 Tabel Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan Desember 2024 - Februari 2025

UNIT	JUMLAH RESEP					
	DESEMBER 2024		JANUARI 2025		FEBRUARI 2025	
	RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK
IRNA	253	8481	216	8639	195	8229
IRJA	2073	8797	2005	7929	1726	7389
IKO	0	810	0	899	0	794
IGD	121	1970	133	2225	84	1944
TOTAL	2447	20058	2354	19692	2005	18356
JUMLAH RESEP OBAT	22.505		22.046		20.361	

3.2.1.8 Grafik Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan Desember 2024 - Februari 2025



Analisis :

Secara keseluruhan total resep pada bulan Februari 2025 mengalami penurunan, hal ini disebabkan kunjungan pasien rawat jalan mengalami penurunan karena target PRB rawat jalan dimana pasien rujuk balik ke FKTP dikarenakan pasien sudah stabil dan retur obat tertinggal rawat jalan yang tidak diambil pasien, rawat inap mengalami penurunan karena batasan diagnosa yang tidak bisa di layani di FKRTL.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Meningkatkan promosi tarif dan tindakan RS di sosial media RS agar kunjungan pasien meningkat.
2. Meningkatkan pelayanan resep yang tepat, cepat, dan akurat sehingga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan di Farmasi.
3. Mengajukan fitur cek hasil laboratorium dalam batas waktu 6 bulan dari IRNA dan IRJA untuk memudahkan pemberian obat sesuai dengan retriksi yang ditentukan.
4. Menciptakan inovasi pengembangan pelayanan pengantaran obat dengan penambahan jumlah driver.
5. Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan. Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru dan obat tertinggal.
6. Perubahan alur distribusi obat, petugas melebur menjadi satu. Penambahan petugas shift malam supaya tidak terjadi lembur menyelesaikan obat rawat jalan.
7. Penambahan admin IKO untuk focus pada mutase barang di Floorstok IKO.

3.2.1.9 Tabel Hasil Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Bulan Desember 2024 - Februari 2025

No	Kegiatan	Standard	Pencapaian			Keterangan
			Desember 2024	Januari 2025	Februari 2025	
1.	Pengkajian Resep	100%	99.33%	99.42%	99.17%	Jumlah pengkajian resep, yaitu Desember 2024 = 22.505 Januari 2025 = 22.046 Februari 2025 = 20.361 Jumlah ketidaklengkapan penulisan resep, yaitu Desember 2024 = 151 Januari 2025 = 128 Februari 2025 = 168 Januari 2025 = 128
2.	Dispensing sediaan steril	100%	100%	100%	100%	Dispensing sediaan steril dilakukan oleh apoteker di Ruang Pencampuran Obat Steril (LAF).
3.	Pemantauan Terapi Obat (PTO)	100%	100%	100%	100%	Form PTO sudah terlaksana dimana apoteker melakukan seleksi pasien berdasarkan kriteria PTO. Form PTO diletakkan dalam RM.
4.	Kejadian Efek Samping Obat	0	0	0	1	Ditemukan pelaporan efek samping obat.
5.	Edukasi Obat pada pasien dan keluarga	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan rekam medis dan resep obat yang ditandatangani oleh penerima obat.
6.	Konseling	100%	100%	100%	100%	Konseling sudah dilakukan apoteker dibuktikan dengan bukti edukasi di Lembar Edukasi (pasien rawat inap) dan tanda-tangan penerima obat di resep (pasien rawat jalan).
7.	Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah	TDD	TDD	TDD	TDD	Tidak punya alat untuk pemantauan kadar obat dalam darah. TTD RS tipe C tidak wajib.
8.	Visite Ronde Besar	100%	0%	0%	0%	Koordinasi dengan PPA (Professional Pemberi Asuhan) agar dilakukan visite ronde besar.
9.	Visite Pasien/ Farmasi Klinik	100%	100%	100%	100%	Seluruh pasien rawat inap dilakukan visite mandiri dibuktikan dengan pengisian

						CPPT oleh Apoteker di RM.
10.	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan map informasi obat, MIMS, aplikasi Medscape.
11.	Obat tidak bertuan	0	0	0	365	Ditemukan retur obat tidak bertuan sehingga dilakukan retur ke Gudang Retur dan sudah dilakukan penerimaan farmasi lain di SIMRS.
12.	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien	0	126	50	34	Obat tertinggal dikirimkan menggunakan PRIMANTARA, untuk pasien yang tidak merespon obatnya dilakukan penerimaan hibah lainnya ke gudang retur.
13.	Penempelan label obat rawat inap	100%	100%	100%	100%	Tidak ada laporan penempelan label obat rawat inap yang tidak ada dan tidak ada laporan IKP kejadian kesalahan penulisan etiket obat.

3.2.1.10 Tabel Analisa dan Tindaklanjut Hasil Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada pada Bulan Desember 2024 - Januari 2025

Kinerja	Analisa	Tindak Lanjut
Pengkajian Resep	Penulisan resep yang lengkap bulan Februari 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Januari 2025, dengan total resep yang tidak lengkap yaitu : bulan Januari 2025 sebanyak 128 dan bulan Februari 2025 sebanyak 168. Dari data di atas ditemukan pengkajian resep : - Dari segi telaah adminitrasi : sudah lengkap karena menggunakan e-resep melalui SIMRS - Dari segi telaah farmasetik : masih ditemukan dokter salah input dosis dan jumlah obat, aturan dan cara penggunaan serta rute pemberian tidak lengkap terisi. - Dari segi telaah klinis : sudah terlaksana oleh apoteker karena jika ada interaksi obat langsung diberi jeda pemberian obat oleh apoteker.	- Koordinasi dengan tim SIMRS untuk membuat sistem jika resep tidak terinput dengan lengkap maka resep tidak dapat masuk ke IFRS. - Inputan resep harus dilakukan oleh dokter/ dokter spesialis yang kompeten dan berwenang mulai dari identitas pasien, nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dan tandatangan dokter (untuk resep manual). - Pelatihan penulisan resep untuk semua dokter dan dokter spesialis.
Kejadian Efek Samping Obat	- Hasil monitoring pelaporan MESO bulan Februari 2025 ditemukan terjadinya efek samping obat Divalproex sodium er tab 500 mg yaitu pasien mengeluhkan tidak bisa tidur. - Kurangnya pelaporan kejadian efek samping obat oleh tenaga kesehatan.	- Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan. - Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien.

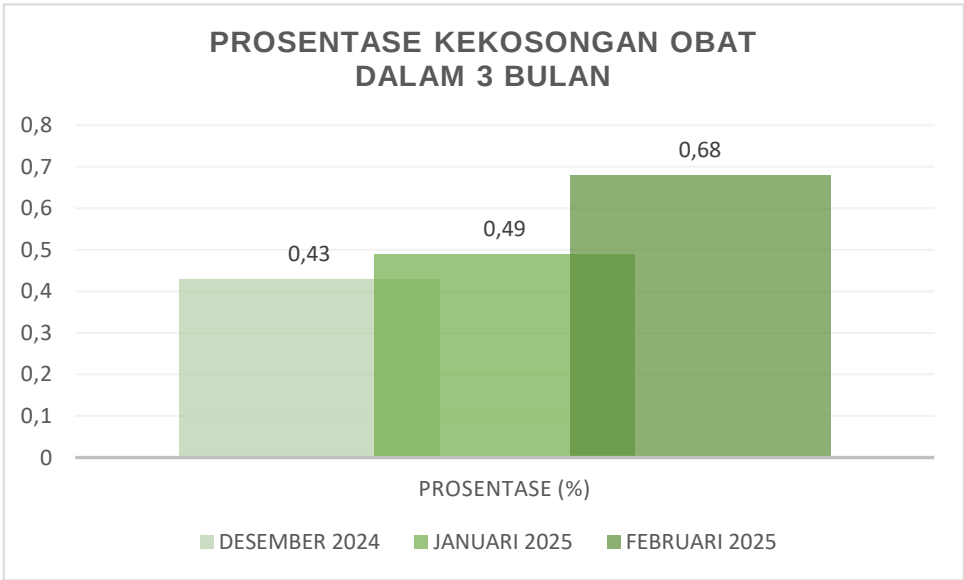
		3. Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO). 4. Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO. 5. Menganalisa laporan ESO. 6. Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO). 7. Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD. 8. Pelaporan ESO ke pusat meso/farmakovigilans nasional
Edukasi Obat Pada Pasien dan Keluarga	1. Hasil supervisi dari rekam medis di rawat inap pada form edukasi bahwa apoteker sudah melakukan edukasi dibuktikan dengan ttd pasien/ keluarga di form edukasi. 2. Hasil supervisi dirawat jalan petugas farmasi sudah melakukan edukasi ke pasien dibuktikan dengan ttd penerima obat beserta KIE. 3.	Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan edukasi obat di rawat inap dan rawat jalan.
Pelayanan Informasi Obat (PIO)	PPA dapat megakses Map informasi obat berisi : daftar dosis maksimal prorenata (jika perlu), daftar obat automatic stop order, daftar obat high alert update, daftar obat resiko jatuh, informasi cara pengenceran obat, informasi pembatasan resep, tabel rekonstitusi untuk pemberian intravena; MIMS; aplikasi Medscape di nurse station atau di poli.	Map informasi obat, MIMS, aplikasi Medscape sudah tersedia di unit pelayanan
Obat Tertinggal Yang Tidak Diambil Pasien	Data obat tertinggal yang tidak diambil pasien bulan Februari 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Januari 2025, dengan total resep yang di retur yaitu bulan Januari 2025 sebanyak 50 dan bulan Februari 2025 sebanyak 34. Hal ini disebabkan beberapa pasien tidak mengetahui mendapatkan resep sehingga obat ditinggal dalam waktu 3x24 jam dan keterlambatan penyiapan obat sehingga waktu tunggu obat lama.	Terdapat program pengantaran obat gratis melalui Primantara sehingga mengurangi jumlah obat tertinggal.

1.2.1.11 Tabel Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada
Desember 2024 - Februari 2025

NO	TANGGAL	NAMA OBAT	GOLONGAN OBAT	DISTRIBUTOR	TINDAK LANJUT
DESEMBER 2024					
1.	1/12/2024 – 31/12/2024	Haloperidol tab 5 mg - Yarindo	Anti psikosis	PT. Parit Padang Global PT. Kebayoran Pharma	Substitusi ke Haloperidol tab 0.5 mg
2.	1/12/2024 – 31/12/2024	Methylegometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg
3.	1/12/2024 – 31/12/2024	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
4.	1/12/2024- 23/12/2024	Spironolakton tab 25 mg	Diuretik	PT. Anugrah Argon Medica	Tanpa saran substitusi
5.	6/12/2024- 29/12/2024	Spironolakton tab 100 mg	Diuretik	PT. Anugrah Argon Medica	Tanpa saran substitusi
Total prosentase Desember 2024 = 0.43%					

JANUARI 2025					
1.	1/1/2025-31/1/2025	Haloperidol tab 5 mg - Yarindo	Anti psikosis	PT. Parit Padang Global PT. Kebayoran Pharma	Substitusi ke Haloperidol tab 0.5 mg
2.	1/1/2025-31/1/2025	Methylergometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg
3.	1/1/2025-31/1/2025	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
4.	1/1/2025-31/1/2025	Spironolakton tab 25 mg	Diuretik	PT. Anugrah Argon Medica	Tanpa saran substitusi
5.	1/1/2025-31/1/2025	Spironolakton tab 100 mg	Diuretik	PT. Anugrah Argon Medica	Tanpa saran substitusi
6.	4/1/2025-15/1/2025	Gliquidone tab 30 mg	Antidiabetes	PT. Anugrah Argon Medica	Substitusi dengan golongan Antidiabetes Oral lain
Total Prosentase Desember 2024 = 0.43%					
FEBRUARI 2025					
1.	1/2/2025-28/2/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2.	1/2/2025-28/2/2025	Spironolakton tab 100 mg	Diuretik	PT. Anugrah Argon Medica	Substitusi ke Spironolakton tab 25 mg
3.	1/2/2025-28/2/2025	Orezinc syr 60 ml	Obat untuk diare	PT. Antar Mitra Sembada	Zincpro syr 60 ml
4.	1/2/2025-28/2/2025	Quetvell tab 200 mg	Anti psikosis	PT. Antar Mitra Sembada	Soroquin tab 200 m
5.	1/2/2025-28/2/2025	Haloperidol tab 5 mg - Yarindo	Anti psikosis	PT. Parit Padang Global PT. Kebayoran Pharma	Substitusi ke Haloperidol tab 0.5 mg
6.	1/2/2025-28/2/2025	Methylergometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg
7.	1/2/2025-28/2/2025	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
8.	1/2/2025-28/2/2025	Gliquidone tab 30 mg	Antidiabetes	PT. Anugrah Argon Medica	Substitusi dengan golongan Antidiabetes Oral lain
Total prosentase Februari 2025 = 0.68%					

1.2.1.12 Grafik Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada
 Bulan Desember 2024 - Januari 2025



Analisis :

1. Hasil monitoring ketersediaan obat selama 3 bulan ditemukan masih sering terjadi kekosongan di distributor karena kekurangan bahan baku, delisting produk (pabrik tidak produksi), stok di distributor habis, kekosongan produk originator seperti Haloperidol tab 5 mg – Yarindo dan Itraconazole caps 100 mg sehingga tidak tersedia di pabrik lain dengan kandungan yang sama.
2. RS belum bisa melakukan pembelian lewat e-purchasing sehingga belum bisa order obat fast moving khusus obat kronis.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Evaluasi mutu perjanjian kerjasama dengan distributor untuk memberikan konfirmasi apabila stok barang tidak tersedia di distributor setelah menerima pesanan dari RS.
2. Mencari substitusi obat lain yang isi/ kandungannya sama.
3. Evaluasi stok minimal depo farmasi dan Gudang farmasi serta alur pengadaan.
4. RS sudah mempunyai akun e-purchasing dan koordinasi dengan pengadaan terkait e-purchasing.
5. Memberitahukan info kekosongan obat di distributor ke DPJP melalui surat edaran beserta saran substitusi.

1.2.1.13 Tabel Pemusnahan Obat, BMHP/ Alat Kesehatan Rusak (Substandar), dan Recall Bulan Februari 2025

NO	KEGIATAN	NAMA OBAT/ BMHP/ ALAT KESEHATAN	JUMLAH	ALASAN	KETERANGAN
1.	Pemusnahan	-	-	-	Tidak ada pemusnahan obat
2.	BMHP/Alat Kesehatan Rusak (Substandar)	Harum Pen (Couter Pencil) - Medmax	Semua stok yang tersedia	1. Jika dipakai mengeluarkan bau tak sedap (asumsi dpjp dari cat birunya) 2. Jika dipakai coagulasi lewat alat harus menggunakan bagian ujung (tapi mengeluarkan percikan api), jika menggunakan bagian tengah tidak bisa 3. Risiko menimbulkan luka bakar pada pasien	Form keluhan alat kesehatan substandard dari IGD dilaporkan tanggal 01/02/2025 sudah diajukan ke Pengadaan PT. DPM namun belum ada tindak lanjut penggantian produk
3.	Recall	-	-	-	Tidak ada recall

3.2.1.14 Tabel Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Farmasi Pada Bulan Februari 2025

NO	MONITORING DAN EVALUASI	HASIL	TINDAK LANJUT
1.	Perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP	Perencanaan dilakukan dengan metode konsumsi dan pengadaan sediaan farmasi dan BMHP dengan pembelian, repacking dan donasi/ hibah Evaluasi terhadap perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP digudang farmasi menggunakan sistem ROP dan Non ROP farmasi di SIMRS, dikarenakan sistem ROP belum mendeteksi penjualan obat slow moving namun tetap harus disediakan jadi petugas mendata obat menipis secara manual kemudian diinput Non ROP farmasi	Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP menggunakan sistem ROP di gudang farmasi.
2.	Pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP ke distributor	Tersedia PKS dengan distributor; Semua pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, termasuk obat vaksin harus menjamin garansi keaslian yakni : a. Sediaan farmasi - No.Ijin Edar dari BPOM b. Alkes - No.Ijin Edar dari Dirjen Binfar dan CoA c. BMHP - No ijin edar dari Binfar d. B3 - MSDS; Kunjungan ke distributor; Surat Pesanan obat, alkes, dan BMHP di tandatangan oleh APJ	Monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP
3.	Pemantauan suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin	Form monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin sudah tersedia namun petugas masih tidak rutin mengisi.	Monitoring dan evaluasi pengisian monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin di depo dan gudang farmasi oleh apoteker setiap hari
4.	Supervisi box emergency, trolley emergency, kit emergency, box HPP dan Eklamsi	Pengecekan obat yang mendekati ED (<i>expired date</i>) 6 bulan segera diganti dilakukan tiap 3 bulan sekali. Bedah box triwulan 1 pada bulan januari 2025 sudah dilakukan. Berikut temuan obat yang mendekati ED 6 bulan dan diganti dengan ED jauh yaitu : - Box emergency poli lantai 1 : penggantian obat near Ed dexamethason injeksi (ed : 8/25 → 6/26), valisanbe injeksi (ed 8/25 → 7/26) - Box emergency poli treadmill : manitol infus (5/25 → 6/26), na phenytoin injeksi (ed 7/25 → 9/27), dexamethason injeksi (ed : 8/25 → 6/26) - Box emergency poli lantai 2 : tidak ada obat ED < 6 bulan - Trolley emergency IGD : dobutamin injeksi (7/25 → 9/27, infus gelafusal (ec 5/25 → 3/27), manitol infus (5/25 → 1/26), na phenytoin injeksi (ed 7/25 → 7/26) - Box emergency infant Ponak IGD : gelafusal infus (ed 5/25 → 3/27) - Box HPP - Eklamsi tidak ada obat near ED - Kit emergency IGD : infusion set dewasa (ED 6/25 → 10/29), dexamethason injeksi (ED 5/25 → 5/26) - Box emergency ambulance 1 : amiodarone inj (ED 5/25 → 6/26), dexamethasone inj (ED 6/25 → 6/26), miniaspi (ED 5/25 → 3/27), phinev inj (ED 7/25 → 7/27), cairan NS 0.9 500 ml (ED 6/25 → 10/26) - Box emergency ambulance 2 : cairan NS 0.9% 500 ml (ED 6/25 → 10/26), infusion set dewasa (ED	Dilakukan supervisi oleh apoteker terhadap penyimpanan obat <i>emergency</i> dan segera diganti apabila dipakai, kedaluwarsa, atau rusak. Pelaksanaan supervisi dilakukan sebagai berikut : a. Pengecekan segel, pengecekan kedaluwarsa di list daftar obat dan pengecekan suhu penyimpanan dilakukan setiap hari. b. Pengecekan jumlah dan dipakai dilakukan saat segel terbuka. c. Pengecekan obat yang mendekati ED (<i>expired date</i>) 6 bulan segera diganti dilakukan tiap 3 bulan sekali untuk mencegah kedaluwarsa saat dibutuhkan.

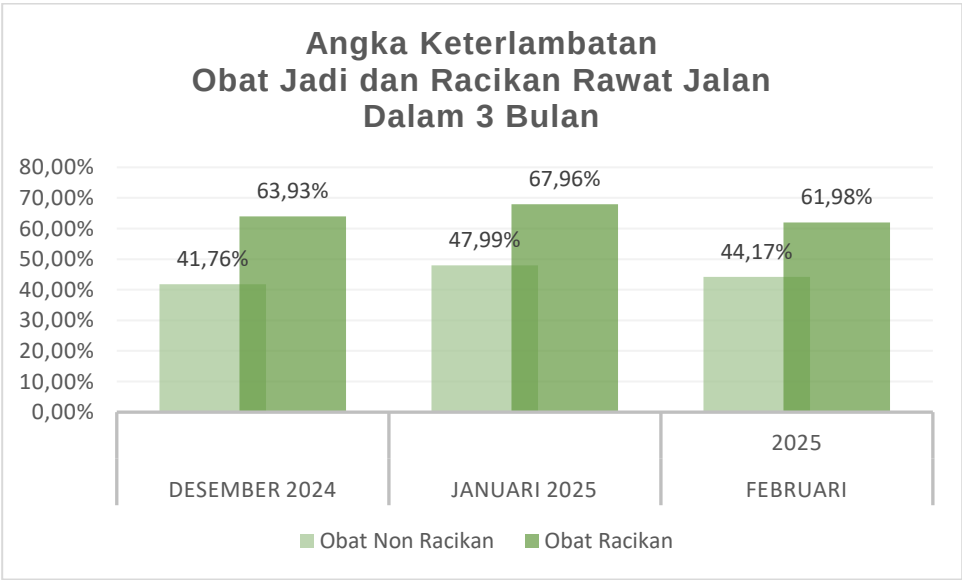
		5/25 → 10/29), iv canul 20 (ED 6/25 → 6/29), iv canul 22 (ED 6/25 → 6/28) - Box HPP-Eklamsi set IKO : As. Tranexamat (3/26 → 10/26), Misoprostol (11/25 → 3/26), Kondom (3/26 → 12/26), Cairan WFI (5/26 → 9/26), Calcii gluconas (4/26 → 3/27), MgSO4 20 % (6/25 → 9/26), MgSO4 40% (5/25 → 11/26), Jarum no. 23 (8/26 → 11/27) - Box emergency infant dan trolley emergency IKO: tidak ada obat ED < 6 bulan - Box emergency 2C : Amiodarone (9/25 → 6/26) dexametasone (5/25 → 6/26), Dopamine (9/25 → 9/26), valisanbe (3/25 → 6/26), Infus D5% (7/25 → 11/26) Infus gelafusal (6/25 → 4/27) - Box emergency ICU Ventilator : Dexametasone (5/25 → 6/26), Norepinephrine (6/25 → 4/26). Box emergency ICU : Amiodarone (11/25 → 5/26), Dopamine (9/25 → 9/26), Phenytoine (7/25 → 9/27), Infus D5% (7/25 → 11/26) - Box emergency HCU : Amiodarone (8/25 → 6/26), Dopamine (9/25 → 9/26), Infus D5% (7/25 → 11/26), Spuit 1cc (8/25 → 5/29) - Box emergency 3C : Amiodarone (8/25 → 6/26), Dopamine (9/25 → 2/26), furosemide (9/25 → 6/26), infus D5% (7/25 → 11/26), Iv cannula no. 20 (10/25 → 6/26) - Box emergency 3A : Amiodarone (9/25 → 6/26), Dexametasone (8/25 → 6/26), Dobutamine (8/25 → 11/27), Furosemide (9/25 → 6/26), Na phenytoin (7/25 → 9/27), Dopamine (9/25 → 2/26), Infus D5% (9/25 → 11/26), Clopidogrel (12/25 → 10/26) - Box emergency 4A : Dobutamin (10/25 → 11/27), Dopamine (11/25 → 9/26), Dexametasone (6/25 → 6/26), Furosemide (9/25 → 6/26), Manitol (9/25 → 6/26) - Box emergency Maternitas : tidak ada obat ED < 6 bulan - Trolley emergency Maternitas : Spuit 3 cc (10/25 → 6/29), Blood set (8/25 → 7/29), Spuit 20 cc (7/25 → 10/29), Oxyflow dewasa (10/25 → 11/29) - Box emergency PICU : ISDN (5/25 → 8/26), Ephineprine (10/25 → 8/26), Dexametasone (8/25 → 6/26), suction cath no. 8 (10/25 → 2/28) - Box emergency 5C : Infus D5 (9/25 → 11/26), infus gelafusal (9/25 → 4/27), amiodarone (11/25 → 6/26), clopidogrel (11/25 → 10/26), dexamethasone (10/25 → 6/26), dopamin (4/26 → 9/26), ephineprine (8/25 → 7/27), na. phenytoin (7/25 → 9/27), furosemide (9/25 → 6/26), atropine sulfate (11/26 → 4/27), manitol (1/26 → 6/26) - Box emergency 6A : Infus D5% (7/25 → 11/26), Manitol (5/25 → 1/26), Dexametasone (6/25 → 6/26) - Box emergency 7A : Dexametasone (6/25 → 6/26), atropin sulfate (11/25 → 4/27), Infus D5% (8/25 → 11/26) - Box emergency 8A : ephinephrine (8/25 → 7/27), spuit 10 cc terumo (10/25 → 6/29), spuit 3 cc terumo (10/25 → 6/29) - Radiologi : Amiodaron (8/25 → 6/26), Aspilet (11/25 → 8/26), Atropin (11/26 → 4/27), Clopidogrel (2/26 → 10/26), Dexametason	
--	--	--	--

		(10/25 → 6/26), Dopamine (9/25 → 9/26), Furosemide (9/25 → 6/26), Infus D5% (9/25 → 11/26), Manitol (1/26 → 6/26), Na phehytoin inj (1/26 → 9/27), Valisanbe Inj (12/25 → 6/26), IV cannula no. 22 (1/26 → 1/29)	
5.	Kartu stok obat	Kepatuhan penulisan kartu stok 70% di depo farmasi, petugas masih merapel pengeluaran kartu stok dan belum menulis sisa stok. Kepatuhan penulisan kartu stok 100% di gudang farmasi.	a) Supervisi petugas farmasi dalam melakukan pelayanan (barang masuk dan keluar) dengan tetap menuliskan pada kartu stok b) Petugas lebih teliti ketika menghitung pemasukan atau pengeluaran.
6	Penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3)	Penyimpanan bahan berbahaya dan beracun di ruangan terpisah dan didalam lemari B3 tersedia APAR dan diberi label B3 sesuai sifat dan risiko bahan.	Monitoring dan evaluasi terhadap penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3)
7	Penyimpanan produk steril di unit	Masih ditemukan poli melakukan penyimpanan NS 0.9% 500 ml sisa untuk rawat luka dan digunakan kembali besok hari (1x24 jam) sehingga melewati batas BUD.	Supervisi secara berkala dan edukasi ke perawat BUD produk steril tidak boleh lebih dari 3 jam
8	Pelaksanaan double check untuk pemberian obat high alert	Bulan februari 2025 terjadi perubahan sistem dari distribusi UDD (<i>Unit Dose Dispensing</i>) ke ODD (<i>One Daily Dose</i>) dimana double check obat high alert dengan mengisi daftar tilik serah terima obat farmasi - rawat inap sudah ditiadakan. Serah terima obat menggunakan lembar serah terima obat pasien, resep dan daftar pemberian obat (DPO) antar farmasi dan perawat. Double check dilakukan oleh farmasi sebelum distribusi obat. Tidak ditemukan kejadian IKP.	Supervisi berkala

3.2.1.15 Tabel Angka Keterlambatan Obat Jadi dan Racikan Bulan Desember 2024 – Februari 2025

INDIKATOR	BULAN		
	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025
Penyiapan Obat Jadi Rawat Jalan > 30 menit	41.76%	47.99%	44.17%
Penyiapan Obat Racikan > 60 menit	63.93%	67.96%	61.98%

3.2.1.16 Grafik Angka Keterlambatan Obat Jadi dan Racikan Bulan Desember 2024 – Februari 2025



Analisis :

Waktu tunggu obat rawat jalan pada bulan Februari 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Januari 2025. Namun prosentasi tersebut masih jauh dari target (20%) dikarenakan libur tanggal merah dan poli tutup sehingga menyebabkan penumpukan kunjungan pasien pada saat hari aktif, kunjungan pasien yang tidak dibatasi sehingga terjadi penumpukan resep di jam-jam tertentu.

Rencana Tindak Lanjut:

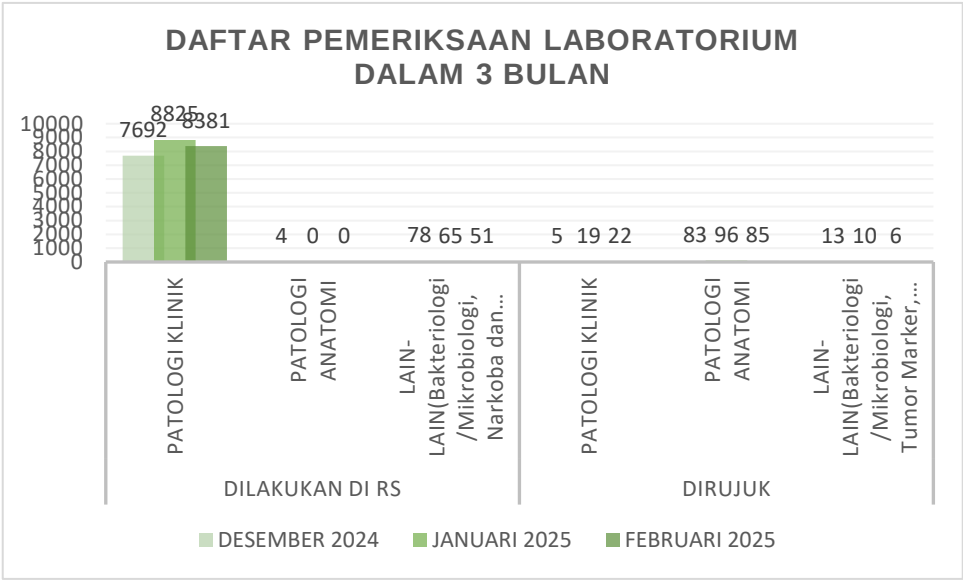
- 1. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi dalam klik obat selesai maupun ambil obat, sehingga petugas farmasi diharapkan *real time* dalam pelaksanaannya.
- 2. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terkait alur pemberian obat kepada pasien, bahwa harus dihindari terjadi penumpukan obat yang telah siap diberikan.
- 3. Terdapat program pengantaran obat melalui Primantara sehingga mengurangi antrian pasien menunggu obat.
- 4. Petugas input dibagi menjadi resep kronis dan resep non kronis oleh TTK, resep iter dan PRB oleh Apoteker.

1.2.2 Laboratorium

1.2.2.11Tabel Daftar Pemeriksaan Laboratorium yang Dilakukan Didalam dan Diluar Desember 2024 – Februari 2025

No	Jenis Pemeriksaan	Bulan		
		Desember 2024	Januari 2025	Februari 2025
Dilakukan di Rumah Sakit				
1.	Patologi Klinik			
	Kimia darah	4673	4910	4940
	Hematologi	2058	2825	2520
	Serologi dan Molekuler	540	666	533
	Urine	403	415	383
	Liquor	-	-	-
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Feses	18	9	5
Total		7692	8825	8381
2.	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	4	0	0
	Pemeriksaan Histopatologi	0	0	0
Total		4	0	0
3.	Lain-lain			
	Bakteriologi/Mikrobiologi	51	50	37
	Narkoba	19	8	11
	Covid-19	8	7	3
Total		78	65	51
Dilakukan di Luar Rumah Sakit (Dirujuk)				
1.	Patologi Klinik			
	Kimia darah	1	0	1
	Hematologi	0	4	7
	Serologi dan Molekuler	4	15	14
	Urine	0	0	0
	Liquor	-	-	-
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Feses	0	0	0
Total		5	19	22
2.	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	4	8	10
	Pemeriksaan Histopatologi	79	88	75
Total		83	96	85
3.	Lain-lain			
	Bakteriologi/Mikrobiologi	13	9	6
	PCR	0	0	0
	Tumor Marker	0	1	0
	Cholinesterase	0	0	0
Total		13	10	6

1.2.2.12 Grafik Pemeriksaan Didalam Rumah Sakit Bulan Desember 2024 – Februari 2025



Analisis :

- Permintaan pemeriksaan laboratorium pada Bulan Februari 2025 mengalami penurunan, yaitu sebesar 8381 pemeriksaan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh penurunan jumlah kunjungan laboratorium, salah satunya adalah kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan juga mengalami penurunan.
- Angka rujukan pemeriksaan patologi anatomi di Laboratorium luar masih mendominasi diantara pemeriksaan lainnya dalam 3 bulan terakhir, yaitu :
 - Patologi Anatomi = 264 sampel
 - Patologi Klinik = 46 sampel
 - Lain-lain = 29 sampel
- Angka rujukan pemeriksaan patologi anatomi pada dalam 3 bulan terakhir mencapai 254 pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena Rumah Sakit belum memiliki Laboratorium Patologi Anatomi, ditunjang dengan meningkatnya jumlah tindakan excise yang membutuhkan pemeriksaan penunjang (PA) untuk kebutuhan klaim.
- Hasil pemeriksaan PA masih mengalami keterlambatan, hal ini disebabkan karena adanya tindakan potong ulang dari hasil yang mengarah atau curiga keganasan.
- Angka rujukan pemeriksaan patologi klinik pada Bulan Februari 2025 mengalami peningkatan sebesar 22 pemeriksaan, yaitu antara lain pemeriksaan Resikulosit, D Dimer, ANA Test, Serum Iron, TIBC, Gamma GT, Hbe Ag, Ig G/M Anti Dengue, NS One Dengue, IgM CMV, Anti HCV, TPHA, IgM Toxoplasma, IgM Rubella dan ASTO. Rumah Sakit tidak melakukan pengadaan alat dan reagen karena permintaan hanya sedikit.

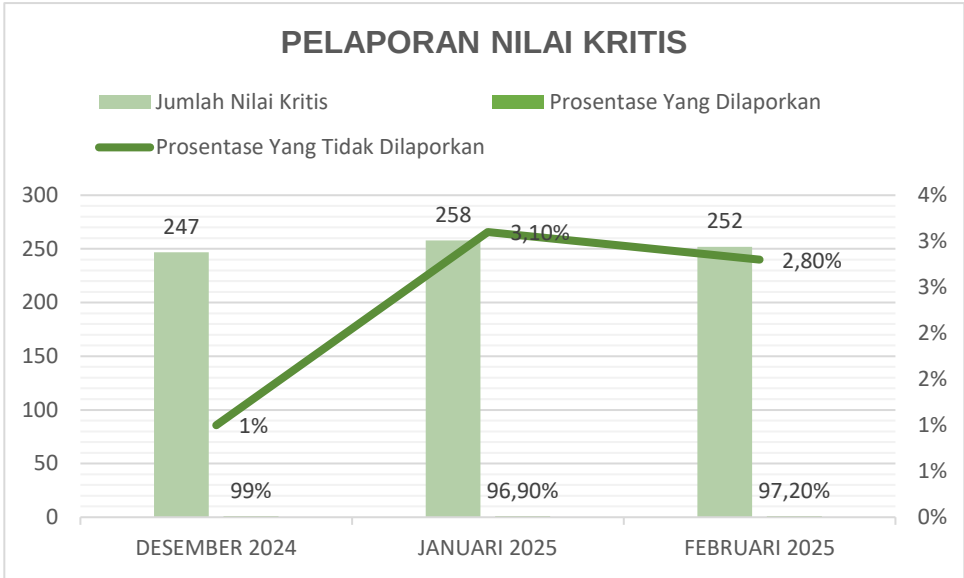
Rencana Tindak Lanjut :

- Proses pengembangan pelayanan dengan menggunakan LIS.
- Perbaikan serah terima hasil laboratorium menggunakan system digital.
- Melakukan pencatatan keluar masuk stok reagen pada kartu stok dan dilakukan SO.
- Follow up pengadaan reagen yang lama kosong.
- Mengajukan pengadaan Laboratorium PA di RS Prima Husada Malang.
- Membuat kesepakatan batas akhir bacaan hasil PA dan follow up secara berkala kepada Dokter Penanggungjawab Patologi Anatomi.

1.2.2.13 Pelaporan Nilai Kritis

NO	BULAN	JUMLAH NILAI KRITIS	PROSENTASE YANG DILAPORKAN	PROSENTASE YANG TIDAK DILAPORKAN
1.	Desember 2024	247	99%	1%
2.	Januari 2025	258	96,9%	3,1%
3.	Februari 2025	252	97,2%	2,8%

1.2.2.14 Grafik Pelaporan Nilai Kritis



Analisis :

Pelaporan nilai kritis pada Bulan Februari 2025 mencapai 97.20%, prosentase yang tidak dilaporkan mengalami penurunan sebesar 2.80%.
Meskipun mengalami perbaikan, masih ditemukan pelaporan nilai kritis yang tidak dilaporkan, hal ini disebabkan oleh kelalaian petugas saat malam hari, pelaporan nilai kritis sudah dilakukan <5menit tetapi petugas tidak melakukan dokumentasi pada buku pelaporan.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Supervisi berkala dilakukan oleh Karu dan Kabid Penunjang Medis
- 2. Kolaborasi dengan Kabid Keperawatan dan Kabid Pelayanan Medis terkait pelaporan complain DPJP terhadap keterlambatan pelaporan nilai kritis.
- 3. Kolaborasi dengan SDM terkait kedisiplinan petugas dalam melakukan pekerjaan.

3.1.1.5 Tabel Pelaporan Kerusakan Sampel pada Bulan Februari 2025

No	Nama pasien	No RM	Tanggal Pengambilan sampel	Unit Asal	Sampel yang diterima
Bulan Januari 2025					
1.	Durasid	205115	02/01/2025	IGD	DL Clothing
2.	Mori	224882	01/01/2025	IGD	DL Clothing
3.	Ervan W	161868	01/01/2025	IRNA 4A	SE Rusak
4.	Christian	161417	08/01/2025	IGD	DL Clothing
5.	By Ny Nuri	225528	13/01/2025	Neonatologi	Sampel Kurang
6.	Eritri	208429	13/01/2025	IRNA 6A	DL Clothing
7.	Olga S	149217	17/01/2025	IGD	DL Clothing
8.	Setiani	213248	22/01/2025	ICU	Lisis
9.	Atim	064323	22/01/2023	IRNA 6A	DL Clothing
Bulan Febaruari 2025					
Tidak ada					

Analisis :

Pada Bulan Februari 2025 tidak ditemukan sampel rusak, sudah ada sosialisasi oleh Kabid Keperawatan saat Rapat Unit Bulanan saat melakukan sampling darah, kebutuhan dan prosedur penyimpanan sampai dengan pengiriman sampel ke laboratorium.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Monitoring dan Evaluasi.
- 2. Memberikan pemahaman bahwa pengambilan sampel sesuai dengan batas garis indicator.
- 3. Kolaborasi dengan Kabid Keperawatan terkait training prosedur pengambilan darah, penyimpanan dan pengiriman sampel.
- 4. Supervisi ED reagen.

3.1.1.6 Tabel Pelayanan BDRS Bulan Desember 2024 – Februari2025

Bulan	Permintaan Labu Darah				Total	Return Labu Darah				Total
	A	B	O	AB		A	B	O	AB	
Desember 2024	13	9	21	21	64					
Januari 2025	24	1	31	25	81	-	3	-	9	12
Februari 2025	17	6	20	18	61	2	-	-	-	2

3.1.1.7 Tabel Hasil Incompatible pada Crossmatch pada Bulan Februari 2025

No	Nama Pasien	Jumlah pasien dan permintaan labu darah Incompatible				Total Permintaan Labu darah
		A	AB	O	B	
Bulan Januari 2025						
1.	Ayu Rahmalia	√				1 Labu
2.	Dursaid				√	2 Labu
3.	Pi'i			√		2 Labu
Bulan Februari 2025						
1.	Sukarno			√		1 Labu
2.	Luke Kurnia			√		3 Labu

Analisis :

- 1. Permintaan labu darah Pada Bulan Februari 2025 mengalami penurunan, hal ini disebabkan jumlah kunjungan pasien rawat inap menurun.
- 2. Masih ditemukan return labu darah ke PMI sebanyak 2 labu, mengalami penurunan karena petugas rutin melakukan penulisan kartu control dan order labu darah terjadwal.
- 3. Masih ditemukan hasil incompatible pada crossmatch pada Bulan Februari 2025 sebanyak 2 pasien.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mengurangi stok maksimum labu darah dengan permintaan jarang.
- 2. Mengirimkan analis untuk magang di PMI selama 2 minggu secara bergantian, biaya free.
- 3. Melakukan penertiban penulisan kartu stok labu darah secara real time, pelaksanaan SO dilakukan setiap akhir bulan.
- 4. Sampel darah dikirim ke UTD terdekat, karena UTD yang bisa mengeluarkan surat keterangan hasil crossmatch incompatible ke DPJP.

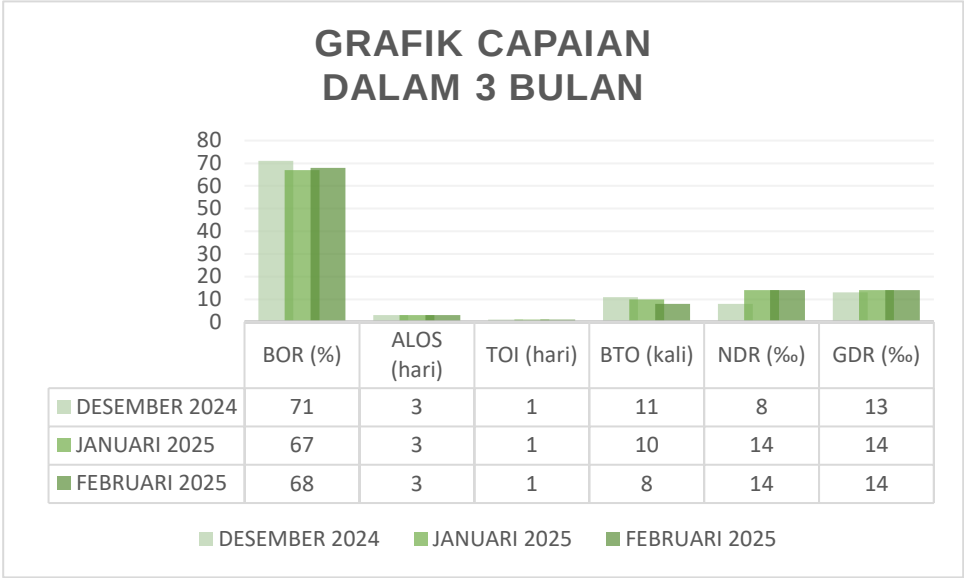
3.2.3 Rekam Medis – Pendaftaran

3.1.1.1 Tabel Kinerja Unit Rawat Inap Bulan Februari 2025

Indikator	Rumus	Data	Standar Depkes	Bulan	Unit												Total
					2C	3A	3C	4Ab	5C	6A	7A	8A	MTS	NICU	HCU	ICU	
BOR (Bed Occupancy Rate) “Prosesntase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu”	$(\sum HP / (\sum TT \times \text{jumlah hari dalam satu periode})) \times 100$	Jumlah hari perawatan, jumlah TT, jumlah hari dalam satu periode	60-80 %	Desember 2024	70	54	82	60	56	69	70	64	43	2	25	25	71%
				Januari 2025	62	57	71	50	53	68	65	53	70	32	27	42	67%
				Februari 2025	72	68	80	62	57	78	82	68	65	24	29	30	68%
ALOS (Average Length of Stay) “Rata-rata lama rawat seorang pasien”	$LD / \sum px \text{ keluar } (H+M)$	Jumlah lama dirawat, jumlah pasien keluar	6-9 hari	Desember 2024	4	2	3	3	3	4	3	3	3	2	0	2	3hari
				Januari 2025	4	3	3	3	4	4	4	1	3	3	2	2	3hari
				Februari 2025	4	2	3	3	3	4	3	3	3	2	0	2	3 hari
TOI (Turn Over Interval) “Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati”	$((\sum TT \times \sum \text{hari}) - HP) / \sum \text{pasien keluar } (H+M)$	Jumlah tempat tidur, hari perawatan, pasien keluar	1-3 hari	Desember 2024	1	2	1	1	2	1	1	1	2	92	0	4	1hari
				Januari 2025	2	2	1	2	2	1	1	2	1	4	3	2	1hari
				Februari 2025	1	1	1	1	2	1	1	1	1	5	3	4	1 hari
BTO (Bed Turn Over) “Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode”	$\sum Px \text{ keluar } (H+M) / \sum TT$	Jumlah pasien, Jumlah TT	4-5 kali (dalam hitungan bulan)	Desember 2024	8	9	13	9	8	10	10	9	8	0	0	5	11kali
				Januari 2025	8	8	10	8	7	9	9	8	12	6	8	8	10kali
				Februari 2025	7	8	8	8	7	8	8	8	8	4	7	5	8kali

NDR (Net Death Rate) “Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit”	$(\sum Px \text{ Mati} > 48 \text{ jam}) / \sum Px \text{ keluar (H+M)} \times 1000\%$	Jumlah pasien meninggal >48jam, jumlah pasien keluar	<25 ‰	Desember 2024	0	0	0	0	0	17	0	9	0	0	0	95	8‰
				Januari 2025	0	0	0	16	29	0	10	11	0	0	0	179	14‰
				Februari 2025	0	0	0	8	10	0	21	11	0	12	133	235	14‰
GDR (Gross Death Rate) “Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit”	$(\sum Px \text{ mati} / \sum Px \text{ keluar (H+M)}) \times 1000\%$	Jumlah pasien keluar mati, jumlah pasien keluar	<45‰	Desember 2024	0	0	0	0	0	17	8	9	0	0	0	176	13‰
				Januari 2025	0	0	0	16	29	0	10	11	0	0	0	179	14‰
				Februari 2025	0	0	0	8	10	0	21	11	0	12	133	235	14‰

3.1.1.2 Grafik Kinerja Unit Rawat Inap Bulan Februari 2025



Analisis :
Berdasarkan hasil perhitungan statistik rumah sakit pada Bulan Februari Tahun 2025, kinerja RSPHM didapatkan hasil nilai indikator:

1. BOR sebesar 68% (standar : 60-85%) sesuai standar.
2. LOS sebesar 3 hari sesuai dengan standard RSPHM terkait SE dari PT.DPM khusus pasien BPJS (standar pasien umum : 6-12 hari)
3. TOI sebesar 1 hari (standar : 1-3 hari)
4. BTO sebesar 8 kali (standar : 4-5 kali)

BOR Bulan Februari Tahun 2025 di bandingkan dengan Bulan Januari Tahun 2025 mengalami kenaikan. BOR tersebut menjadi bukti bahwa penggunaan tempat tidur di Bulan Februari sudah standar. Hal tersebut menandakan bahwa penggunaan tempat tidur sudah efisien dari segi ekonomi menghasilkan pemasukan bagi rumah sakit.

Masalah :
Indikator TOI, LOS dan BTO belum memenuhi standar, terkait TOI sebesar 0.50 hari menandakan bahwa waktu tempat tidur tidak tersisa sangat pendek, ini bisa menjadi salah satu faktor nosocomial, begitupun dengan beban kerja perawat yang cukup tinggi.
Terkait LOS yang belum memenuhi standar (standard lama belum berubah tidak sesuai peraturan baru). Standard saat ini sesuai dengan ketentuan BPJS yang mengacu juga pada PPK-CP masing-masing kasus/penyakit. Hal ini menunjukkan adanya kualitas pelayanan yang baik serta adanya kendali mutu dan kendali biaya sehingga lama perawatan pasien lebih cepat. Sedangkan BTO standar tersebut digunakan untuk satu tahun penuh, angka 10 mencerminkan bahwa 1 tempat tidur bisa digunakan 10 kali perawatan dalam sebulan.

Rencana Tindak Lanjut :
Meningkatkan kualitas pelayanan di rawat inap dan menjalankan sasaran keselamatan pasien agar mutu pelayanan tetap sesuai standar

3.1.1.3 Tabel Diagnosa Terbanyak Bulan Februari 2025

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	E11.9	DM Tanpa komplikasi / Without complications	412
2.	I25.9	Chronic ischemic heart disease, unspecified	333
3.	I51.9	Decomp Cordis/Heart Disease, unspecified	333
4.	I69.3	Sequelae of cerebral infarction	315
5.	I11.9	HHD / Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	260
6.	J44.9	COPD / Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified	217
7.	M17.9	Gonarthrosis, unspecified	195
8.	J47	Bronchiectasis	184
9.	R50.9	Febris / Fever, unspecified (Observasi Febris)	175
10.	F41.2	Mixed anxiety and depressive disorder	167

3.1.1.4 Tabel Diagnosa Rawat Inap Bulan Februari 2025

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	A01.0	Typhoid Fever (TF)	200
2.	P24.9	Neonatus Cukup Bulan	74
3.	A90	Dengue Fever	66
4.	I63.9	Cerebro Vaskuler Accident	43
5.	J18.9	Pneumonia	34
6.	E11.9	Diabetes Mellitus Type 2	29
7.	E14.9	Diabetes Mellitus Hyperglikemia	19
8.	J18.0	Broncho Pneumonia	13
9.	I20.0	Neprolithiasis	13
10.	J96.0	Tumor Mammae	12

Analisis :

1. Diagnosa terbanyak di Rawat Jalan adalah DM tanpa komplikasi sebesar 412 kasus, sedangkan diagnose terbanyak di Rawat Inap adalah Typhoid Fever sebesar 200 kasus.
2. Tarikan data diagnose rawat inap diambil dari hasil analisa pada resume medis saat pasien pulang, yaitu pada diagnose utama yang ditulis oleh DPJP. Sedangkan tarikan data diagnose rawat jalan diambil dari SIMRS.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan analisa pada resume medis saat pasien pulang berdasarkan diagnose sekunder.

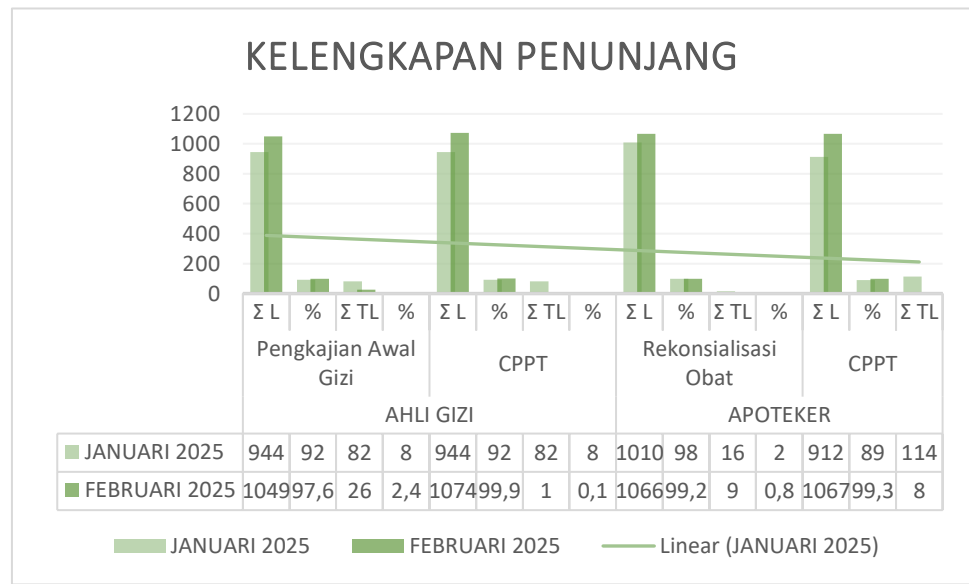
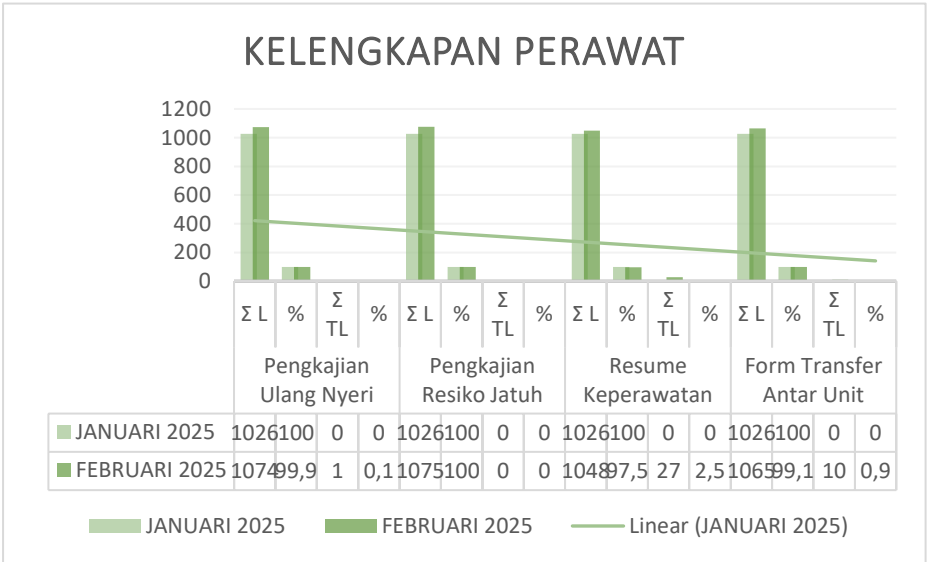
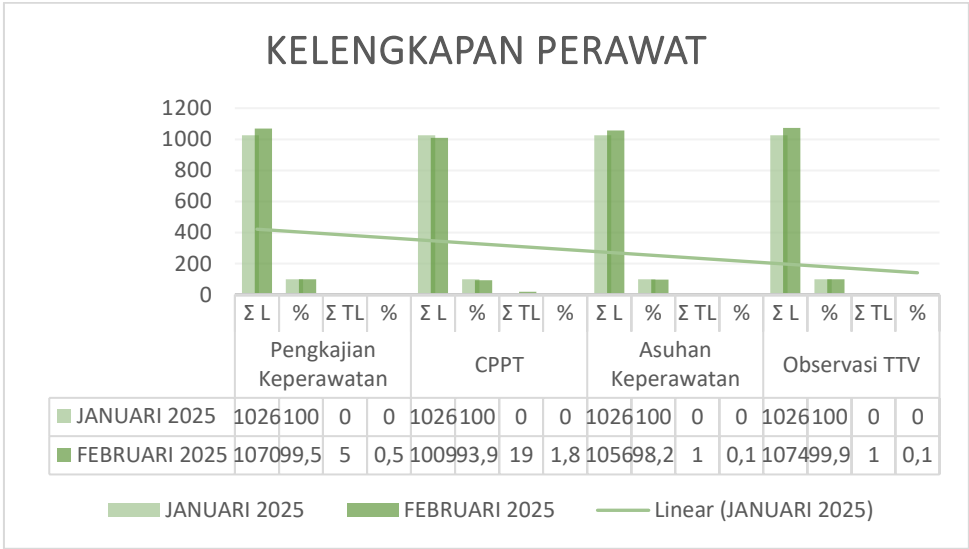
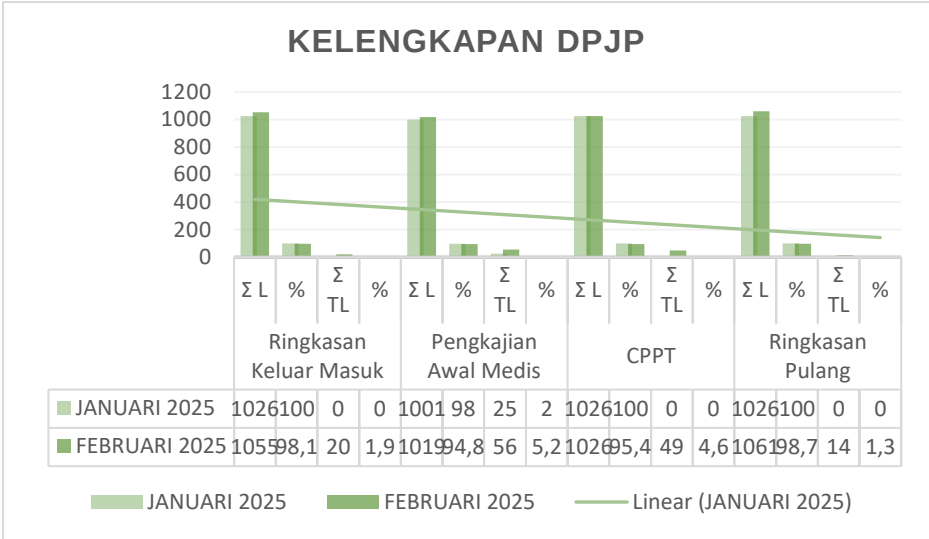
3.1.1.5 Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Februari 2025

KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	1026	100	0	0	1001	98	25	2	1026	100	0	0	1026	100	0	0
Februari	1055	98.1	20	1.9	1019	94.8	56	5.2	1026	95.4	49	4.6	1061	98.7	14	1.3

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Observasi TTV			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	1026	100	0	0	1026	100	0	0	1026	100	0	0	1026	100	0	0
Februari	1070	99.5	5	0.5	1009	93.9	19	1.8	1056	98.2	1	0.1	1074	99.9	1	0.1
BULAN	Pengkajian Ulang Nyeri				Pengkajian Resiko Jatuh				Resume Keperawatan				Form Transfer Antar Unit			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	1026	100	0	0	1026	100	0	0	1026	100	0	0	1026	100	0	0
Februari	1074	99.9	1	0.1	1075	100	0	0	1048	97.5	27	2.5	1065	99.1	10	0.9

KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	944	92	82	8	944	92	82	8	1010	98	16	2	912	89	114	11
Februari	1049	97.6	26	2.4	1074	99.9	1	0.1	1066	99.2	9	0.8	1067	99.3	8	0.7

3.1.1.6 Grafik Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Februari Tahun 2025



Analisis :

Kelengkapan Keseluruhan :

Kelengkapan DRM rawat inap DPJP dan Perawat mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena perubahan alur analisa rekam medis, perawat melakukan setor terlebih dahulu ke petugas rekam medis sehingga data yang didapatkan valid.

Rencana Tindak Lanjut :

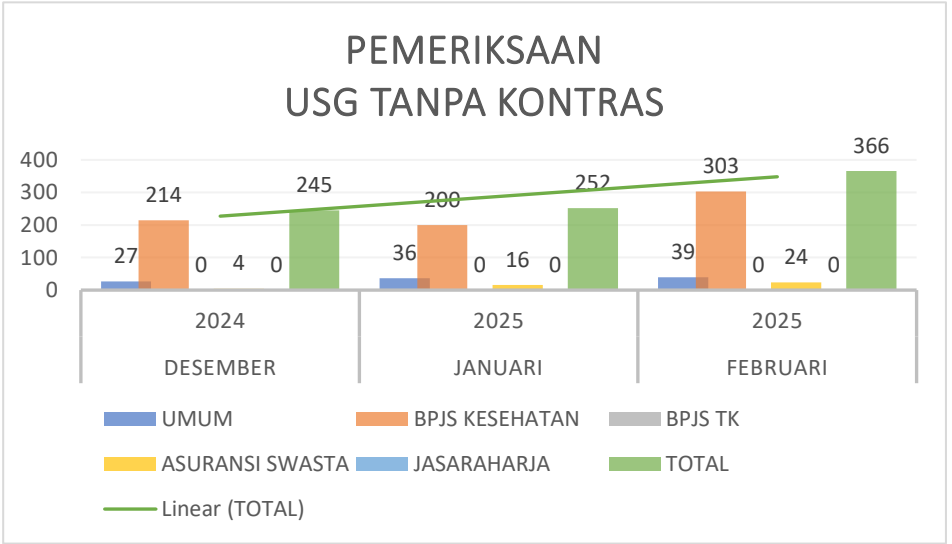
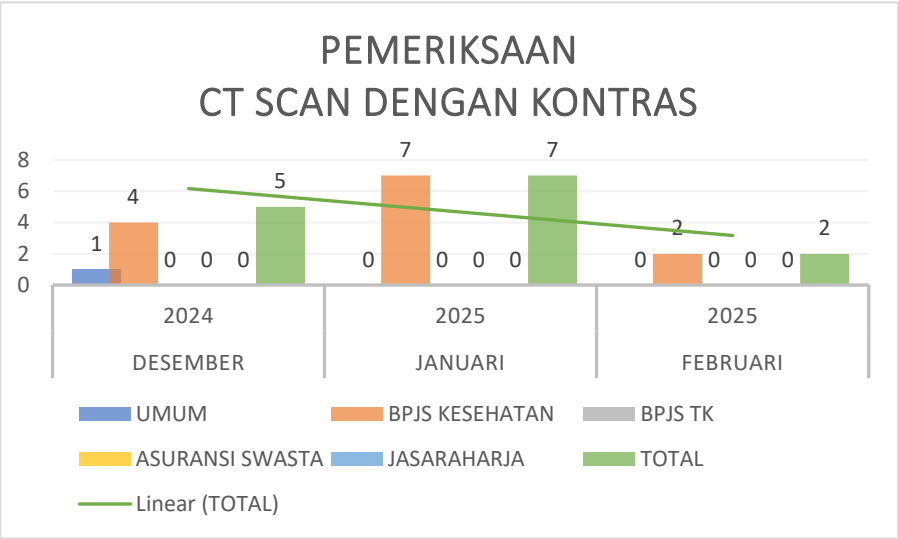
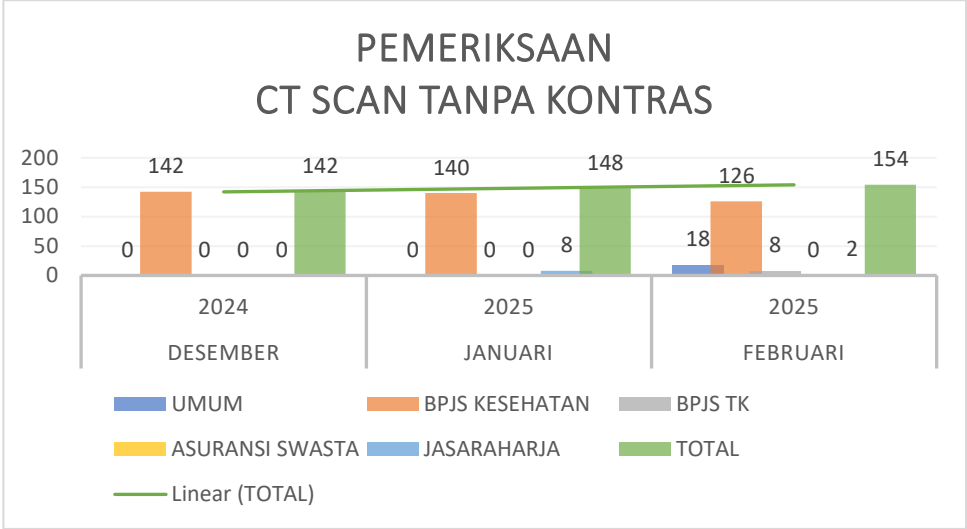
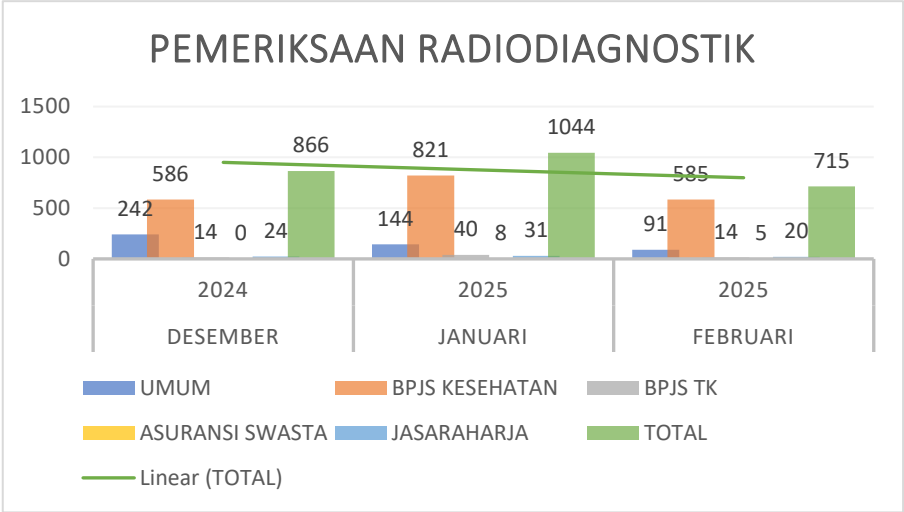
- 1. Menginformasikan kepada KARU hasil audit ketidaklengkapan DRM untuk melengkapi kekurangannya.
- 2. Melakukan supervise secara berkala.
- 3. Membuat rapot ketidaklengkapan dan kolaborasi dengan Kabid Keperawatan.

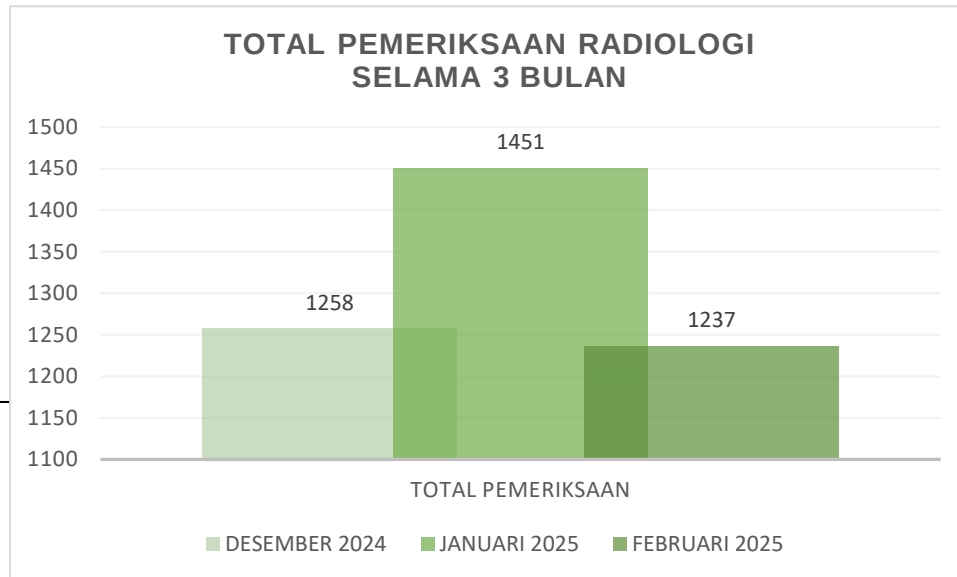
3.2.4 Radiologi

3.2.4.1 Tabel Jumlah Pemeriksaan Radiologi Desember 2024 – Februari 2025

NO	JENIS PEMERIKSAAN	PENJAMIN	BULAN		
			DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025
1.	RADIODIAGNOSTIK	UMUM	242	144	91
		BPJS KESEHATAN	586	821	585
		BPJS TK	14	40	14
		ASURANSI SWASTA	0	8	5
		JASARAHARJA	24	31	20
	TOTAL		866	1044	715
2.	CT SCAN TANPA KONTRAS	UMUM	0	0	18
		BPJS KESEHATAN	142	140	126
		BPJS TK	0	0	8
		ASURANSI SWASTA	0	0	0
		JASARAHARJA	0	8	2
	TOTAL		142	148	154
3.	CT SCAN DENGAN KONTRAS	UMUM	1	0	0
		BPJS KESEHATAN	4	7	2
		BPJS TK	0	0	0
		ASURANSI SWASTA	0	0	0
		JASARAHARJA	0	0	0
	TOTAL		5	7	2
4.	USG TANPA KONTRAS	UMUM	27	36	39
		BPJS KESEHATAN	214	200	303
		BPJS TK	0	0	0
		ASURANSI SWASTA	4	16	24
		JASARAHARJA	0	0	0
	TOTAL		245	252	366
TOTAL KESELURUHAN			1258	1451	1237

3.2.4.2 Grafik Jumlah Pemeriksaan Radiologi Desember 2024 – Februari 2025





Analisis :

1. Pelayanan pemeriksaan selama Bulan Februari 2025 meliputi Radiodiagnostik, USG dan CT Scan, terbagi menjadi pasien UMUM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Swasta dan Jasaraharja.

Pada Bulan Februari 2025 pemeriksaan terbanyak, yaitu :

- a. Radiodiagnostik : 715
- b. USG Tanpa Kontras : 366
- c. CT Scan Tanpa Kontras : 154

2. Produktivitas pemeriksaan radiodiagnostik mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya tambahan pasien MCU haji dan MCU Perusahaan/mandiri pada bulan sebelumnya.
3. Jumlah total pemeriksaan selama Bulan Februari 2025 adalah sebanyak 1237 pemeriksaan.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Koordinasi dengan Humas & Marketing untuk meningkatkan kunjungan di Radiologi dengan cara :
 - 1) Melakukan kerja sama dengan RS yang belum memiliki CT Scan untuk meningkatkan pendapatan.
 - 2) Mengajukan MCU kepada perusahaan-perusahaan besar di Kab/Kota Malang.
2. Kolaborasi dengan Humas & Marketing untuk mengawal Polisi LAKA supaya tetap melakukan rujukan LAKA LANTAS ke RS Prima Husada Malang.
3. Melakukan review tarif tindakan yang dibutuhkan DPJP atau bisa dilakukan di RS, namun belum ada di Billing. Contoh : CTA Cardiac.
4. Mendokumentasikan respon time pelayanan Radiologi menggunakan Google Spreadsheet, sambil menunggu waktu selesai hasil dimunculkan di Hasil Bacaan oleh Programmer PT.

3.2.4.3 Tabel Laporan Ulang Hasil Bulan Desember 2024 – Februari 2025

NO	NAMA DOKTER	NAMA PASIEN	BACAAN AWAL	BACAAN ULANG	TOTAL
Bulan Desember 2024					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	0	0	0	0
2.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	0	0	0	0
Bulan Januari 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	0	0	0	0
2.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	0	0	0	0
Bulan Februari 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	Dahniyar Afandi (227465)	Kongestif Pulmonum	Pneumonia	1
2.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	0	0	0	0

Analisis :

1. Pada Bulan Februari terdapat pembacaan ulang pemeriksaan ke radiologi. Hal ini disebabkan karena klinis tidak ditulis secara lengkap pada surat permintaan radiologi.
2. Pembacaan ulang pada dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad tidak terdokumentasikan, karena tidak ada laporan yang masuk.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan MOD dan Kabid Pelayanan jika ada complain DPJP untuk melaporkan ke Radiologi dan Kabid Penunjang Medis.
2. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan untuk melengkapi pemeriksaan klinis pada surat pengantar supaya dapat menunjang hasil pemeriksaan.

3.2.4.4 Tabel Rata-Rata Respon Time Pembacaan Pemeriksaan Radiologi

NO	PEMERIKSAAN	RATA-RATA WAKTU (menit)			
		dr Agung, Sp.Rad (K)		dr Yudho, Sp.Rad	
		SELESAI PERIKSA	SELESAI PEMBACAAN	SELESAI PERIKSA	SELESAI PEMBACAAN
1.	Ro Thorax PA/AP	3	25-60	3	1440
2.	Ro Vertebrae	-	-	4	1440
3.	Ro Abdomen	-	-	10	1440
4.	Ro Extremitas	-	25-420	2	1440
5.	Ro Skull	-	-	2	1440
6.	USG Abdomen	8	3	8	3
7.	CT Scan Non Kontras	5	30-1440	-	-
8.	CT Scan Dengan Kontras	15	30-1440	-	-
9.	Radiologi CITO	-	-	-	-

Analisa :

1. Rata-rata pemeriksaan radiologi adalah 3 menit dengan rata-rata hasil pembacaan radiologi 25 menit untuk dr Agung, Sp.Rad (K), hal ini disebabkan karena hasil rontgen dapat dikonsultasikan via pesan whatsapp. (Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam).
2. Rata-rata pembacaan radiologi oleh dr Yudho, Sp.Rad adalah 1440menit/24 jam, tidak sesuai dengan target standar RS. Hal ini disebabkan karena adanya pembagian jobdesk konsulan, dr Yudho, Sp.Rad tidak berkenan dikonsuli via pesan whatsapp dan dibacakan saat praktik keesokan harinya.
3. Pembacaan elektif dilakukan oleh dr Yudho, Sp.Rad saat praktik. (Semua foto Vertebrae, Ekstremitas, Abdomen, dan Skull).
4. Tidak terdapat pemeriksaan CITO dan kasus kritis selama Bulan Februari 2025.
5. Semua pemeriksaan CT Sacan dibacakan oleh dr Agung, Sp.Rad (K).
6. Terdapat kekosongan jam pelayanan radiologi pada siang hari.
7. Pembacaan hasil pemeriksaan radiologi oleh dr Agung, Sp.Rad, diatas target standar RS yakni 420-1440 menit dikarenakan hasil jadi diatas pukul 00.00 WIB dan DPJP meminta dibacakan oleh dr Agung, Sp.Rad.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Menemui kedua DPJP Radiologi untuk menambah jam praktik.
2. Memberikan surat pemberitahuan kepada Kepala Kolegium Radiografer bahwa RS membutuhkan tambahan DS Radiologi untuk mengisi jadwal praktik siang hari, sudah diterima oleh dr Agung, Sp.Rad.
3. Melakukan supervise pencatatan respon time pada Google Spreadsheet.
4. Membuat perjanjian dengan Kains Radiologi (dr Agung, Sp.Rad (K)) selama belum terpenuhi dokter untuk merespon konsulan secara cepat.

3.2.4.5 Tabel Angka Komplain DPJP Terhadap Keterlambatan Hasil Pembacaan Radiologi pada Bulan Februari 2025

NO	NAMA PASIEN	NAMA DPJP	PEMERIKSAAN	WAKTU	
				SELESAI PERIKSA	SELESAI HASIL
1.	-	-	-	-	-

Analisis :

Pada Bulan Februari tidak ada komplain DPJP dan Dokter Umum karena keterlambatan hasil pembacaan radiologi.

Hal ini disebabkan, selain waktu tunggu cito tidak melebihi standar, bisa disebabkan ketidakpahaman petugas pelayanan dalam melaporkan complain sehingga tidak

terdokumentasikan dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :

Kolaborasi dengan MOD dan Kabid Pelayanan jika ada complain DPJP untuk melaporkan ke Radiologi dan Kabid Penunjang Medis.

3.2.4.6 Tabel PMI dan PME di Radiologi

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Pemantapan Mutu Internal (PMI)			
1.	Mencatat waktu tunggu pelayanan foto	Mencatat waktu mulai pengerjaan hingga hasil diserahkan.	1. Respons time pelayanan radiologi terukur dan sesuai standar. 2. Pengendalian kegagalan foto dan meminimalkan pengulangan. 3. Mengendalikan penggunaan BMHP radiologi.
2.	Mencatat jumlah Reject Film	Mencatat kegagalan foto (review pembacaan dan review hasil radiograf)	
3.	Memonitor pemakaian BMHP	Memonitor penyimpanan, pemeliharaan dan pemakaian bmhp.	
Pemantapan Mutu Eksternal (PME)			
1.	Melakukan uji paparan radiasi	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	1. Peralatan radiologi dalam kondisi siap pakai. 2. Standarisasi pelayanan radiologi rujukan.
2.	Melakukan uji akurasi tegangan	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	
3.	Pengukuran TLD Badge	Kegiatan pengukuran dilakukan setiap 3 bulan sekali ke BPFK (Balai Pengaman Fasilitas .Kesehatan)	
4.	Kalibrasi alat radiologi	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali.	
5.	Uji kesesuaian	Pengujian kondisi alat dilakukan setiap 4 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	
6.	Sertifikat kalibrasi	Memastikan sertifikat kalibrasi rs rujukan masih berlaku	

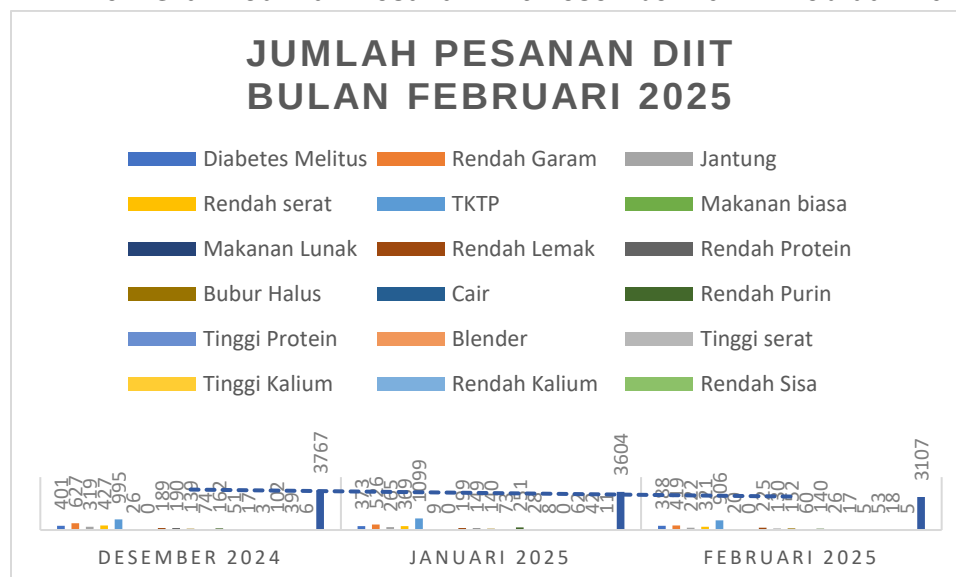
2.4.5 Gizi

2.4.5.1 Tabel Pemesanan Diit Desember 2024 – Februari 2025

NO	NAMA DIIT	BULAN			PROSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA (%)
		DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	
1.	Diabetes Melitus	401	373	388	104
2.	Rendah Garam	627	526	419	80
3.	Jantung	319	265	222	84
4.	Rendah serat	427	369	321	87

5.	TKTP	995	1099	906	82
6.	Makanan biasa	26	9	20	222
7.	Makanan Lunak	0	0	0	0
8.	Rendah Lemak	189	199	225	113
9.	Rendah Protein	190	149	130	87
10.	Bubur Halus	139	140	152	109
11.	Cair	74	73	60	82
12.	Rendah Purin	162	251	140	56
13.	Tinggi Protein	51	28	26	93
14.	Blender	17	8	17	213
15.	Tinggi serat	3	0	5	0
16.	Tinggi Kalium	102	62	53	85
17.	Rendah Kalium	39	42	18	43
18.	Rendah Sisa	6	11	5	45
TOTAL		3767	3604	3107	86

2.4.5.2 Grafik Jumlah Pesanan Diit Desember 2024 – Februari 2025



Analisis :

1. Jumlah pemberian diit pasien rawat inap pada Bulan Februari mengalami penurunan, hal ini berbanding lurus dengan penurunan jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit.
2. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pemesanan diit terbanyak selama Bulan Februari 2025 adalah TKTP sebanyak 906, berbanding lurus dengan diagnose terbanyak di rawat inap yaitu Thypoid Fever dengan kebutuhan diit TKTP.
3. Dari hasil survey kepuasan pasien terhadap menu makanan tidak ditemukan penurunan kepuasan terhadap variasi makanan.

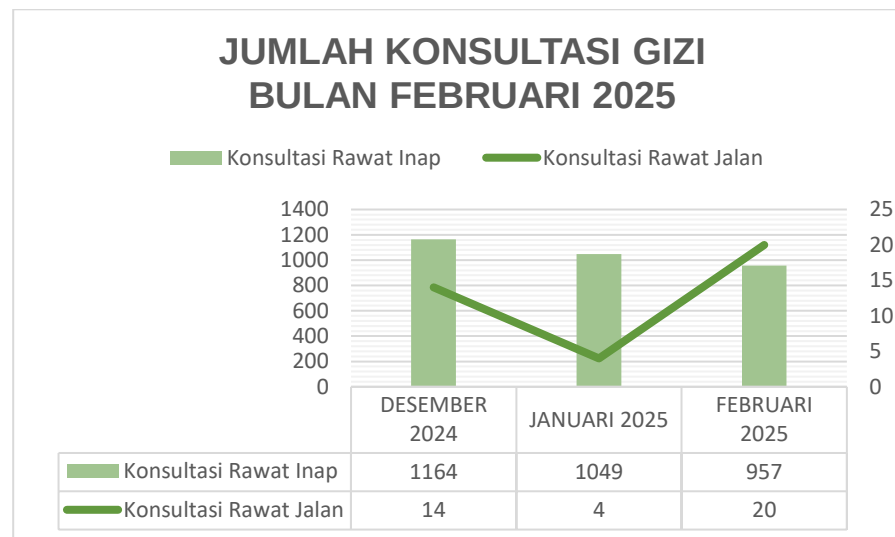
Rencana Tindak Lanjut :

1. Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan.
2. Mengajukan pelayanan catering makanan untuk pemulihan pasien saat pulang rawat inap.
3. Kolaborasi dengan layanan primantara (pengantaran obat) untuk MCU Gizi gratis sebagai reward.
4. Melakukan perbaikan menu makanan dan plating sesuai dengan kelas pasien.
5. Kolaborasi dengan PKRS untuk membuat leaflet menu makanan dan diupload di Sosial Media.
6. Perbaikan pencatatan food waste dipisahkan setiap menu makanan untuk mengetahui menu makanan mana yang tidak diminati.

2.4.5.3 Tabel Jumlah Konsultasi Gizi

No	Indikasi	Jumlah Pasien		
		Desember 2024	Januari 2025	Februari 2025
1.	Konsultasi Rawat Inap	1164	1049	957
2.	Konsultasi Rawat Jalan	14	4	20

2.4.5.4 Jumlah Konsultasi Gizi



Analisis :

1. Jumlah konsultasi gizi rawat inap pada Bulan Februari 2025 menurun mengikuti jumlah pasien yang rawat inap.
2. Jumlah konsultasi gizi rawat jalan pada Bulan Februari 2025 mengalami peningkatan hal ini disebabkan pasien dan keluarga menunda datang pada Bulan Januari dikarenakan liburan tahun baru.
3. Tidak semua DPJP memberikan rujukan ke Poli Gizi, rujukan diterima dari Poli Jantung dan

Poli IPD saja ketika pasien bertanya terkait pantangan makan saat control ke Poli Spesialis.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Merancang pengembangan pelayanan MCU Konsultasi Gizi dengan perusahaan.
2. Koordinasi dengan Humas Marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan.
3. Koordinasi dengan Kabid Pelayanan agar DPJP merujuk pasien ke Poli Gizi.

2.4.5.5 Tabel Rekap Data Komplain Pasien Terhadap Gizi Bulan Februari 2025

NO	JENIS KOMPLAIN	NAMA PASIEN	ANALISIS	RENCANA TINDAK LANJUT	TOTAL
1.	Makanan yang disajikan dan penjelasan mengenai menu makanan.	1. Ny Lovi Krissadi (IRNA 3A Tulip) Isi Komplain : Komplain dari keluarga pasien Tulip 3A bahwa menu daging masih keras, lalu alas daun pisang sudah tidak berwarna hijau, dan juga baki yang digunakan tidak bersih.	1. Tidak dilakukan QC menyeluruh terhadap peralatan yang digunakan. 2. Tidak mencicipi olahan daging yang sudah matang sebelum di porsi.	1. QC dilakukan menyeluruh kesemua bagian bukan hanya pada platingan makanan yang akan disajikan saja. 2. Mengadakan cooking class.	1
2.	OB / pasien yang tidak mendapatkan makanan	1. Ny Alifah (ICU) 2. Ny Siti Fatimah (IRNA 8A)	Petugas penyaji sudah memberikan kepada pasien igd, tetapi saat memindah pasien keruangan oleh petugas / keluarga makanan nya tidak dibawa naik. Petugas penyaji tidak fokus saat bekerja, petugas merasa sudah memberikan	Komunikasi antar petugas penyaji dan perawat harus lebih baik lagi, dan harus sama-sama double croscek terutama pasien yang diberikan makan tapi belum mendapatkan ruangan (masih di IGD). Petugas penyaji saat membagikan makan harus fokus dan juga	2

			makanan pasien dan tinggal memberikan minum nya saja, tetapi saat petugas sudah selesai membagi, pasien baru konfirmasi kepada AG yang jaga bahwa belum mendapatkan makanan.	melihat data di pemesanan diet yang dibawa saat membagi makanan pasien, serta memintakan Tanda Tangan ke pasien/keluarga yang menerima makanan dan juga perawat ruangan sebagai bukti bahwa penyerahan makanan sudah selesai dilakukan ke semua pasien lantai tersebut.	
--	--	--	--	---	--

2.4.5.6 Tabel Rekap Food Waste (Sisa Makanan)

NO	BULAN TAHUN 2025	HASIL (KG)			TOTAL
		LANTAI VIP	LANTAI DEWASA	LANTAI ANAK	
1.	Januari	73,5	486,6	166,1	726,2
2.	Februari	56,3	459,24	151,5	667,04
3.	Maret				
4.	April				
5.	Mei				
6.	Juni				
7.	Juli				
8.	Agustus				
9.	September				
10.	Oktober				
11.	November				
12.	Desember				

Analisis :

1. Terdapat sisa makanan paling banyak ada pada Lantai Dewasa yaitu sebesar 459,24 kg, hal ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain :
 - 1) Ada batasan diit yang dapat mempengaruhi rasa dan tampilan sehingga kurang menggugah selera.
 - 2) Tidak ada pantangan dari keluarga pasien, sehingga konsumsi makanan dari luar / dibawa

3) Suasana lingkungan perawatan dan kondisi fisik pasien.

- ### Rencana Tindak Lanjut :

- #### 2.4.5.7 Lampiran Pemantauan Air Panas di Pencucian Alat Makan

2.4.5.8 Lampiran Rekap Dara Kehilangan Alat Makan

71

2.	21/01/2025	Anissa Octaviafitri Widodo	B5C-2	Sendok			Pasien sudah KRS
3.	26/01/2025	Aqilla Rassi Susanto	B2	Mangkuk Kecil			Sudah kembali
4.	31/01/2025	Ilma Ayuningsi	T4C-3	Gelas			Sudah pembayaran
Februari 2025							
1.	01/02/2025	Abid Fadhul Abyan	B3C-4	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
2.	01/02/2025	Cholifah	B5C-4	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
3.	04/02/2025	Widya Dwi Anandita	D6A-11	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
4.	05/02/2025	Arzanka Daneswara Ghazali	A1	Sendok Makan			Sendok terbawa pulang
5.	05/02/2025	Arzanka Daneswara Ghazali	A1	Sendok Snack			Sendok terbawa pulang
6.	06/02/2025	Chabibatul Aziizah	B3C-1	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
7.	06/02/2025	Mimi Eka	D4C-7	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang

Analisis :

1. Dari table diatas dapat diketahui bahwa ada 7 pasien yang menghilangkan/memecahkan alat makan, hal ini disebabkan kurangnya edukasi kepada pasien dan keluarga, ada peraturan yang tertulis dan tidak dijalankan, sehingga alat makan dianggap sebagai barang yang tidak memiliki nilai.
2. Tidak ada supervisi dari Kepala Ruang terhadap SPO yang sudah dibuat.

Rencana Tindak Lanjut :

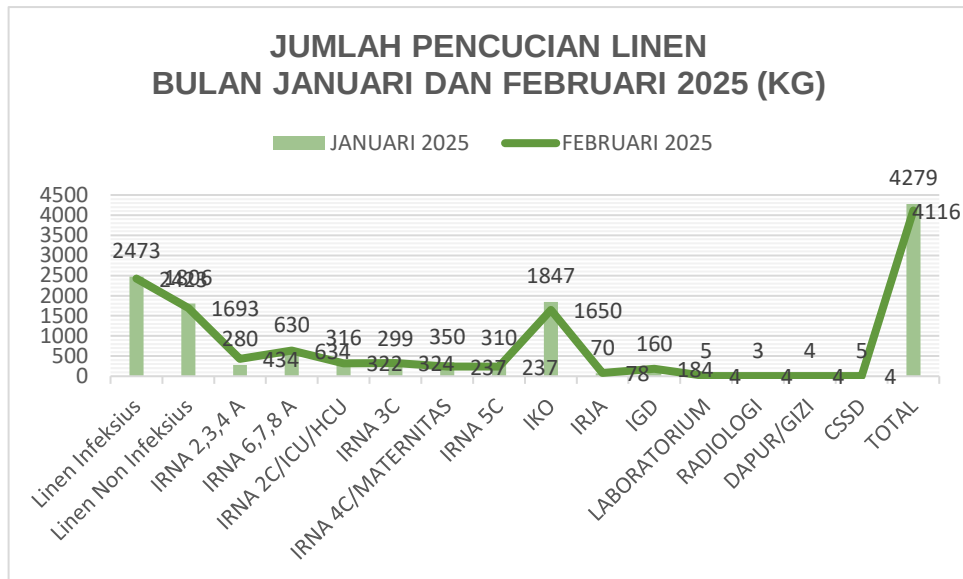
1. Mencantumkan tata tertib menjaga fasilitas pada GC, sehingga petugas admisi dapat mengedukasi saat melakukan pendaftaran, jika pasien menghilangkan atau merusak fasilitas maka wajib mengganti. Sementara menggunakan catatan tertulis selama GC yang lama belum habis.
2. Melakukan supervisi “SPO Pengecekan Fasilitas RS Sebelum Pasien KRS”, sebagai panduan petugas dalam pelayanan dimana terdapat kolaborasi antara Instalasi Gizi, Perawat Ruangan , CS Pantry dan Ruangan, dan Kasir.

4.4.7 CSSD - Laundry

4.4.7.1 Tabel Jumlah Pencucian Linen di Laundry Januari – Februari 2025

NO	HAL	BULAN	
		Januari 2025	Februari 2025
BHP			
1.	Chemical Clax Buit Lite (dirigen)	2	1
2.	Chemical Clax 100 Ob (dirigen)	1.5	1.5
3.	Chemical Clax Sonril Ultra (dirigen)	1.5	1.5
4.	Chemical Clax Anti Chlor (dirigen)	1	1
5.	Pewangi Kispray 300ml (pcs)	22	21
6.	Pemutih Bayclean (liter)	10	9
7.	Softener (liter)	18	17
8.	Liquid matic (liter)	9	8
9.	Tabung LPG 12 kg (tabung)	20	17
Total		85	77
LINEN (kg)			
1.	Linen Infeksius	2473	2423
2.	Linen Non Infeksius	1806	1693
3.	IRNA 2,3,4 A	280	434
4.	IRNA 6,7,8 A	630	634
5.	IRNA 2C/ICU/HCU	316	322
6.	IRNA 3C	299	324
7.	IRNA 4C/MATERNITAS	350	237
8.	IRNA 5C	310	237
9.	IKO	1847	1650
10.	IRJA	70	78
11.	IGD	160	184
12.	LABORATORIUM	5	4
13.	RADIOLOGI	3	4
14.	DAPUR/GIZI	4	4
15.	CSSD	5	4
Total		4279	4116

4.4.7.2 Grafik Jumlah Pencucian Linen di Laundry Pada Bulan Januari 2025



Analisis :

1. Data diatas adalah jumlah pencucian linen pada Bulan Februari 2025 sebanyak 4050kg, mengalami penurunan karena sebanding dengan penurunan kunjungan pasien rawat inap.
2. Jumlah linen infeksius sebesar 2423kg, sebagian besar berasal dari IKO. Hal ini disebabkan produktivitas IKO pada Bulan Februari 2025 meningkat.
3. Perbandingan bisa dilakukan 3 bulan selanjutnya.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan breakdown pencatatan linen infeksius/non infeksiun per unit.
2. Dilakukan perubahan alur permintaan linen bersih menggunakan digital form per unit, dilakukan pendistribusian sehari 2 kali untuk memenuhi kebutuhan unit sesuai dengan permintaan, yang dilaksanakan mulai awal Tahun 2025.
3. Rencana akan dilakukan pencatatan keluar masuknya linen menggunakan google spreadsheet per hari nya.
4. Rencana akan dilakukan stok opname setiap bulan.
5. Pemampatan jadwal dinas malam untuk memaksimalkan pekerjaan.
6. Perubahan alur pengambilan linen yang perlu disterilisasi, dilakukan oleh petugas CSSD karena petugas laundry yang kurang.

4.4.7.3 Tabel Inventarisasi Linen Laundry Pada Bulan Januari - Februari 2025

NO	NAMA / JENIS LINEN	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025
1.	Sprei	195	185
2.	Sarung bantal	290	275

3.	Selimut	225	216
4.	Baju tim IKO	118	118
5.	Baju ganti pasien	44	44
6.	Skort	162	160
7.	Perlak	21	19
8.	Baju ganti laundry	15	15
9.	Duk lubang besar	23	23
10.	Duk pembungkus	59	59
11.	Duk kecil 1 meter	58	58
12.	Duk ortho	20	20
13.	Duk lubang kecil	18	18
14.	Duk kaki	11	11
15.	Meja mayo	21	21
16.	Skort IKO	50	48
17.	Waslap	60	46
18.	Handuk CSSD	10	10

4.4.7.4 Tabel Rekap Kerusakan Linen dan Pemusnahan Pada Bulan Januari - Februari 2025

NO	NAMA / JENIS LINEN	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025
1.	Sprei	25	10
2.	Sarung bantal	24	15
3.	Selimut	14	10
4.	Baju tim IKO	9	0
5.	Baju ganti pasien	5	0
6.	Skort	0	2
7.	Perlak	6	2
8.	Baju ganti laundry	0	0
9.	Duk lubang besar	0	0
10.	Duk pembungkus	0	0
11.	Duk kecil 1 meter	0	0
12.	Duk ortho	0	0
13.	Duk lubang kecil	0	0
14.	Duk kaki	0	0
15.	Meja mayo	4	0
16.	Skort IKO	0	0
17.	Waslap	2	14
18.	Handuk CSSD	0	0
19.	Kerudung	1	0
20.	Bantal	12	3
Pemusnahan (+)		Tanggal 27/01/2025	Belum dijadwalkan

Analisis :

Petugas melakukan sortir setiap hari, linen tidak layak dijadikan satu dan diajukan untuk dilakukan pemusnahan, BA sudah dikirim ke PT sebagai lampiran untuk penambahan linen pengganti.

Rencana Tindak Lanjut :
Follow up Pengadaan PT

4.4.7.5 Tabel Pelaporan Limbah atau Benda Asing Tercampur Linen Pada Bulan Januari - Februari 2025

No	Nama Benda	Jumlah	
		Januari 2025	Februari 2025
1.	Masker IKO	6	2
2.	Tissue	1	1
3.	Jarum	0	1
4.	Bumbu Dapur	0	0
5.	Uang	0	0
6.	Alat Tulis	1	0
7.	Benda lainnya	0	1

Analisis :

1. Masih ditemukan benda asing tercampur dengan linen, karena pemilahan seharusnya dilakukan di Unit sebelum linen dimasukkan kedalam tong linen kotor.
2. Ketidakterdisiplinan paling banyak dari Unit IKO.
3. Hal ini dapat menyebabkan kontaminasi terhadap linen lainnya dan dapat menyebabkan kerusakan pada mesin.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan sosialisasi kepada unit.
2. Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kemudian dilaporkan kepada Kabid Keperawatan dan SDM terkait hasil evaluasi.

4.4.7.6 Tabel Permintaan Linen Cito/Tidak Sesuai Jadwal Pada Bulan Februari 2025

UNIT	TANGGAL	JENIS LINAN	JUMLAH	ALASAN
-	-	-	-	-

Analisis :

Tidak ada permintaan linen cito dari unit, hal ini dikarenakan laundry memiliki jadwal permintaan linen sehari 2 kali, dan laundry standby 24 jam.

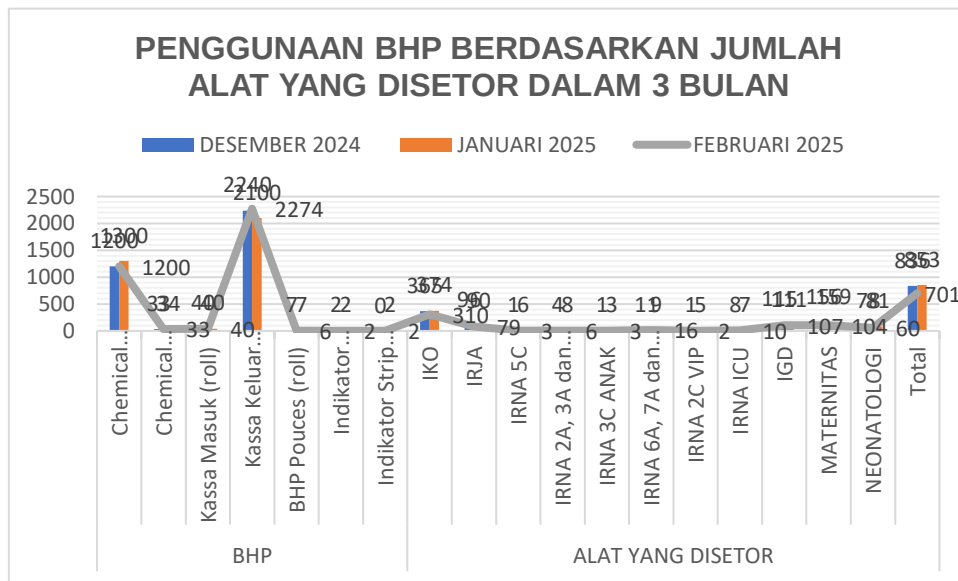
Rencana Tindak Lanjut : -

4.4.8 CSSD

4.4.8.1 Tabel Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai dan Alat yang Disetor ke CSSD Pada Bulan Desember 2024, Januari dan Februari 2025

NO	HAL	BULAN TAHUN 2024		
		DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025
BHP				
1.	Chemical Alcacide (ml)	1200	1300	1200
2.	Chemical Alkazyme (pcs)	33	34	33
3.	Kassa Masuk (roll)	40	40	40
4.	Kassa Keluar (pouches)	2240	2100	2274
5.	BHP Pouces (roll)	7	7	6
6.	Indikator Adhesive (roll)	2	2	2
7.	Indikator Strip Steam (roll)	1,5	2	2
Alat Yang Disetor				
8.	IKO	365	374	310
9.	IRJA	96	90	79
10.	IRNA 5C	1	6	3
11.	IRNA 2A, 3A dan 4A	4	8	6
12.	IRNA 3C ANAK	1	3	3
13.	IRNA 6A, 7A dan 8A	11	9	16
14.	IRNA 2C VIP	1	5	2
15.	IRNA ICU	8	7	10
16.	IGD	115	111	107
17.	MATERNITAS	156	159	104
18.	NEONATOLOGI	78	81	60
Jumlah		836	853	701

4.4.8.2 Grafik Jumlah Alat Yang Disetor ke CSSD selama Bulan Desember 2024, Januari 2025 dan Februari 2025



Analisis :

1. Dari data diatas dapat diketahui bahwa, pengeluaran BHP dalam 3 bulan terakhir adalah stabil, ada penurunan tetapi tidak signifikan. Hal ini disebabkan produktivitas CSSD membuat kassa steril meningkat.
2. Jumlah alat yang disterilisasi paling banyak dari Unit IKO dengan jumlah setor alat pada Bulan Februari 2025 yaitu sejumlah 310 set, diikuti dari Unit Maternitas 107 set dan IGD 104 set. Dimana dari ketiga unit tersebut paling sering melakukan tindakan, mengalami penurunan hal ini sebanding dengan penurunan jumlah kunjungan pasien rawat inap.
3. Dengan perbaikan pencatatan menggunakan google spreadsheet data yang diambil valid, namun penggolongan kategori alat tidak seragam, seperti gunting talpus terhitung 1 alat dan set partus juga terhitung 1 alat.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Memperbaiki pencatatan keluar masuk alat bersih dan kotor per bulan dengan kesepakatan alat yang dihitung.
2. Pendistribusian kasa steril dalam bentuk pouches terpusat di Gudang Farmasi, dengan jadwal permintaan BMHP seminggu 2x.
3. Monitoring dan Evaluasi pencatatan digital.
4. Melakukan orientasi petugas baru di CSSD.

4.4.8.3 Tabel Penggunaan Reuse Pada Bulan Februari 2025

Nama Alat	Reuse ke1
Junctionrees	
Breathing circuit	

Analisis :

Tidak ada permintaan alat reuse pada Bulan Februari 2025.

4.4.8.4 Tabel Hasil Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD

UNIT	BULAN			TOTAL 3 BULAN
	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	
Kejadian Instrument Kurang				
IKO	0	0	0	0
IGD	0	0	2	2
IRNA	0	0	0	0
IRJA	0	0	0	0
Kejadian Instrumen Hilang				
IKO	0	0	0	0
IGD	0	0	0	0
IRNA	0	0	0	0
IRJA	0	0	0	0
Kejadian Instrument Tercampur Benda Asing				
IKO	0	1	0	1
IGD	0	0	0	0
IRNA	0	0	0	0
IRJA	0	0	0	0

Kejadian Instrument Tidak Dilakukan Perendaman				
IKO	0	0	0	0
IGD	0	0	0	0
IRNA	0	0	0	0
IRJA	0	0	0	0

Analisis :

1. Ditemukan kejadian instrument kurang di IGD, sebanyak 2 kali. Hal ini ditemukan ketika perawat setor alat kotor dan langsung dicek oleh petugas CSSD.
2. Ditemukan benda asing yaitu jarum hecting sebanyak 1 kali pengiriman dari IKO, hal ini disebabkan karena tidak dilakukan pemilahan saat menyetorkan alat ke CSSD. Dengan ketidaksiplanan petugas dapat mengakibatkan resiko pajan.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan pencatatan saat ada penemuan.
2. Melaporkan temuan kepada Kabid Keperawatan untuk dilakukan pendisiplinan petugas.

4.4.8.5 Tabel Rekap Data Permintaan Instrumen Cito Selama Bulan Februari 2025

UNIT	JUMLAH PERMINTAAN CITO			KETERANGAN
	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025	
IKO	0	0	0	
IGD	0	0	0	
IRNA	0	0	0	
IRJA	0	0	0	

Analisis :

Tidak ada permintaan instrument cito selama 3 bulan terakhir, hal ini dipengaruhi ketertiban petugas dalam menyetorkan instrument kotor sehingga unit saat meminta alat selalu tersedia.

Rencana Tindak Lanjut : -

4.5 Kinerja Bidang Umum dan Keuangan

4.5.7 SDM

4.5.7.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Satuan Pengawas Internal	SMK	1	1	1	0	0
7	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
8	Dokter Casemix	Dokter Umum	1	1	0	1	0
9	Farmasi	Profesi Apoteker	41	13	6	7	0
		S1 Farmasi		3	2	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		20	12	8	0
		SMK		4	3	1	0
		S1 Akuntansi		0	0	0	0
10	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
11	CSSD	D3 Keperawatan	5	3	2	1	0
		SMA		1	1	1	0
		SMK		1	0	1	0
12	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
13	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	2	0	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		7	0	7	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0
14	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
15	ICU dan HCU	Profesi Ners	12	6	6	0	0
		D3 Keperawatan		6	5	1	0
16	IGD	Profesi Ners	25	11	8	3	0
		D3 Keperawatan		9	7	2	0

		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
17	IKO	Profesi Ners	12	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
18	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
19	IPSRs	S1 Tenik Elektro	6	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0
20	IRJA	Profesi Ners	27	8	7	1	0
		D3 Keperawatan		14	13	1	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
21	IRNA 2C	Profesi Ners	8	6	5	1	0
		D3 Keperawatan		2	2	0	0
22	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	18	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		13	7	6	0
23	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	15	6	4	0	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
24	IRNA 5C	Profesi Ners	9	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		6	4	2	0
25	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	25	12	6	6	0
		D3 Keperawatan		13	8	3	0
26	Maternitas	Profesi Kebidanan	12	2	0	2	0
		D4 Kebidanan		2	1	1	0
		D3 Kebidanan		8	8	0	0
27	Neonatologi	Profesi Ners	8	2	2	0	0
		D3 Keperawatan		5	4	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
28	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	10	2	2	0	0
		S1 Akuntansi		2	0	2	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
29	Laboratorium	D4 Analisis Kesehatan	10	2	1	1	0
		D3 Analisis Kesehatan		8	7	1	0
30	Laundry	SMK	5	1	0	1	0
		SMA		3	0	3	0
		SMP		1	0	1	0
31	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	10	10	10	0	0
32	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	18	1	1	0	0

		S1 Manajemen		1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D4 Destinasi Wisata		1	0	1	0
		D3 Asuransi Kesehatan		2	0	2	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		6	4	2	0
		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		4	4	0	0
33	PIPP & MPP	Profesi Ners	5	2	1	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
34	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
35	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	5	2	0
36	SDM	S1 Psikologi	2	1	0	1	0
		S1 Ilmu Sosial		1	1	0	0
37	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
38	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
39	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
40	Cleaning Service	SMK	46	17	8	9	0
		SMA		24	20	4	0
		SMP		5	5	0	0
41	Security	SMK	12	5	2	3	0
		SMA		7	6	1	0
42	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	5	1	1	0	0
		SMA		3	2	1	0
		SMP		1	1	0	0
43	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
44	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
45	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
46	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
47	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
51	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
54	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0

55	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total			461				

3.5.1.1 Update STR / SIP

NO	NAMA	PROFESI	TANGGAL KEJADIAN	KETERANGAN
1	Miftakhul Khoiriyah	Fisioterapis	07 Februari 2025	SIP Baru
2	dr. Titok Hariyanto, Sp.M	Dokter Spesialis Mata	18 Februari 2025	SIP Perpanjangan

Keterangan : Pada bulan Februari 2025 terdapat 2 SIP baru

3.5.1.2 Rekrutmen

NO	PROFESI	JUMLAH YANG DIBUTUHKAN	TERPENUHI	KEKURANGAN	PENYEBAB	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Terapi Okupasi	1	0	1	Sulit mencari kandidat terapis okupasi	Menghubungi sosial media komunitas terapis okupasi, menghubungi kampus dengan jurusan terapis okupasi
2	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	0	1	Sulit mencari kandidat Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	Menguhubungi kampus dengan jurusan tersebut
3	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	1	0	1	Sulit mencari Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	Menguhubungi kampus dengan jurusan tersebut
4	Dokter Spesialis Radiologi	1	0	1	Belum mendapatkan kandidat	Dibutuhkan yang Perempuan
5	Fisioterapis	5	4	1	Belum mendapatkan kandidat yang cocok	Sedang proses pemenuhan
6	Perawat Gigi	2	1	1	Sudah ACC dari PT DPM	Open recruitment setelah hari raya
7	Terapis Wicara	2	1	1	On proses pengajuan ke PT DPM	On proses pengajuan ke PT DPM

3.5.1.3 Orientasi Staf Baru

3.5.1.3.1 Orientasi Staf

No	Tanggal	Jenis Orientasi	Nama Staf	Pendidikan	Profesi	SPMJ (Tanggal Masuk)	Keterangan
1	5 Desember 2024	Orientasi Khusus	Renaldi Salsabila, A.Md.Rad	D3 Radiologi	Radiografer	5 Desember 2024	Bulan ke-3 orientasi khusus
2	16 Desember 2024	Orientasi Khusus	Miftakhul Khoiriyah, S.Ft	Profesi Fisioterapi	Fisioterapis	16 Desember 2024	Bulan ke-3 orientasi khusus
3	01 Februari 2025	Orientasi Khusus	dr. Annishafira Widyawardhani	Profesi Kedokteran	Dokter Umum	01 Februari 2025	Nulan ke-1 orientasi khusus

Keterangan :
Pada bulan Februari 2025 terdapat 3 staf yang menjalani orientasi khusus

3.5.1.4 Diklat

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	JENIS DIKLAT	JUDUL DIKLAT	SASARAN	KETERANGAN	RTL
1	Senin, 03 Februari 2025 s/d Sabtu, 15 Februari 2025	Diklat Eksternal Non Fee	Magang BDRS Analis Lab	Puji Utami, A.Md.Kes	Diklat Eksternal Non Fee	Disiapkan peserta selanjutnya setelah Puji Utani, A.Md.Kes
2	Jumat, 07 Februari 2025	Diklat Internal Oleh DPJP	Kegawat Daruratan Neonatus Pemateri oleh d. Fiona Paramitha, Sp.A	Bidan, Perawat Ponek, Kabid Pelayanan Medis, Kabid Keperawatan, Kabid Penunjang	Dihadiri oleh 30 staf	Proses sertifikat
3	Senin, 10 Februari 2025	Pengembangan Rohani Staf	Kajian Rutin Seni & Kamis	Staf RS Prima Husada	Dihadiri oleh 15 karyawan	Dilakukan sosialisasi H-1 sebelum pelaksanaan
4	Kamis, 13 Februari 2025	Pengembangan Rohani Staf	Kajian Rutin Seni & Kamis	Staf RS Prima Husada	Dihadiri oleh 21 karyawan	Dilakukan sosialisasi H-1 sebelum pelaksanaan
5	Senin, 17 Februari 2025	Pengembangan Rohani Staf	Kajian Rutin Seni & Kamis	Staf RS Prima Husada	Dihadiri oleh 19 karyawan	Dilakukan sosialisasi H-1 sebelum pelaksanaan
6	Senin, 17 Februari 2025 s/d Jumat, 28 Februari 2025	Diklat Eksternal Non Fee	Magang BDRS Analis Lab	Arinta Astri Maulina, A.Md.Kes	Diklat Eksternal Non Fee	Disiapkan peserta selanjutnya setelah Arinta Astri Maulina, A.Md.Kes
7	Kamis, 20 Februari 2025	Pengembangan Rohani Staf	Kajian Rutin Seni & Kamis	Staf RS Prima Husada	Dihadiri oleh 22 karyawan	Dilakukan sosialisasi H-1 sebelum pelaksanaan
8	Senin, 24 Februari 2025	Pengembangan Rohani Staf	Kajian Rutin Seni & Kamis	Staf RS Prima Husada	Dihadiri oleh 12 karyawan	Dilakukan sosialisasi H-1 sebelum pelaksanaan
9	Kamis, 27 Februari 2025	Pengembangan Rohani Staf	Kajian Rutin Seni & Kamis	Staf RS Prima Husada	Dihadiri oleh 12 karyawan	Dilakukan sosialisasi H-1 sebelum pelaksanaan

Keterangan:
Pada bulan Februari 2025 terdapat pelaksanaan diklat internal yang dilaksanakan di RS Prima Husada Malang.

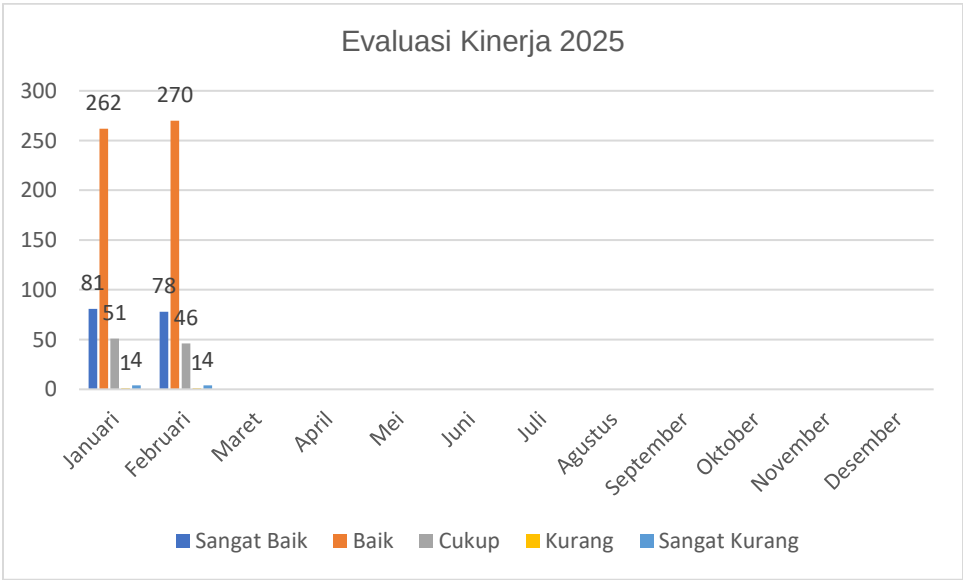
3.5.1.5 Evaluasi Kinerja Staf

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
1	Manajemen	Umum	13 staf	0 staf	6	6	1	0	Unit Manajemen RS Prima Husada secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
2	Asuransi Center	Umum	10 staf	0 staf	2	8	0	0	Unit Asuransi Center secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
3	IRNA 2C	Umum	8 staf	0 staf	0	7	1	0	Unit IRNA 2C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
4	IRNA 3C Anak	Umum	15 staf	0 staf	1	12	2	0	Unit IRNA 3C Anak secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
5	IRNA 234A	Umum	18 staf	0 staf	0	15	3	0	Unit IRNA 234A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
6	IRNA 5C	Umum	9 staf	0 staf	0	8	7	0	Unit IRNA 5C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
7	IRNA 678A	Umum	25 staf	0 staf	0	22	3	0	Unit IRNA 678A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum. Terdapat 1 staf dengan evaluasi kinerja sangat kurang dikarenakan cuti melahirkan.
8	Maternitas	Umum	12 staf	0 staf	9	3	0	0	Unit Maternitas secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
9	Neonatologi	Umum	8 staf	0 staf	3	5	0	0	Unit Neonatologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
10	IGD	Umum	25 staf	0 staf	5	17	3	0	Unit IGD secara keseluruhan mendapatcatatan baik dalam penilaian kinerja umum.
11	ICU dan HCU	Umum	12 Staf	0 staf	2	8	1	1	Unit ICU & HCU secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
12	IKO	Umum	12 staf	0 staf	10	2	0	0	Unit IKO secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
13	Gizi	Umum	17 staf	0 staf	5	9	2	1	Unit Gizi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
14	Farmasi	Umum	41 staf	0 staf	3	32	6	0	Unit Farmasi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
15	Laboratorium	Umum	10 staf	0 staf	0	9	1	0	Unit Laboratorium secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
16	Radiologi	Umum	7 staf	0 staf	2	5	0	0	Unit radiologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
17	Rekam Medis	Umum	9 staf	0 staf	1	7	1	0	Unit Rekam Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	Pendaftaran	Umum	18 staf	0 staf	3	3	12		Unit Pendaftaran secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	CSSD dan	Umum	9 staf	0 staf	3	6	0	0	Unit CSSD & Laundry secara

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
	Laundry								keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
19	Keuangan dan Akuntansi	Umum	10 staf	0 staf	0	6	4	0	Unit Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
20	PIPP	Umum	5 staf	0 staf	0	4	0	1	Unit PIPP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum. Terdapat 1 staf dengan evaluasi kinerja sangat kurang dikarenakan cuti melahirkan.
21	Cleaning Service	Umum	45 staf	0 staf	15	27	2	1	Unit Cleaning Service secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
22	IT SIMRS	Umum	3 staf	0 staf	0	3	0	0	Unit IT SIMRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
23	IPSRS	Umum	6 staf	0 staf	1	8	0	0	Unit IPSRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
24	Gudang Umum	Umum	2 staf	0 staf	0	1	1	0	Unit Gudang Umum secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
25	Driver	Umum	5 staf	0 staf	3	2	0	0	Unit Driver secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
26	Security	Umum	12 staf	0 staf	8	4	0	0	Unit Security secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
27	IRJA	Umum	32 staf	0 staf	0	27	4	1	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

Analisis : Hampir seluruh unit di RS Prima Husada Malang berada pada kategori Sangat Baik pada penilaian umum periode Februari 2025.

3.5.1.5.1 Grafik Evaluasi Kinerja Karyawan

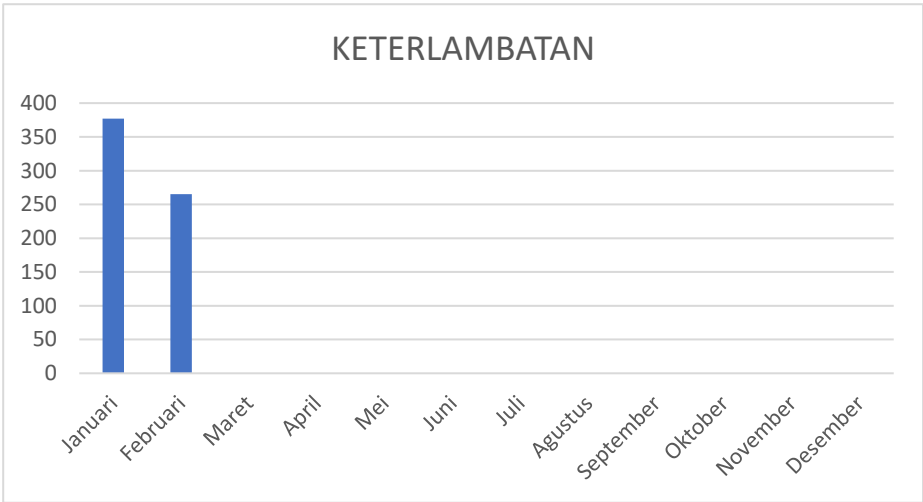


Kategori	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Sangat Baik	81	78										
Baik	262	270										
Cukup	51	46										

Kurang	1	1										
Sangat Kurang	4	4										
TOTAL	399	399										

Analisa :
secara umum terdapat peningkatan kinerja dari staf dilihat dari jumlah kategori cukup yang naik menjadi kategori diatasnya.

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
KETERLAMBATAN	377	265										



Rencana Tindak Lanjut :

1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.

3.5.1.6 Konseling

3.5.1.6.1 Tabel Capaian Konseling Perbulan Tahun 2025

NO	JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Konseling	0	0									

Analisis :
Tidak ada konseling di bulan ini (sesuaikan dengan kebutuhan)

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

Jenis	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Supervisi (2x/bulan)	0	100%										

3.5.2 MFK dan K3RS

3.5.2.1 Pemeliharaan Alat Medis

Perhitungan capaian berdasarkan jumlah kunjungan per unit oleh elektromedis ke unit-unit di rumah sakit (33 unit) dalam satu bulan

3.5.2.1.1 Tabel Capaian Maintenance Alat Medis

	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Capaian Maintenance Ruangan	90%	84.61	66.6										

BULAN	TOTAL ALAT	CAPAIAN	PROSENTASE
Januari	268	154	57.46%
Februari	270	135	50.00%

TOTAL ALAT (PERBAIKAN)	TOTAL ALAT
Januari	21
Februari	22

Analisa :

Pada bulan ini, capaian maintenance alat berdasarkan ruangan 66.6% dan jumlah alat 50%. Beberapa factor yang menyebabkan fluktuatif antara lain : alat medis masih dipakai oleh pasien, ruangan atau unit masih ada tindakan pasien, perbantuan perbaikan alat medis klinik Mutiara sehat dan perbaikan data ASPAK RS untuk kebutuhan Dinas Kesehatan.

Rencana Tindak Lanjut :

Koordinasi dengan PT untuk ATEM sesuai ABK

3.5.2.2 Pemeliharaan Alat Non Medis

3.5.2.2.1 Air Conditioner

3.5.2.2.1.1 Tabel Capaian Pemeliharaan AC Split

BULAN	MAINTENANCE / 1 BULAN	MAINTENANCE / 2 BULAN	MAINTENANCE / 3 BULAN	TOTAL	CAPAIAN
TARGET/BULAN	42	30	23	95	
JANUARI	11	6	16	33	35%
FEBRUARI	23	17	11	51	53.6%
MARET					
APRIL					
MEI					
JUNI					
JULI					
AGUSTUS					

SEPTEMBER					
OKTOBER					
NOVEMBER					
DESEMBER					

Analisa :
 Pada awal januari digunakan metode baru pencatatan kinerja terutama terkait system pencatatan dan target perbulan. Sudah dilakukan pencatatan metode baru, hasil evaluasi lebih baik dari tahun 2024. Capaian bulan ini meningkat menjadi 53.6%.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring

1.5.2.2.3 Genset

1.5.2.2.3.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Genset

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target

Analisis :
 Pada bulan ini, pemeliharaan genset dilakukan 4x dan sudah terlapor dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi berkala

1.5.2.2.4 Panel Listrik

3.5.2.2.4.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Panel

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target

Analisis :
 Pemeliharaan panel listrik di Gedung A,B,C,D,E dan LVMDP dilakukan 4x dalam satu bulan dan dilakukan rekapan dokumentasi. Kegiatan ini sudah berjalan sesuai target

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.5 Liquid Oksigen

1.5.2.2.5.1 Tabel Pencatatan Liquid Harian

Februari 2025							
Tanggal	Stok Liquid	Sebelum Pengisian	Penggunaan	Satuan	Keterangan	Pengiriman	Satuan
01/02/2025	3446	3270	176	MMHG			MMHG
02/02/2025	3270	2900	370	MMHG			MMHG
03/02/2025	2900	2750	150	MMHG			MMHG

04/02/2025	2750	2470	280	MMHG			MMHG
05/02/2025	2470	2190	280	MMHG			MMHG
06/02/2025	2190	1904	286	MMHG			MMHG
07/02/2025	1904	1461	443	MMHG			MMHG
07/02/2025	1461	3387	0	MMHG		1926	MMHG
08/02/2025	3387	3254	133	MMHG			MMHG
09/02/2025	3254	2910	344	MMHG			MMHG
10/02/2025	2910	2720	190	MMHG			MMHG
11/02/2025	2720	2475	245	MMHG			MMHG
12/02/2025	2475	2230	245	MMHG			MMHG
13/02/2025	2230	1998	232	MMHG			MMHG
14/02/2025	1998	1698	300	MMHG			MMHG
15/02/2025	1698	1469	229	MMHG			MMHG
15/02/2025	1469	3377	0			1908	
16/02/2025	3377	3056	321	MMHG			MMHG
17/02/2025	3056	2816	240	MMHG			MMHG
18/02/2025	2816	2660	156	MMHG			MMHG
19/02/2025	2660	2395	265	MMHG			MMHG
20/02/2025	2660	2155	505	MMHG			MMHG
21/02/2025	2155	1925	230	MMHG			MMHG
22/02/2025	1925	1671	254	MMHG			MMHG
23/02/2025	1671	1469	202	MMHG			MMHG
24/02/2025	1469	1107	362	MMHG			MMHG
24/02/2025	1107	3470		MMHG		2363	MMHG
25/02/2025	3470	3277	193	MMHG			MMHG
26/02/2025	3277	3065	212	MMHG			MMHG
27/02/2025	3065	2828	237	MMHG			MMHG
28/02/2025	2828	2524	304	MMHG			MMHG
			0	MMHG			MMHG
			0	MMHG			MMHG
			0	MMHG			MMHG
			0	MMHG			MMHG
			0	MMHG			MMHG
			0	MMHG			MMHG
Jumlah total pemakaian oksigen bulan ini			7384	MMHG			MMHG
Jumlah total pengisian liquid oksigen bulan ini						6197	MMHG
Rata-rata penggunaan oksigen per hari			422,25	MMHG			
Rata- rata pengisian liquid per bulan ini						3098,5	MMHG

Analisis :

Kegiatan sudah dilakukan dengan baik sesuai target, setiap hari dilakukan pengecekan. Stok oksigen selalu terjaga.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.6 IPAL

1.5.2.2.6.1 Tabel Capaian Pemeliharaan IPAL

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :

Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan. Pencatatan debit IPAL juga dilakukan dan di dokumentasikan.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.7 Filter Air

3.5.2.2.7.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Filter Air

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :

Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.8 Lift

1.5.2.2.8.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Lift

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.9 UPS
1.5.2.2.9.1 Tabel Capaian Pemeliharaan UPS

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

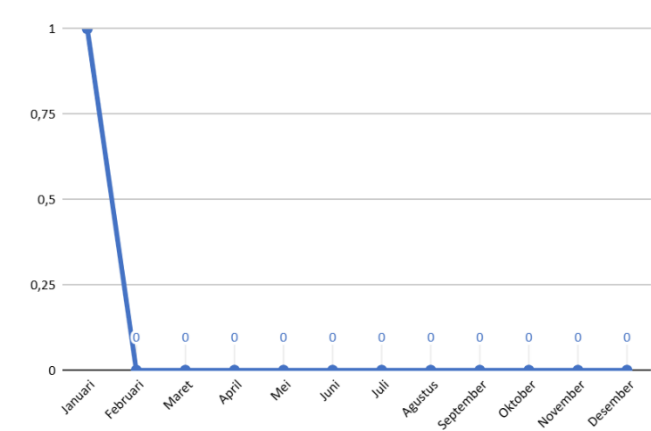
Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.3 Security

3.5.3.1 Tabel Angka Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0

3.5.3.2 Grafik Kejadian Kehilangan Barang



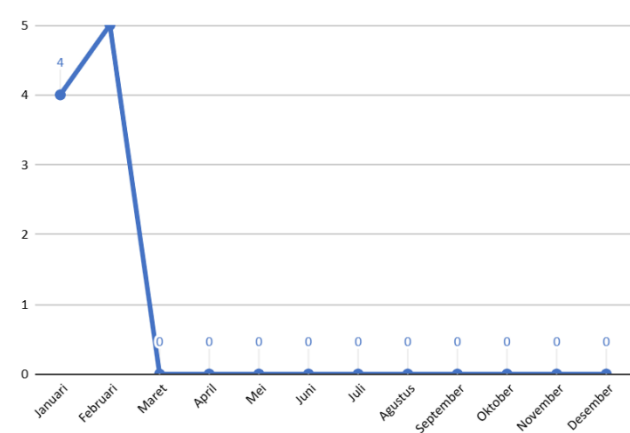
Analisa :
Tidak ada kejadian barang hilang di bulan februari 2025

Rencana Tindak Lanjut :
monitoring dan evaluasi

3.5.3.3 Tabel Angka Potensi Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	4	5	0	0	0	0	1	3	5	1	2

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kehilangan Barang



ANGKA KEJADIAN BARANG BERPOTENSI HILANG		
TANGGAL	KETERANGAN	RTL
26 – 02 - 2025	Telah ditemukan kunci motor karyawan yang tertinggal di area poli , diamankan di pos poli	Telah diambil pemilik
23 – 02 – 2025	Telah ditemukan kunci motor karyawan yang tertinggal di area parkir belakang , diamankan di pos poli	Telah diambil pemilik
19 – 02 – 2025	Telah ditemukan kunci mobil yang tertinggal di ruang tunggu poli orthopedi , diamankan di pos poli	Telah diambil pemilik
07 – 02 – 2025	Telah ditemukan kunci motor yang tertancap di motor karyawan parkir tingkat , diamankan di pos igd	Telah diambil pemilik
02 – 02 – 2025	Telah ditemukan helm di ruang tunggu poli lt 2 diamankan di pos igd	Telah diambil pemilik

Analisis :

Barang hilang sudah dikembalikan ke pemilik. Alur berjalan baik. Pencatatan telah dilakukan dengan baik.

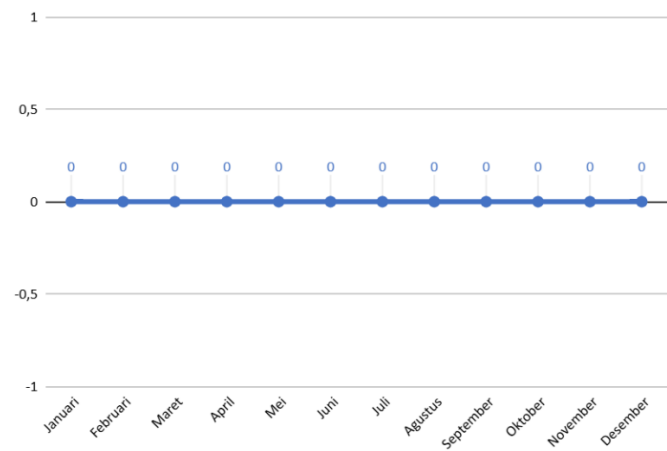
Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.3.3 Tabel Angka Kekerasan di Lingkungan Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1.	Angka kejadian kekerasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kekerasan

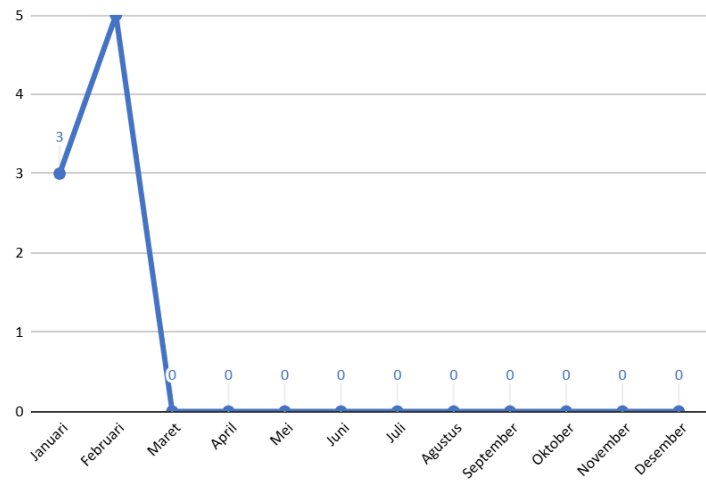


Analisis :
Tidak terdapat kejadian kekerasan karena pelayanan dilakukan dengan baik oleh seluruh karyawan dan tidak ada oknum yang menciptakan kerusakan.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.3.5 Tabel Angka Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Angka kejadian merokok di area Rumah Sakit	3	5										



Analisis :

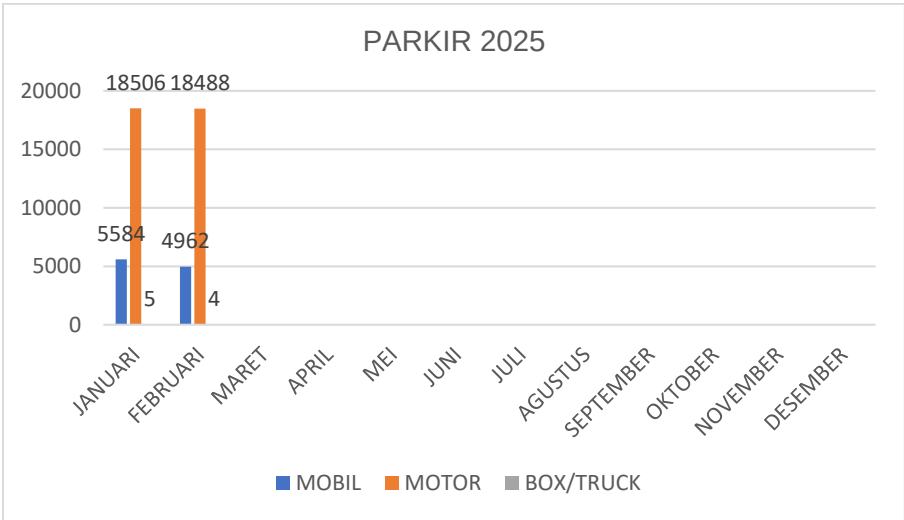
Angka ini relative kecil. Belum sepenuhnya tercatat. Yang tercatat adalah laporan security saat keliling saja.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.4 Parkir

3.5.4.1 Grafik Jumlah Parkir Keluar Non Member



Analisis :

Progres parkir bulan januari masih fluktuatif. Akan dilihat pada progress bulan Februari 2025

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.5 Humas Marketing

3.5.5.1 Perjanjian Kerjasama (PKS)

3.5.5.1.1 Pencapaian Kinerja PKS – IKS Februari 2025

No	Bulan	Target	Jumlah				Progres	Total Kurang
			Berlaku	ED	Baru	Kurang Baru		
1	Januari 2025	1 IKS baru	115	6	0	0	2 (review pihak kedua) 1 (progres evaluasi) 1 (tdk diperpanjang)	4
2	Februari 2025	1 IKS baru	118	1	1	0	3 (Proses Tanda Tangan Pihak kedua)	3

Analisis ;

- 1. Pada bulan Februari 2025, PKS Expired dengan instansi lain masih dalam progres serta menindaklanjuti progres PKS yang belum selesai di tahun lalu.
- 2. Draft yang dikirim ke perusahaan masih dalam tahap review.

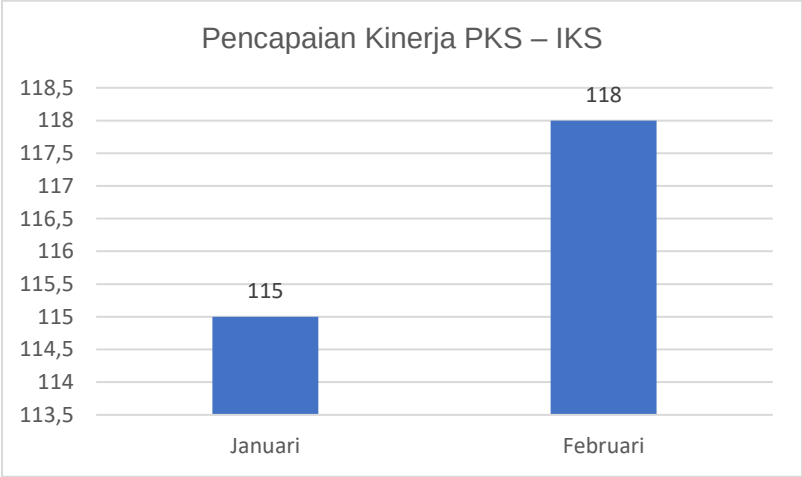
Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Memfollow up PKS yang sudah dikirim ke pihak kedua

3.5.5.1.2 Tabel Progres IKS Baru Februari 2025

NO	NAMA PKS	PROGRES PENGURUSAN	KENDALA
1	PT Nayaka Era Husada	Review pihak kedua	Tanda Tangan Pihak

			Kedua
2	Klinik Brawijaya Lawang	Review pihak kedua	Perbedaan template draft PKS
3	PT. Asuransi Mandiri Inhealth Manage Care Indonesia	Review pihak kedua	Tanda Tangan Pihak Kedua
4	PT. Kasoem Hearing	Mengulang karena ada pergantian PIC dan Direktur	Proses Review dan Tanda Tangan Direktur PT
5	PT Global Excel	Review	Perbedaan template draft PKS
6	PT Malang Intermedia Pers	Review	Proses Perpanjangan
7	PT BNI Life Insurance	Penambahan Addendum	Proses Pembuatan Addendum



3.5.5.2 Medical Check Up (MCU)

3.5.5.2.1 Pencapaian Hasil Kinerja MCU dan Vaksin Februari 2025

NO	BULAN	JUMLAH PASIEN
1	Januari	95
2	Februari	135
3	MARET	
4	APRIL	
5	MEI	
6	JUNI	
7	JULI	
8	AGUSTUS	
9	SEPTEMBER	
10	OKTOBER	
11	NOVEMBER	
12	DESEMBER	

Analisis ;

1. Jumlah peserta MCU dan Vaksin bulan Februari meningkat 1.4% dari bulan Januari

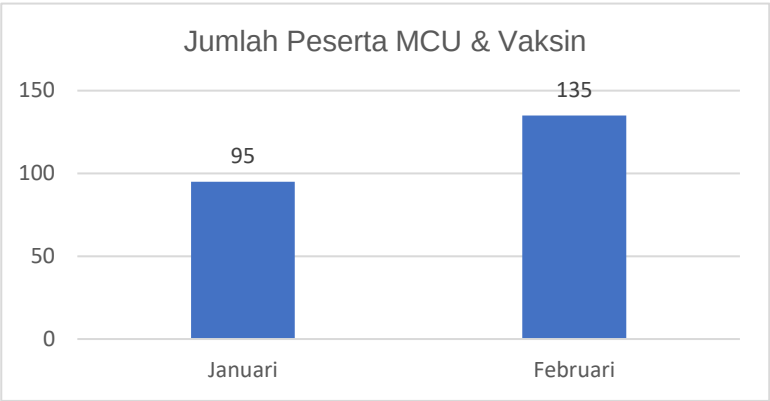
Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan Promosi melalui Social Media

2. Kunjungan ke Perusahaan rekanan, menawarkan program MCU karyawan

3. Mereview tarif/biaya pemeriksaan secara berkala

4. Melakukan Follow Up ke Perusahaan yang sudah diberikan Surat Penawaran



3.5.5.2.3 Kegiatan Kunjungan Eksternal

3.5.5.2.3.1 Tabel Jumlah Kunjungan Eksternal

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Jumlah Kunjungan	5	10									

Analisa :

Kunjungan eksternal mulai dilakukan Kembali untuk sosialisasi kebijakan yang berhubungan dengan rujukan pasien dan pengenalan staf baru. Terdapat peningkatan kunjungan pada bulan Februari karena telah direncanakand dan terjadwal.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi berkala.

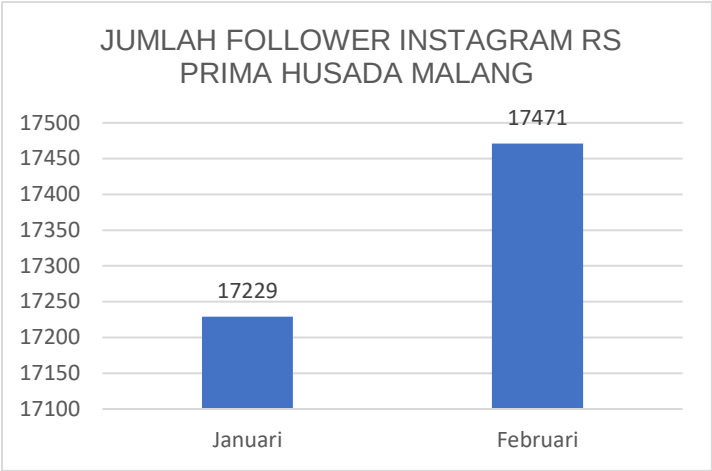
3.5.5.2.4 Digital Marketing

3.5.5.2.4.1 Daftar Kegiatan Digital Marketing

Platform Instagram

JUMLAH KONTEN BARU	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
FEED FOTO	3	7										
REELS	5	5										
STORY	6	10										
TOTAL	14	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL POSTINGAN (BARU + LAMA)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
FEED FOTO	6	11										
FEED VIDEO	0	0										
REELS	3	4										
STORY	29	33										
TOTAL	38	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)	17,229	17,471										
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATAN	496	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FOLLOWER												
TARGET	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

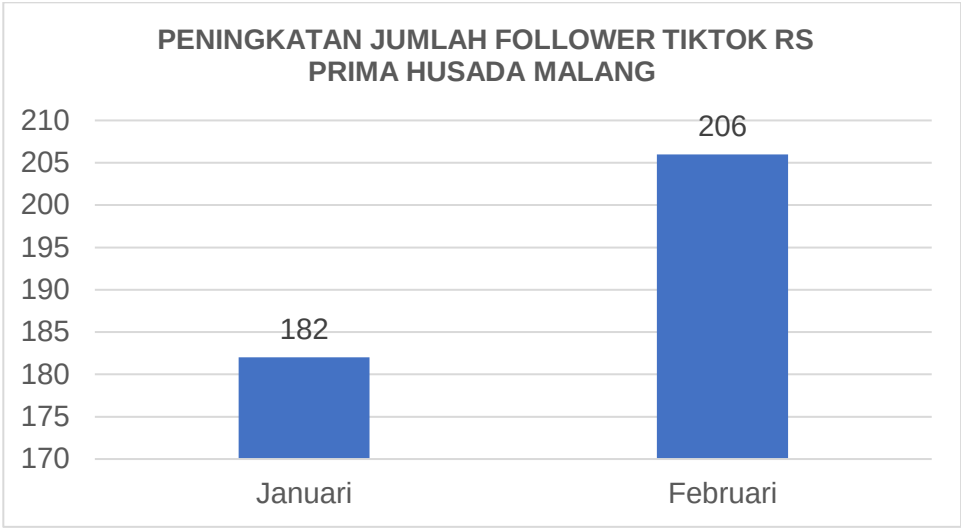


Analisa :
 Jumlah Follower Instagram RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 1% dari bulan Januari

- Rencana Tindal Lanjut :**
1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS setiap harinya
 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Platform Tik Tok

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH KONTEN BARU	2	3										
TARGET	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)	182	206										
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER	16	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TARGET	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH LIKE	45	72										



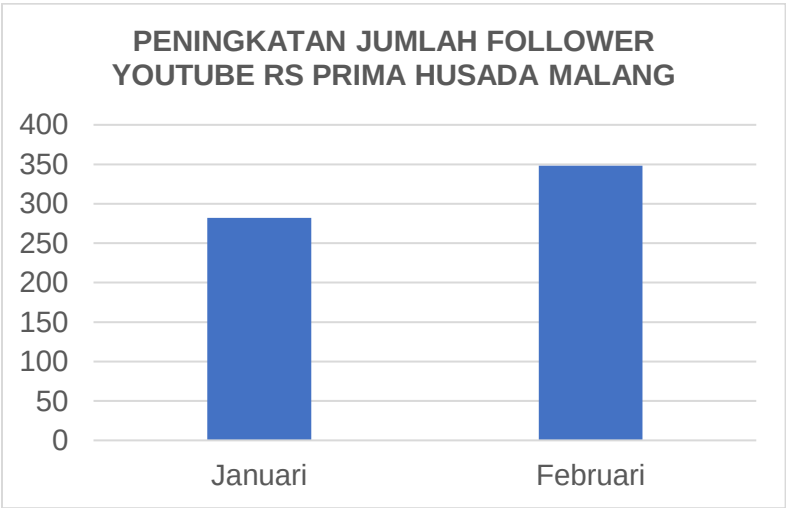
Analisa :
Jumlah Follower Tiktok RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 1.1% dari bulan Januari

- Rencana Tindal Lanjut :**
- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
 - 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 - 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Platform Youtube

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH KONTEN BARU	0	2										
TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH SUBS	282	348										
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATAN SUBS	4	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TARGET	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20



Analisa :
Jumlah Follower Youtube RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 1.2% dari bulan Januari

- Rencana Tindal Lanjut :**
- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
 - 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 - 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

3.5.5 Penjaminan

3.5.5.1 Piutang

3.5.5.1.2 Analisa Progres Penyelesaian Piutang

PIUTANG RS PRIMA HUSADAMALANG															
PERIODE 2025															
NO	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN SEBELUMNYA)	SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN BERJALAN)	SISA PIUTANG (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG				
		a	b	c	(a-b-c=d)	e	f	g	(e-f-g=h)	d+h	0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	>120 HARI
											Total				
PERIODE JANUARI 2025 :															
1	Asuransi	203,604,469	76,844,796	2,082,312	124,677,359	222,634,032	34,991,526	1,425,358	186,217,148	310,894,507	237,611,490	27,995,108	22,804,805	21,900,904	582,140
2	Perusahaan	267,288,964	109,418,709	1	157,870,254	91,931,808	5,912,000	-	86,019,808	243,890,062	363,707,073	2,812,349	17,789,291	33,805,194	25,676,104
3	Mandiri Inhealth	85,607,153	55,329,576	946,619	27,330,958	43,875,009	-	-	43,875,009	71,205,967	70,633,628	-	-	-	372,039
4	Jasa Raharja	120,917,190	119,996,274	1	920,917	81,120,474	-	-	81,120,474	92,041,391	91,130,474	-	-	-	92,041,391
5	BPJS Ketenagakerjaan	745,739,611	-	-	745,739,611	428,693,014	-	-	428,693,014	1,174,432,625	1,167,948,098	2,376,100	-	497,639	3,710,742
										Total Saldo	1,882,464,553	3,723,122,062	33,182,607	43,615,079	56,303,734
															30,341,078
															1,882,464,553
PERIODE FEBRUARI 2025 :															
1	Asuransi	310,890,495	195,143,500	3,453,339	112,293,656	288,168,610	27,204,170	1,021,818	259,942,622	372,236,278	335,610,035	13,873,869	-	22,270,234	582,140
2	Perusahaan	243,890,062	54,574,387	0	189,315,676	127,967,748	-	-	127,967,748	317,283,424	395,790,049	42,760,383	3,403,421	34,334,661	40,994,911
3	Mandiri Inhealth	71,205,967	33,691,344	552,929	36,961,695	17,686,913	-	-	17,686,913	54,648,608	54,276,568	-	-	-	372,039
4	Jasa Raharja	82,041,391	81,120,474	1	920,918	230,199,405	591,728	-	229,607,677	230,528,595	229,607,677	-	-	920,917	230,528,594
5	BPJS Ketenagakerjaan	1,174,432,625	449,762,830	182	724,669,613	328,921,793	-	-	328,921,793	1,053,591,407	995,650,064	51,397,816	2,375,100	-	4,208,377
										Total Saldo	2,028,288,312	1,810,834,393	107,992,069	5,775,671	57,525,812
															46,157,467
															2,028,288,311

Keterangan :
Cut Off Piutang per 28 Februari 2025 saldo akhir Rp 2,028,288,311

3.5.5.2 Klaim Pending

NO	MASALAH	DAMPAK	TINDAK LANJUT
1.	Indikasi pasien untuk dirawat inapkan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
2	Rujuk dihari yang sama	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
3	Persalinan normal ditolong bidan atau dokter	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
4	Syok hipovolemic direseleksi menjadi syok unspecified	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
5	Indikasi kunjungan rawat jalan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
6	Rawat luka berulang dapat dilakukan di FKTP	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
7	Konsul internal 1 tagihan dengan poli utama	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
8	Kontrol berulang potensi fragmentasi	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
9	Fisioterapi tidak sesuai standar pelayanan, pelayanan 8x	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending

3.5.6 PIPP – MOD – MPP

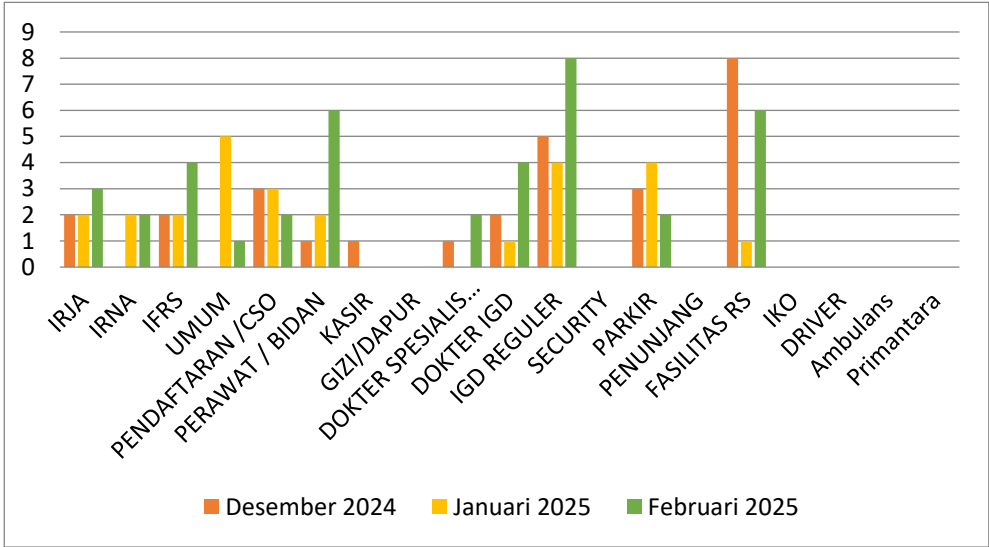
3.5.6.1 Laporan Komplain Pasien

1.5.6.1.1 Tabel Distribusi Laporan Komplain Pasien Per Unit Bulan Februari 2025

NO	JUMLAH KOMPLAIN PASIEN TERHADAP UNIT	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025
1.	IRJA	2	2	3

2.	IRNA	0	2	2
3.	IFRS	2	2	4
4.	UMUM	0	5	1
5.	PENDAFTARAN /CSO	3	3	2
6.	PERAWAT / BIDAN	1	2	6
7.	KASIR	1	0	0
8.	GIZI/DAPUR	0	0	0
9.	DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)	1	0	2
10.	DOKTER IGD	2	1	4
11.	IGD REGULER	5	4	8
12.	SECURITY	0	0	0
13.	PARKIR	3	4	2
14.	PENUNJANG	0	0	0
15.	FASILITAS RS	8	1	6
16.	IKO	0	0	0
17.	DRIVER	0	0	0
18.	Ambulans	0	0	0
19.	Primantara	0	0	0
Total		25	28	26

3.5.7.1.1 Grafik Laporan Komplain Pasien Per Unit Februari 2025



- Analisis :**
- Jumlah pasien komplain selama Bulan Februari 2025 mengacu pada komplain pasien. Asal komplain pasien ditemukan dari beberapa unit yang ada di RS.
- Jumlah complain Pada bulan Februari 2025 meningkat dibanding pada bulan sebelumnya. Pada bulan desember 2024 28 kasus complain, pada Januari 2025 turun menjadi 26 kasus complain Sedangkan pada bulan februari 2025 sebanyak 40 kasus
 - Komplain terbanyak pada bulan Februari 2025 yaitu dari bagian IGD sebanyak 8 kasus, fasilitas RS sebanyak 6 kasus, perawat/bidan sebanyak 6 kasus yang disampaikan secara kuesioner, WA maupun tatap muka langsung.

3. Jumlah komplain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 6 kasus komplain dengan rincian :
- 1) Fasilitas RS sebanyak 4 kasus air kran kloset sering habis, di ruang anak mohon di perbaiki untuk tayangan anak2 nya biar tidak bosan, Ruang Cempaka 4B bisa dipasangkan gordena, karena ranjang yg dekat jendela terasa panas di siang hari, untuk bed yang dekat cendela bisa ditambah gordena lagi karena kalau siang sangat silau
 - 2) Parkir sebanyak 2 kasus yaitu terkait pembayaran parkir yang terlalu mahal, permintaan diberikan kartu bebas parkir untuk pasien rawat inap,

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.2 Tabel Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Februari 2025

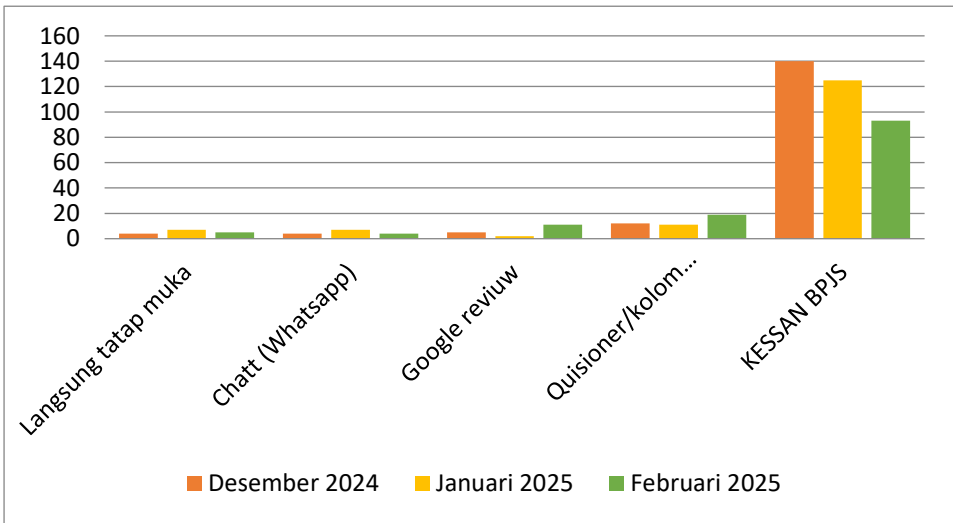
NO	JENIS PASIEN KOMPLAIN	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025
1.	Langsung tatap muka	4	7	5
2.	Tidak Langsung :			
	a. Chatt (Whatsapp)	4	7	4
	b. Google review	5	2	11
3.	Quisioner/kolom kritik saran	12	11	19
4.	KESSAN BPJS	140	125	93

Rincian KESSAN

KESSAN (Kesan dan Pesan Setelah Layanan) merupakan aplikasi dari BPJS Kesehatan untuk mendorong FKTP dalam meningkatkan layanan bagi peserta JKN-KIS serta memenuhi kewajiban terhadap kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan

NO	KETERANGAN	BINTANG 1	BINTANG 2	BINTANG 3	BINTANG 4	BINTANG 5
1.	KESSAN BPJS	0	0	1	18	74

3.5.7.3 Grafik Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Februari 2025



Analisis :

Pada bulan Februari 2025 jumlah jenis pasien komplain terbanyak didapatkan dari Quisioner yaitu sebanyak 19 kasus komplain. Sedangkan terbanyak kedua yaitu dari google review sebanyak 11 kasus complain, tatap muka sebanyak 5 kasus dan WA sebanyak 4 kasus.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.4 Tabel Waktu Tanggap dan Penyelesaian Komplain Bulan Februari 2025

NO	Jenis Pasien Komplain	Waktu Tanggap		Waktu Penyelesaian		< 3 hr Manajerial RS	7 hr ke PT
		Standard < 5 ‘	Pencapaian (dari waktu total dibagi jml komplai atau rata2 waktu tanggap)	Standard < 60 ‘	Pencapaian		
1.	Langsung tatap muka	100%	100%	100%	5	0	0
					100%		
2.	Chat (WA/Tele/SMS/IG)	100%	100%	100%	4	0	0
					100%		
3.	Google reviuw	100%	100%	100%	11	5	0
					56%	54%	
4.	Quisioner/kolom kritik saran	100%	100%	100%	100%	0	0
5.	KESSAN	100%	0	100%	93	0	0
					100%		

Analisis :

Waktu tanggap dan penyelesaian komplain pasien pada bulan Februari 2025 masih ada yang belum sesuai target 100% yaitu complain melalui google riviuw dengan capaian 56% hal ini dikarenakan ada beberapa kasus complain yang tidak bisa langsung diselesaikan seperti fasilitas RS yang memerlukan diskusi dengan manajemen.

Jumlah komplain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 6 kasus complain dengan rincian :

- 1) Fasilitas RS sebanyak 4 kasus air kran kloset sering habis, di ruang anak mohon di perbaiki untuk tayangan anak2 nya biar tidak bosan, Ruang Cempaka 4B bisa dipasangkan gorden, karena ranjang yg dekat jendela terasa panas di siang hari, untuk bed yang dekat cendela bisa ditambah gorden lagi karena kalau siang sangat silau
- 2) Parkir sebanyak 2 kasus yaitu terkait pembayaran parkir yang terlalu mahal, permintaan diberikan kartu bebas parkir untuk pasien rawat inap,

Rencana Tindak Lanjut :

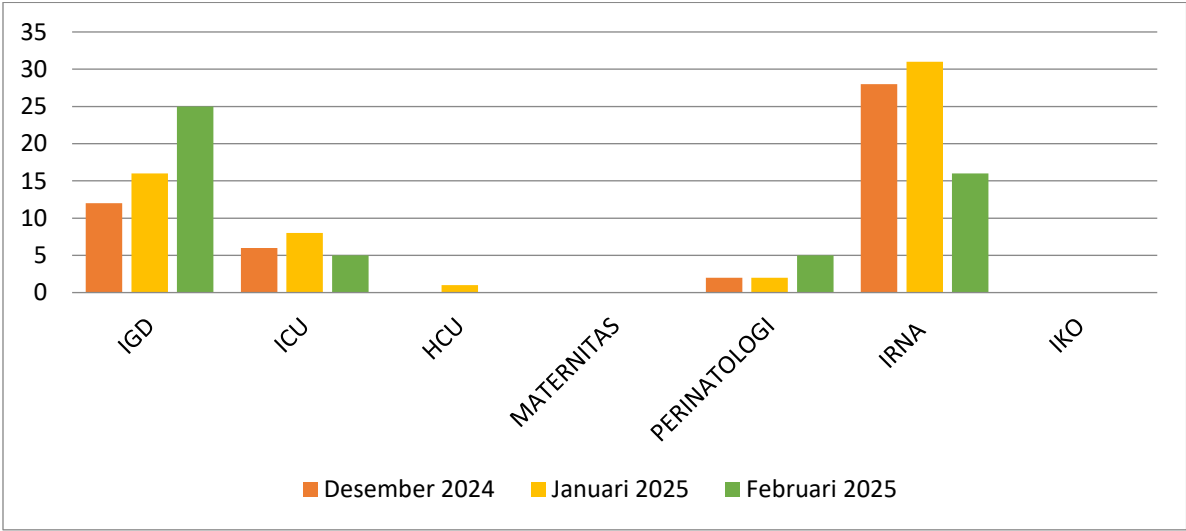
Penyelesaian komplain dilakukan dengan melakukan telusur lapangan sederhana dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.5 Laporan Pasien Rujuk

3.5.7.5.1 Tabel Distribusi Pasien Rujuk Per Unit Bulan Januari 2025

NO	UNIT PERUJUK	NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
1.	IGD	20	12	16
2.	ICU	9	6	8
3.	HCU	0	0	1
4.	MATERNITAS	2	0	0
5.	NEONATOLOGI	2	2	2
6	IRNA	15	28	31
7	IKO	0	0	0
Total		48	46	58

3.5.7.5.2 Grafik Jumlah Pasien Rujuk Eksternal Bulan Februari 2025



3.5.7.5.3 Tabel Rincian Pasien Rujuk Februari 2025

NO	NAMA PASIEN	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP	RS TUJUAN	ALASAN RUJUK	LAMA RAWAT	PLAVON HABIS
1	Ny. NANANG PRIYAMBODO	IGD	ICH	DR. Dewi Maharani. Sp.S	RS Lavaletet	PRO Tatalaksana Lebih Lanjut	2	Tidak
2	TN MOH.SHOLEH	IGD	ALO CARDIOGENIC	DR. YOGA SP.JP	RSUB	PRO Tatalaksana Lebih Lanjut	1	Tidak
3	NY. ASMAH	IRNA	CVA ICH	dr. Farid	RSUD Bangil	PRO EVD dan evakuasi hematome	1	Tidak
4	TN.MASKUR	IGD	COS 335 susp FBC	dr. FACHRI, SP,S	RS SUTOMO	PRO OP BEDAH SARAF DAN PENANGANAN LANJUTAN	1	Tidak
5	NY. KAMSINI	IGD	Cva ICH	dr. Dewi Sp. S konsul dr. Fachriy, Sp. BS	RS LAVALETE	PRO STROKE UNIT	2	Tidak
6	TN. SETO HARYONO	ICU	UAP pro PCI (riwayat oktober 2024 STEMI inferior) RV failure	dr. IRA SP. JP	RS UMM	PRO PCI	2	Tidak
7	BY. NY. FAJRIN ARI HIDAYATI	NEO	RDS	dr. Dicky, Sp. A	RSSA	PRO ventilator	3	Tidak
8	Tn. Ali Bawon	ICU	adhf, hhd, cad, efusi pleura dextra, hipokalemia, dm, aki	dr. Yoga Sp.JP raber dr. Ardhi Sp.PD	RSUB	PRO HD	5	Tidak
9	Tn Tn. Asahri	IRNA	CVA Infark	dr. Farid, Sp. S k/ dr. Eko, SP. KFR	RSSA	PRO STROKE UNIT	5	Tidak

10	Ny. Endang Suriana	IGD	DOC ec susp Encephalopaty Uremikum	DR. Ardhi.Sp.PD	RS LAVALETE	PRO HD Cito	1	Tidak
11	Tn. Samad	IGD	DOC, Ensofalopati Uremikum, Sepsis, Hopohlikemia, Anemia	dr. Ardhany Sp. PD	RS LAVALETE	Pro HD Cito	2	Tidak
12	Ny. Rini	ICU	Syok Cardiogenik, NSTEMI, ADHF dt CAD	dr. Mira Sp. Jp	RST. Soepraone	Pro PCI	3	Tidak
13	Tn Sugeng Irianto	IGD	CVA 2nd Attack+HT Hydrocephalus VP Shunt, CVA SAH	dr. Farid Sp.N	RSUD Lawang	penatalaksanaan lebih lanjut	1	Tidak
14	Tn Zawatul Islam	IRNA		dr Fachri Sp BS	RSSA	PRO DSA	6	Tidak
15	Tn. SAIKHUL ANAM	IGD	NSTEMI, ADHF	dr Ira Sp JP	RSI Aisiyyah	Pro PCI	2	Tidak
16	Ny. Sabna Anggraini	ICU	P1001 AB0, Ekslamsi, Helpp Syndrome	dr. Humairah, Sp. OG	RSSA	Pro tatalaksana Ekslamsi	1	Tidak
17	NY. NASIRAH	IRNA	post hipoglikemia, susp. Makroadenoma, syndrom geriatric	dr. Ardhany, Sp.PD	RSJ LAWANG	PRO PERAWATAN DENGAN Sp.PD-Kger	6	Tarif rs : 10.638.087 Plavon : 6.711.700 Minus : 3.926.387
18	NY. TARMINI	ICU	Cardiogenic Shock, AF, CKD, Anemia	dr Yoga Sp JP	RSSA	PRO TPM dan Back up HD	2	Tidak
19	Tn Atim	IRNA	CKD st V, ADHF dt HDD dd DM cardiomyopathy	dr Heri Sp PD	RSUD Lawang	Pro HD Cito	2	Tidak
20	BY NY WIDYASARI	NEO	RDS ok HMD dd neonatal pneumonia, Prematur BBLR	dr. FIONA , Sp.A	RST. Soepraone	PRO ventilator	1	Tidak
21	TN. KUDJAENI	IRNA	DM, ACKD	dr. ARDHANY, Sp. PD-KGH	RSSA	PERAWATAN Sp. PD KGEH	5	Tidak
22	NY. SUMARTINI	IGD	DOC ec Susp. CVA Hemmorigic	dr. Farid, Sp. S	RSSA	PRO VP SHUNT	2	Tidak
23	BY NY FUJI	NEO	TTNB , Susp. PJB kritikal	dr. Dicky Sp. A	RST	Perawatan lebih lanjut	4	Tidak
24	Tn. Slamet Yantoko	IRNA	DM type 2, Diabetic foot, colic abdomen, sepsis MODS, AKI st 3, Anemia	dr. Ardhi Sp. PD	RSUD Lawang	Perawatan lebih lanjut pro HD	5	Tidak
25	Ny. Saudah	IGD	DOC ec Susp CVA 2nd attack, DM	dr. Farid Sp.N	RST Soepraoen	PRO STROKE UNIT	1	Tidak
26	Ny. Mardiyah	IGD	DOC ec Susp. CVA Infark. Didrocephalus	dr. Farid Sp. N	RS. Lavalette	Pro Bedah Syaraf	1	Tidak
27	Tn. Ari Wibisono	IRNA	Trombus Inferior Vena Cava, Pulmonary Hypertension, Effusion pleura dekstra dd susp. Massa paru dex	dr. Mira Sp. Jp konsul dr Elvi Sp. Jp	RS Karsa Husada Batu	Pro penatalaksanaan lebih lanjut	4	Ya
28	Tn. Harso Subali	IGD	Obseravsi Dyspneu	dr. Heri Sp. PD	RSSA	Pro HD	1	Tidak
29	Sdr. Raihan Asisa Adiyatma	IGD	OF Os Tinia et Fibula Sin + Dislokasi Genu Sin + CKRS	dr. Oka Sp. OT	RSSA	Pro penatalaksanaan lebih lanjut	1	Tidak
30	Tn. Miseli	IRNA	Hematemesis, Dilatasi Gaster	dr. Ardhany Sp. PD	RSSA	Pertimbangan Endoscopy dan perawatan Sp. PD KGH	2	Tidak
31	Ny. Anindya Ayu Pavitasari	IGD	P1001Ab000 post SC H+9 dengan late HPP ec Subinvolusi uteri	dr Humairah Sp. OG	RSSA	Pro perawatan Intensif	2	Tidak
32	Tn. Satim	IGD	Tetraparase Susp PCI, HT Emergency, Central Cord syndrome SCI	dr. Oka Sp. OT	RSSA	Pro MRI	2	Tidak
33	Ny. Kurniawati	IRNA	DM II, CKD, ISK. HT	dr Ardhi Sp. PD	RS. Lavalette	Perawatan lebih lanjut	2	Tidak
34	Ny. Kastumi	IRNA	Dysphagia Susp Tetanus	dr. Heri Sp. PD	RSUD Soetomo	Pro Isolasi Tetanus	4	Tidak
35	Ny. Atim	IRNA	DM Tipe 2, Diabetic Foot Dex, Sepsis, Susp. MDRA	dr. Ardhi Sp. PD	RSSA	Pro penatalaksanaan lebih lanjut	7	Tidak
36	Ny. Muchayanah	IGD	DOC ec Susp. CVA Hemoragic	dr. Farid Sp. N	RSSA	PRO STROKE UNIT	2	Tidak
37	Ny. Supi'ani	IGD	DOC ec CVA Infark, DM Hiperqlikemia	dr. Farid Sp. N	RS. Lavalette	PRO STROKE UNIT	2	Tidak
38	Tn. Supeno	IGD	STEMI Anteroseptal	dr. Mira Sp. Jp	RS. UMM	Pro PCI	1	Tidak
39	Tn Haryono	IRNA	COR 456 + CF Costae 2-3 Posterior Sin + CF Metacarpal Digiti IV - V	dr. Anton Sp. B Konsul dr. Oka Sp. OT	RS. RKZ	Pro BTKV dan Orhopedi	3	Tidak
40	Ny. Herlita Putri Oktaviana	IRNA	Susp. Autoimun Disease, Hiponatremi, Hipokalemia, Diare	dr. Ardhany Sp. PD	RS. Lavalette	Pro penatalaksanaan lebih lanjut	3	Tidak
41	Tn. Jayadi	IRNA	Acute on CKD, Uremic Lung, ADHF	dr. Ardhi Sp. PD	RS. Lavalette	Pro HD	1	Tidak
42	An. Ilham Ma'ruf	IRNA	Intususepsi	dr. Dicky Sp. A	RS. Lavalette	Pro Bedah Anak	2	Tidak

43	Tn.IMRON ROSADI	IGD	Pneumothorax Dextra	dr. Andi,sp.p	RSSA	pemasangan Thorax Drain	2	Tidak
44	By. Ny. Ela Indawati	NEO	RDS	dr. Fiona Sp.A	IGD RST	Rujuk Pro Ventilator	3	Tidak
45	By. Ny. ratnawati	NEO	RDS ok Neonatal pneumonia dd HMD, NEC, Prematur	dr. Fiona Sp.A	RSSA	Rujuk Pro Ventilator	3	Tidak
46	Tn. SUKO	IGD	STEMI inferior, Junctional rhythm, Cardiogenic shock	dr. yoga SP.JP	RS UMM	pro PCI	1	Tidak

Analisis :

1. Terjadi peningkatan jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain dalam bulan Februari 2025, pada bulan desember 2024 sebanyak 46 pasien pada bulan januari 2025 sebanyak 58 pasien Sedangkan pada bulan februari 2025 sebanyak 46 pasien.
2. Alasan rujuk karena sarana dan prasarana tidak dimiliki oleh RSPH Malang, seperti :
 - a) Pro PCI
 - b) Pro CVCU
 - c) Pro stroke unit
 - d) Pro HD
 - e) Pro Bedah digestif
 - f) MRI
 - g) Pro bedah saraf lanjutan
 - h) Membutuhkan alat khusus
 - i) Membutuhkan pengobatan ARV
3. Alasan rujuk karena plavon habis menurun dari bulan sebelumnya bulan Januari 2025 sebanyak 7 pasien dengan total minus Rp. 20.093.811 sedangkan pada bulan februari 2025 sebanyak Rp. 3.926.387

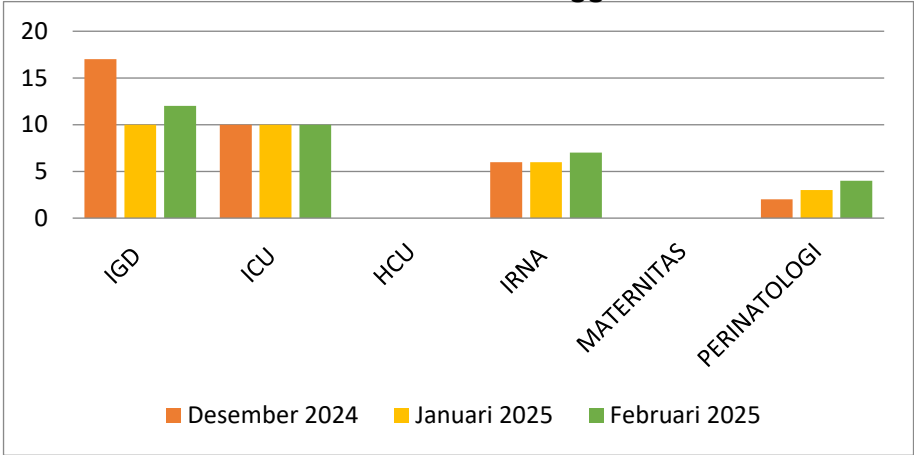
Rencana Tindak Lanjut:

1. Dilakukan evaluasi alasan terhadap rujukan pasien keluar yang semakin meningkat
2. Dilakukan komunikasi dengan DPJP melalui rapat komdik terkait plavon minus.

3.5.7.5.3 Jumlah Pasien Meninggal Bulan Februari 2025

NO	UNIT ASAL PASIEN MENINGGAL	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025
1.	IGD	17	10	12
2.	ICU	10	10	10
3	HCU	0	0	0
4.	IRNA	6	6	7
5.	MATERNITAS	0	0	0
6	NEONATOLOGI	2	3	4
Total		17	35	29

Grafik Jumlah Pasien Meninggal Februari 2025



Tabel Rincian Pasien Meninggal Februari 2025

NO	NAMA PASIEN	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP
1	Tn ZAINAL ABIDIN BIN MD TAHIR	ICU	Cardiogemic Syock	dr Yoga, Sp.JP
2	TN. SUJA'I	IGD	DOC EC SUSP CVA INFARK	dr Yeni
3	TN. SUJIONO	ICU	CVA ICH, Respiratory Failure	dr. Farid Sp. N
4	TN. SUDARSONO	IGD	DOA	dr. Sofia
5	NY. TITIK RUSMIATI	IGD	UAP+TAVB+ARDS+DM TYPE 2+CKD ST 3	
6	TN ACHMAD NURDIN FAUZI	IRNA	jaundice post op laparotomy dan colostomy, syok cardiogenic	dr Ardhany Sp PD
7	NY MUDJAYANA	IRNA	DM Hiperglikemia, DM KAD, ISK	dr Ardhany Sp PD
8	TN ASRON	IGD	DOA	dr Dira
9	TN. ABDULLOH	ICU	ARDS+SYOK SEPTIC DD SYOK CARDIOGENIK+HIPOKALEMIA+AZOTEMIA+POST OP LAPARATOMY	dr. MIRYANTI SP.JP
10	Ny. Nur Yatin	ICU	CVA ICH, HF	dr. Farid Sp. N
11	Ny. DJUMIATIN	ICU	ARDS,Pneumonia,Efusi Pleura Dextra	dr. Andy Sp. P
12	TN DITO HARMADI	IGD	CVA ICH	DR FAHIMA SP S
13	Ny Tripena Sringing	IRNA	DM Hiperglikemia, Bacterial Infection, HT	dr Ardhany Sp PD
14	By Ny Wahyu Saskya	NEO	IUVD + Hidrosefalus	dr Aida Sp OG
15	By. Ny Delia Wahyu Saputri	NEO	Imatur, BBLASR	dr Humaira Sp OG
16	tn sutono	ICU	TB on therapy, pneumonia, ALO	dr.Elvi Sp. P
17	NY. Juana	IGD	DOC1111111	dr. Heri SP.PD
18	An. MUHAMMAD ABRAM ARDIANSYAH	IRNA	DSS, RESPIRATORY FAILURE	dr. DICKY, Sp, A
19	Ny. Suparti	IGD	Cardiac arrest ec ALO	dr Yoga Sp. Jp
20	Ny. Musllicha	ICU	Syock Sepsis, DM Diabetic Foot, Anemia	dr. Zora Sp. PD konsul dr Robby Sp. An. Konsul dr Zaki Sp. B
21	Tn. Sukarno	ICU	Ca Paru sinistra, Anemia, trombositopenia	dr Ardhany Sp PD
22	Ny. Suparni	IGD	DOC dt Hipoglikemia dd stroke, General weeknes dr low intake, geriatric probem	dr Ardhany Sp PD
23	Ny. Ngatinah	IRNA	Susp. CVA Thrombosis dd ICK 2 nd attack, DM Hiperglikemia	dr Fahima Sp. N kosnul dr Zora Sp. PD
24	Ny. Riyamah	IRNA	COPD, Anemia, Hipokalemia	dr Andy Sp. A Konsul Heri Sp. PD konsul dr Yoga Sp. Jp
25	Ny. Sahtuwi	IRNA	Sepsis, Anemia. CKD	dr. Ardhany Sp. PD
26	Ny. Solichah	ICU	DOC, NSTEMI, Hematemesis	dr. Ira Sp. Jp
27	By Ny Amalia	NEO	IUFD	dr Humaira Sp OG
28	Tn. Dahniyar Afandi	ICU	Pneumonia, Efusi pleura, Hiponatremi, Respiratory Failure	dr. Ardhany Sp. PD Konsul dr Heru Sp. An
29	Tn. Soenadi	IGD	DOC ec Respiratoty Failure	dr. Heru Sp. An Konsul dr Elvi Sp. P
30	Ny. Siti Fatimah	IGD	Uremic Ensofalopati	dr. Ardhany Sp. PD
31	By. Ny. Siti Chusnia 2	NEO	Pneumonia	dr. DICKY, Sp, A
32	Ny. NGATMINI	IGD	DOC ec CVA infak	dr Farid SP.N
33	Tn. .IBNU HAJAR	IGD	Obs. Dyspsnea dd Pneumonia dd ALO	dr Elvi SP.P

Analisa :

1. Jumlah pasien meninggal dunia pada bulan Februari 2025 sebanyak 33 pasien
2. Jumlah terbanyak yaitu dari IGD : 12 pasien, ICU : 10 pasien, IRNA 7 pasien, dan Neonatologi sebanyak 4 pasien.
3. Pada bulan Desember 2024 Jumlah kasus DOA di IGD sebanyak 2 kasus.
4. Pengisian EWS sudah dilakukan di IGD dan IRNA.

Rencana Tindak Lanjut
Dilakukan evaluasi terhadap pasien datang ke IGD dengan kasus DOA

3.5.7.6 Laporan MPP

3.5.7.6.1 Tabel Rekap Berdasarkan Skrining Pasien

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN	BULAN / JUMLAH		
		DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025
1	Usia lanjut	-	-	-
2	Kasus penyakit kronis / terminal katastropik	-	-	-
3	Riwayat penggunaan alat bantu (kursi roda, walker, tongkat, dll)	-	-	-
4	Perkiraan biaya tinggi	-	-	-
5	Kemungkinan sistem pembiayaan yang kompleks (2 asuransi)	-	-	-
6	Pasien dengan fungsi kognitif rendah	-	-	-
7	Potensial komplain tinggi	-	-	-
8	Kasus yang melebihi rata-rata lama rawat	-	-	-
9	Kasus yang diidentifikasi rencana pemulangannya	-	-	-
10	Berisiko membutuhkan kontinuitas pelayanan	-	-	-
11	Berpotensi masalah hukum	-	-	-
12	Naik kelas pelayanan	-	-	-
13	Lain - lain	-	-	-

3.5.7.6.2 Tabel Jumlah Lain-Lain (Permasalahan Cara Bayar)

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN LAIN-LAIN (PERMASALAHAN CARA BAYAR)	BULAN / JUMLAH		
		DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025
1	Habis PKS	-	-	-
2	BPJS status Denda	-	-	-
3	BPJS status Premi	-	-	-
4	BPJS status Denda dan Premi	-	-	-
5	BPJS staus Usia lebih dari 21 tahun	-	-	-
6	BPJS status keluar atas kemauan sendiri	-	-	-
7	BPJS status penangguhan pembayaran	-	-	-
8	Rencana pengurusan BPJS	-	-	-
9	BPJS status tidak ditanggung	-	-	-
10	BPJS tidak aktif akhir bulan	-	-	-
11	BPJS peralihan Mandiri ke PBI	-	-	-

3.5.8 Cleaning Service

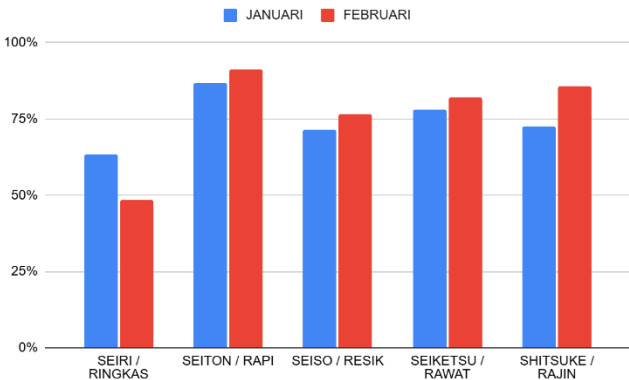
3.5.8.1 Indikator Kerja Cleaning Service

KATEGORI	DESKRIPSI
SEIRI	Penempatan Alat Kebersihan di Janitor/ trolly
	Penempatan Alat Kebersihan di Janitor/ trolly
SEITON	Kerapian baju dan kebersihan, penampilan petugas CS
	Kerapian baju dan kebersihan, penampilan petugas CS
SEISO	Membersihkan area kerja secara rutin sesuai jadwal
	Membersihkan area kerja secara rutin sesuai jadwal
SEIKETSU	Mematuhi SOP kebersihan
	Mematuhi SOP kebersihan
SHIKETSU	Konsistensi dalam menjalankan 5S secara mandiri tanpa pengawasan
	Konsistensi dalam menjalankan 5S secara mandiri tanpa pengawasan

	Konsistensi dalam menjalankan 5S secara mandiri tanpa pengawasan
--	--

3.5.8.2 Tabel Produktifitas *Cleaning Service*

NO	JENIS SPV	JANUARI	FEBRUARI
1	SEIRI / RINGKAS	63%	48%
2	SEITON / RAPI	87%	91%
3	SEISO / RESIK	71%	77%
4	SEIKETSU / RAWAT	78%	82%
5	SHITSUKE / RAJIN	72%	86%



Analisa :
 Produktifitas Unit CS dalam penilaian ini masih dalam moneyv karena memakai instrument supervise yang baru.Terdapat peningkatan kinerja dari 4 poin pada bulan february 2025.

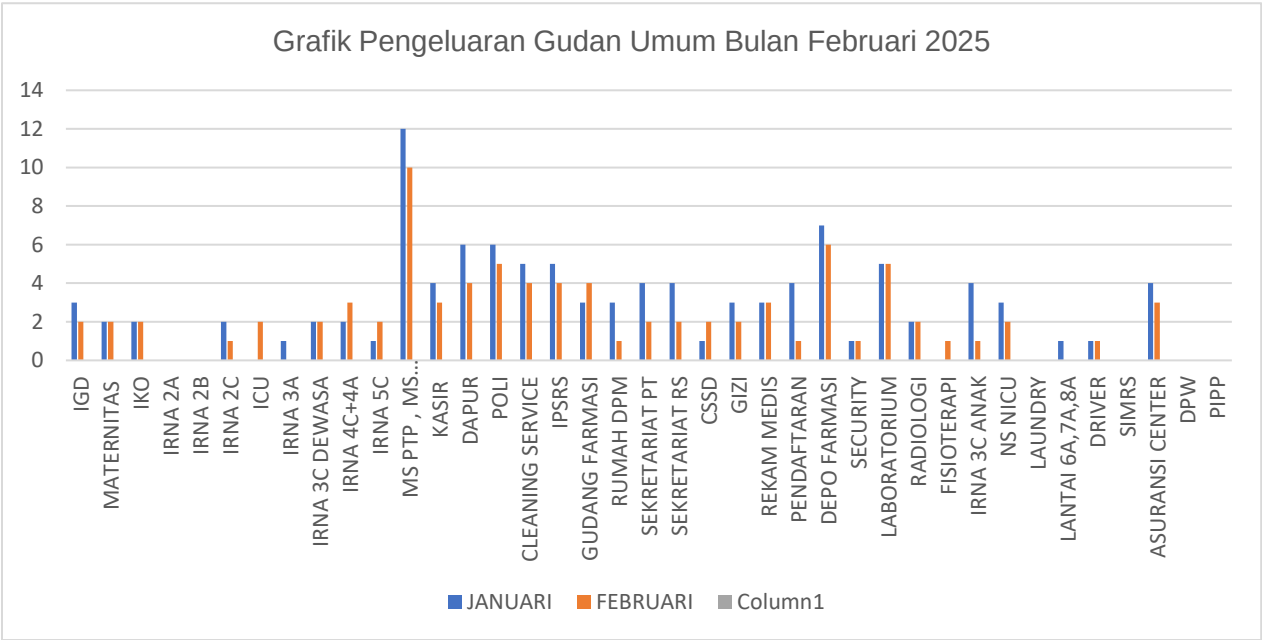
3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum

3.5.9.1 Tabel Laporan Pencatatan Pengeluaran Barang

NO	UNIT ASAL	JUMLAH BARANG		PERSENTASE
		JANUARI	FEBRUARI	
1	IGD	3	2	↓-50%
2	MATERNITAS	2	2	↑0%
3	IKO	2	2	↑0%
4	IRNA 2A	0	0	↓0%
5	IRNA 2B	0	0	↓0%
6	IRNA 2C	2	1	↓-100%
7	ICU	0	2	↑100%
8	IRNA 3A	1	0	↓0%
9	IRNA 3C DEWASA	2	2	↑0%
10	IRNA 4C+4A	2	3	↑33,33%
11	IRNA 5C	1	2	↑50%
12	MS PTP , MS LAWANG,MS KARLOS	12	10	↓-20%
13	KASIR	4	3	↓-33,33%
14	DAPUR	6	4	↓ -50%
15	POLI	6	5	↓-20%
16	CLEANING SERVICE	5	4	↓-25%
17	IPSRS	5	4	↓-25%
18	GUDANG FARMASI	3	4	↑25%
19	RUMAH DPM	3	1	↓-100%

20	SEKRETARIAT PT	4	2	↓-100%
21	SEKRETARIAT RS	4	2	↓-100%
22	CSSD	1	2	↓50%
23	GIZI	3	2	↓-50%
24	REKAM MEDIS	3	3	↓0%
25	PENDAFTARAN	4	1	↓-100%
26	DEPO FARMASI	7	6	↓16,66%
27	SECURITY	1	1	↑0%
28	LABORATORIUM	5	5	↑0%
29	RADIOLOGI	2	2	↑0%
30	FISIOTERAPI	0	1	↓100%
31	IRNA 3C ANAK	4	1	↓-100%
32	NS NICU	3	2	↑-50%
33	LAUNDRY	0	0	↑0%
34	LANTAI 6A,7A,8A	1	0	↓0%
35	DRIVER	1	1	↓0%
36	SIMRS	0	0	↓0%
37	ASURANSI CENTER	4	3	↓-33,33%
38	DPW	0	0	↓0%
39	PIPP	0	0	↑0%

3.5.9.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Barang Berdasarkan Asal Unit



Analisis :

Pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa data barang paling banyak ada pada unit Mutiara sehat dan,Depo Farmasi

Rencana Tindak Lanjut :

1. Mendisiplinkan kepatuhan jadwal pengambilan barang
2. Memberi edukasi ke unit agar tidak salah input barang atau salah unit
3. Menyarankan ke seluruh unit agar punya data inventaris ATK secara terperinci

3.6 Komite dan Tim

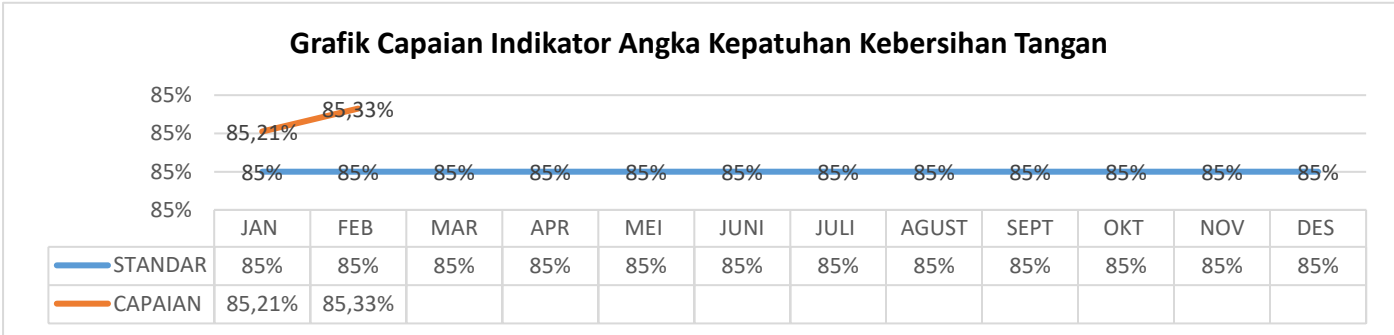
3.6.1 Komite Mutu

3.6.1.1 Indikator Mutu Nasional

NO	JUDUL	STAND	JAN '25	FEB '25	MAR '25	APR '25	MEI '25	JUN '25	JULI '25	AGUST '25	SEPT '25	OKT '25	NOV '25	DES '25	RATA-RATA
1.	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	85,21 %	85,33 %											
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	93,01 %	93,06 %											
3.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99,55 %	99,92 %											
4.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	100%	100%											
5.	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	89,16 %	89,38 %											
6.	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	0%	0%											
7.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	75,9%	76,21 %											
8.	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	96,9%	97,31 %											
9.	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	100%	100%											
10.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	100%	100%											
11.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	99,75 %	98,64 %											
12.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	100%	99,92 %											
13.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	99,81 %	99,79 %											

3.6.1.1Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

3.6.1.1.1.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



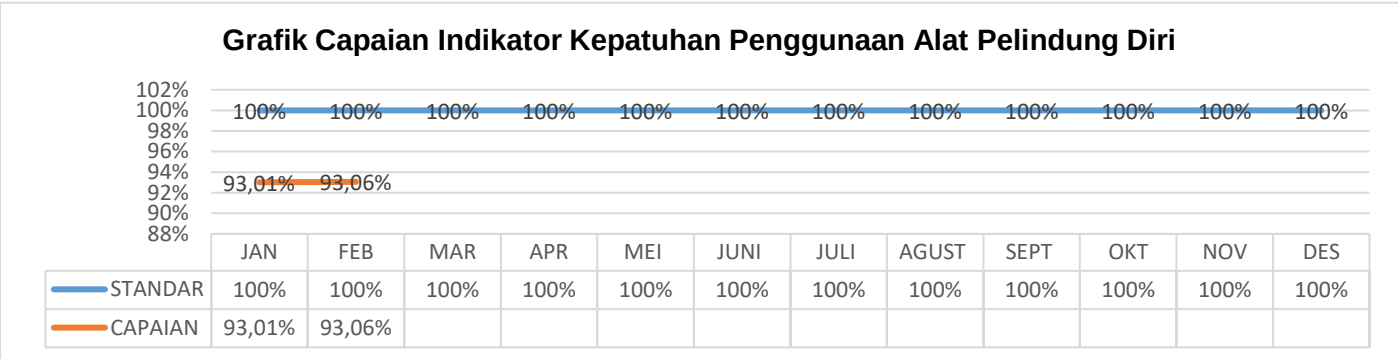
Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Januari tahun 2025 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu 85,21% dan pada bulan Februari capaian meningkat menjadi 85,33%. Meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin hingga 100%.				
DO	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.				
STUDY	Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Januari tahun 2025 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu 85,21% dan pada bulan Februari capaian meningkat menjadi 85,33%. Meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Seluruh petugas pelayanan pasien	-Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/IPC�	- Satu bulan

			- Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. - Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. - Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. - Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.		
--	--	--	--	--	--

3.6.1.1.1 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

3.6.1.1.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri



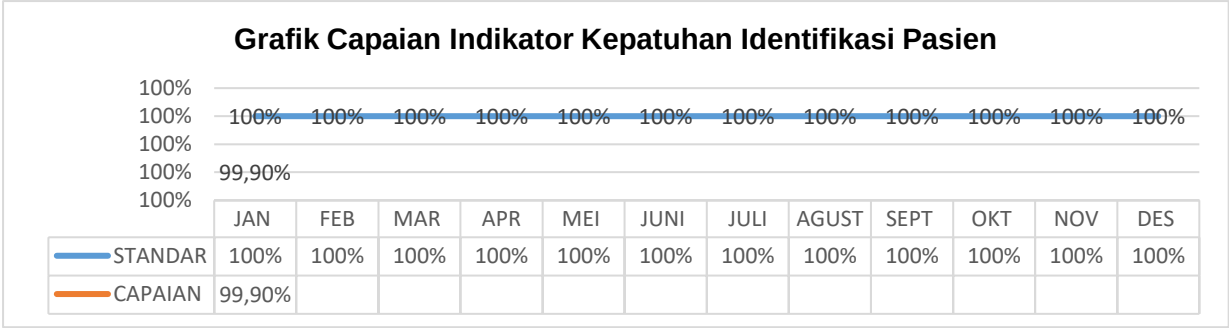
Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan penggunaan alat pelindung alat pelindung diri pada bulan Januari Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin hingga 100%.
DO	6. Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 7. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 8. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 9. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD petugas dapur).

	10. Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter. 11. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.				
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart. Capaian di bulan Januari tahun 2025 yaitu 93,01% dan dibulan Februari sebesar 93,06%. Dari hasil monitoring dan supervise, masih ditemukan petugas perawat yang memakai APD tidak sesuai dengan jenis tindakan dan transmisi penyakit, misalnya seperti injeksi lewat selang infus / hanya TTV ke pasien non infeksi namun menggunakan handscoon. Kepatuhan APD petugas dapur terutama pengolah makanan masih sangat kurang terutama penggunaan masker. Untuk petugas medis, masih ditemukan DPJP yang masih menggunakan handscoon meskipun hanya visite tidak melakukan tindakan. Untuk petugas CS ditemukan masih menggunakan handscon medis untuk mengepel yang seharusnya menggunakan handscoon kerja.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Tercapainya kepatuhan APD hingga maksimal 100%.	-Berkolaborasi dengan IPCD untuk melakukan edukasi terhadap para DPJP. -Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan. -Lakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. -Berikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. -Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. -Tanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	- Satu Bulan

3.6.1.1.2 Kepatuhan Identifikasi Pasien

3.6.1.1.3.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien

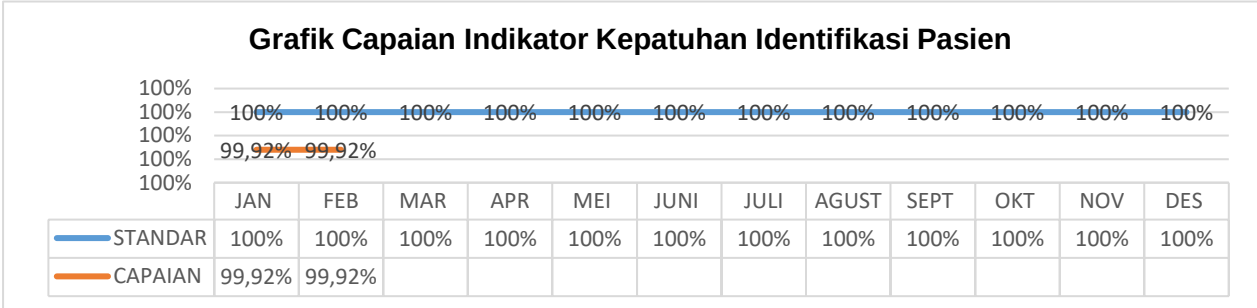


Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Januari Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	1. Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan 2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien 3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart dengan capaian bulan Januari tahun 2025 yaitu 99,90%. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Terus melakukan supervisi pada petugas unit 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu Bulan

3.6.1.1.3 Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

3.6.1.1.4.1 Grafik Capaian Indikator Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

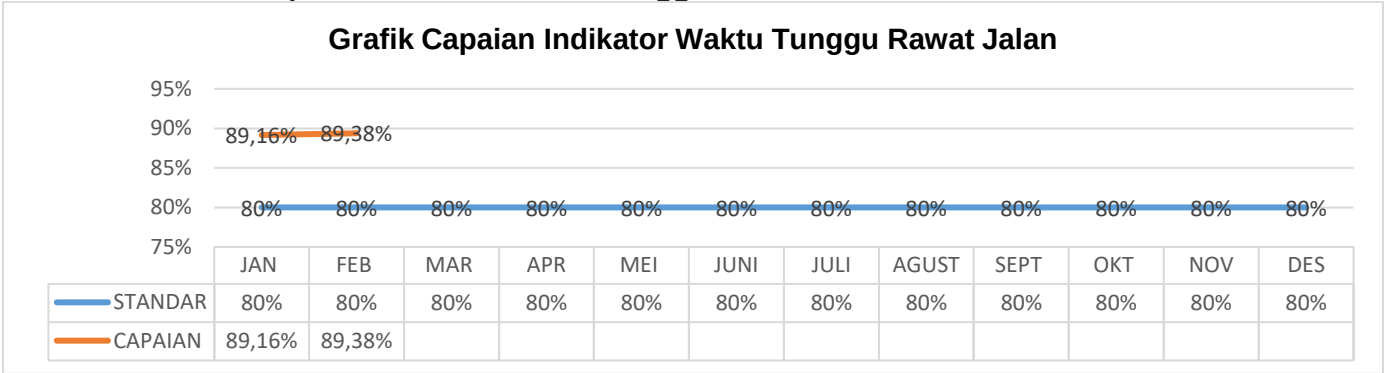


Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Januari Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	- Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan - Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien - Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart dengan capaian bulan Januari tahun 2025 yaitu 99,92 % dan pada bulan Februari sebesar 99,92%. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
-Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	- Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	- Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	- Terus melakukan supervisi pada petugas unit - Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	- Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	- Satu Bulan

3.6.1.1.1 Waktu Tunggu Rawat Jalan

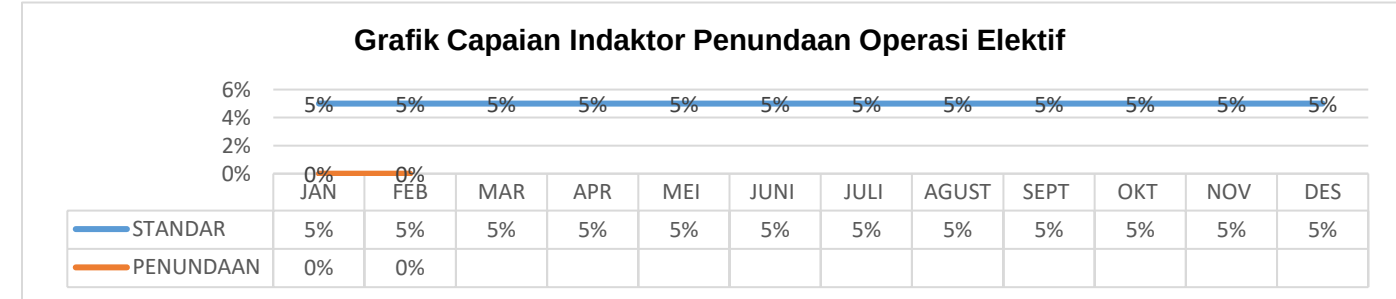
3.6.1.1.5.1 Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



Berdasarkan grafik capaian indikator waktu tunggu rawat jalan pada bulan Januari Tahun 2025 capaian telah mencapai standart dengan capaian di bulan februari yaitu 89,16% dan di bulan Februari 89,38%. Hal ini berkat kerjasama yang baik antara manajemen dan juga DPJP yang sudah berusaha datang tepat waktu dan evaluasi berkelanjutan yang telah dilakukan manajemen terhadap keterlambatan DPJP. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dibulan berikutnya.

3.6.1.1.2 Penundaan Operasi Elektif

3.6.1.1.6.1 Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif

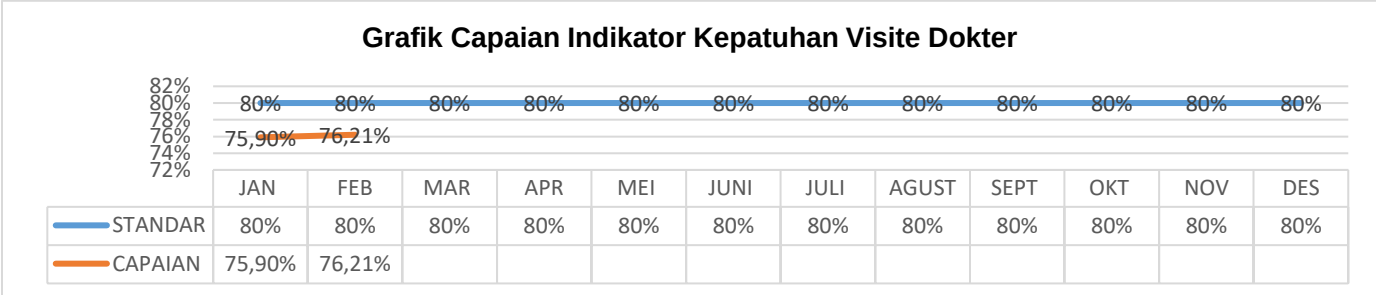


Dari grafik indikator penundaan operasi elektif bulan Januari dan Februari tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 0%, hal ini kerjasama yang baik antara unit Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian indikator penundaan operasi elektif . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.1.7 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

3.6.1.1.3 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

3.6.1.1.7.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter

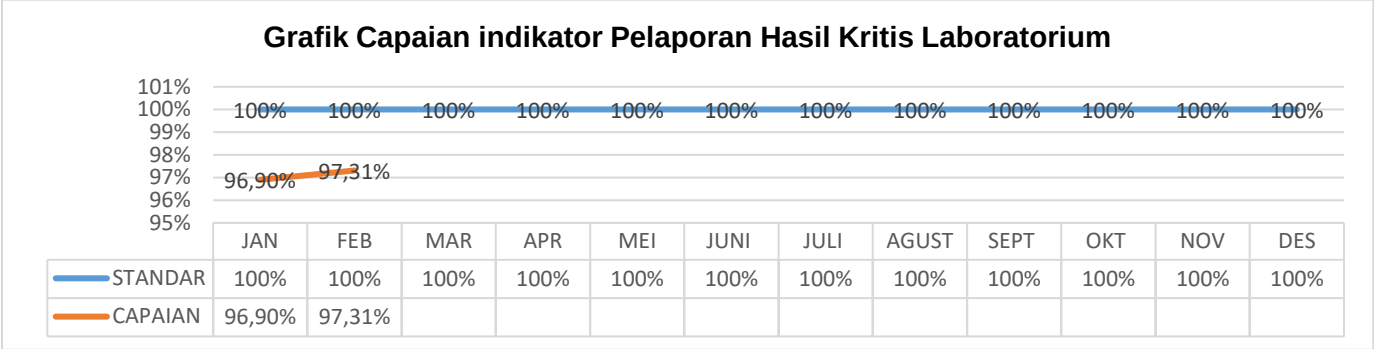


Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan visite Dokter pada bulan Januari Tahun 2025 belum mencapai standart, hal ini disebabkan karena Seluruh dokter Klinisi di Rumah Sakit Prima Husada adalah dokter tamu dari luar, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan waktu visite dokter hingga dapat mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan masukan pada SDM dan Kabid pelayanan untuk melakukan rekrutmen home dokter lebih banyak				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 75,9% dan di bulan februari 76,21%. Dari hasil supervisi didapatkan nya Angka kepatuhan waktu visite Dokter belum mencapai standart karena masih banyak dokter yang visite diatas jam 14.00 karena masih bertugas di RS asal karena RS Prima Husada belum memiliki dokter tetap. Dokter visite jam 07.00-14.00 : dr. Ira, Sp.JP, dr. Mira, Sp.JP, dr. Anton, Sp.B, dr. dr. Dicky,Sp.A , dr. Elvi, Sp.P, dr. Dewi, Sp.S, dr. Ardhi, Sp.PD, dr. Humairoh, Sp.Og, dr. Aida, Sp.Og, dr. Nimim, Sp.THT.KL, dr. Dokter visite jam 14.00-21.00 : dr. Heriyatmo, Sp.PD, dr. Andi, Sp.P, dr. Farid, Sp.S, dr. Yoga, Sp.JP (Tidak menentu)				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan selanjutnya	Melakukan KIE dan komunikasi dengan DPJP terkait waktu visite dokter, hal ini menjadi PR yang cukup besar bagi tim mutu dan manajemen karena sebagian besar DPJP tidak hanya bertugas di RS Prima Husada.	Manajemen RS	- Satu Bulan

3.6.1.1.7.2 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

3.6.1.1.8.1 Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

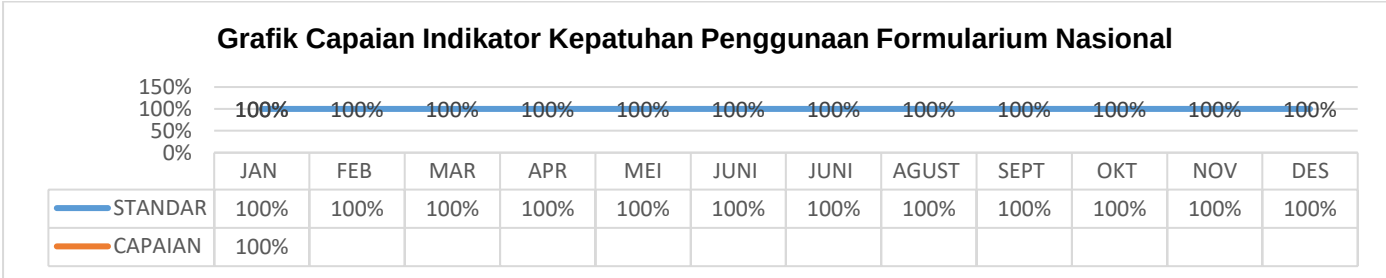


Berdasarkan grafik capaian indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium pada bulan Januari Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan pelaporan hasil kritis laboratorium hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan supervisi baik dari komite mutu maupun kepala instalasi laboratorium supaya seluruh petugas laboratorium segera melaporkan hasil kritis dan melakukan dokumentasi dengan baik dan lengkap.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 96,9% dan bulan Februari 97,31%. Berdasarkan hasil supervisi masih ada petugas yang melaporkan hasil kritis laboratorium tetapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan lengkap.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Capaian pelaporan hasil kritis laboratorium dapat mencapai standart 100% pada bulan berikutnya	- Menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang terlapor dan tidak terlapor - Memasukkan catatan ketidak patuhan staf kedalam evaluasi kinerja staf secara langsung kepada petugas laboratorium yang tidak melaporkan hasil kritis laboratorium ataupun yang melapor tapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik dan lengkap.	- Komite mutu - Kepala instalasi laboratorium	Satu Tahun

3.6.1.1.4 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

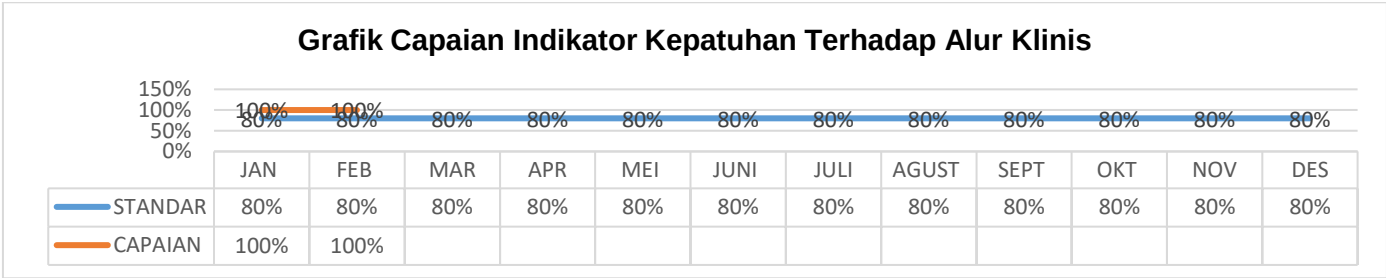
3.6.1.1.9.1 Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Dari grafik indikator Formularium Nasional bulan Januari dan Februari tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.6.1.1.5 Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

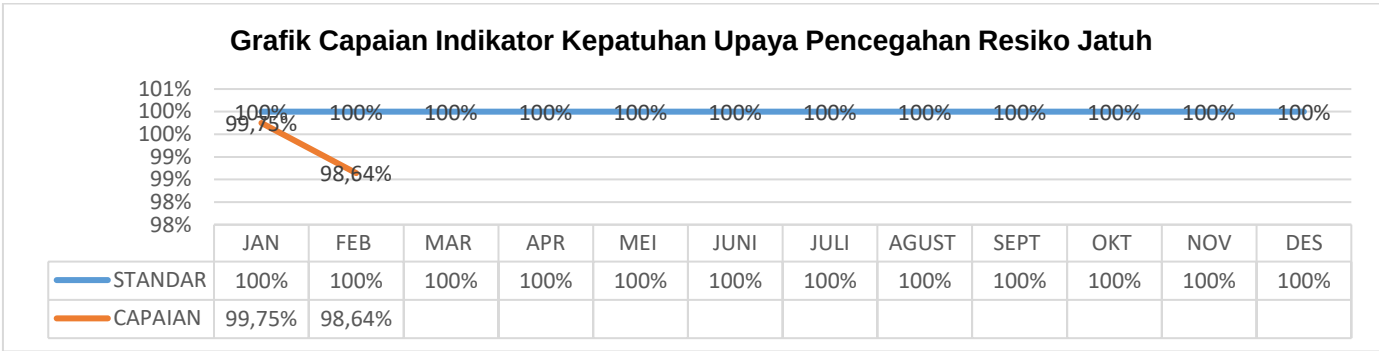
3.6.1.1.10.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



Dari grafik indikator kepatuhan terhadap alur klinis bulan Januari dan Februari tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.6 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

3.6.1.1.11.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

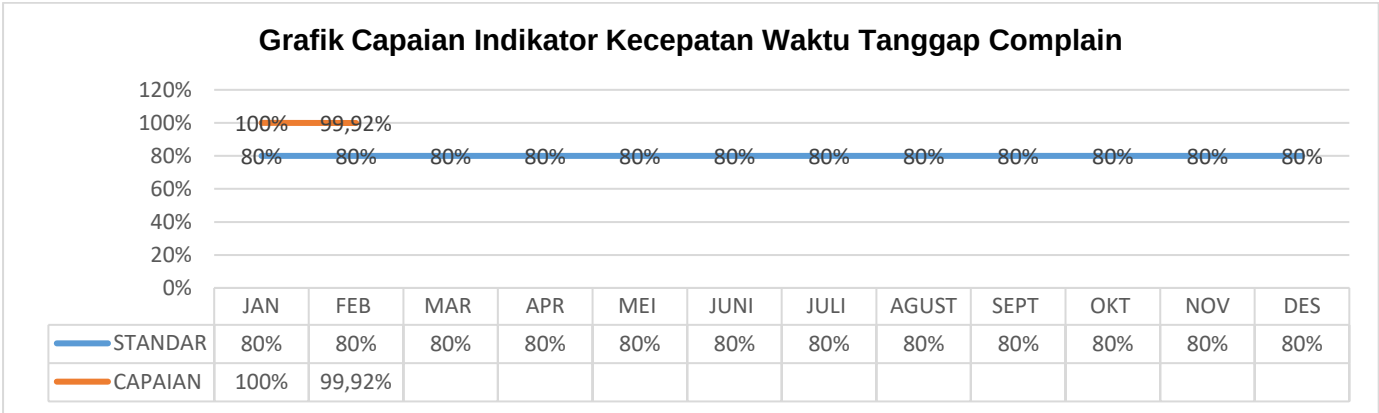


Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari dan Februari Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 99,75%, begitupun capaian di bulan Februari 98,64%. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalu memasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	Melakukan supervisi berjenjang mulai dari PJ shift, kepala ruangan, kepala bidang keperawatan dan tim mutu guna memastikan perawat ruangan telah melakukan KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	Satu Tahun

3.6.1.1.7 Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

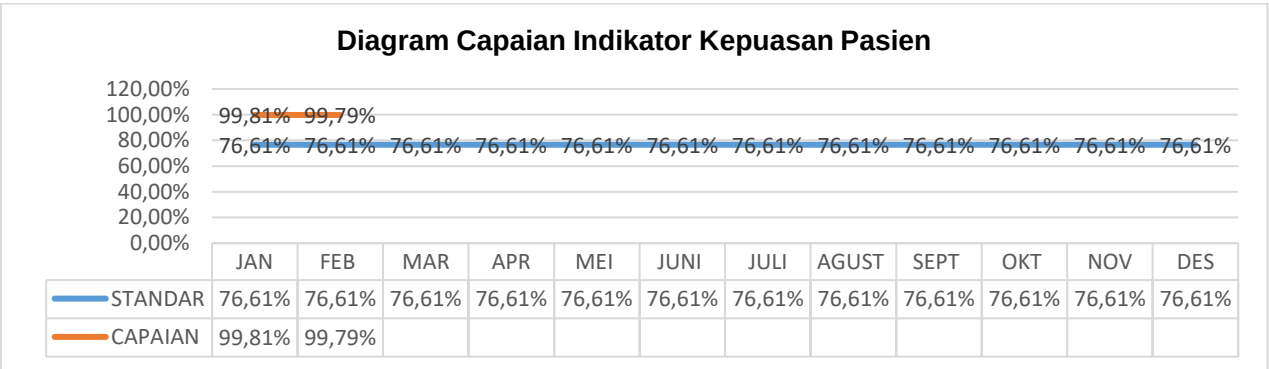
3.6.1.1.12.1 Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Komplain



Dari grafik indikator waktu tanggap kompalian bulan Januari dan Februari tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart lebih dari 80%, hal ini kerjasama yang baik antara PIPP dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk segera menanggapi dan melakukan tindak lanjut terkait komplain yang diterima. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya

3.6.1.1.8 Kepuasan Pasien

3.6.1.1.13.1 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Dari grafik indikator kepuasan pasien bulan Januari dan Februari tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart lebih dari 76,61%, meskipun belum mencapai nilai sempurna 100% tetapi capaian ini telah melebihi standart. Hal ini karena kerjasama yang baik antara seluruh karyawan Rumah Sakit Prima Husada Malang dan

juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepuasan pasien . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.1 Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,55%	99,92%											
2.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis (IRNA,IRJA, IGD,IKO)	100%	99,55%	99,92%											
3.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi (IRNA,IGD,IKO)	100%	100%	100%											
4.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%											
5.	Kejadian Ketidaklengkapan Lembar Operan Pasien (IRNA,IRJA, IGD,IKO)	0	0	0											
6.	Angka Kelengkapan Penyiapan Dan Pengelolaan Obat Yang Perlu di Waspadai / High Alert (Farmasi)	100%	100%	100%											
7.	Kepatuhan penyiapan, pengelolaan, pemberian sesuai standar obat elektrolit pekat (Farmasi)	100%	100%	100%											
8.	Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi Sesuai Prosedur (IGD,IRNA,IKO)	100%	100%	100%											
9.	Kepatuhan Pengisian Daftar Tilik Keselamatan Pasien Operasi (IKO)	100%	100%	100%											
10.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan) (IRNA,IRJA,IGD,IKO)	100%	98,64%	98,64%											
11.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh	100%	98,64%	98,65%											
12.	Kepatuhan kebersihan tangan	85%	85,21%	85,35%											

3.6.1.1.2 Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Apendicitis akut	100%	100%	100%											
2.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi STT	100%	100%	100%											

3.6.1.1.3 Tujuan Strategis

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Juli '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	99,81%	99,79%											

3.6.1.14 Perbaikan Sistem

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kesesuaiaan Penarikan Data SIMRS Dengan Data Manual Pada Laporan Unit	100%	80,39%	81,69%											

1.6.1.2.5 Mutu Unit

1.6.1.2.5.1 Instalasi Gawat Darurat

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Batas waktu pasien menunggu tempat tidur kurang dari 6 jam (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%											
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	98,2%	98,36%											
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%											
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%											
5.	Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi	≥ 80%	100%	100%											
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%											
7.	Kepuasan pasien	85%	97,36%	97,29%											
8.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%											
9.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%											
10.	Kejadian Ketidaktepatan waktu pelaporan hasil kritis gula darah (Lab)	100%	100%	100%											
11.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%											
12.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis di IGD	100%	100%	100%											
13.	Angka tindak lanjut screening nyeri pasien di IGD	100%	100%	100%											
14.	Angka kepatuhan triage untuk penyakit menular di IGD	100%	100%	100%											
15.	Respon time IGD kurang dari 5 menit	100%	100%	100%											
16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	4,65%	3,7%											
17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan	100%	100%	100%											

	sendiri														
18.	Kepatuhan pemasangan gelang identitas pasien kurang dari 30 menit setelah pasien terdaftar rawat inap	100%	100%	100%											
19.	Kejadian merujuk pasien berdasarkan aspek pilihan pasien	0	0	0											

1.6.1.2.5.2IRNA 2A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	-	-											
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	-	-											
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	-	-											
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	-												
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	-	-											
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-											
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	-	-											
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	-	-											
9.	Kepuasan pasien	85%	-	-											
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	-	-											
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	-	-											
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	-	-											

13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	-	-											
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	-	-											
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	-	-											
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	-	-											
17.	Angka efektivitas discharge planning	100%	-	-											
18.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	-	-											
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-											
20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-											
21.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	-	-											
22.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	-	-											
23.	Kelengkapan follow up setelah discharge	100%	-	-											
24.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	-	-											
25.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	-	-											
26.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	-	-											

3.6.1.2.6.3 IRNA 3A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%											
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	92,8%	94,7%											
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	93,7%	94,5%											
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%											
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	90,6%	89,82%											
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-											
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	88,98%	100%											
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	88,98%	100%											
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%											
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%											
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%											
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%											
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%											
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%											
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajenen nyeri	100%	100%	100%											

16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%										
17.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%										
18.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%										
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-										
20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-										
21.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%										
22.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%										
23.	Kelengkapan follow up setelah discharge	100%	100%	100%										
24.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0										
25.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%										
26.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%										

3.6.1.2.6.4 IRNA 4A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%											
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	96,72%	96,88%											
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,6%	96,9%											
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%											

5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	88,98%	95,17%											
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-											
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	97,14%	100%											
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	97,14%	100%											
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%											
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%											
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%											
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%											
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%											
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%											
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%											
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%											
17.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%											
18.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%											
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-											
20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-											

21.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%										
22.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%										
23.	Kelengkapan follow up setelah discharge	100%	100%	100%										
24.	Kejadian merujuk pasien (Hirizontal)	0	0	0										
25.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%										
26.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%										

3.6.1.2.6.5 IRNA 2C

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%											
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	98,9%	97,5%											
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	95,8%	97,3%											
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%											
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	81,25%	81,44%											
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-											
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	87,91%											
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	87,91%											
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%											

10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%											
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%											
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%											
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%											
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%											
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%											
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%											
17.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%											
18.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%											
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-											
20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-											
21.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%											
22.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%											
23.	Kelengkapan follow up setelah discharge	100%	100%	100%											
24.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0											
25.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%											

26.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%											
-----	---	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.6.1.2.6.6 IRNA 3C ANAK

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%											
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	96,7%	97,1%											
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	94,8%	96,1%											
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%											
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	100%	80,72%											
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-											
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	88,1%											
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	88,1%											
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%											
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%											
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%											
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%											
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%											
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%											

15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%											
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%											
17.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%											
18.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%											
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-											
20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-											
21.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%											
22.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%											
23.	Kelengkapan follow up setelah discharge	100%	100%	100%											
24.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0											
25.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%											
26.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%											

3.6.1.2.6.7 IRNA 5C

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%											
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	99,6%	99,8%											

3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,7%	99,1%											
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%											
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	81,25%	81,44%											
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-											
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	87,91%											
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	87,91%											
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%											
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%											
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%											
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%											
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%											
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%											
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%											
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%											
17.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%											
18.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%											

19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0,97%	1,06%											
20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%											
21.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%											
22.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%											
23.	Kelengkapan follow up setelah discharge	100%	100%	100%											
24.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0											
25.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%											
26.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%											

3.6.1.2.6.8 IRNA 6A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%											
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89,2%	90,3%											
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,1%	97,3%											
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%											
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	82,14%	78,72%											
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-											
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%											

8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%											
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%											
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%											
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%											
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%											
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%											
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%											
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%											
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%											
17.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%											
18.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%											
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	1,75%	0%											
20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	-											
21.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%											
22.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%											
23.	Kelengkapan follow up setelah discharge	100%	100%	100%											

24.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0										
25.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%										
26.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%										

3.6.1.2.6.9 IRNA 7A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%											
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89,98%	93,4%											
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	87,24%	89,22%											
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%											
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	80,36%	80,58%											
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-											
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%											
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%											
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%											
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%											
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%											
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%											
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%											

14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%											
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%											
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%											
17.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%											
18.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%											
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	1,23%	0%											
20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	-											
21.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%											
22.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%											
23.	Kelengkapan follow up setelah discharge	100%	100%	100%											
24.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	1											
25.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%											
26.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%											

3.6.1.2.6. 10 IRNA 8A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agt'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%											
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	97,8%	99,8%											

3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	92,1%	95,6%											
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%											
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	80,36%	72,79%											
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-											
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%											
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%											
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%											
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%											
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%											
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%											
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%											
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%											
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%											
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%											
17.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%											
18.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%											

19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%											
20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%											
21.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%											
22.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%											
23.	Kelengkapan follow up setelah discharge	100%	100%	100%											
24.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0											
25.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%											
26.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%											

3.6.1.2.6.11 ICU

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%											
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89,9%	95,5%											
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,2%	99,8%											
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	95,64%	97,81%											
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	96,72%	96,89%											
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	92%	93,2%											
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesauaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%											

8.	Kepuasan pasien	85%	-	-											
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%											
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%											
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%											
12.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%											
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%											
14.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%											
15.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%											
16.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge		100%	100%											
17.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%											
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0	0											
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-											
20.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%											
21.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU	100%	100%	100%											
22.	Angka kelengkapan pengkajian pasien tahap akhir kehidupan	0%	100%	100%											

23.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%											
24.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, pelayanan intensive)	100%	100%	100%											
25.	Kejadian merujuk pasien	0	100%	100%											
26.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%											

3.6.1.2.6.12. HCU

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%											
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	88,99%	96,22%											
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,5%	99,2%											
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	95,71%	98,92%											
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	96,21%	96,71%											
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	94%	97,1%											
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesauaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%											
8.	Kepuasan pasien	85%	-	-											
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%											
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%											

11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%											
12.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%											
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%											
14.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%											
15.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%											
16.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge		100%	100%											
17.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%											
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0	0											
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-											
20.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%											
21.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU	100%	100%	100%											
22.	Angka kelengkapan pengkajian pasien tahap akhir kehidupan	0%	100%	100%											
23.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%											
24.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, pelayanan intensive)	100%	100%	100%											
25.	Kejadian merujuk pasien	0	100%	100%											

26.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%											
-----	---	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.6.1.2.6.13 IRJA

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan pengkajian medis rawat jalan (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%											
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	99,2%	98,72%											
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,35	98,71%											
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%											
5.	Waktu tunggu rawat jalan	≥ 80%	89,16%	89,3%											
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%											
7.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%											
8.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%											
9.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%											
10.	Angka kelengkapan pengkajian keperawatan rawat jalan	100%	100%	100%											
11.	Ketepatan waktu jam praktek dokter	100%	78,92%	77,8%											
12.	Kejadian merujuk pasien	0	0	0											
13.	Angka kelengkapan inform concent	100%	100%	100%											

14.	Angka kelengkapan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%											
15.	Kelengkapan profil pasien rawat jalan	100%	100%	100%											

3.6.1.2.6.14 MATERNITAS

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kematian ibu (mutu prioritas unit)	0%	0	0%											
2.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%											
3.	Waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi.	≥80%	100%	100%											
4.	Kepatuhan waktu visite dokter.	≥80%	25,95%	24,56%											
5.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥80%	100%	100%											
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%											
7.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%											
8.	Kejadian keterlambatan operasi sectio caesaria (SC) > 30 menit	<5%	0%	0%											
9.	Angka keterlambatan penyediaan darah > 60 menit	<10%	0%	0%											
10.	Kejadian perdarahan post partum	0	0	2											
11.	Kejadian partus macet	0	0	0											
12.	Kejadian eklamsi	0	1	0											
13.	Kejadian pre eklamsi	0	5	2											
14.	Kejadian infeksi nifas	0	0	0											

15.	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	100%	13,6%	12,5%											
16.	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100%	13,6%	12,5%											
17.	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0	108	77											
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%												
19.	Kepuasan pasien	≥ 76,61	100%												
20.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%											
21.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%											
22.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%											
23.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%											
24.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%											
25.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%											
26.	Kelengkapan forum edukasi terintegrasi	100%	100%	100%											
27.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%											
28.	Angka Kelengkapan Follow up Discharge Planing	100%	100%	100%											
30.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%											
31.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%											

32.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%											
33.	Angka kelengkapan pengkajian awal gizi	100%	100%	100%											
34.	Kejadian tidak dilakukan edukasi RSSIB pada pasien post partum dan post SC	0	0	0											
35.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%											
36.	Kejadian tidak dilakukannya IMD pada bayi baru lahir	0	0	0											

3.6.1.2.6.15 NICU

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian kematian bayi (mutu prioritas unit)	0	0	1											
2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	98,31%	99,02%											
3.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,98%	99,79%											
4.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%											
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	85,11%	85,51%											
6.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%											
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%											
8.	Kepuasan Pasien	85%	100%	100%											
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%											
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%											

11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%											
12.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%											
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%											
14.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%											
15.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%											
16.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%											
17.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge	100%	100%	100%											
18.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%											
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%											
20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-											
21.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%											
22.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk NICU	100%	100%	100%											
23.	Angka Kelengkapan Pengkajian Pasien Tahap Akhir Kehidupan	100%	100%	100%											
24.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%											
25.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (neonatus)	100%	100%	100%											
26.	Kejadian Merujuk Pasien (Horizontal)	0	0	0											

3.6.1.2.6.16 PICU

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (Anak) (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%											
2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	99,23%	99,44%											
3.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,11%	98,79%											
4.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%											
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	100%	100%											
6.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%											
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%											
8.	Kepuasan Pasien	85%	100%	100%											
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%											
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%											
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%											
12.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%											
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%											
14.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%											
15.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%											
16.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%											

17.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge		100%	100%											
18.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%											
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%											
20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-											
21.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%											
22.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk PICU	100%	100%	100%											
23.	Angka Kelengkapan Pengkajian Pasien Tahap Akhir Kehidupan	0%	-	-											
24.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%											
25.	Kejadian Merujuk Pasien (Horizontal)	0	0	0											

3.6.1.2.6.17 IKO

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian tidak dilakukannya skiren pada pasien operasi yg seharusnya diskiren (mutu prioritas unit)	0	0	0											
2.	Kepatuhan identifikasi pasien.	100%	100%	100%											
3.	Penundaan operasi elektif.	≤ 5%	0%	0%											
4.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%											
5.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%											
6.	Kejadian keterlambatan operasi> 30 menit	0	0	0											

7.	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis pemulihan anestesi dan sedasi dalam	0	0	0											
8.	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis selama anestesi	0	0	0											
9.	Kejadian tidak dilaksanakannya pengkajian pra sedasi dan pra anestesi	0	0	0											
10.	Kejadian diskrepansi diagnose pre dan post op	0	0	0											
11.	Kejadian tidak dilaksanakan SSC	0	0	0											
12.	Kejadian tidak lengkapnya pengkajian pra bedah	0	0	0											
13.	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0											
14.	Kejadian ketidaklengkapan form daftar tilik pasien operasi	0	0	0											
15.	Kejadian Ketidapatuhan Prosedur Pasien Yang Menggunakan Implan	0	0	0											
16.	Kejadian ketidaklengkapan formular penandaan pasien operasi	0	0	00											
17.	Ketidakhadiran dokter anak saat operasi SC	0	0	0											
18.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan inform consent	100%	100%	100%											
19.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Apendicitis	100%	100%	100%											
20.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi STT	100%	100%	100%											

21.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%											
22.	Kepatuhan pencatatan pesan lewat telepon	100%	100%	100%											
23.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%											
24.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%											
25.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%											
26.	Kepatuhan pelaksanaan asesmen nyeri	100%	100%	100%											
27.	Kelengkapan forum edukasi terintegrasi	100%	100%	100%											
28.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%											
29.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%											
30.	Kelengkapan Asesmen pra sedasi dan pra anastesi	100%	100%	100%											

3.6.1.2.6.18 Laboratorium

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian ketidaktersediaan Reagen esensial di laboratorium (mutu prioritas unit)	0	0	0											
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%											

3.	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%	96,9%	97,31%											
4.	Ketersediaan kantong darah sesuai golongan	100%	100%	100%											
5.	Survilen harian hemofiglen	100%	100%	100%											
6.	Angka kepatuhan Prosedur penggunaan produk darah	100%	100%	100%											
7.	Kejadian salah input hasil laboratorium	0	0	0											
8.	Waktu tunggu hasil laboratorium >140 menit	0%	0%	0%											
9.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%											
10.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%											
11.	Kepatuhan Pelaporan Kritis Gula Darah	100%	100%	100%											
12.	Angka kepatuhan pengelolaan POCT (proses pelaporan nilai kritis, kualifikasi)	100%	100%	100%											
13.	Waktu tunggu hasil laborat cito <30 menit	100%	100%	100%											

3.6.1.2.6.19 Radiologi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	97,88%												
2	Angka ketidaklengkapan permintaan form radiologi	0%	2,12%												
3	Kepatuhan pelaporan nilai kritis hasil radiologi <30 menit	0	0												
4.	Kepatuhan edukasi pada prosedur radiasi	100%	100%												
5.	Angka kelengkapan inform consen pada prosedur radiasi	100%	100%												

6.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%												
7.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%												

3.6.1.2.6.20 Gizi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian pasien baru tidak mendapatkan makan (mutu prioritas unit)	0	0	0											
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%											
3.	Kejadian kesalahan pemberian diit	0	0	0											
4.	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	0	0											
5.	Kelengkapan pengkajian gizi (awal dan lanjut)	100%	100%	100%											
6.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	99,44%	99,67%											
7.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,01%	99,23%											

3.6.1.2.6.21 Farmasi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka ketersediaan obat obatan emergency (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%											
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%											
3.	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%	100%											
4.	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	0	0											

5.	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0											
6.	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,85%	61,98%											
7.	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	48,68%	44,17%											
8.	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0											
9.	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0											
10.	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0											
11.	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0											
12.	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0											
13.	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0											
14.	Kejadian obat pasien rawat jalan yang tidak diambil	0	0	0											
15.	Kepatuhan penggunaan panduan antibiotik dan efektifitas jangka panjang dan jangka pendek	100%	100%	100%											
16.	Kepatuhan penyimpanan obat obatan emergency disimpan secara seragam	100%	100%	100%											
17.	Kepatuhan proses pengelolaan obat recal hingga pengembalian atau pemusnahan	100%	100%	100%											
18.	Angka Kepatuhan pengelolaan obat kedaluwarsa	0	0	0											
19.	Angka Kepatuhan penyimpanan dan pengelolaan obat yang perlu di waspadi	100%	100%	100%											
20.	Kepatuhan penyimpanan, pengelolaan dan pemberian obat elektrolit pekat	100%	100%	100%											

21.	Angka Kepatuhan peresepan dan interuksi medis	100%	100%	100%											
22.	Angka kepatuhan dispensing	100%	100%	100%											
23.	Angka kepatuhan pemberian obat	100%	100%	100%											
24.	Angka kelengkapan pencatatan efek samping obat	100%	100%	100%											
25.	Angka Kepatuhan Pelaporan Medication Error	100%	100%	100%											
26.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%											
27.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%											
28.	Kepatuhan pelaksanaan panduan penggunaan single use dan multi dose vial	100%	100%	100%											
29.	Kepatuhan penggunaan risk based approach monitoring penggunaan obat	100%	100%	100%											
30.	Angka kepatuhan pengkajian risiko penggunaan obat yang dibawa pasien dari rumah	100%	100%	100%											

3.6.1.2.6.22 Pengadaan Farmasi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sep '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kekosongan stok farmasi	0%	0%	0%											
2	Angka kepatuhan kolaborasi tim pengadaan obat	0%	0%	0%											

3.6.1.2.6.23 PPI

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sep '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0,27%	0,29%											
2.	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰	0‰											
3.	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 ‰	0‰	0‰											
4.	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 ‰	0‰	0‰											
5.	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0,21%	0,23%											
6.	Angka Decubitus	0%	0%	0%											
7.	Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%	85,21%	85,35%											
8.	Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%	93,01%	93,06%											
9.	Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan	100%	93,44%	93,21%											
10.	Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)	0	0	0											

3.6.1.2.6.24 PIPP

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Terhubungnya Display TT Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%											
2.	Angk Terhubungnya Operasi Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%											
3.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain < 1 kali dari 24 jam	100%	100%	100%											
4.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain < 1 kali dari 24 jam	100%	100%	1005											
5.	Kepuasan Pasien	76,61%	99,81%	99,79%											
6.	Kepatuhan Petugas Dalam Mengumpulkan Kuesioner Kompalin dan Kepuasan Pelanggan (Indikator baru 2024)	100%	14,12	18,94%											
7.	Angka Kepuasan Pasien BPJS	100%	99,9%	99,89											
8.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%											

9.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge	100%	100%	100%											
----	---	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.6.1.2.6.25 SDM

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK.	0	0	0											
2	Angka kedisiplinan staf terhadap finger print.	100%	78%	98,51%											
3	Angka keterlambatan kehadiran staf	0%	37%	2,39%											
4.	Angka pemenuhan kompetensi sesuai dengan unit	100%	100%	100%											
5.	Angka kelengkapan file kepegawaian dimasing masing unit	100%	100%	100%											

3.6.1.2.6.26 Rekam Medis

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap (mutu prioritas unit)	100%	91,86%	29,3%											
2.	Angka kejadian nomor rekam medis ganda	0%	0,14%	0,23%											
	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat jalan	100%	91,86%	70,8%%											
3.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat jalan	100%	100%	100%											
4.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien IGD	100%	100%	100%											
5.	Kejadian Kendala Pada SIMRS Dalam Upaya Menunjang Pelayanan Rekam Medis Elektronik	0	0	0											
6.	Kelengkapan Keakuratan Pada Penginputan Data Pasien Di SIMRS	100%	100%	100%											

7.	Keterlambatan Pengumpulan DRM Pasien Rawat Inap Lebih Dari 24 Jam	0%	7,56%	7,89%											
8.	Angka keterbacaan dokumen rekam medis	100%	100%	100%											

3.6.1.2.6.27 K3RS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka kepatuhan petugas melakukan pengecekan APAR.	100%	100%	100%											
2	Kejadian kebakaran di ruangan.	0	0	0											
3	Kejadian tenaga Kesehatan sakit akibat kerja	0	0	0											

3.6.1.2.6.28 Asuransi Center

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian dokumen rawat jalan tidak layak klaim	0	0	Belum ada data											
2.	Angka pending klaim BPJS	0%	3,05%	2,54%											
3.	Prosentase readmisi pasien rawat inap	0%	0,91%	1,9%											
4.	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS	100%	98,99%	98,96%											
5.	Kejadian Pasien Tidak Di SEP	0	1	2											

3.6.1.2.6.29 IPSRS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Keterlambatan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam	0%	46%	65%											

2.	Angka keterlambatan respon dan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam (alat medis)	0%	97%	92%											
----	--	----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.6.1.2.6.30 UMUM

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Keterlambatan barang datang di Gudang	0	7	8											
2	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	0	10	8											

3.6.1.2.6.31 Cleaning Service

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka ketidakpatuhan penggunaan spillkit	0%	47,5%	59,26%											
2.	Kejadian komplain Kebersihan Kamar Mandi	0%	0	0											
3.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	88,72%	91,33%											
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	92%	94,07%											

3.6.1.2.6.32 KESEKRETARIATAN

	No	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka keterlambatan pengumpulan laporan bulanan unit tanggal 4 setiap bulannya	0%	50%	40,48%											

2	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS 1x 24 jam hari kerja	0%	27,27%	23,08%											
3	Angka tindaklanjut balasan surat masuk eksternal lebih dari 2x24 jam	0%	29,41%	29,41%											

3.6.1.2.6.33 Laundry

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka keterlambatan penyediaan linen	0%	2,14%												
2	Kejadian linen ruang perawatan hilang	0	0												
3.	Kejadian Tercampur Benda Asing	0	0												

3.6.1.2.6.34 CSSD

No	Judul	Stan	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian ditemukannya instrument hilang	0	0	0											
2	Kejadian instrument kurang	0	0	1											
3.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%											
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	96,77%	97,11%											

3.6.1.2.6.35 Humas dan Pemasaran

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka kunjungan rawat inap >90 pasien perhari	100%	98,71%	98,71%											
2	Angka kunjungan rawat jalan >350 pasien perhari	100%	86,69%	93,82%											

1.6.1.2.6.36 IT

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
----	-------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	----------	---------	---------	---------	-----------

1	Kejadian downtime	0	0	0											
2	Respon time penanganan internet dan billing error < 30 mnt	100%	100%	100%											
3	Respon Time untuk penanganan computer < 15 menit	100%	100%	100%											

3.6.1.2.6.37 Kamar Jenazah

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Pencatatan kematian pasien di kamar mayat (registrasi) < 2jam	100%	100%	100%											
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	-	-											
3.	Kepatuhan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	1005											

3.6.1.2.6.38 PKRS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan pelaksanaan edukasi kelompok	100	53,26%	68,38%											

3.6.1.2.6.38 DRIVER

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Respon time Panggilan Driver < 10 menit On Side	100%	99,2%												
2	Respon time Panggilan Driver < 30 menit On Call	100%	100%												
3	Kepatuhan pemeliharaan alat transportasi	100%	100%												

4	Angka kelengkapan alat emergency untuk ambulance emergency	100%	100%												
5	Kepatuhan pelaksanaan decontaminasi pasca transport pasien menular pada ambulance	100%	100%												

3.6.1.2.6.39 SECURITY

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian ditemukannya merokok, puntung rokok di lingkungan RS (mutu prioritas unit)	0	0	0											
2	Kejadian Barang Hilang Di Area Rumah Sakit	0	0	0											
3	Kejadian potensial barang hilang	0	0	0											
4	Kejadian kekerasan di lingkungan RS	0	0	0											

1.6.2 Komite PPI

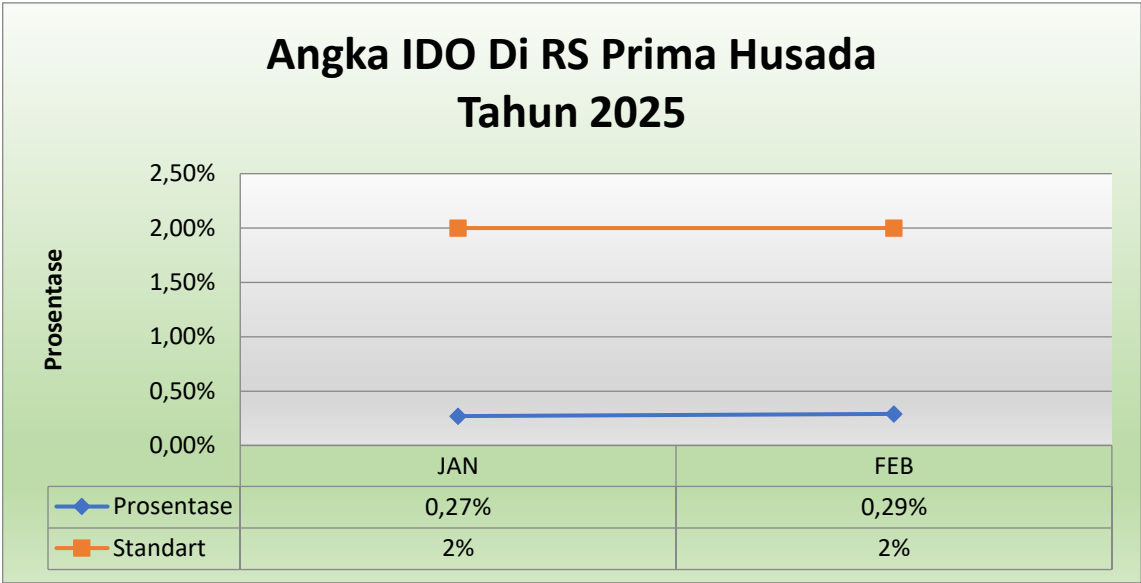
1.6.2.2 Hasil Surveilans dan Mutu PPI

1.6.2.2.5 IDO (Infeksi Daerah Operasi)

1.6.3.5.1 Tabel Data IDO berdasarkan Jenis Tindakan Operasi Sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Jenis Tindakan Operasi di RS	SSI		
	Jumlah Kasus	Jumlah Tindakan Operasi	Insiden (%)
Bedah Orthopedi	0	60	0%
Seksio Sesar	1	51	1,96%
Apendiktomi	0	3	0%
Herniotomi	0	12	0%
Katarak	0	43	0%
CABG	-	-	-
Tumor Payudara	0	14	0%
Semua Operasi	1	341	0,29%

1.6.3.5.2 Grafik Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO)



Analisa	Dari grafik diatas diperoleh data terdapat kejadian IDO pada 1 orang pasien yang menjalani operasi SC. Dari hasil assesmen pasien diperoleh data bahwa pasien berusia 28 tahun. Saat kontrol hari 1, ditemukan kondisi jahitan luka sedikit terbuka dan keluar darah bercampur puss. Pasien belum sempat melakukan perawatan luka sebelumnya dan luka tidak dibuka sama sekali setelah operasi. Dari hasil assesmen diperoleh data bahwa pasien tidak melakukan mandi sebelum operasi dilakukan dengan alasan karena operasinya cyto saat itu. Selain itu, dari hasil laboratorium juga menunjukkan adanya kondisi anemia dengan Hb 8,9 g/dl serta kondisi leukositosis sebanyak 14.440. Pasien saat operasi tidak ada jadwal operasi pasien lain yang bersamaan, karena dalam kondisi cyto dan malam hari dimana jarang sekali ada operasi malam hari (kecuali cyto).				
Masalah saat ini	1. Masih belum berjalannya secara rutin terkait anjuran pasien untuk melakukan mandi sebelum operasi baik itu operasi elektif maupun cyto.				
Permasalahan sebelumnya	2. Pasien dengan kondisi terdapat penyakit infeksi penyerta sebelumnya, perlu dilakukan edukasi lebih lanjut terkait perawatan lukanya dan perilaku hidup bersihnya.				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan evaluasi pada pasien-pasien yang dilakukan mandi sebelum operasi dan yang tidak melakukan. Kebanyakan pasien dengan kondisi fraktur dan cyto yang tidak dilakukan mandi sebelum operasi dilakukan. 2. Mengajukan petugas unit untuk tetap melakukan edukasi/tindakan memandikan pasien (diseka) dengan sabun antiseptic sebelum pasien dilakukan operasi. 3. Monitoring proses edukasi tambahan pada pasien yang terjadi IDO, untuk tidak khawatir jika terdapat penyakit penyerta dan konsultasi dengan DPJP untuk mendapatkan terapi yang sesuai untuk membantu mempercepat pemulihan. 4. Monitoring pelaksanaan audit bundle IDO sesuai di ruang perawatan pasien.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Memastikan bundle IDO berjalan dengan baik.	Resiko IDO pada pasien berkurang/hilang.	Pasien operasi	1. Melakukan monitoring persiapan pasien operasi khususnya pasien dianjurkan untuk mandi antiseptic/sabun untuk mengurangi resiko infeksi. 2. Berkolaborasi dengan PPA terkait kondisi penyakit penyerta serta memberikan edukasi untuk mencegah agar risiko infeksi tidak menjadi aktual. 3. Memastikan bundle IDO (pre, durante, dan post op dilakukan dengan baik)	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan
Lanjutkan evaluasi pemahaman pemberian edukasi perawatan pasien di rumah	Meminimalisir kesalahpahaman penangkapan terkait edukasi perawatan pasien post operasi.	Pasien post operasi.	1. Koordinasi dengan perawat ruangan untuk memastikan pasien sudah mendapatkan edukasi terkait perawatan saat di rumah.	1. Perawat /Bidan 2. Karu 3. IPCLN/IPCN	Satu bulan

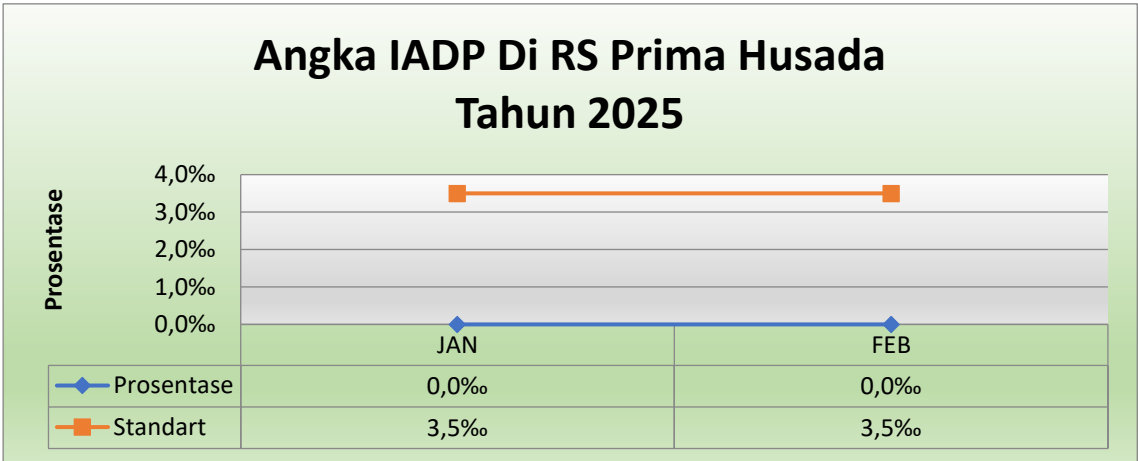
			2. Pastikan pasien paham saat diedukasi dengan menanyakan kembali inti edukasi yang telah diberikan. (Memastikan komponen edukasi tersampaikan dengan baik/Komunikasikan-komunikasikan-pesan-media-feedback) 3. Lakukan edukasi pada saat pasien terdapat pendamping keluarga terutama yang satu rumah dengan pasien. 4. Berikan tambahan edukasi terkait kontrol pikiran pasien terutama pada ibu muda yang baru memiliki anak.		
--	--	--	---	--	--

3.6.1.1.2 IADP

3.6.1.1.2.1 Tabel Data IDP Berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAI_s Kemenkes

Ruang	SSI		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian CVC	Insiden (%)
ICU	0	37	0‰
HCU	0	0	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	0	0‰

3.6.1.1.2.2 Grafik Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)



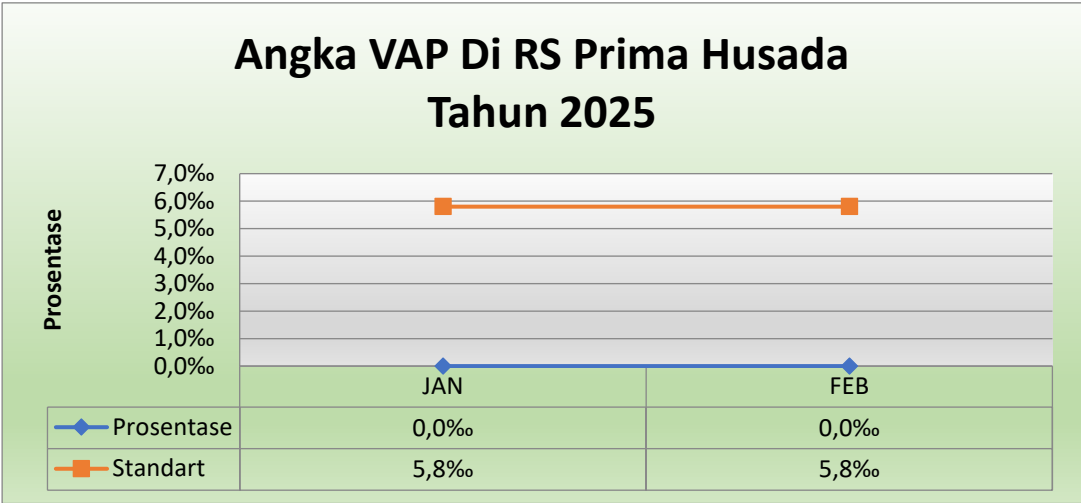
Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus IADP pada 37 hari total lama pemasangan CVC pada pasien bulan ini.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi IADP				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi IADP				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan tindakan pemasangan CVC. 2. Melakukan evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. 3. Melakukan monitoring kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. 4. Melakukan monitoring 5. perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle IADP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IADP.	Pasien dengan pemakaian CVC.	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. 3. Monitoring evaluasi kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. 4. Monitoring evaluasi perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

1.6.1.1.3 VAP

1.6.1.1.3.1 Tabel Data VAP berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Ruang	VAP		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian Ventilator	Insiden (%)
ICU	0	59	0%
HCU	0	0	0%
NICU	0	0	0%
PICU	0	0	0%

1.6.1.1.3.2 Grafik Angka Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus VAP pada 59 hari total lama pemasangan ventilator pada pasien bulan ini.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi VAP				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi VAP				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan evaluasi perawatan pasien dengan terpasang ventilasi mekanik. 2. Melakukan audit monitoring saat pemasangan ventilator. 3. Melakukan observasi tanda-tanda dehidrasi (bibir kering) pada pasien yang terpasang ventilator. 4. Melakukan evaluasi saat pasien dilakukan penghisapan lendir / suction. 5. Melakukan koordinasi dengan Kabid keperawatan terkait edaran kewajiban melakukan oral hygiene pada pasien yang terpasang ventilator dan mendokumentasikan di CPPT/Askep.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Tingkatkan kepatuhan bundle VAP, khususnya pelaksanaan oral hygiene.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP (oral hygiene).	Pasien yang terpasang ventilator mekanik	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator. 3. Monitoring evaluasi posisi tepat pasien <i>head of bed</i> >30°-45°. 4. Monitoring evaluasi tindakan pemasangan ventilator. 5. Monitoring kegiatan oral hygiene dan pendokumentasian di RM. 6. Pemberian tindakan oral	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	5. Satu bulan

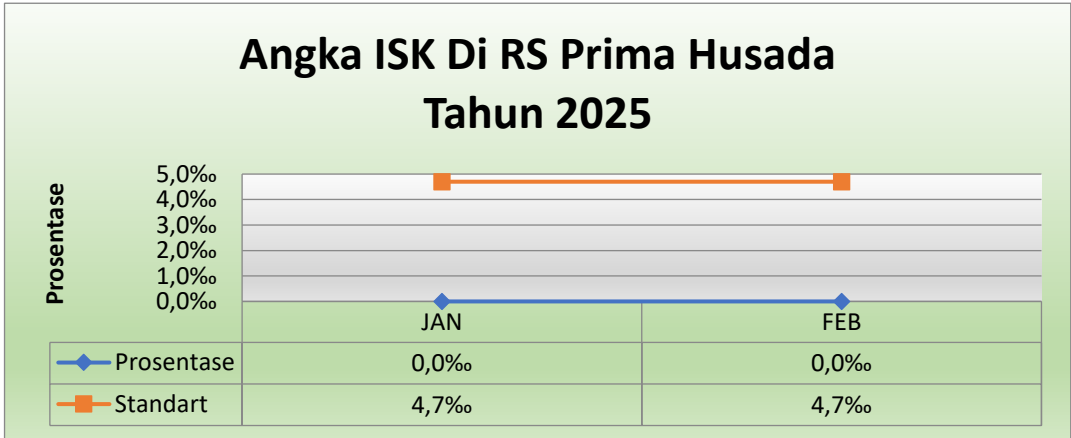
			hygiene mewajibkan juga diedukasikan pada keluarga pasien, agar keluarga ikut aktif mengingatkan petugas untuk melakukan tindakan tersebut.		
--	--	--	---	--	--

1.6.1.1.4 ISK

1.6.1.1.4.1 Tabel Data berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR ((Pelaporan INM dan HAIs Kemenkes)

Ruang	ISK		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian Ventilator	Insiden (‰)
ICU	0	281	0‰
HCU	0	37	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	0	0‰

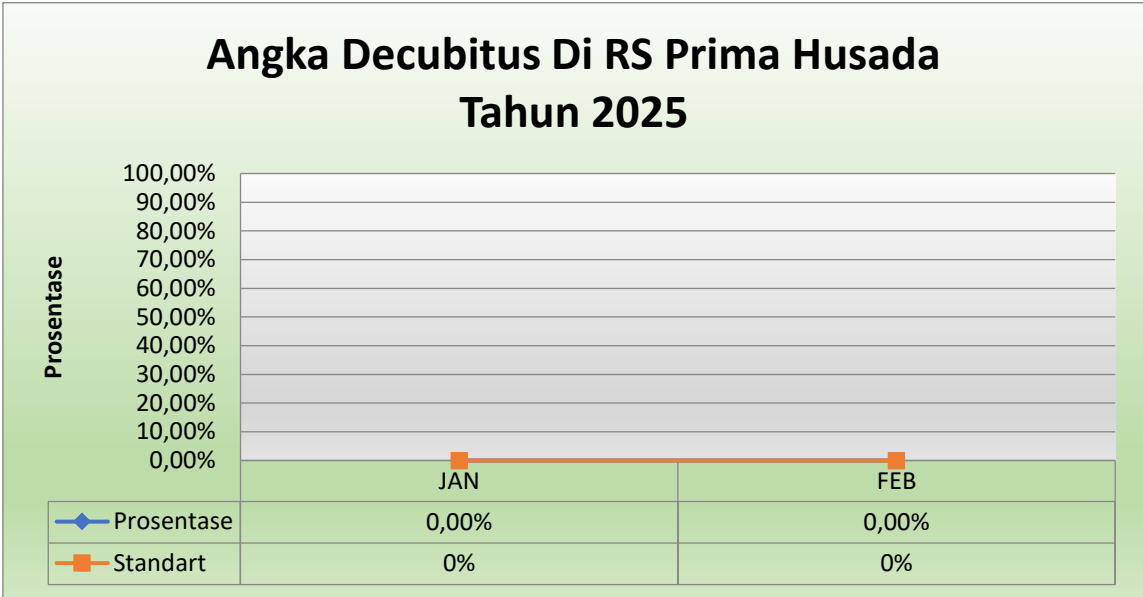
3.6.1.1.4.2 Grafik Angka Infeksi Saluran Kencing (ISK)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus ISK pada total 1202 hari lama pemakaian kateter pasien.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi ISK				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi ISK				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan perawatan pasien. 2. Melakukan monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. 3. Melakukan monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. 4. Melakukan monitoring perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle ISK.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle ISK.	Pasien yang terpasang kateter	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. 3. Monitoring evaluasi teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. 4. Monitoring evaluasi perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCN	Satu bulan

1.6.1.1.5 Decubitus

3.1.1.1.5.1 Grafik Angka Decubitus

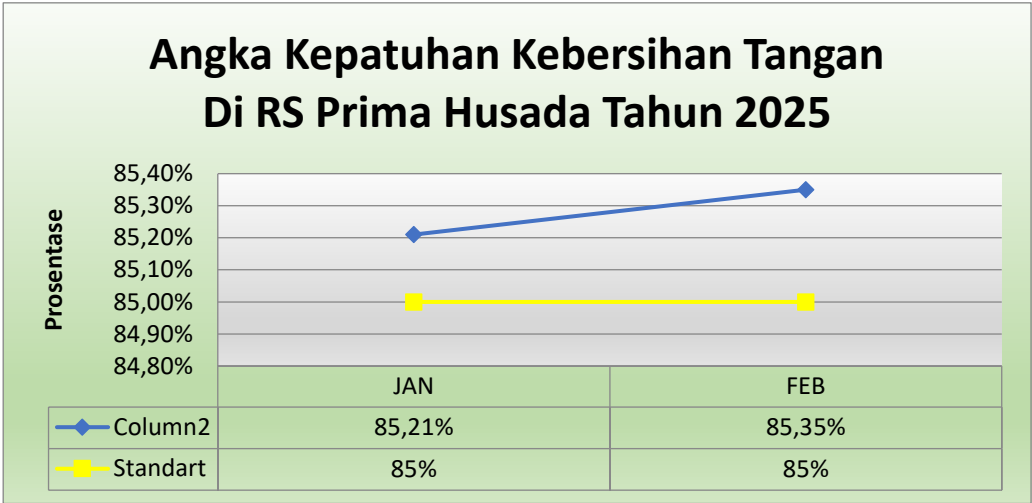


Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus decubitus pada 8 pasien tirah baring lama.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi decubitus				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi decubitus				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan proses perawatan pasien. 2. Melakukan monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). 3. Melakukan monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. 4. Memastikan personal hygiene dilakukan dengan rutin oleh petugas.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan pencegahan dekubitus.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan pencegahan dekubitus.	Pasien yang tirah baring lama (> 3x24 jam)	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). 3. Anjurkan penggunaan kasur anti decubitus atau alternatif lain 4. Monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	5. Satu bulan

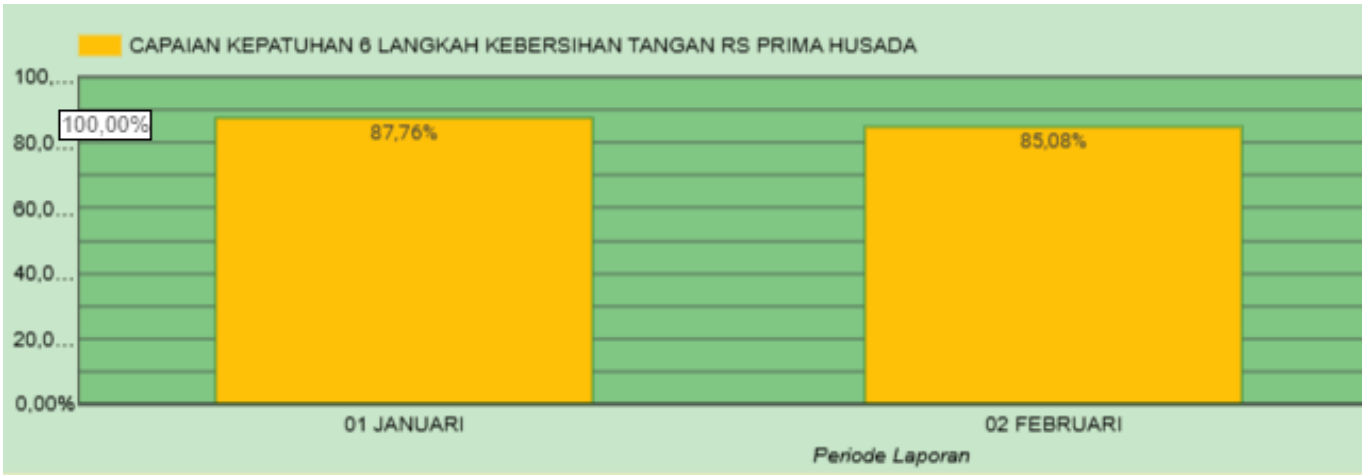
Perbaikan kepatuhan bundle phlebitis.	Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	Pasien yang terpasang infus	1. Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic diberikan secara aman. 2. Monitoring kondisi luka tusukan infus setiap selesai melakukan injeksi. 3. Memberikan injeksi obat secara perlahan untuk mengurangi nyeri dan memperkecil resiko phlebitis. 4. Mengedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan. 5. Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus dan kebersihan tangan sebelum memakai sarung tangan. 6. Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus. 7. Monitoring penyuntikan yang aman benar dilakukan. 8. Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus pasien beserta tanggal pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCN	Satu bulan
---------------------------------------	---	-----------------------------	--	---	------------

1.6.1.1.7 Kebersihan Tangan

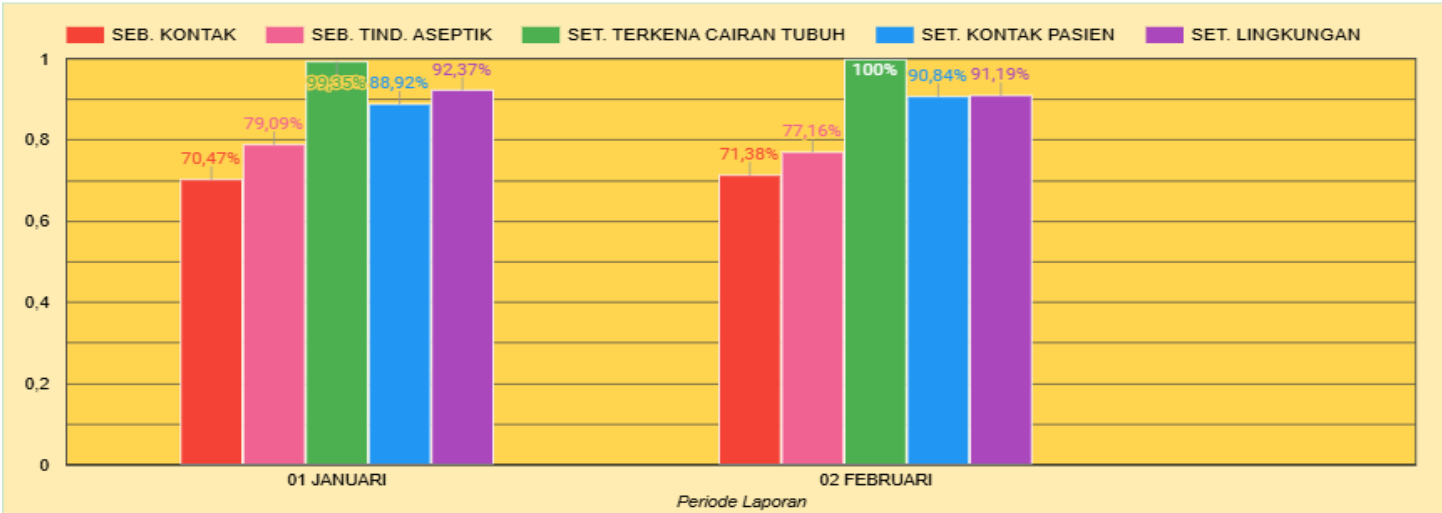
3.6.1.1.7.1 Grafik Angka Kepatuhan kebersihan Tangan (*Hand Hygiene*)



1.6.1.1.7.2 Grafik Kepatuhan 6 Langkah Kebersihan (Hand Hygiene)



1.6.1.1.7.3 Grafik Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan 5 Momen Cuci Tangan

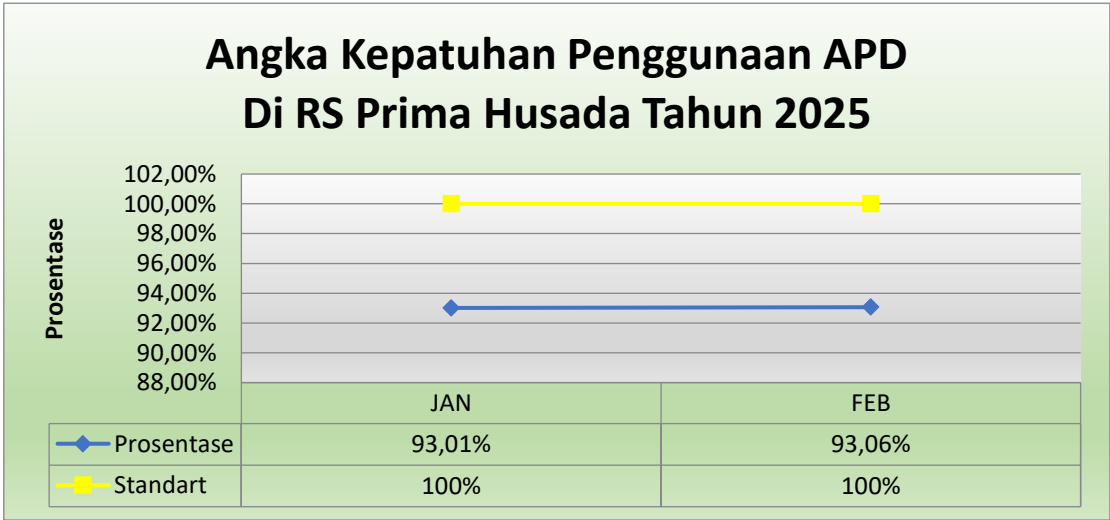


Analisa	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,35%. Masih belum bisa mencapai target 100% karena memang masih ditemukan petugas yang tidak melakukan cuci tangan terutama pada momen sebelum kontak pasien (71,38%) dan sebelum melakukan tindakan aseptik (77,16%). Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa.
---------	--

	Dilihat dari segi kepatuhan 6 langkah cuci tangan, 85,08% dari petugas dapat melakukan 6 langkah cuci tangan dengan baik. Namun memang karena belum menjadi kebiasaan dari petugas sehingga masih ada yang tidak urut melaksanakan 6 langkah cuci tangannya.				
Masalah saat ini	Petugas paham terkait 5 momen 6 langkah cuci tangan tetapi tidak dijalankan sepenuhnya saat pelayanan ke pasien (belum terbiasa).				
Permasalahan sebelumnya	Kurangnya kesadaran petugas terhadap pentingnya cuci tangan dan persepsi kebersihan tangan yang salah.				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Mengajarkan cuci tangan yang benar saat melakukan audit di ruangan. 3. Memberikan proses pembelajaran dengan membuat video pendek edukasi cuci tangan supaya lebih mudah untuk mengingat. 4. Melakukan kontrol monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.8 Kepatuhan APD

3.6.1.1.8 .1 Grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD oleh Petugas



Analisa	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 93,06%. Dari hasil monitoring dan supervise, terjadi sedikit peningkatan kepatuhan pemakaian APD, kepatuhan petugas penjamah makanan masih baik sejak akhir bulan lalu dikarenakan setelah mendapatkan resosialisasi terkait hygiene penjamah makanan. Namun, pada petugas cleaning service masih ditemukan petugas yang tidak memakai sarung tangan kerja tetapi memakai handscoon untuk membersihkan ruangan dengan alasan sarung tangan kerjanya berlubang/robek, namun sudah sedikit berkurang jumlahnya.
---------	--

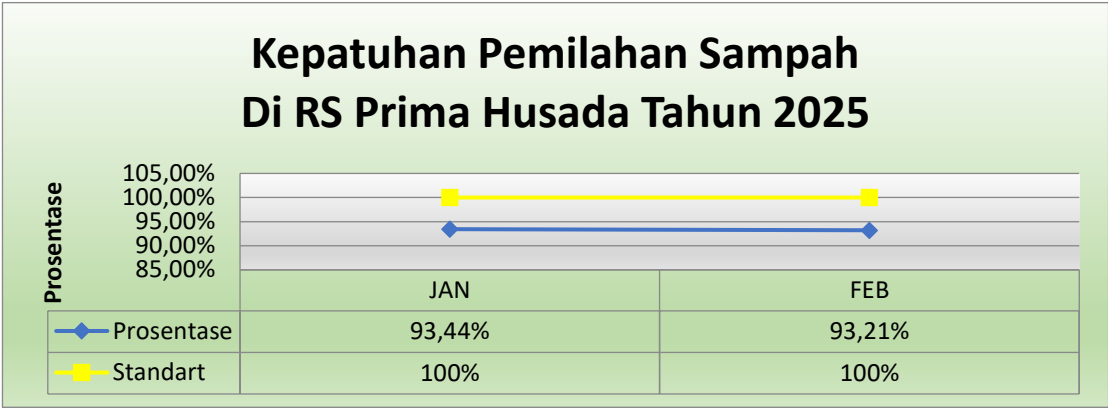
Masalah saat ini	Petugas masih belum bisa membiasakan dengan kebiasaan baru yang benar dan lebih memilih diam-diam menjalankan kebiasaan yang salah.				
Permasalahan sebelumnya	Kurangnya kesadaran petugas terhadap penggunaan APD yang sesuai untuk menghindari penyebaran infeksi.				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD, konfirmasi Karu dan SDM). 5. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. 6. Melarang perawat untuk memberikan handscoon jika ada CS yang meminta untuk membersihkan ruangan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Berkolaborasi dengan SDM terkait ketidakdisiplinan petugas dalam pemakaian APD. 2. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan. 3. Lakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 4. Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. 5. Tanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.9

Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius

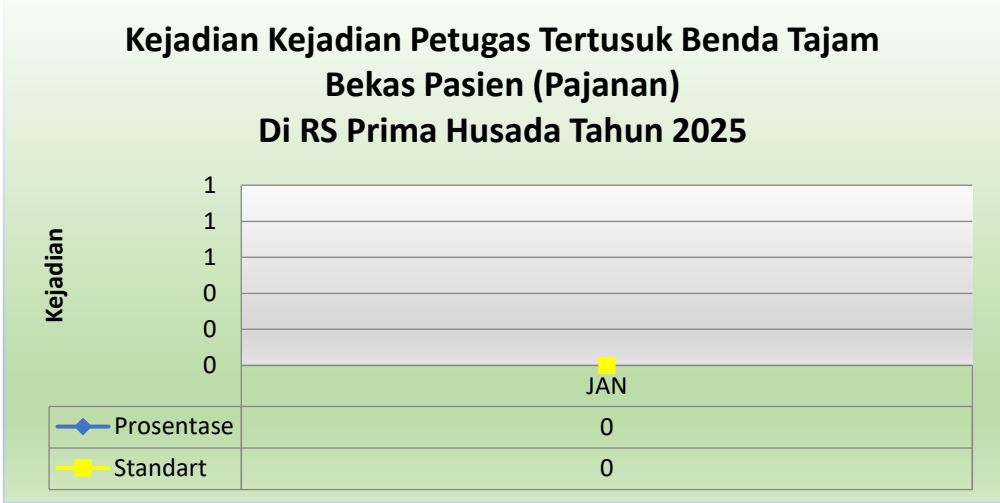
3.6.1.1.9.1

Grafik Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan



3.6.1.1.10 Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam

3.6.1.1.10.1 Grafik Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam Bekas Pasien (Pajanan)



Analisa	Tidak ditemukan kejadian pajanan.				
Masalah saat ini	Tidak ada kejadian pajanan.				
Permasalahan sebelumnya	Safety box tidak standar, tembus tusukan jarum.				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring pemilahan sampah khususnya benda tajam pada saat melakukan tindakan. 2. Melakukan monitoring kerapian dan kebersihan troli tindakan untuk segera dibersihkan setelah tindakan dan tidak meninggalkan jarum/benda tajam terbuka di troli tindakan. 3. Melakukan monitoring teknik recapping saat menutup jarum saat menyiapkan obat pasien. 4. Sudah diajukan telaah penggantian safety box, dengan melampirkan kejadian pajanan namun tidak ada penggantian safety box.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan proses pemilahan sampah yang benar dan pengelolaan benda tajam yang baik.	Menurunkan kejadian pajanan sesuai dengan standar 0 kejadian.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Monitoring proses pemilahan sampah khususnya benda tajam saat melakukan tindakan. 2. Monitoring penggunaan safety box pada troli tindakan. 3. Biasakan petugas untuk membersihkan peralatan yang digunakan langsung tanpa mengoperkan pada shift berikutnya. 4. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan untuk mencegah paparan. 5. Monitoring teknik recapping tutup jarum.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.3 Tim PKRS

3.6.3.1 Edukasi Kelompok Unit

NO	UNIT	TARGET	DES	JAN	FEB	%	MANDOK	KETERANGAN
1	IRNA 2C	8x/Bulan	100%	100%	50%	Menurun	Ada	
2	ICU HCU	8x/Bulan	0%	0%	0%	Menurun	Ada	
3	IRNA 3C	8x/Bulan	100%	100%	50%	Menurun	Ada	
4	MATERNITAS	8x/Bulan	100%	100%	75%	Menurun	Ada	
5	PERINATOLOGI	8x/Bulan	100%	100%	75%	Menurun	Ada	

6	IRNA 5C	8x/Bulan	100%	100%	50%	Menurun	Ada	
7	IRNA 2A,3A,4A	8x/Bulan	75%	75%	25%	Menurun	Ada	
8	IRNA 6A,7A,8A	8x/Bulan	100%	100%	75%	Menurun	Ada	
9	IGD	8x/Bulan	25%	0%	100%	Tercapai	Ada	
10	FARMASI	8x/Bulan	100%	100%	25%	Menurun	Ada	
11	GIZI	8x/Bulan	75%	50%	100%	Tercapai	Ada	
12	IRJA	8x/Bulan	100%	100%	50%	Menurun	Ada	
13	PPI		100%	100%	100%	Tercapai	Ada	

Analisis : Berdasarkan data edukasi kelompok unit pada bulan Februari Petugas PKRS tiap unit sudah melakukan kegiatan dengan baik , dari data tersebut Unit ICU/HCU, IRNA 2A,3A,4A, FARMASI belum melaksanakan Edukasi Kelompok dengan maksimal sehingga peresentasi cukup kurang dimana masih 0% dan 25%, untuk Unit IRNA 2C, IRNA 3C, MATERNITAS, PERINATOLOGI, IRNA 5C, IRNA 6A,7A,8A, IRJA mengalami penurunan dari bulan Januari 2025.

Rencana Tindak Lanjut : Menyampaikan kepada KARU unit yang belum tercapai kinerjanya untuk mengejar ketertinggalan edukasi, edukasi dilakukan di bulan Maret.

3.6.3.2 KIE Individu

NO	UNIT	TARGET	DES	JAN	FEB	%	Keterangan
1	IRNA 2C	100%	100%	100%	100%	100%	
2	ICU HCU	100%	100%	100%	100%	100%	
3	IRNA 3C	100%	100%	100%	100%	100%	
4	MATERNITAS	100%	100%	100%	100%	100%	
5	PERINATOLOGI	100%	100%	100%	100%	100%	
6	IRNA 5C	100%	100%	100%	100%	100%	
7	IRNA 2A,3A,4A	100%	100%	100%	100%	100%	
8	IRNA 6A,7A,8A	100%	100%	100%	100%	100%	
9	IGD	100%	100%	100%	100%	100%	
10	FARMASI	100%	100%	100%	100%	100%	
11	GIZI	100%	100%	100%	100%	100%	
12	IRJA	100%	100%	100%	100%	100%	

Analisis : Hasil Edukasi individu unit pada bulan oktober tercapai 100%, terbukti dalam lembar edukasi kolaborasi DRM telah terisi.

Rencana Tindak Lanjut : -

3.6.3.3 Pembinaan Komunitas Berbasis RS Prima Husada

UNIT	TARGET	KEGIATAN	DES	JAN	FEB	%	MANDOK	KET
Komunitas Geriatri	2X/Bulan	Senam	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Ibu Hamil	2X/Bulan	Senam	100%	50%	100%	Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Shirothul Jannah Perempuan	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Karya wisata						
Komunitas Shirothul Jannah Laki Laki	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
Bimbingan Doa	8X/Bulan	Mendoakan Pasien	100%	100%	100%	100%	Ada	
General	1x/2Bulan		100%	0%	100%	Tercapai	Terlaksana	

Meeting Karyawan								
Pembinaan Fatayat	1X/Tahun							

3.6.3.4 KIE Upaya Preventif Promotif PROGNAS

NO	UNIT	TARGET	DES	JAN	FEB	%	MANDOK	KETERANGAN
1	PONEK	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%	-	
2	HIV	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%	-	
3	STUNTING dan WASTING	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%	-	
4	KELURAGA BERENCANA RUMAH SAKIT (KABERUSA)	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%	-	
5	TB DOTS	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%	-	

- Analisis

: PROGNAS yang tercapai di bulan Januari hanya dari Unit Gizi.
- Rencana Tindak Lanjut

: Koordinasi dengan Kepala Bidang Umum dan Pelayanan untuk dapat menghidupkan kembali kegiatan PROGNAS

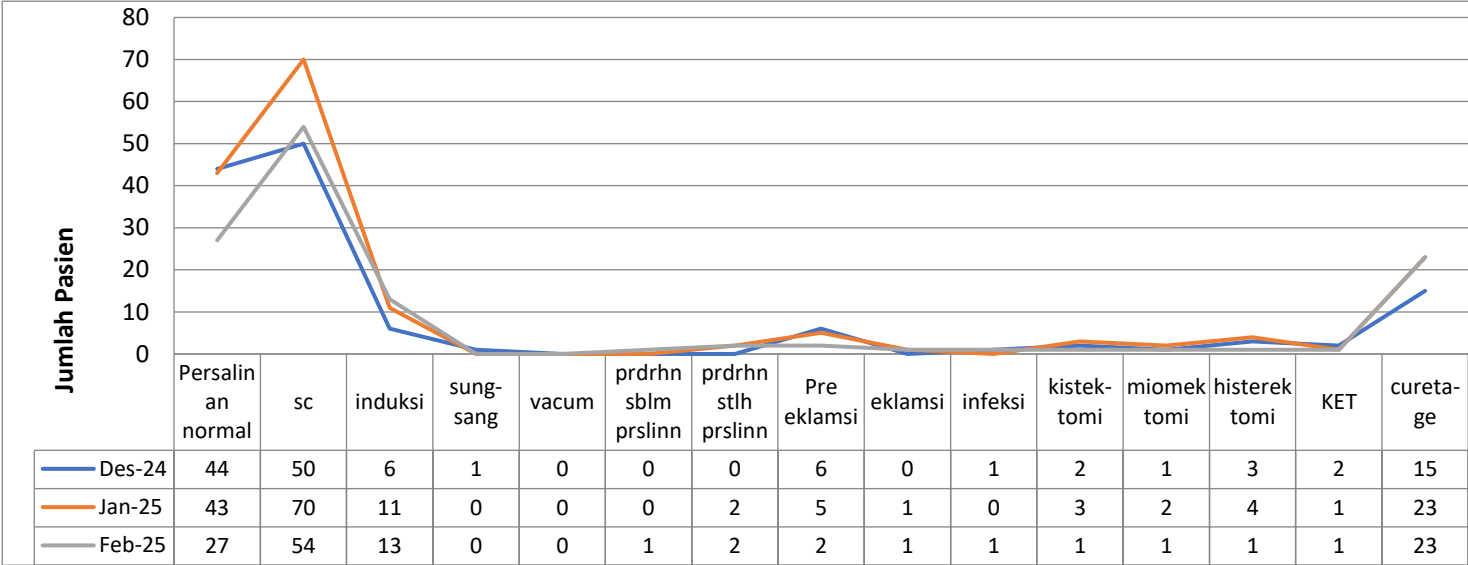
3.6.4 Tim Prognas

3.6.4.1 PONEK

3.6.4.1.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek Februari 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien		
		Bulan Desember 2024	Bulan Januari 2025	Bulan Februari 2025
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal	44	43	27
	b. <i>SectioCaesaria</i>	50	73	54
2				
	a. Induksi / Drip	6	11	13
	b. Sungsang	1	0	0
	c. Vacum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	0	0	1
	b. Perdarahan setelah Persalinan	0	2	2
	c. Pre Eklamsi	6	5	2
	d. Eklamsi	0	1	1
	e. Infeksi	1	0	1
4				
	a. Curretage	17	23	23
	b. Kistektomi	0	3	1
	c. Miomektomi	0	2	1
	d. Histerectomy	1	4	1
	e. KET	2	1	1

1.6.2.1.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan Februari 2025



Analisis :

- 1. Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada bulan Februari 2025 mengalami penurunan yang cukup banyak jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 54 pasien. Dan untuk persalinan normal pada bulan Februari 2025 juga menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 27 persalinan. Untuk persalinan normal, jika memang tidak ada penyulit maka persalinan bisa ditolong bidan terlebih dahulu.
- 2. Kebanyakan pasien yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas sc, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya, atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distress. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi sc cito.
- 3. Tidak ada persalinan dengan sungsang pada bulan Januari dan Februari 2025, sedangkan pada bulan Desember terdapat 1 persalinan dengan sungsang. Dan tidak ada persalinan dengan vacum pada bulan Februari 2025 dan 2 bulan sebelumnya.
- 4. Induksi Persalinan pada bulan Februari mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 13 pasien
- 5. Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan Februari 2025 sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 2 pasien. Dan ada 1 kejadian eklamsi pada bulan Januari dan Februari 2025
- 6. Jenis pelayanan curretage di bulan Februari 2025 sama jumlahnya dengan bulan sebelumnya yaitu 23 pasien. *Curretage* dilakukan untuk Indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynekology biasanya dengan indikasi menometroragi, hiperplasia endometrium, dan lainnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

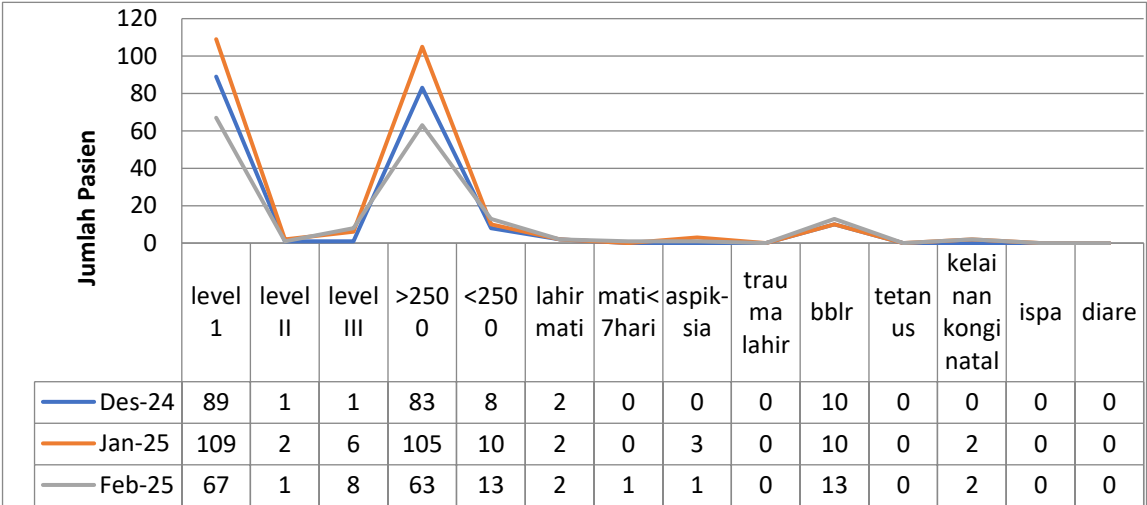
- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
- 2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
- 4. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.

3.6.4.1.2 Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

3.6.4.1.2.1 Tabel Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Ponpek Februari 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien		
		Bulan Desember 2024	Bulan Januari 2025	Bulan Januari 2025
1				
	a. Level 1	89	109	67
	b. Level II	2	2	1
	c. Level III	2	6	8
2				
	a. ≥ 2500 gram	83	105	63
	b. ≤ 2500 gram	10	10	13
3				
	a. Kelahiran Mati	2	2	2
	b. Mati Neonatal < 7 Hari	0	0	1
4				
	a. Asphyxia	0	3	1
	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	10	10	13
	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0
	e. Kelainan Congenital	0	2	2
	f. ISPA	0	0	0
	g. DIARE	0	0	0
5	Lain-lain	0	0	0

3.6.2.1.2.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada Februari 2025



Analisis :

1. Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1 di bulan Februari 2025 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 67 bayi. Dan pada level 2 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 1 bayi. Sedangkan pada level 3 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 8 bayi.
2. Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah >2500 gram di bulan Februari 2025 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 63 bayi.
3. Dan jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan Februari 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 13 bayi. Masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.
4. Kasus BBLR pada bulan Februari 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 13 bayi.

- 5. Ada 2 kasus kelahiran mati pada bulan Februari 2025 dan juga pada 2 bulan sebelumnya
- 6. Ada 1 kasus kematian neonatus <7 hari pada bulan Februari 2025, sedangkan pada 2 bulan sebelumnya tidak ada kasus kematian bayi

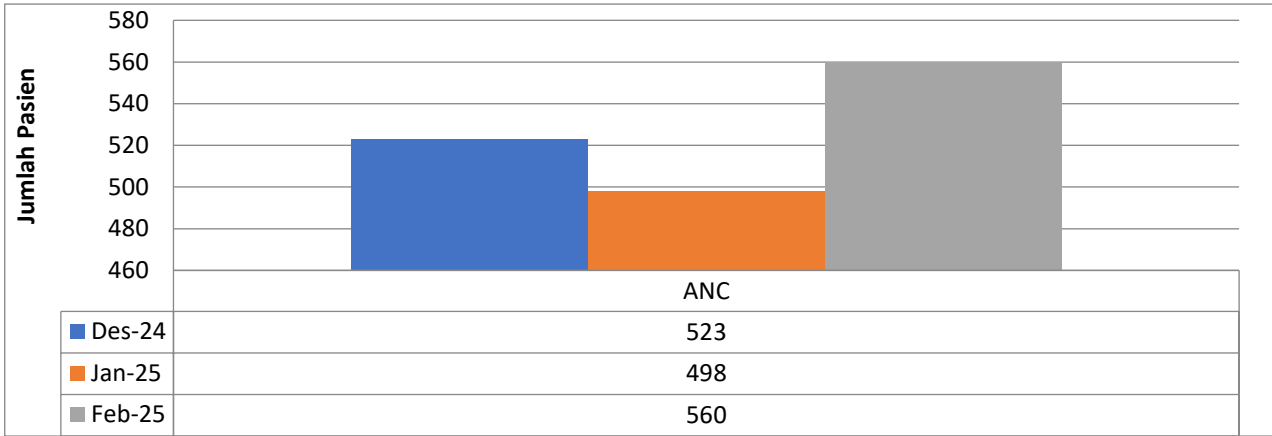
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
- 2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.

3.6.2.1.2.3 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)
Tabel Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponpek Februari 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025	BULAN FEBRUARI 2025
1	ANC	523	498	560

Grafik Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada Februari 2025



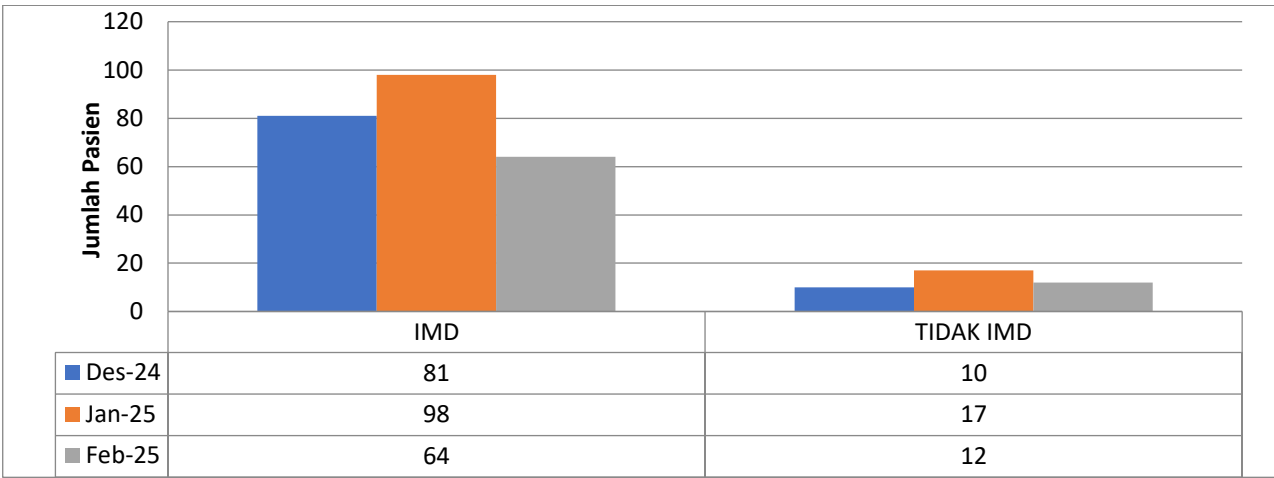
Analisis :
Pelayanan ANC pada bulan Februari 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 560 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pemeriksaan ANC seperti USG 4 dimensi serta kegiatan senam hamil yang diharapkan menarik minat para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di RS.

3.6.1.2.4 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Tabel Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Januari 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025	BULAN FEBRUARI 2025
1	IMD	81	98	64
2	Tidak IMD	10	17	12

Grafik Jumlah Pelayanan IMD di RS Prima Husada Bulan Februari 2025



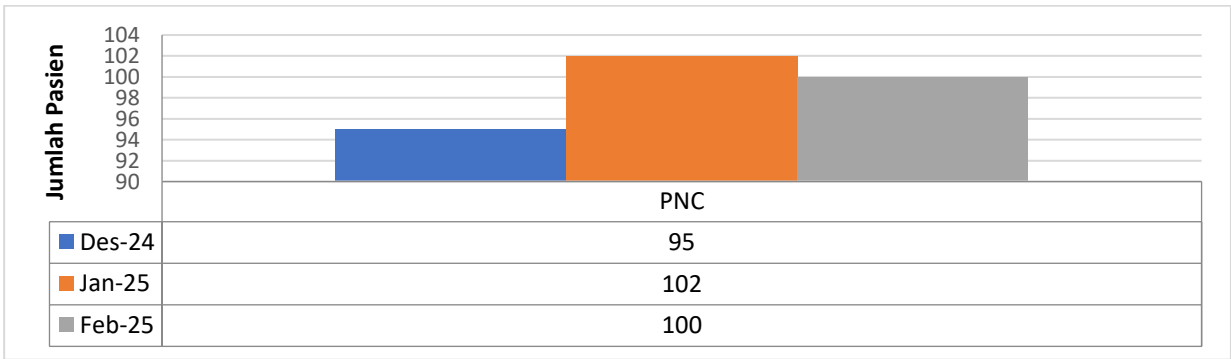
- Analisis :**
- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Februari 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 64 bayi. Dan tidak semua bayi baru lahir dilakukan IMD, dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD.
 - 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Februari sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 12 bayi, Sedangkan pada bulan Januari 17 bayi, dan Desember 2024 sebanyak 10 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
 - 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat ataupun tidak.

3.6.1.2.5 Pelayanan Post Natal Care (PNC)
Tabel Pelayanan Post Natal (PNC) Ponek Februari 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025	BULAN FEBRUARI 2025
1	PNC	95	102	100

Grafik Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan Februari 2025



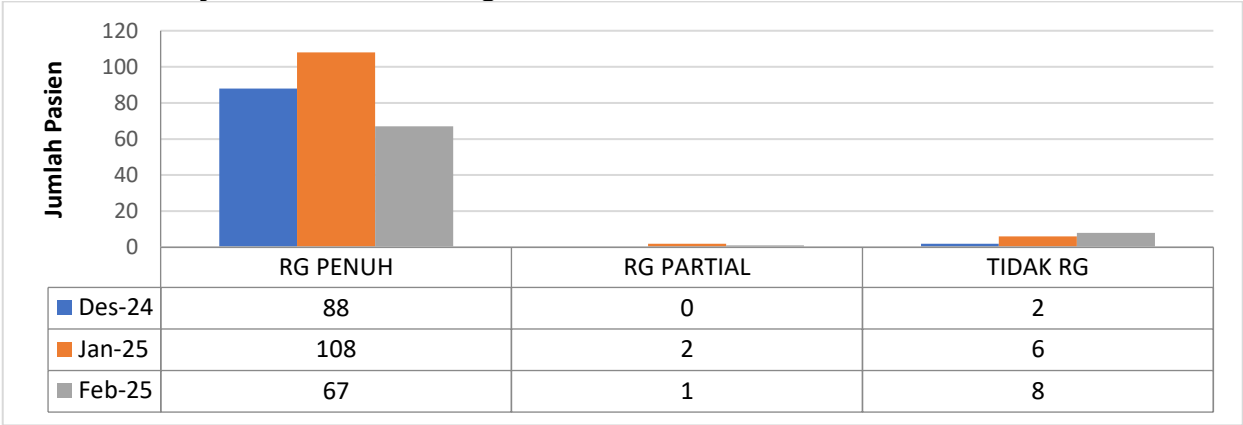
Analisis :
Pelayanan PNC pada bulan Februari 2025 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 100 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan Edukasi ke pasien pasca bersalin untuk melakukan pemeriksaan PNC di RS Prima Husada

3.1.2.2.1.5 Pelayanan Rawat Gabung
Tabel Pelayanan Rawat Gabung Ponpek Februari 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025	BULAN FEBRUARI 2025
1	Rawat gabung penuh	88	108	67
2	Rawat gabung partial	0	2	1
3	Tidak Rawat gabung	2	6	8

Grafik Pelayanan Rawat Gabung Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Januari 2025



Analisis :

- 1. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan Februari 2025 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 67 bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
- 2. Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan Februari 2025 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 8 bayi.
Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram dan masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan.

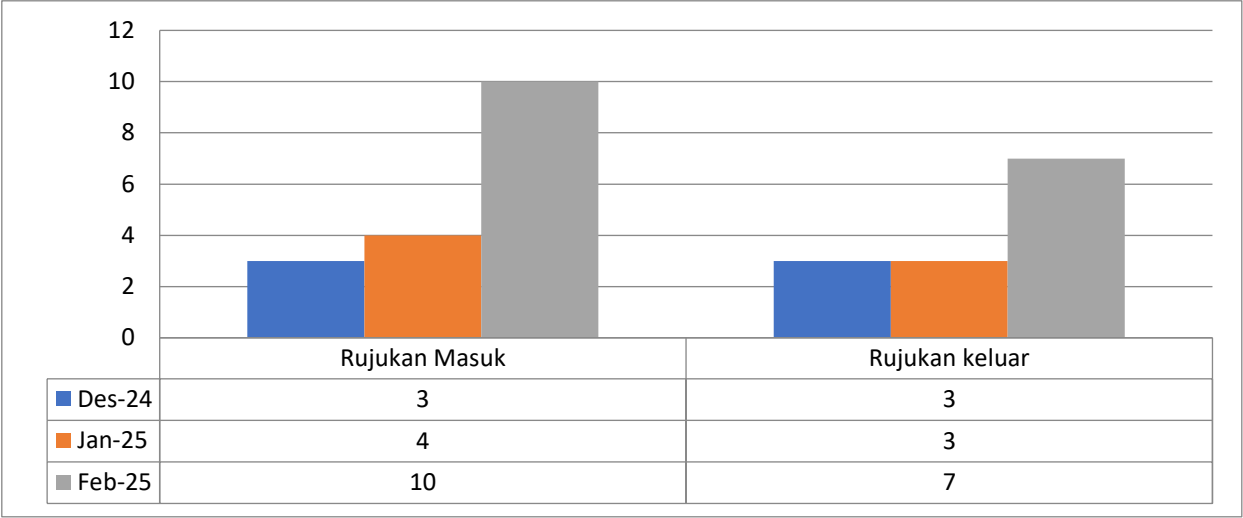
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan skrining awal untuk pasien yang layak dilakukan rawat gabung ibu dan bayi.

3.1.2.2.1.6 Pelayanan Jejaring Rujukan
Tabel Pelayanan Jejaring Rujukan Ponpek Februari 2025

NO	RUJUKAN	BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025	BULAN FEBRUARI 2025
1	Rujukan Masuk	3	4	10
2	Rujukan keluar	3	3	7

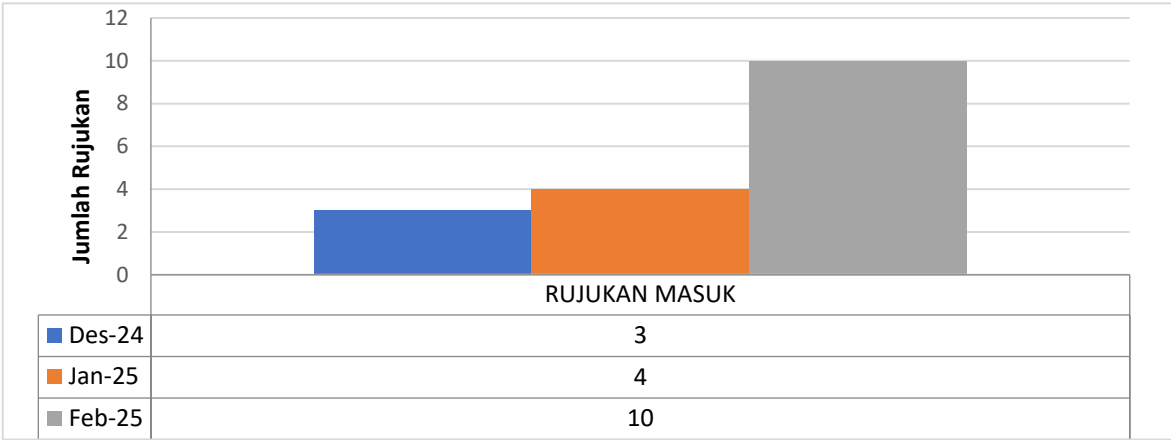
Grafik Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan Februari 2025



3.1.2.2.1.6.1 Rujukan Masuk
Tabel Rujukan Masuk Ponpek Februari 2025

BULAN DESEMBER 2024		
1	G2 P1001 Ab000 UK 12 -14 mgg dg HEG	Klinik Mutiara Sehat
2	G4 P3003 Ab000 UK 39 - 40 mgg dg KIFA	BPM Lilik Agustina
3	G1 P0000 Ab000 UK 40-41 mgg dg KIFA	PKM Singosari
BULAN JANUARI 2025		
1	G2 P1001 Ab000 UK 39-40 mgg dg BSC + Prolong KIFL	BPM Lilik Agustina
2	G1 P0000 Ab000 UK 37-38 mgg dg KPD	BPM Titik Sunariyati
3	G3 P1001 Ab100 UK 10-12 mgg dg HEG	Klinik Mutiara Sehat
4	G3 P2002 Ab000 UK 37-38 mgg dg KPD +KIFL	PKM Singosari
BULAN FEBRUARI 2025		
1	G2 P1001 Ab000 uk 30-32 mgg dg PPI	BPS Lilik Agustina
2	G3 p0201 Ab000 uk 32-34 mgg dg KIFA	Klinik Putra Husada
3	G1 P0000 Ab000 uk 37-38 mgg dg KPD	BPS Subaedah I
4	G1 P0000 Ab000 uk 39-40 mgg dg Prolong KIFA	BPM Titik Sunaryati
5	G1 P0000 Ab000 uk 39-40 mgg dg IUFD + Letli + High miopi	Klinik Kartini
6	G2 P1001 Ab000 uk 10-12 mgg dg Abortus Inkomplit	Klinik Putra Husada
7	P2002 Ab000 dg kala 3 + Retensio Plasenta	PKM Singosari
8	G2 P1001 Ab000 uk 30-32 mgg dg PPI	BPM Tri
9	Anemia Grafis + Massa IntraAbdominal susp CA Ovari + Prolaps Uteri grade 4	PKM Pakis
10	Anemia +Susp CA Serviks	Klinik Nayaka

Grafik Pelayanan Rujukan Masuk RS Prima Husada Bulan Februari 2025



Analisis :

Jumlah rujukan masuk pada bulan Februari 2025 meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 10 rujukan, sedangkan pada bulan Januari sebanyak 4, dan bulan Desember 2024 sebanyak 3 rujukan.

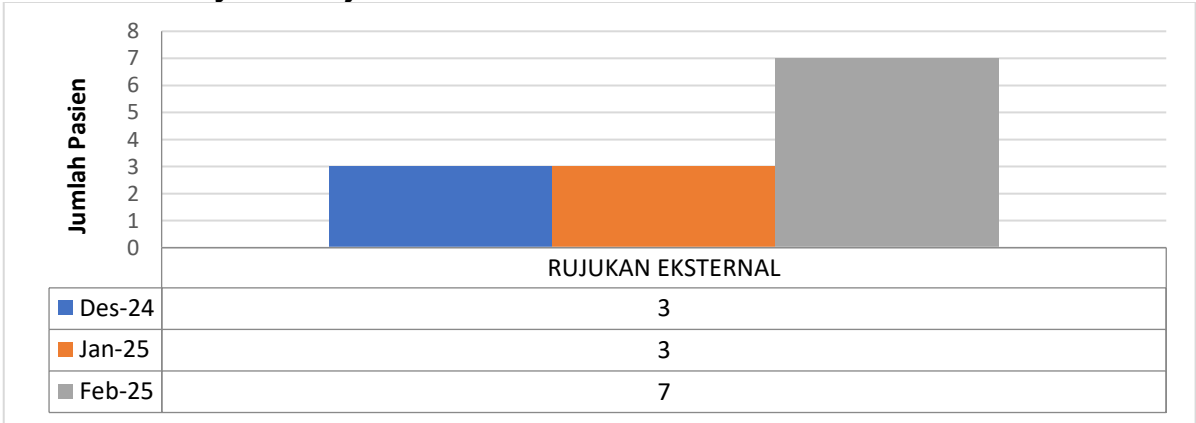
Rencana dan Tindak Lanjut

Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM atau RS setempat untuk bekerja sama.

3.1.2.2.7.2 Rujukan Keluar
Tabel Rujukan Keluar Ponpek Februari 2025

BULAN DESEMBER 2024		
1	RDS + Prematur + BBLASR	RS Lavalette
2	Abdominal Pregnancy dd syok Hipovelemik	RS Saiful Anwar
3	PEB + BSC+Ascites Permagna+ IUFD	RS Saiful Anwar
BULAN JANUARI 2025		
1	BBLR + Asfiksia	RS Saiful Anwar
2	RDS ok Neonatal pneumonia dd TTNB + Makrosefali	RS Soepraon
3	Post curettage + Sub Involusi Uteri + syok hipovolemi	RS Saiful anwar
BULAN FEBRUARI 2025		
1	P1001 Ab000 dg Eklamsia	RS saiful Anwar
2	P1001 Ab000 dg post SC h+9 dg late HPP ec Sub Involusi Uteri	RS Saiful Anwar
3	RDS +NKB	RS Saiful Anwar
4	RDS + BBLSR	RS Soepraoen
5	RDS + NKB + BBLSR	RS Soepraoen
6	RDS + BBLR	RS Soepraoen
7	RDS + BBLR	RS Saiful Anwar

Grafik Pelayanan Rujukan Eksternal di RS Prima Husada Bulan Februari 2025



Analisis :

Pada bulan Januari 2025 dan Desember 2024 pasien terdapat 3 pasien dirujuk, dan bulan Februari 2025 ada 7 pasien,

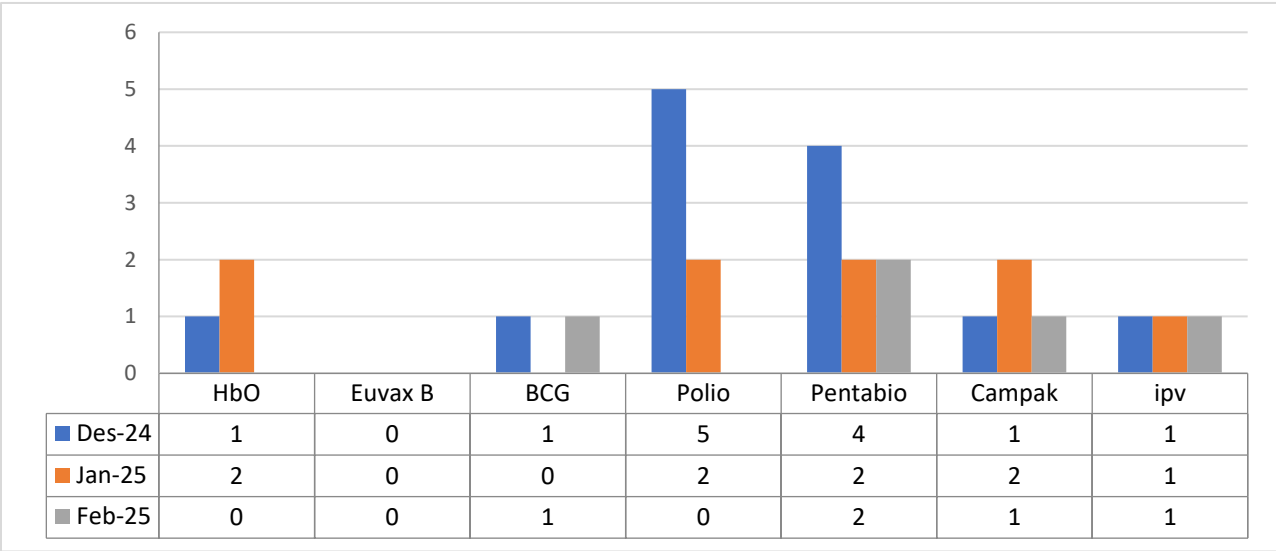
Rencana dan Tindak Lanjut :

Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.1.2.2.12.8 Pelayanan Imunisasi
Tabel Pelayanan Imunisasi Ponek Februari 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025	BULAN FEBRUARI 2025
1	HbO	1	2	0
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	1	0	1
3	Polio	5	2	0
4	Pentabio	4	2	2
5	Campak	1	2	1
6	IPV	1	1	1

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Februari 2025



Analisis :

1. Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode Februari 2025 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga tidak menggunakan vaksin euvax B
2. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi Hbo pada bulan Februari 2025, sedangkan pada Januari 2025 sebanyak 2 bayi, dan Desember 2024 sebanyak 1 bayi. Hal ini dikarenakan ketidaktersedianya vaksin HB0 di RS prima Husada malang, dikarenakan stok vaksin dari dinas Kesehatan kabupaten malang terbatas sehingga Puskesmas belum bisa memeberikan ke RS swast, sehingga bayi yang baru lahir diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari
3. Bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Februari 2025 dan 2 bulan sebelumnya sebanyak 1 bayi dikarenakan tidak ada kunjunagn dan ada yang beralih ke vaksin swata

- 4. Bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Februari 2025 dan Desember 2024 sebanyak 1 bayi dan tidak ada pada bulan Januari 2025 dikarenakan tidak ada kunjunagn dan ada yang beralih ke vaksin swata
- 5. Bayi yang melakukan Imunisasi Campak Pada bulan Februari 2025 dan Desember 2024 sebanyak 1 bayi dan 2 bayi pada bulan Januari 2025, dikarenakan tidak ada kunjunagn dan ada yang beralih ke vaksin swata
- 6. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Februari 2025, sedangkan pada bulan Januari 2025 sebanyak 2 bayi, dan 5 bayi pada bulan desember 2024 dikarenakan tidak ada kunjunagn dan ada yang beralih ke vaksin swata
- 7. Jumlah pasien yg imunisasi Pentabio pada bulan Januari dan Februari 2025 tetap, yaitu 2 bayi, dan 4 bayi pada bulan Desember 2024, imunisasi pentabio diberikan bersamaan dg rota dan PCV, sedangkan vaksin tersebut ada pembatasan dari puskesmas

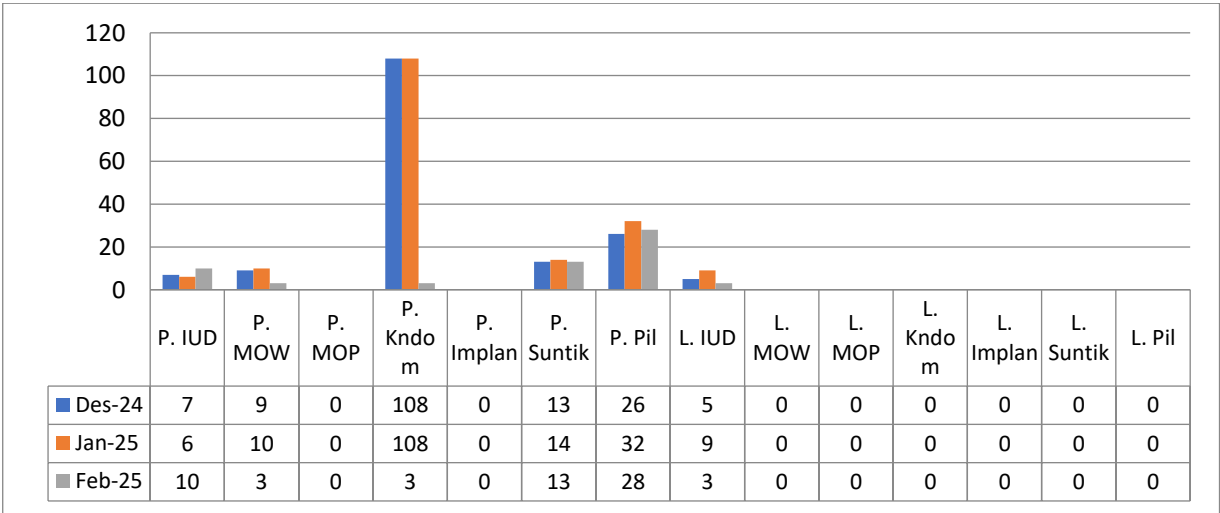
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
- 2. Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.2.2.1.2.9 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Tabel Pelayan Keluarga berencana (KB) Ponek Februari 2025

NO	JENIS	JUMLAH PASANG			JUMLAH LEPAS		
		BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025	BULAN FEBRUARI 2025	BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025	BULAN FEBRUARI 2025
1	IUD	7	6	10	5	9	3
2	MOW	9	10	3	0	0	0
3	MOP	0	0	0	0	0	0
4	Kondom	108	108	3	0	0	0
5	Implant	0	0	0	0	0	0
6	Suntikan	13	14	13	0	0	0
7	Pil	26	32	28	0	0	0

Grafik Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Februari 2025



Aanalisis :

1. Pemasangan KB IUD pada bulan bulan Februari 2025 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 10 akseptor yang terdiri dari 6 akseptor IUD Nova T dan 4 akseptor IUD copper T, pemakaian KB belum maksimal dikarenakan KB IUD coper T pasca salin ada biaya jasa dokter Rp. 400.000, biaya gratis jika dipasang oleh bidan tetapi pasien tidak berkenan, memilih KB di faskes tingkat 1
2. Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan Februari 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 3 pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder. Tindakan MOW dilakukan jika ada indikasi dari DPJP.
3. Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan Februari mengalami penurunan yang sangat banyak jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 3 pengguna, sedangkan pada bulan Desember 2024 dan Januari 2025 sama, yaitu 108 pengguna
4. Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan Februari 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 28 pengguna
5. Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan Februari 2025 dan Desember 2024 sama, yaitu 13 pengguna, sedangkan pada bulan Januari sebanyak 14 pengguna.

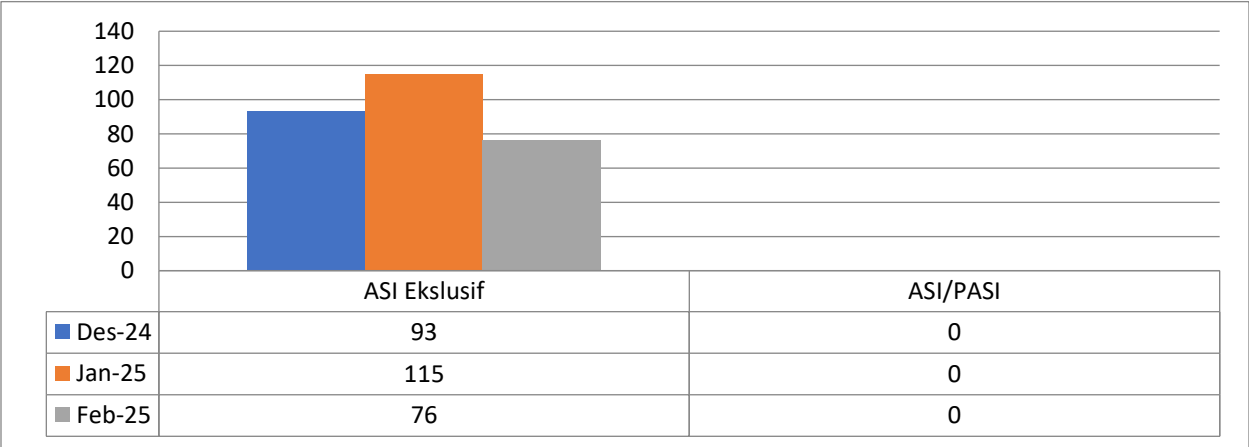
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif
Tabel 5.10 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif Februari 2025

NO	PEMBERIAN ASI	JUMLAH PASIEN		
		BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025	BULAN FEBRUARI 2025
1	Asi eksklusif	93	115	76
2	Asi /PASI	0	0	0

Grafik Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif Di RS Prima Husada Bulan Februari 2025



Analisis :

1. Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan Februari 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 76 bayi. Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
2. Diperbolehkan menggunakan sufor pada bayi dengan kondisi tertentu, dan pastinya atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

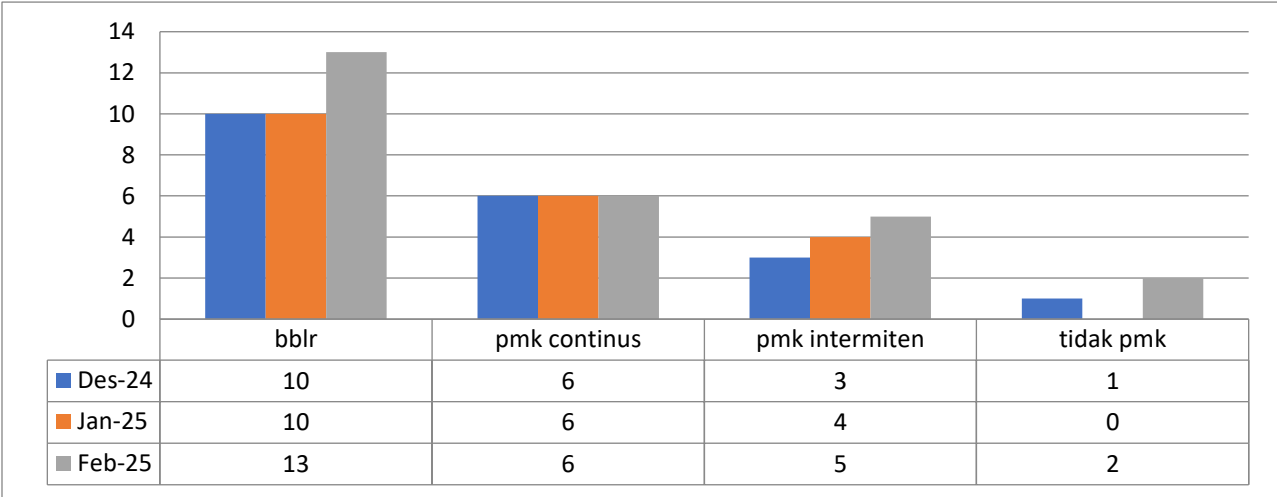
Rencana dan Tindak Lanjut :

Dilakukannya Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI eksklusif

3.2.2.1.2.10 Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR
Tabel Pelayanan Perawatan metode kangguru (PMK) Pada BBLR di Ponpek Februari 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025	BULAN FEBRUARI 2025
1	Bayi BBLR	10	10	13
2	PMK continuos	6	6	6
3	PMK Intermiten	3	4	5
4	Tidak PMK	1	0	2

Grafik Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR di RS Prima Husada Februari 2025



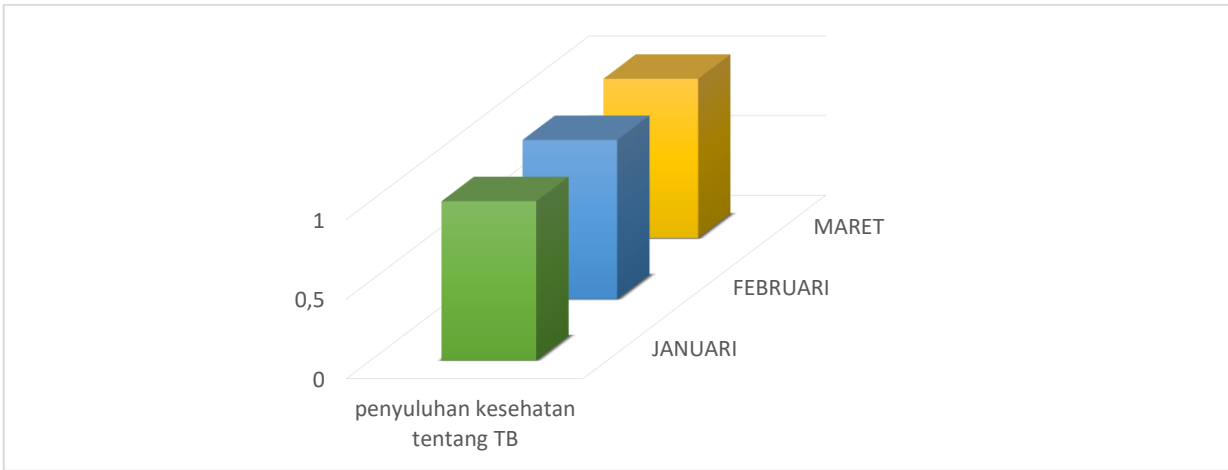
- Analisis :**
- Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500gram.
 - Pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan Februari 2025 meningkat sedikit jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 5 bayi, sedangkan pada bulan Januari 2025 sebanyak 4 bayi dan pada bulan Desember 2024 sebanyak 3 bayi
 - Sedangkan metode PMK continus pada bulan Februari 2025 dan 2 bulan sebelumnya tetap sebanyak 6 bayi. hal ini seiring dg jumlah BBLR yang ada
 - Ada 2 bayi yang tidak dilakukan PMK pada bulan Februari 2025, dan tidak ada yang tidak PMK pada bulan Januari 2025, sedangkan pada bulan Desember 2024 sebanyak 1 bayi. Hal ini dikarenakan kondisi bayi yg tidak mendukung untuk dilakukan PMK karena terpasang alat C-pep dan bayi di rujuk ke RS lain.

Rencana dan Tindak Lanjut
Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku

1.1.2.2. TB DOT'S
3.1.2.2.1 Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Tentang Tuberculosis

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH KEGIATAN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	Penyuluhan kesehatan tentang tuberculosis	1	1	

Grafik Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan di RS Prima Husada



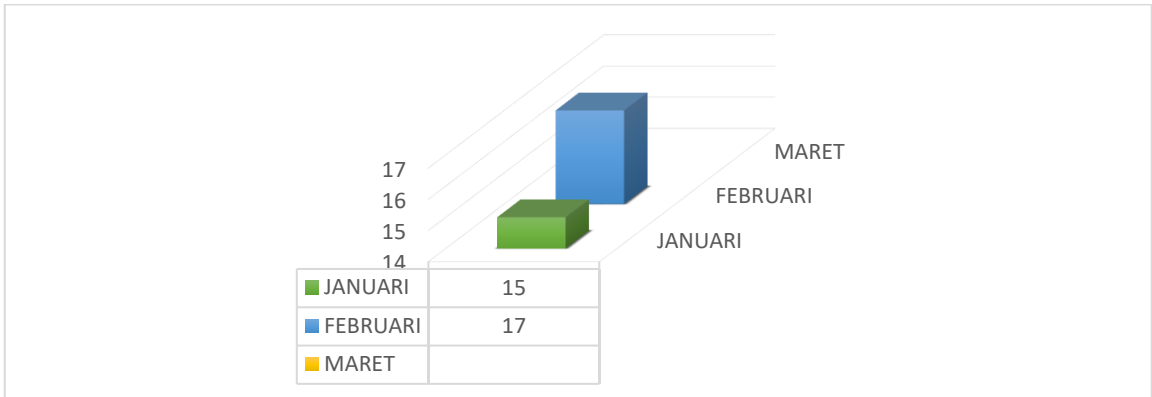
Analisis:
Peserta audiens ditujukan kepada pasien dan keluarga pasien, dengan harapan peserta memahami hasil penyuluhan.

Rencana dan Tindak Lanjut:
Harus diadakan promosi kesehatan secara berkala terkait TBC seperti; pentingnya patuh dalam pengobatan TBC, kapan waktu yang tepat minum obat TBC, apa tanda gejala TBC, dll.

3.1.2.2.2 Skrining Pasien

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pemberian Masker	15	17	

Grafik Jumlah Pasien Dengan Skrining Awal Pemberian Masker di RS Prima Husada



Analisis :

- Pada bulan Januari 2025 terdapat 15 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standar
- Pada bulan februari 2025 terdapat 17 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standar

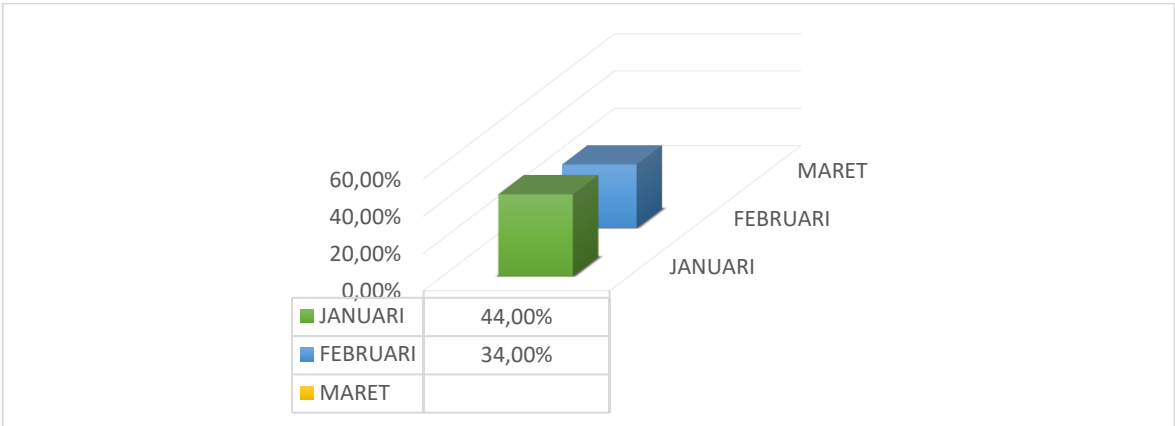
Rencana dan Tindak Lanjut:

- Memfasilitasi ketersediaan masker
- Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

3.1.2.2.3 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Proporsi pasien (terduga dan baru) tekonfirmasi bakteriologis	44	34	

Grafik Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis di RS Prima Husada



Analisis :

- 1. Pada bulan januari 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 44
- 2. Pada bulan februari 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 34

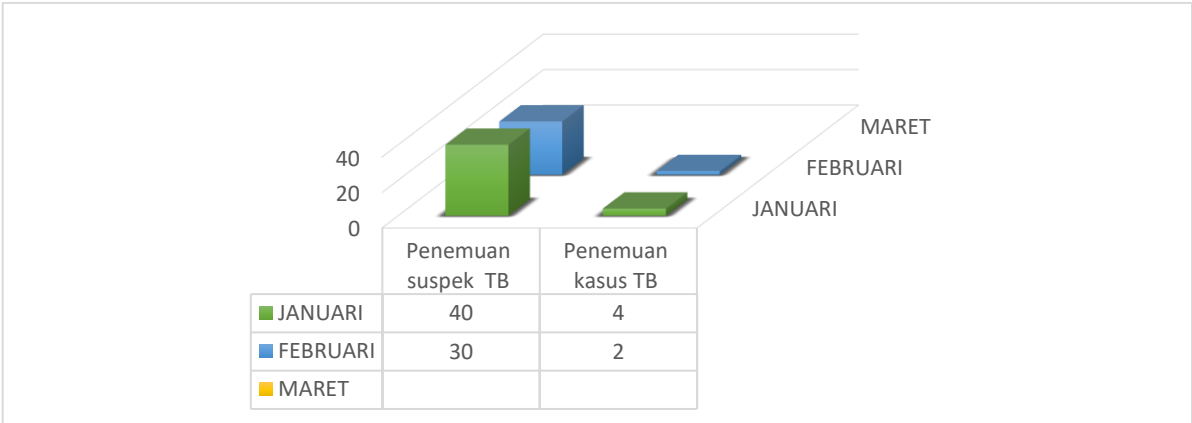
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

3.1.2.2.4 Penemuan Kasus TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Penemuan suspek TB	40	32	
2	Penemuan kasus TB	4	2	

Grafik Penemuan Kasus TB Baru di Rumah Sakit Prima Husada



Analisis :

- 1. Pada bulan januari 2025 terdapat 40 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 4 pasien
- 2. Pada bulan Februari 2025 terdapat 32 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 2 pasien

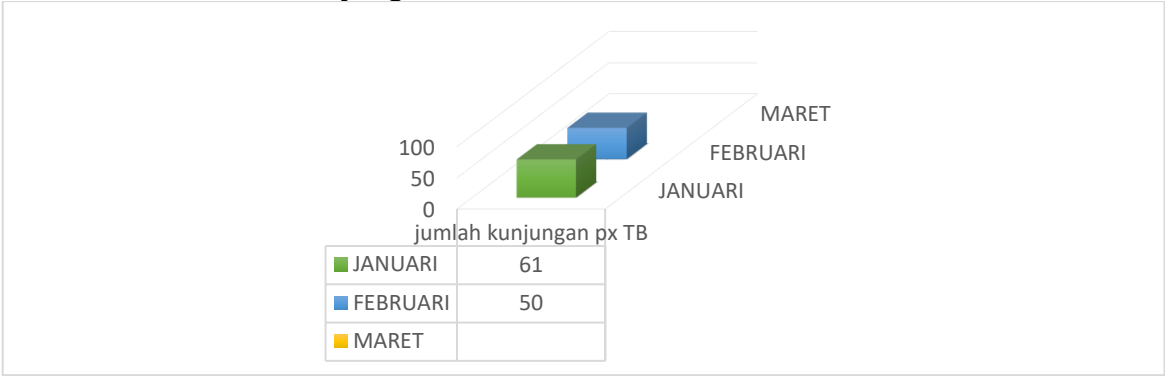
Rencana dan Tindak Lanjut:

Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasien untuk melakukan skrinning TB

3.1.2.2.5 Jumlah Kunjungan pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pasien TB Kunjungan Keseluruhan	61	50	

Grafik Jumlah Kunjungan Pasien TB Baru di Rumah Sakit Prima Husada



Analisis:

- 1. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan Januari 2025 di poli pasien TBC mencapai 61 pasien.
- 2. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan februari 2025 di poli pasien TBC mencapai 50 pasien.

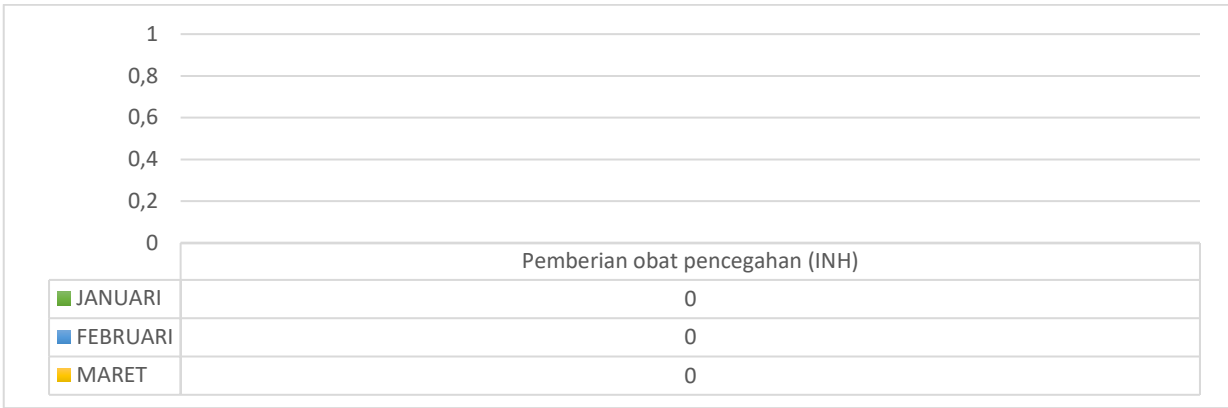
Rencana dan Tindak Lanjut :

Meningkatkan kunjungan pasien

3.1.2.2.6 Pemberian Obat Pencegahan

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pemberian obat pencegahan (INH)	0	0	

Grafik Pemberian Obat Pencegahan di Rumah Sakit Prima



Analisis :
Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

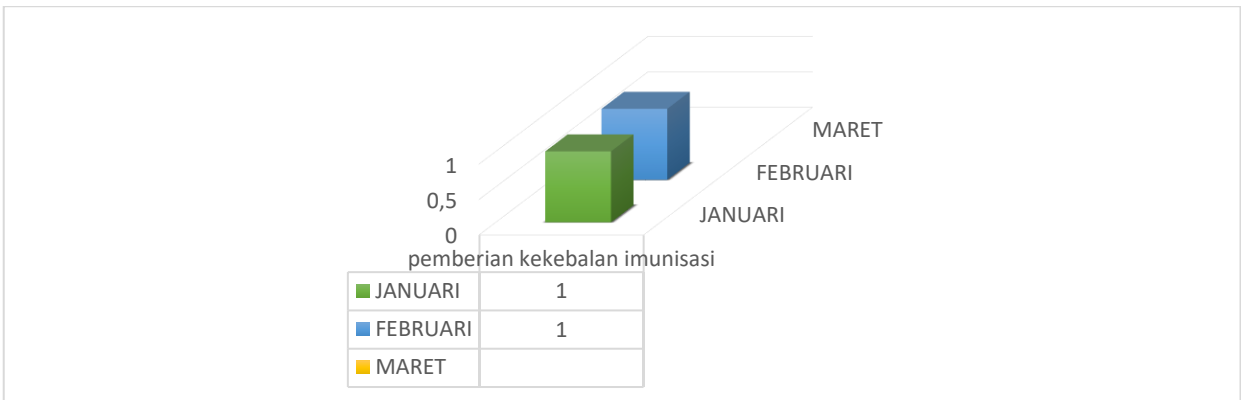
Rencana dan Tindak Lanjut

1. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB kemudian memiliki saudara dengan usia dibawah 17 tahun, agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH)
2. Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB

3.1.2.2.7 Pemberian Imunisasi BCG

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pemberian imunisasi BCG	1	1	

Grafik Pemberian Kekebalan Imunisasi Di RS Prima Husada



- Analisis :**
1. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 1 pasien yang diimunisasi pada bulan Januari
 2. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 1 pasien yang diimunisasi pada bulan Februari

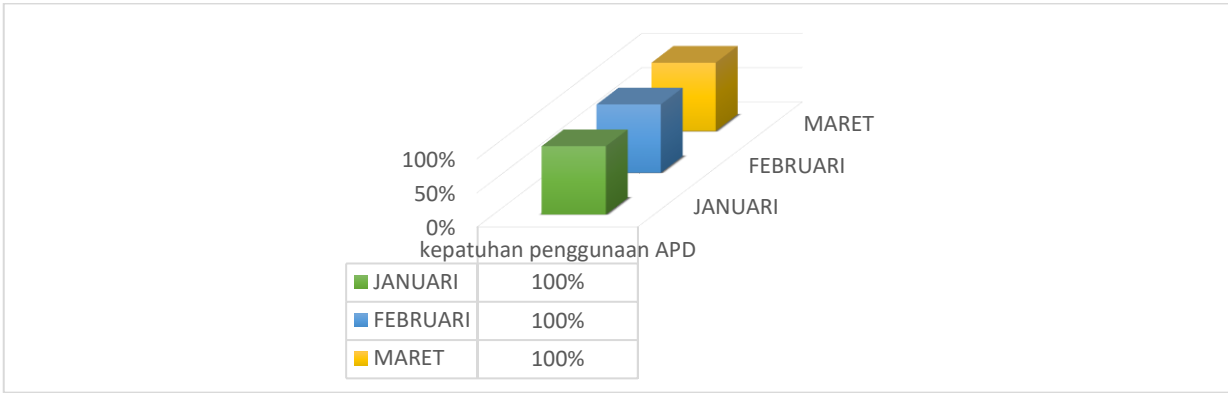
Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
2. Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulanya

3.1.2.2.8 Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD	100%	100%	100%

Grafik Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APDRS Prima Husada



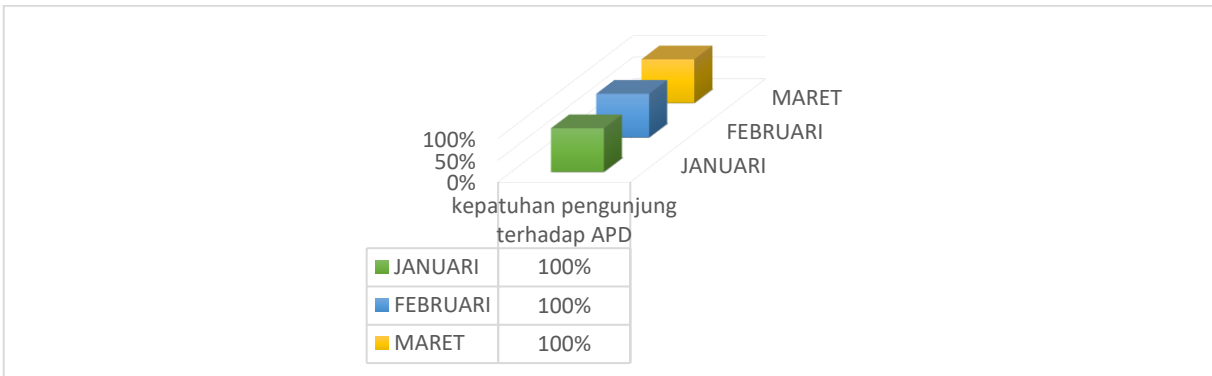
Analisis :
Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.9Kepatuhan Pengunjung Pasien Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Kepatuhan pengunjung pasien terhadap APD	100%	100%	100%

Grafik Kepatuhan Pengunjung Terhadap APD di RS Prima Husada



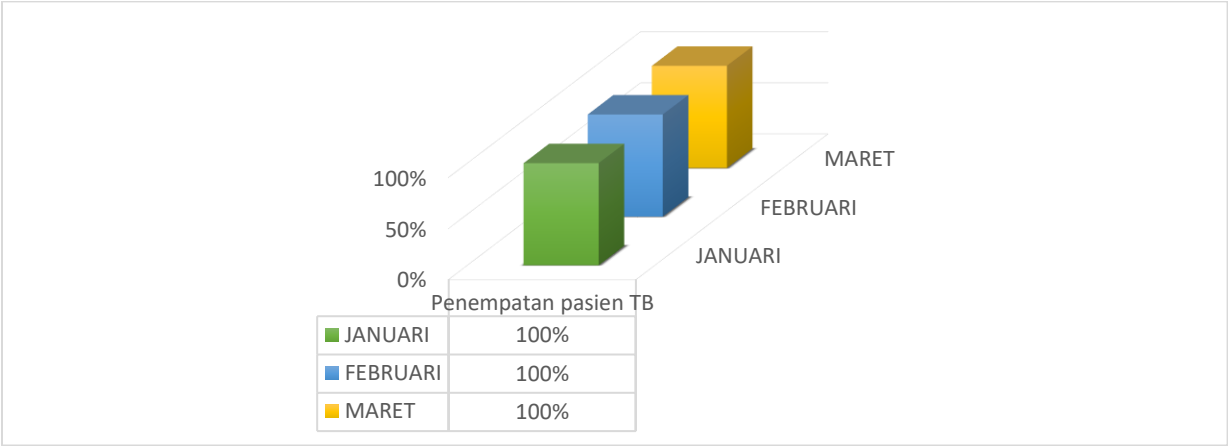
Analisis:
Hasil diatas menunjukan (100%) kepatuhan terhadap APD. Hal ini terjadi karna peningkatan kesadaran pengunjung akan cara penulara.n karena disebabkan covid yang terus menularkan virus

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memperkuat kepatuhan pengunjung dengan cara wajib memberikan masker kepada pengunjung saat di nerstation dengan menanyakan keluarga dari pasien isolasi

3.1.2.2.10 Penempatan Pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Penempatan pasien TB	100%	100%	100%

Grafik Penempatan Pasien TB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Oktober 2024



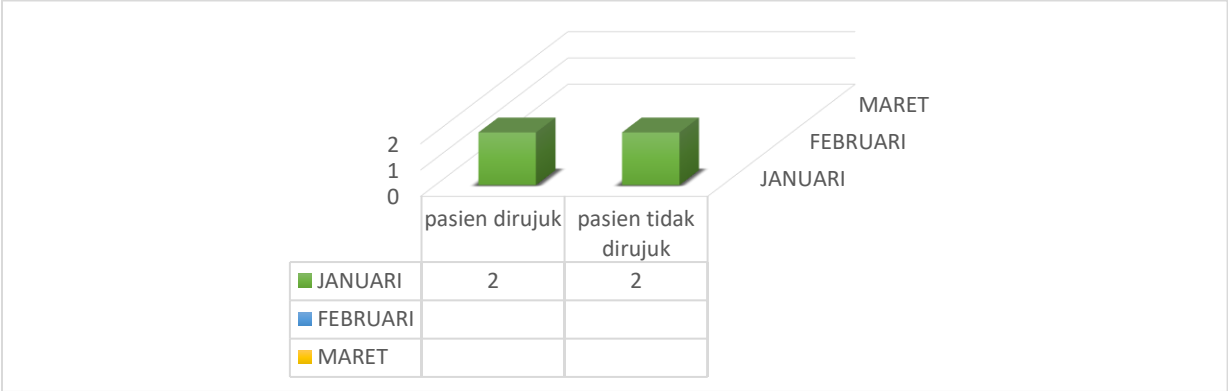
Analisis:
Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang isolasi, hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan penempatan dengan benar

3.1.2.2.11 Pasien TB yang dirujuk

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pasien TB yang dirujuk	2	1	
2.	Pasien TB yang tidak dirujuk	2	1	

Grafik Pasien TB yang dirujuk Di Rumah Sakit Prima Husada



Analisis :

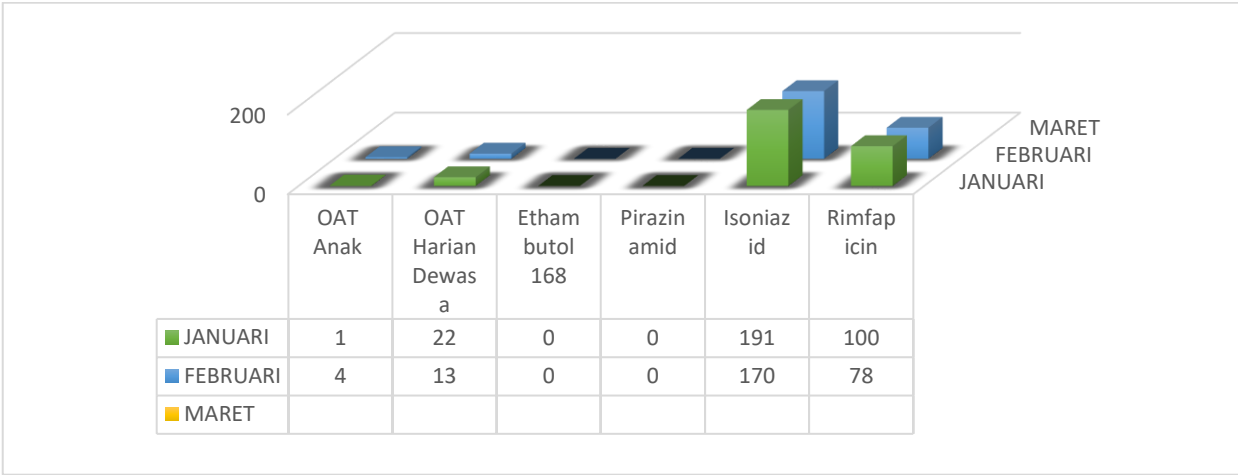
1. Pada bulan Januari 2025 terdapat 2 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
2. Pada bulan Januari 2025 terdapat 1 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

3.1.2.2.12 Stok OAT

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	OAT Anak	1	4	
2.	OAT Harian Dewasa	22	13	
3.	Ethambutol	0	0	
4.	Pirazinamid	0	0	
5.	Isoniazid	191	170	
6.	Rimfapicin	100	78	

Grafik Stok Obat TBC Di Rumah Sakit Prima Husada



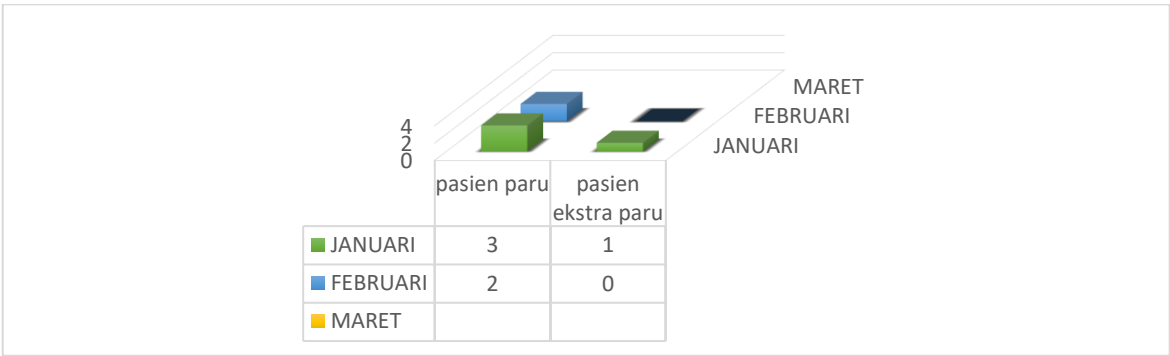
Analisis :
Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

Rencana dan Tindak Lanjut :
Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal.

3.1.2.2.13 Pasien Paru dan Ekstra Paru

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pasien paru	3	2	
2.	Pasien Ekstra paru	1	0	

Grafik Pasien Paru dan Ekstra Paru di Rumah Sakit Prima Husada



Evaluasi :

1. Pada bulan Januari 2025 terdapat 1 pasien ekstra paru

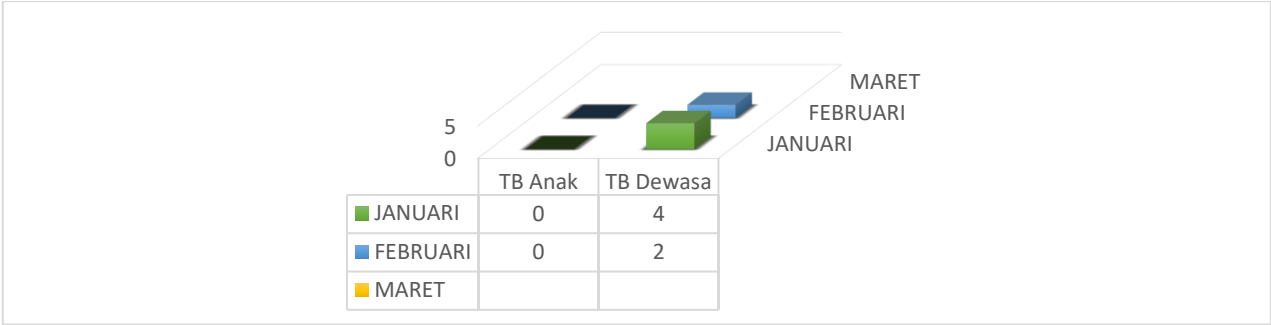
2. Pada bulan Februari 2025 terdapat 0 pasien ekstra paru

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama

3.1.2.2.14 Pasien Anak Dan Pasien Dewasa TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pasien Anak	0	0	
2.	Pasien Dewasa	4	2	

Grafik Pasien Anak dan Pasien Dewasa di Rumah Sakit Prima



- Analisis :**
- Pada bulan Januari terdapat 0 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 4 pasien
 - Pada bulan Februari terdapat 0 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 2 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pencatatan TB sesuai kategori pasien.

3.1.2.2.15 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK TB

NO	KEGIATAN	NAMA PASIEN	PATUH	TIDAK PATUH	ALASAN
1.	dr. Andy, Sp. P	Ny. S	V		
		Ny. I	V		
		Ny. S	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P	Tn. P	V		
3.	Dr. Yunita, Sp. P	Ny. S	V		

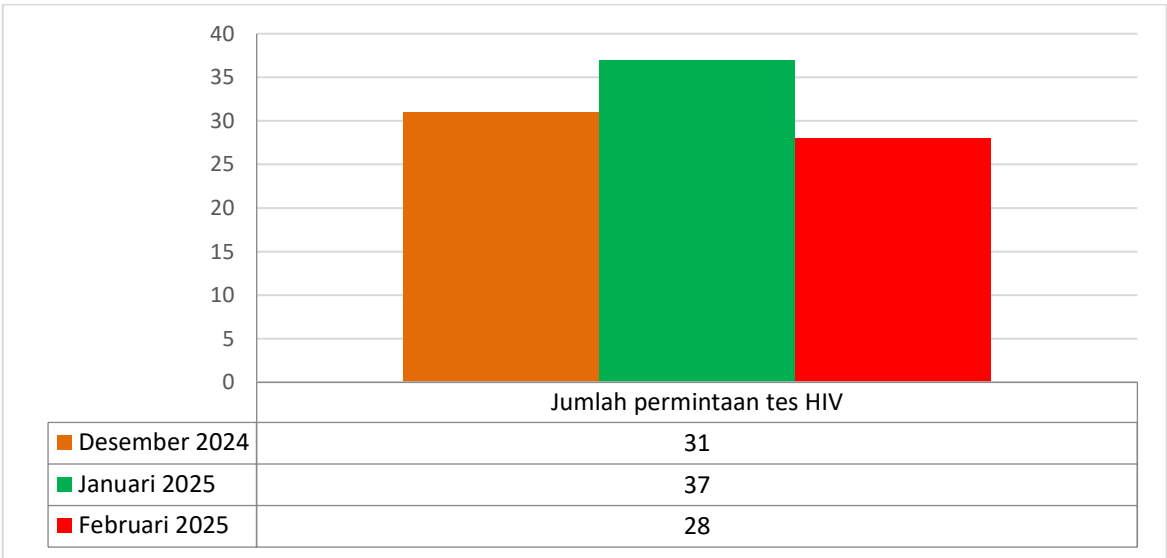
Analisis :
Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

Rencana dan Tindak Lanjut :
Tetap mempertahankan kepatuhan dokter sesuai dengan PPK TB yang berlaku di RS Prima Husada Kabupaten Malang

3.1.2.3 HIV

Jumlah Permintaan Tes HIV				
NO	URAIAN	BULAN		
		DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025
1	Permintaan Test HIV	31	37	28

Grafik Jumlah Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Februari 2025



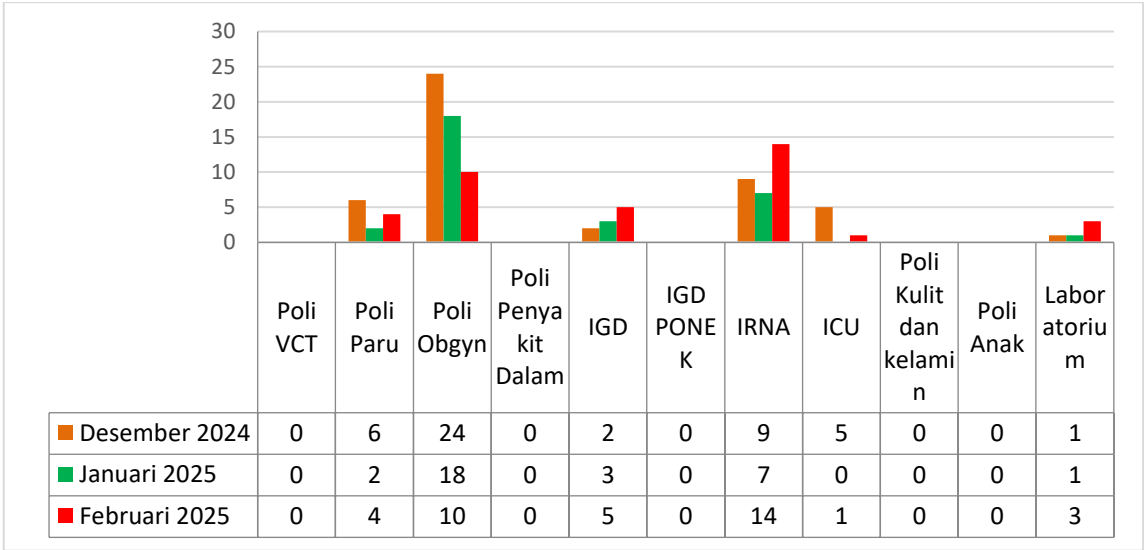
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah permintaan test HIV pada bulan Januari 2025 sebanyak 37 pemeriksaan, pada bulan Desember 2024 sebanyak 31 pemeriksaan, Sedangkan pada bulan November 2024 sebanyak 47 pemeriksaan, Hal ini dikarenakan terdapat pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

3.1.2.3.1. Asal Permintaan Tes HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025
1	Poli VCT	0	0	0
2	Poli Paru	2	4	4
3	Poli Obgyn	18	10	7
4	Poli Penyakit Dalam	0	0	0
5	IGD	3	5	4
6	IGD PONEK	0	0	0
7	IRNA	7	14	11
8	ICU	0	1	0
9	Poli Kulit dan kelamin	0	0	0
10	Poli Anak	0	0	0
11	Laboratorium	1	3	2

Grafik Jumlah Asal Permintaan Tes HIV Februari 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah asal permintaan test HIV di Poli kandungan tetap tinggi dibandingkan dari unit lain pada bulan Desember 2024 sebanyak 17 pasien, pada bulan januari 2025 sebanyak 10 pasien Sedangkan pada bulan februari 2025 sebanyak 7 pasien

Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV.

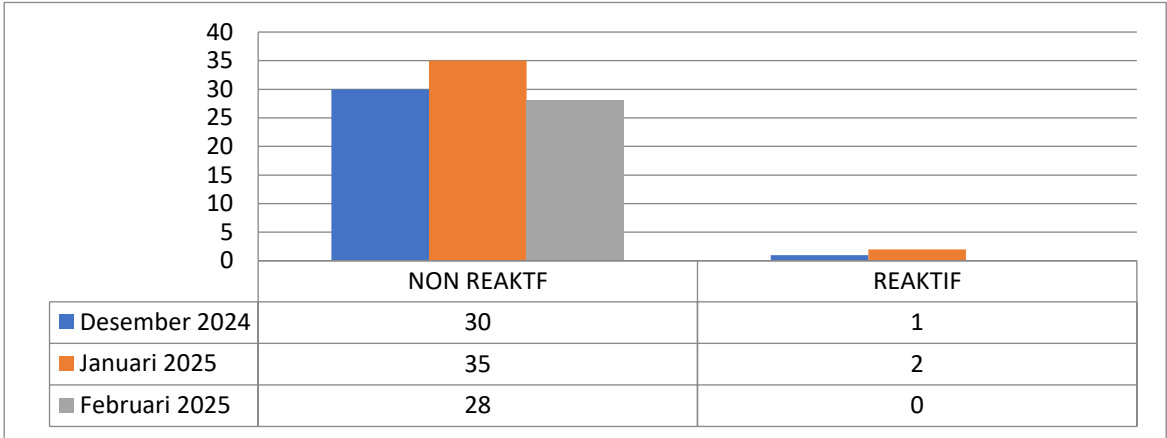
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

3.1.2.3.2 Status HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025
1	Non Reaktif	30	35	28
2	Reaktif	1	2	0

Grafik Status HIV Februari 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan pasien dengan status HIV reaktif yang dilakukan pemeriksaan di RS prima Husada Malang pada pada bulan Januari sebanyak 2 kasus dari rawat inap.

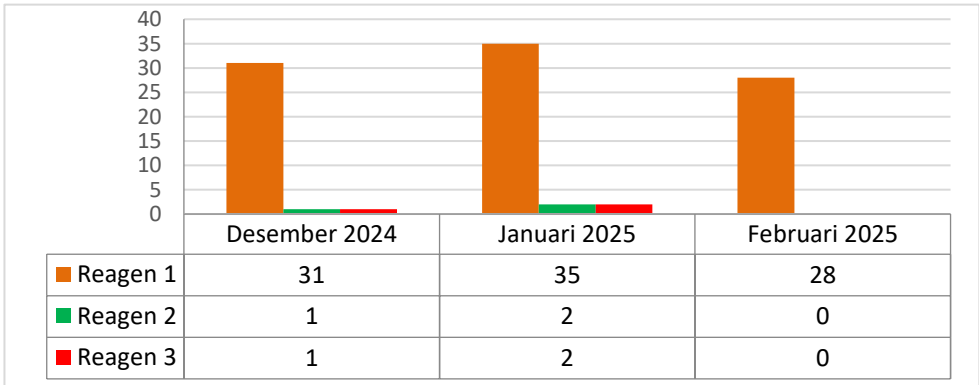
Rencana Tindak Lanjut :

Rumah sakt prima husada malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

3.1.2.3.3 Jumlah Pemakaian Reagen

No	URAIAN	BULAN		
		DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025
1	Reagen 1	31	35	28
2	Reagen 2	1	2	0
3	Reagen 3	1	2	0

Grafik Jumlah Pemakaian Reagen Februari 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen pada bulan Februari 2025 hanya memakai reagen 1 karena tidak ada pasien dengan hasil positif. Pada bulan Januari memakai reagen 3 dikarenakan ada pasien hasil reaktif sebanyak 2 pasien. Pada bulan Desember 2024 memakai reagen 3 Dikarenakan ada pasien dengan hasil reaktif sebeanyak 1 pasien,

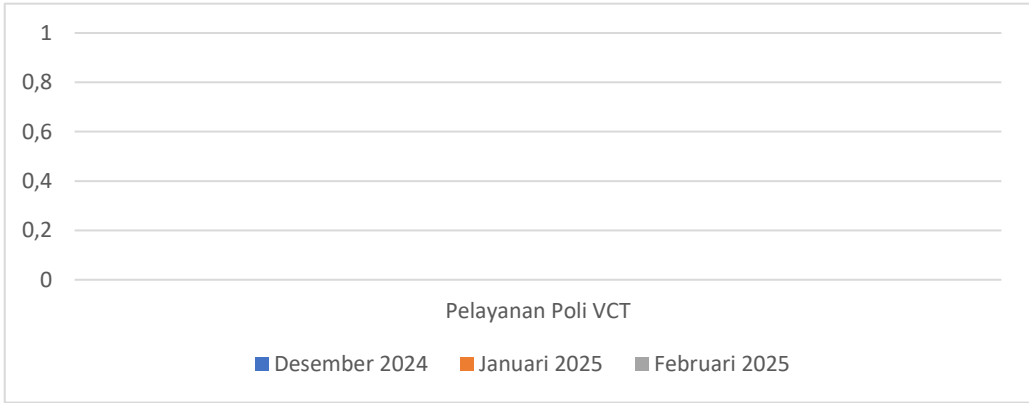
Rencana Tindak Lanjut :

Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3. Tetapi apaila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

3.1.2.3.4 Pelayanan Poli Vct (Voluntary Conseling And Testing)

No	URAIAN	BULAN		
		DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025
1	Pelayanan Poli VCT	0	0	0

Grafik Pelayanan Poli VCT Februari 2025



Analisis pelayanan Poli VCT

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

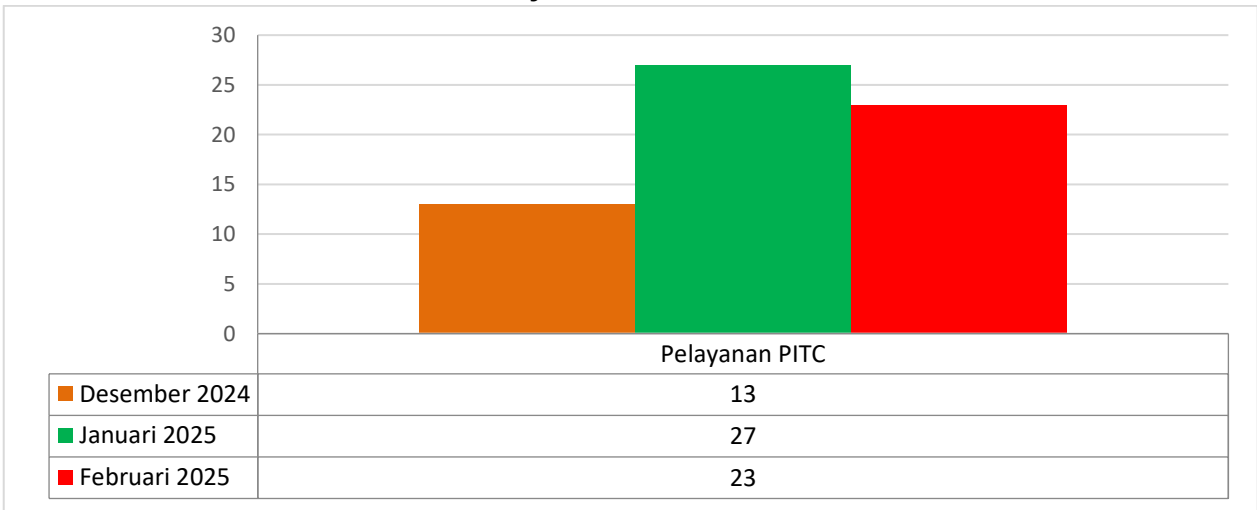
Rencana Tindak Lanjut

Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husadabelum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarenaka asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

3.1.2.3.5 Pelayanan PITC (Provider Initiated Testing and Counseling)

No	URAIAN	BULAN		
		DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025
1	Pelayanan PITC	13	27	23

Grafik Pelayanan PITC Februari 2025



Analisis :

Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada bulan desember sebanyak 13 pasien. pada bulan januari 2025 sebanyak 27 pasien. Sedangkan pada bulan februari sebanyak 23 pasien. Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukkan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

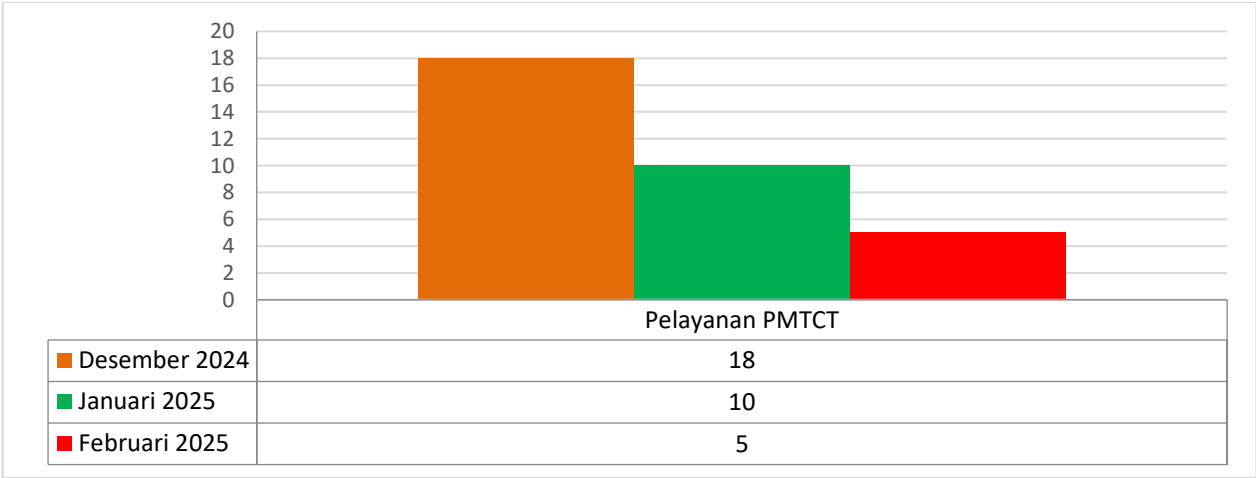
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan peningkatan terkait penjangingan pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan HIV.

3.1.2.3.6 Pelayanan Pmtct (Prevention to Mother Of Child Transmision)

No	URAIAN	BULAN		
		DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025
1	Pelayanan PMTCT	18	10	5

Grafik Pelayanan PMTCT Februari 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada bulan Desember sebanyak 18 pasien Pada bulan januari 2025 sebnayak 10 pasien. Sedangkan pada bulan februari 2025 sebanyak 5 pasien. Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

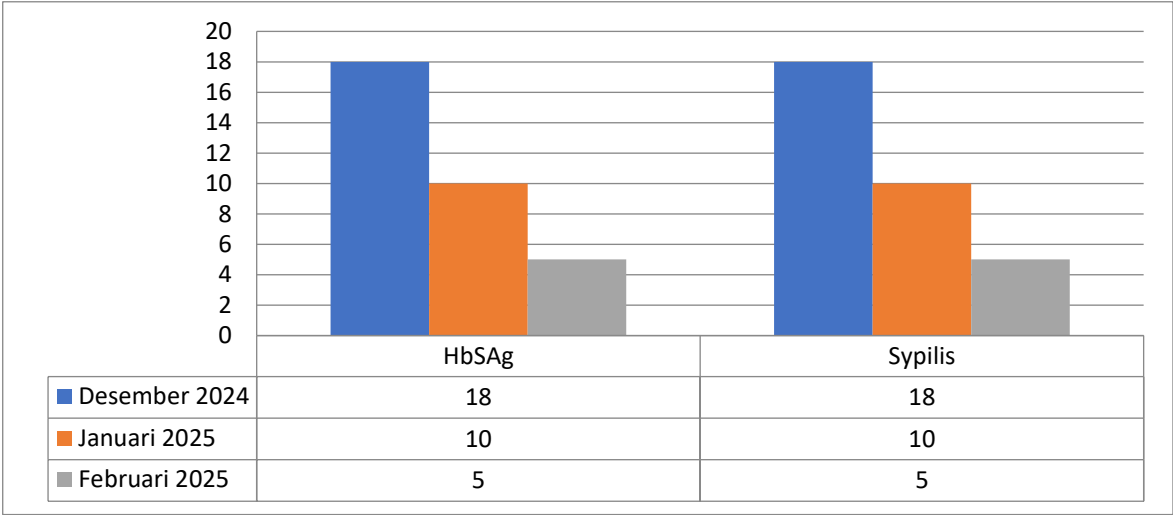
Rencana Tindak Lanjut :

Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

3.1.2.3.7 Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025
1	HbSAg	18	10	5
2	Sypilis	18	10	5

Grafik Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
Februari 2025



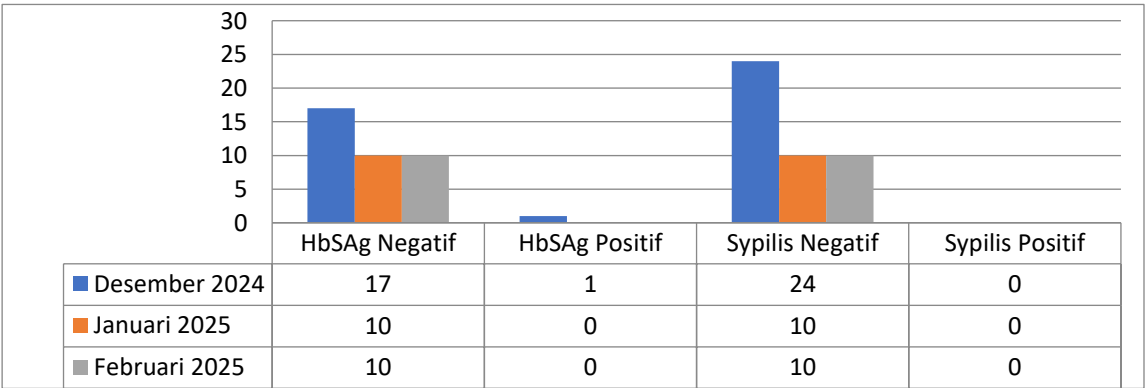
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Sypilis pada bulan desember 2024 sebanyak 18 pasien, pada bulan Januari 2025 sebanyak 10 pasien Sedangkan pada bulan Februari 2025 sebanyak 5 pasien.
Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Sypilis bisa dilakukan.

Rencana Tindak lanjut :
Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

3.1.2.3.8 Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025
1	HbSAg			
	Negatif	17	10	5
	Positif	1	0	0
2	Sypilis			
	Negatif	17	10	5
	Positif	0	0	0

Grafik Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
Februari 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data bahwa pada bulan januari dan february 2025 tidak ditemukan pasien dengan HbSAg maupun Shypilis dengan hasil positif sedangkan pada bulan desember 2024 ditemukan 1 pasien dengan HbSAg Positif

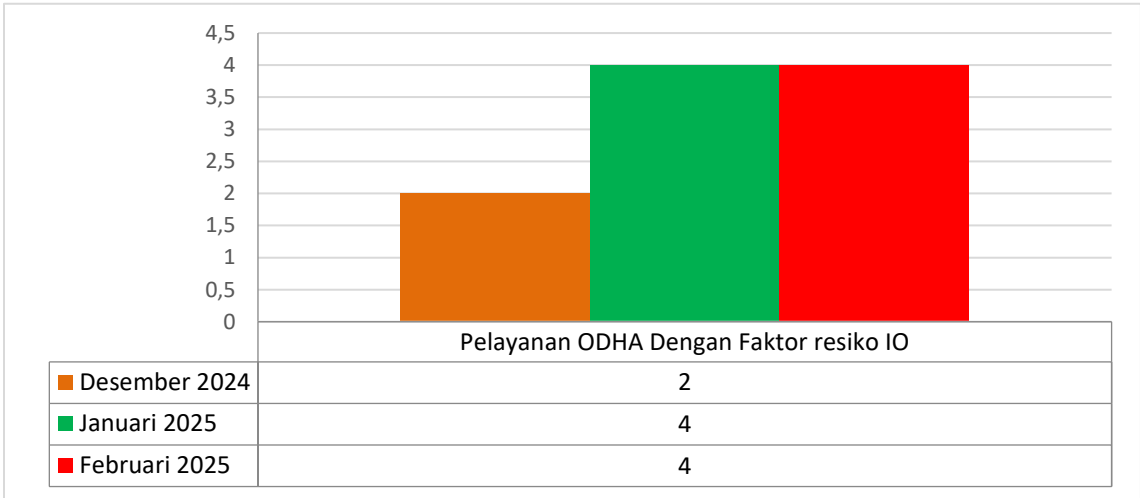
Rencana Tindak Lanjut :

1. Pada pasien HbSAg
- Saat kelahiran aka nada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien.Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.
2. Pada pasien Sypilis
- Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

3.1.2.3.9 Pelayanan Odha Dengan Factor Resiko Infeksi Oportunistik

No	URAIAN	BULAN		
		DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025
1	Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO	2	4	4

Grafik Pelayanan Odha dengan Faktor Resiko IO Februari 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa terdapat pasien dengan diagnose TB positif yang dilakukan pemeriksaan HIV di RS Prima Husada. Pada bulan Desember 2024 didapatkan 2 pasien. Sedangkan pada bulan Januari 2025 dan february 2025 didapatkan 4 pasien. Hal ini dikarenakan dilakukanya screening pasien TB di RS Prima Husada Malang

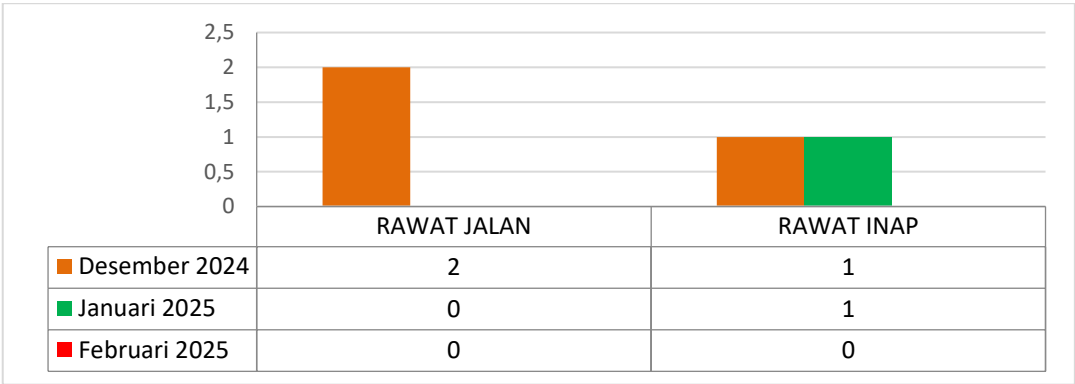
Rencana Tindak Lanjut :

Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di Rumah Sakit Prima Husada Malang sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO. Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

3.1.2.3.10 Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025
1	Rawat Jalan	2	0	0
2	Rawat Inap	1	1	0

Grafik Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS Februari 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa Pada bulan desember 2024 terdapat 3 pasien yang dirujuk 2 dari poli dan 1 dari rawat inap pada bulan januari terdapat 1 pasien yang dirujuk dari rawat inap Sedangkan pada bulan februari 2025 tidak ada pasien dengan HIV yang dirujuk Pasien Dilakukan rujuk dikarenakan RS Prima husada malang belum bisa menangani pasien yang ditemukan positif HIV .

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

3.1.2.4 Stunting & Wasting

3.1.2.4.1 Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

Tabel Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting Januari 2025

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf , pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting	Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien dan sosialisasi kepada seluruh staff mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting.
2	Program 1000 HPK	Pemberian Penyuluhan tentang pentingnya pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien
3	Suplementasi Folat Pada Ibu hamil	Suplementasi Folat Pada ibu hamil dilaksanakan di poli kandungan di RS Prima Husada Malang
4	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil	Pemberian PMT pada ibu hamil dilaksanakan pada saat kegiatan senam hamil di RS Prima Husada Malang
5	Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	1. Kegiatan konseling IMD dilaksanakan sesaat setelah ibu melahirkan 2. Konseling IMD dan ASI eksklusif dilaksanakan pada saat ibu telah memasuki rawat inap maternitas

		3. Penyuluhan tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI eksklusif juga dilaksanakan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan
6	Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dilaksanakan di ruang rawat inap dan melakukan pendampingan di poli anak RS prima husada
8	Pemberian imunisasi	Pemberian imunisasi dilaksanakan di poli anak RS prima husada malang sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis anak dan di rawat inap sesaat setelah bayi baru dilahirkan.
9	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang dilaksanakan apabila ditemui balita dengan gizi kurang di rawat inap
10	Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi	1. Menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan maternal dan neonatal. 2. Konseling pemberian ASI eksklusif. 3. Penyediaan Pojok Laktasi untuk mendukung pemberian ASI eksklusif
11	Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting	1. Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk pada Balita 2. Memastikan kasus, penyebab dan tatalaksana lanjut oleh dokter spesialis anak. 3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting.
12	Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan	Tidak terdapat kunjungan/ Pendampingan klinis kepada balita gizi kurang yang telah KRS dari RSPHM.
13	Program Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait edukasi yang sudah diberikan, serta membuat laporan dan evaluasi kegiatan.

Analisis

1. Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di Rumah Sakit.
2. Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah skait.

3.1.2.4.2 Kinerja Produktivitas
Tabel Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	LOKASI	DESEMBER '24	JANUARI '25	FEBRUAR I '25
Program 1000 HPK	Penyuluhan mengenai kehidupan 1000 hari pertama	Pengunjung RS Prima Husada Malang	IRJA anak dan Kandungan	1	1	1
Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall gedung baru lantai 5	1	1	1

	2. Pembagian tablet tambah darah dan asam folat					
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Hall gedung baru lantai 5	1	1	1
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan, irna maternitas	1	1	1
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita 2. Pembagian PMBA	IRNA Anak	-	1	1	0
Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan Pencatatan dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak	Pasien Anak	IRJA anak	1	1	1
Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Pasien anak dan Bayi baru lahir	IRJA anak	1	1	1
Pemberian vitamin A	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian vitamin A	Pasien anak	IRJA anak	0	0	0

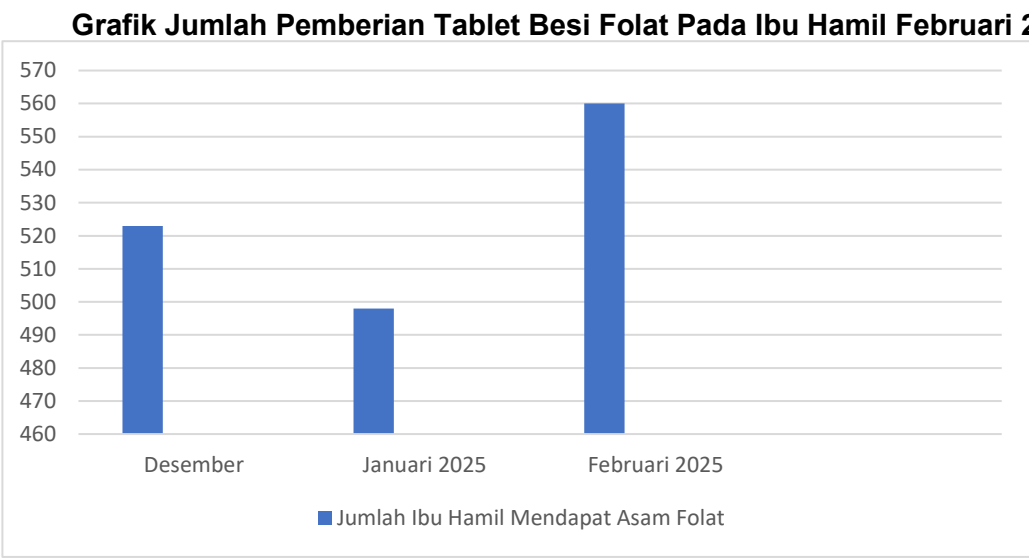
Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan di lingkungan	Pasien anak	Rawat Inap	1	1	0
Pemberian Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian bubuk taburia	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0
Pemberian Obat cacing pada ibu hamil	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0

Analisis :
 Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Pemberian bubuk Taburia dan Mineral mix dilakukan pemberian kepada pasien apabila terdapat pasien rujukan dari puskesmas. Karena bubuk taburia dan mineral mix hanya terdapat di puskesmas. Sehingga jika ada pasien teridentifikasi wasting pihak RS baru mendapat distribusi dari puskesmas wilayah balita tersebut tinggal.

Rencana Tindak Lanjut :
 Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

3.1.2.4.3 Pemberian Tablet Besi Folat Bagi Ibu Hamil
Tabel Distribusi Tablet Besi Folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang

BULAN	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	523	498	560



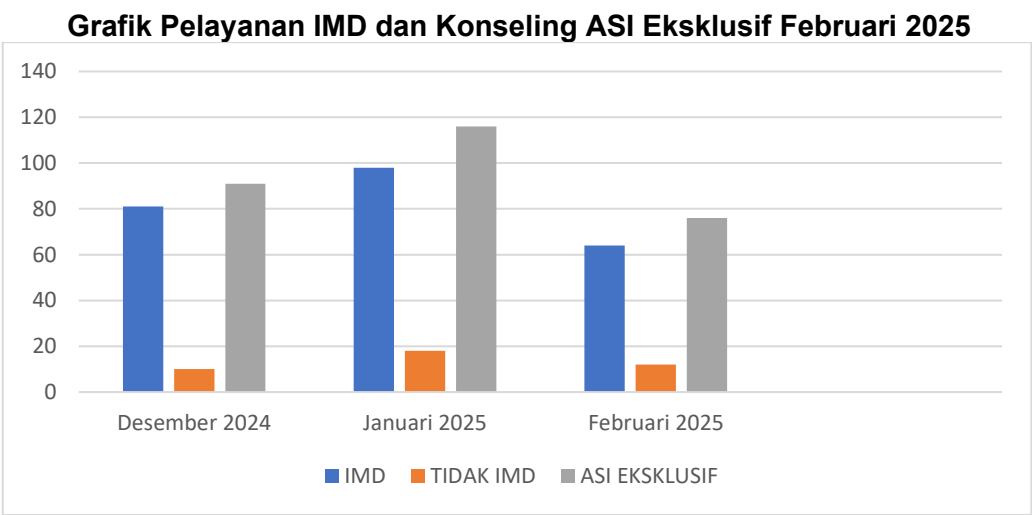
Analisis :
Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat meningkat pada bulan Februari 2025 yaitu 560 ibu hamil yang mendapat tablet besi folat.

- Rencana Tindak Lanjut:**
1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
 2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

3.1.2.4.4 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

Tabel Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025	BULAN FEBRUARI 2025
1	IMD	81	98	64
2	Tidak IMD	10	18	12
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	91	116	76



- Analisis :**
1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Februari 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu 64 bayi.

- 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Februari 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 12 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
- 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
- 4. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif meningkat pada bulan Februari 2025 yaitu sebanyak 76 pasien.

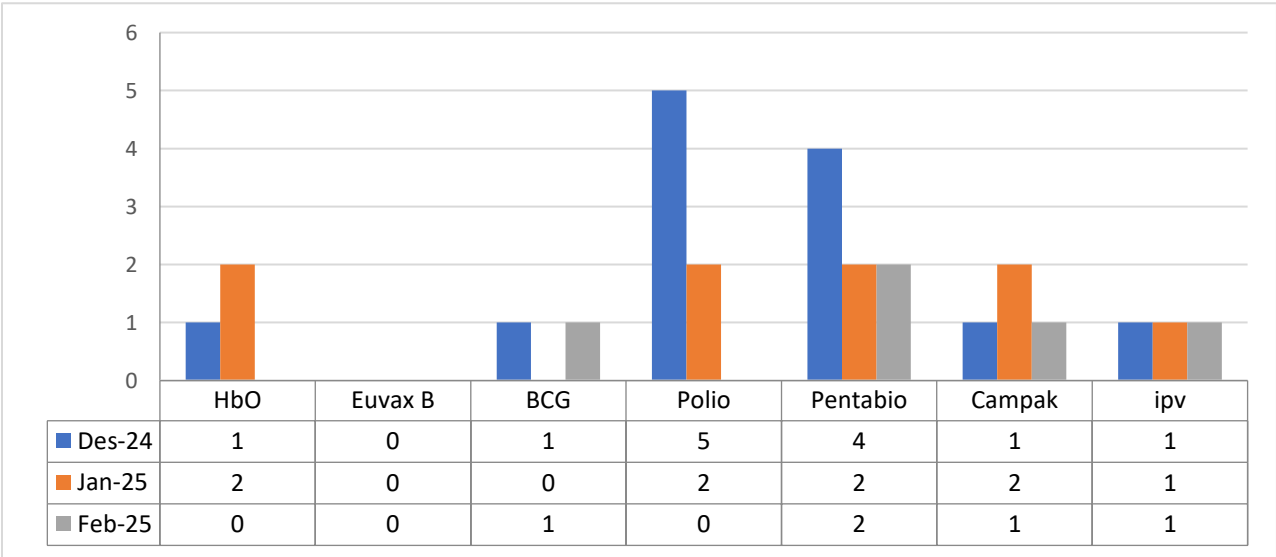
Rencana Tindak Lanjut:

Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

3.1.2.4.5 Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi
Tabel Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025	BULAN FEBRUARI 2025
1	BCG	1	2	0
2	DPT 1	0	0	0
3	DPT 2	1	0	1
3	DPT 3	5	2	0
4	DPT 4	4	2	2
5	Campak	1	2	1
6	IPV	1	1	1

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Desember 2024 - Februari 2025



Analisis:

- 1. Terdapat 1 bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Februari 2025
- 2. Tidak terapat bayi yang melakukan imunisasi Hb0, Euvax B, dan polio
- 3. Terdapat 1 bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Februari 2025
- 4. Pada periode Februari 2025 bayi yang melakukan Imunisasi Campak menurun yaitu 1 bayi.

Rencana Tindak Lanjut :

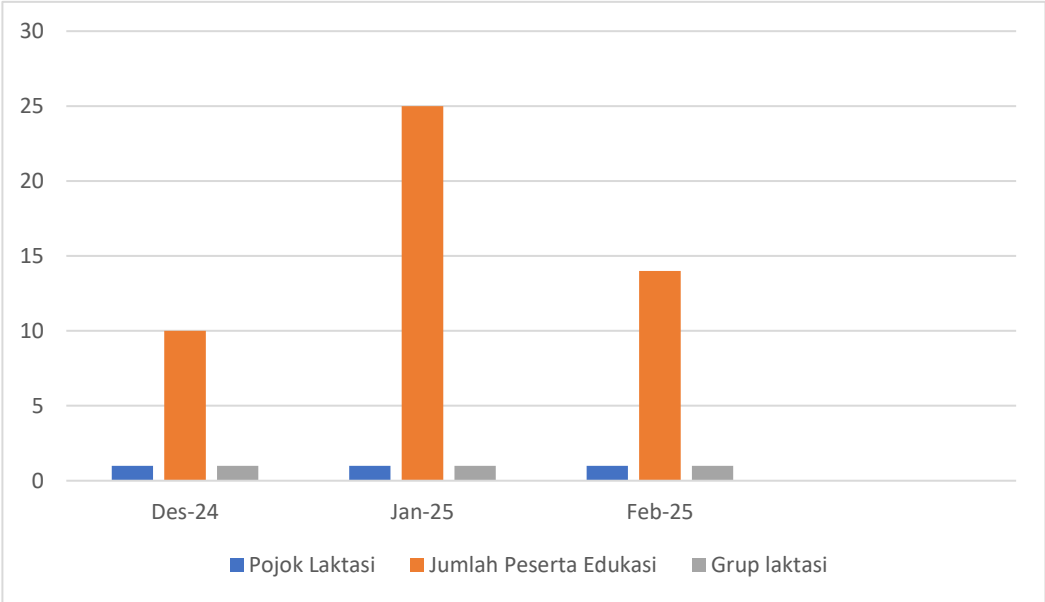
Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit. Bekerjasama dengan pihak puskesmas untuk keersediaan vaksin di RS.

3.1.2.4.6 Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi

Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

KEGIATAN PENERAPAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025
Ruang Pojok Laktasi	1	1	1
Senam Hamil	10	25	14
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1

Grafik Senam Hamil Di Rumah Sakit Prima Husada Desember 2024 – Februari 2025



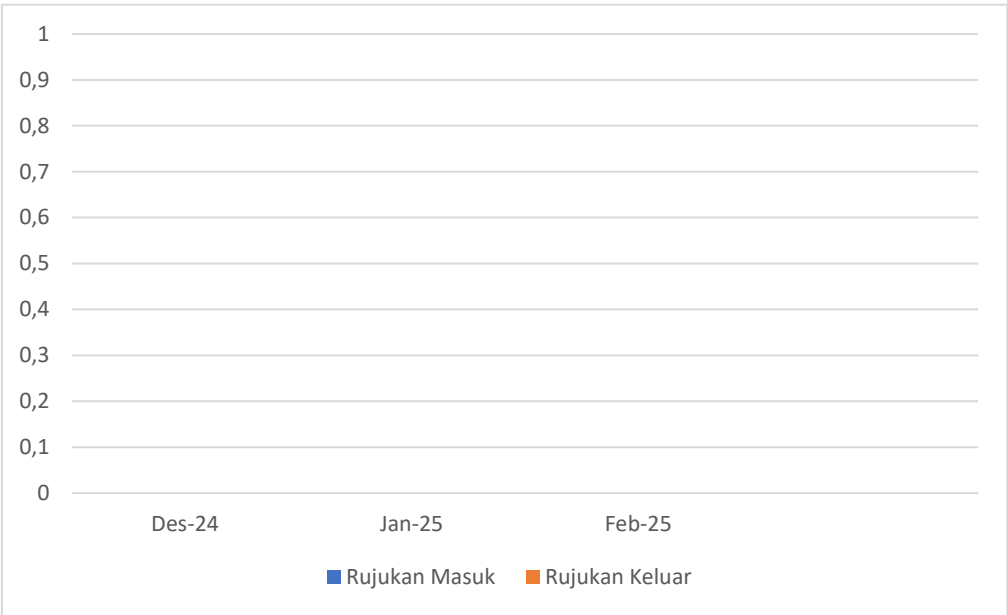
- Analisis :
- Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah rumah sakit prima husada malang.
 - Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
 - Jumlah peserta edukasi pada bulan Februari menurun dibandingkan bulan sebelumnya yaitu sebanyak 14 orang

- Rencana Tindak Lanjut :
- Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.
 - Melakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti senam ibu hamil pada ibu hamil yang tidak memiliki kondisi penyulit saat hamil.

3.1.2.4.7 Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting

Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

RUJUKAN MASUK				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Asal Rujukan
Desember	-	-	-	-
Januari	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-
RUJUKAN KELUAR				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Tujuan Rujukan
Desember	-	-	-	-
Januari	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-



Analisis :
Tidak Terdapat pasien stunting atau wasting yang dirujuk keluar RS maupun rujuk masuk RS

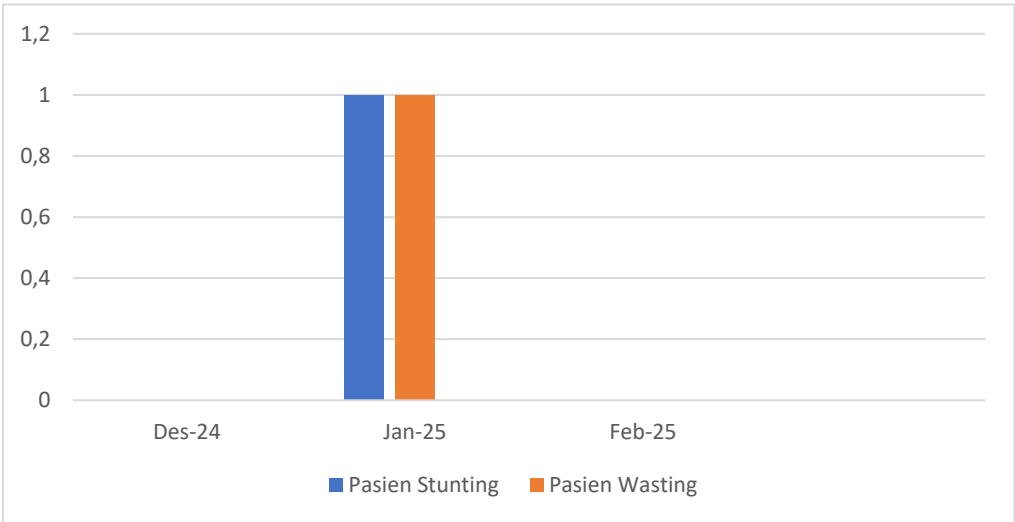
Rencana Tindak Lanjut:
Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjaring pasien stunting dan wasting.

3.1.2.4.8 Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

Tabel Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

BULAN	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	FEBRUARI 2025
Jumlah Pasien Stunting	0	1	0
Jumlah Pasien Wasting	0	1	0

Grafik Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan



Analisis :

Terdapat 1 pasien stunting dan wasting pada bulan Februari 2025. Hal tersebut berkaitan dengan pola makan pasien yang terbilang kurang yaitu 2x sehari dan jumlah asupan makan sekali makan terbilang kurang yaitu 2 sdm tiap makan.

Rencana Tindak Lanjut :

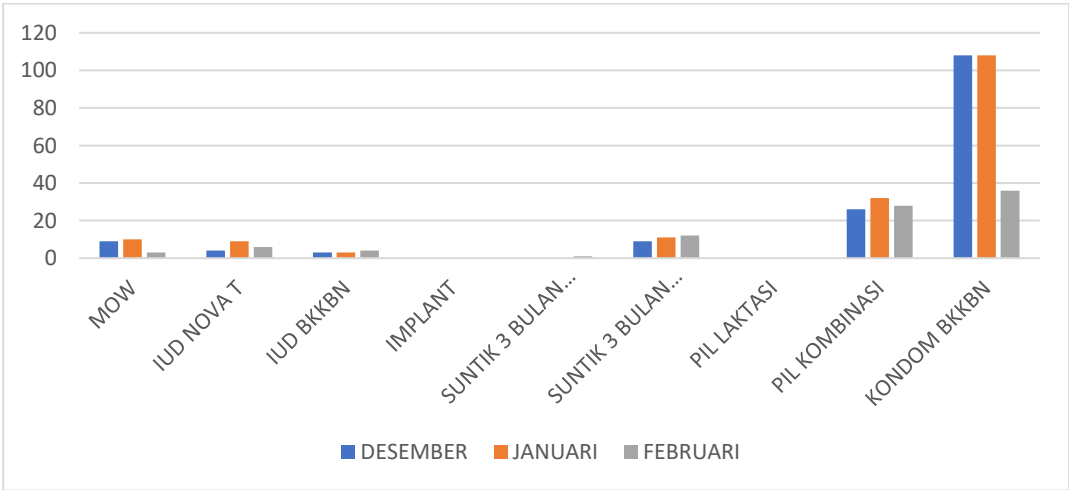
Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada memberikan terapi dengan bekerja sama dengan dokter spesialis anak untuk memberikan vitamin dan antibiotik yang dibutuhkan untuk mengatasi infeksi yang diderita pasien. Selain itu tim SW juga bekerjasama dengan cara melaporkan pasien stunting kepada petugas Gizi Puskesmas wilayah pasien tinggal untuk melakukan pemantauan lebih lanjut dan pemberian intervensi lanjutan kepada balita stunting dan wasting tersebut. Edukasi pemberian intervensi lanjut dilakukan dengan cara mengunjungi kediaman

3.1.2.5 KBRS

3.1.2.6 Angka Capaian Pelayanan KB per Metode Kontrasepsi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025	BULAN FEBRUARI 2025
1	MOW	9	10	3
2	IUD Nova T	4	9	6
3	IUD BKKBN	3	3	4
4	IMPLANT	0	0	0
5	SUNTIK 3 BULAN KOMBINASI	4	3	1
6	SUNTIK 3 BULAN PROGESTIN	9	11	12
7	SUNTIK 1 BULAN	0	0	0
8	PIL KOMBINASI	26	32	28
9	PIL LAKTASI	0	0	0
10	KONDOM BKKBN	108	108	36

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Per Metode Kontrasepsi



- Evaluasi :**
- 1. Peserta MOW pada bulan Desember turun (7) Januari (10) Februari (3)
 - 2. Peserta IUD Nova T pada bulan Desember (4) naik Januari (9) Februari (6)

- 3. Peserta IUD BKKBN Desember naik (3) Januari (3) naik Februari (4)
- 4. Peserta KB suntik 3 bulan kombinasi, pada bulan Desember turun (4) Januari (3) Februari (1)
- 5. Peserta KB suntik progestin naik Desember (9) Januari (11) Februari (12)
- 6. Peserta KB pil kombinasi pada bulan Desember naik (26), Januari (32) Februari (28)
- 7. Peserta KB Kondom pada bulan Desember (108) Januari (108) menurun Februari (36)

Analisis :

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

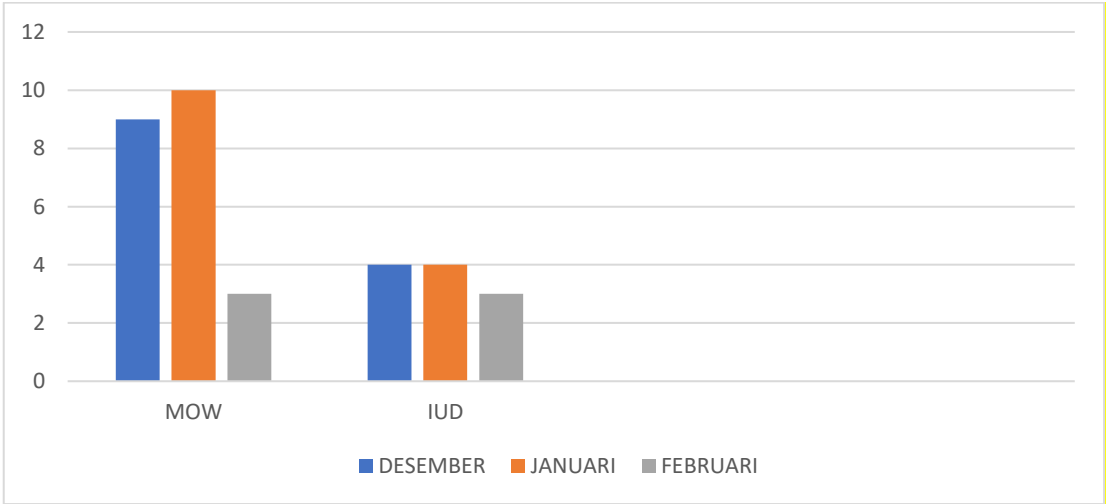
Rencana Tindak Lanjut :

Demi meningkatkan capaian KB maka rumah sakit akan melakukan pelatihan internal bagi para bidan dalam pemasangan IUD pasca plasenta,dan akan diadakan safari KB setiap 2 bulan sekali

Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Persalinan

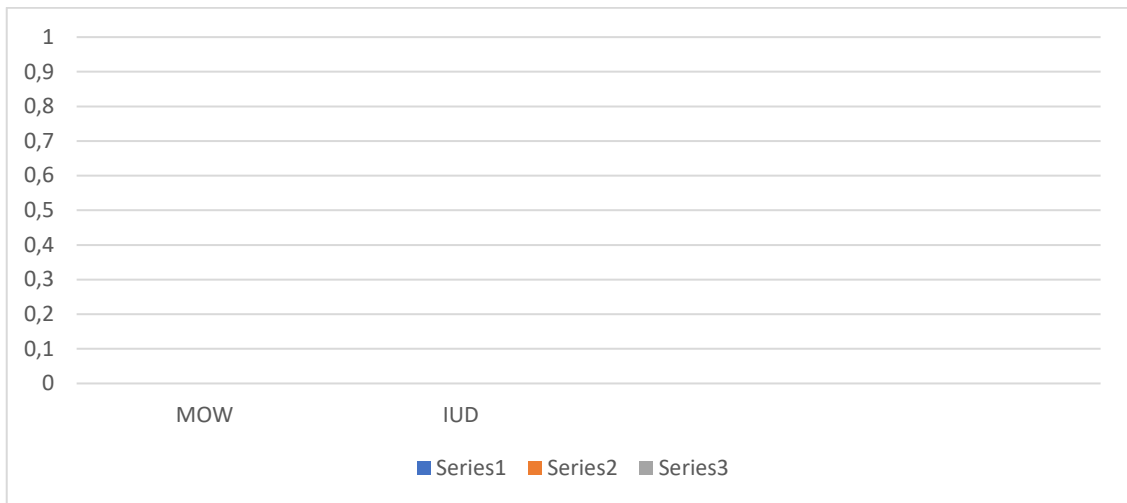
NO	JENIS PELAYANAN PASCA PERSALINAN	JUMLAH PASIEN		
		Bulan Desember 2024	Bulan Januari 2025	Bulan Februari 2025
1	MOW	9	10	3
2	IUD	4	4	3

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



NO	JENIS PELAYANAN PASCA KEGUGURAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025	BULAN FEBRUARI 2025
1	MOW	0	0	0
2	IUD	0	0	0

Grafik Angka Capaian Pelayan KB Pasca Keguguran



Evaluasi :

- 1. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada bulan Desember-Januari-Februari meningkat
- 2. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada bulan Desember -Januari - Februari menetap.

Analisis :

- 1. Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan pertama kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.
- 2. Capaian pelayanan KB pasca keguguran menetap dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan

3.2.3 Tim PPRA

3.2.3.1 Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan III Tahun 2024

3.2.2.1.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Desember 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Emi	P/65	dr. Farid, Sp. N	222921	Hydrocephalus	23/11/2024	04/12/2024	12	Ceftriaxone	3	2x1	15	2	7,5
									Meropenem		3x1	14	3	4,67
									Levofloxacin inf		1x0,5	1,5	0,5	3
2	Reni Fitrijayanti	P/36	dr. Anton, Sp.B	189252	Acute lymphadenitis of face	30/11/2024	02/12/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	0,75
3	Amanie	P/63	dr. Zaki, Sp. B	193977	Necrotizing facitis	30/11/2024	03/12/2024	4	Cefoperazone sodium	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	7	2	3,5
4	Djatismiko	L/70	dr. Heri, Sp. Pd	102366	DM Hiperglikemi	30/11/2024	3/12/2024	4	Metronidazole inf	1	2x0,5	3,5	1,5	2,33
5	Rektiyani	P/47	dr. Ardhany, Sp.Pd	217160	DM Type 2	02/12/2024	06/12/2024	5	Levofloxacin inf	2	1x0,75	1,5	0,5	3
									Meropenem		3x1	9	3	3
6	Raymond S	L/75	dr. Andy, Sp. P	168930	COPD	03/12/2024	10/12/2024	8	Cefoperazone sodium	2	2x1	9	4	2,25
									Gentamycin inj		2x0,08	0,48	0,24	2
7	Suyatno	L/76	dr. Heri, Sp. Pd	058618	DM	06/12/2024	10/12/2024	5	Ceftriaxone	2	2x1	9	2	4,5
									Sulfasalazine		2x0,5	4	2	2
8	Suginem N	L/69	dr. Heri, Sp. Pd	077564	TF	07/12/2024	10/12/2024	4	Levofloxacin po	1	1x0,75	2,25	0,5	4,5
9	Dasuki	L/64	dr. Andy, Sp. P	186331	COPD	09/12/2024	12/12/2024	4	Azithromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
10	Riyanto	L/70	dr. Zora, Sp. Pd	192849	DM, TF	10/12/2024	14/12/2024	5	Levofloxacin inf	1	1x0,5	2,5	0,5	5
11	Amalia W	P/45	dr. Aida, Sp. OG	223649	Leiomyoma of uterus	12/12/2024	14/12/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefixime		2x0,1	0,4	2	0,2
12	Nuryati	P/61	dr. Ardhi, Sp. Pd	059905	Colic Abdomen	13/12/2024	17/12/2024	5	Ceftriaxone	2	2x1	9	2	4,5
									Asam Pipemidat		2x0,4	2,8	0,8	3,5

13	Jito	L/62	dr. Ardhany, Sp.Pd	224093	Febris	17/12/2024	20/12/2024	4	Ceftriaxone	3	2x1	7	2	3,5
									Asam pipemidat		2x0,4	1,6	0,8	2
									Levofloxacin po		1x0,75	1,5	0,5	3
14	Teko Wahyu P	L/56	dr. Anton, Sp.B	216562	Necrotizing fasciitis	18/12/2024	20/12/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		3x1	8	2	4
									Metronidazole po		3x0,25	2	2	1
15	Sukoyo	L/47	dr. Titok, Sp.	077824	Injury of eye and orbit	19/12/2024	23/12/2024	5	Ciprofloxacin inf	2	2x0,2	0,8	0,8	1
									Ciprofloxacin inj		2x0,4	1,6	0,8	2
16	Tony Setiawan	L/61	dr. Ardhi, Sp. Pd	196592	TF	19/12/2024	24/12/2024	6	Ceftriaxone	2	2x1	10	2	5
									Levofloxacin po		1x0,5	2,5	0,5	5
17	Fany Chusnia	P/33	dr. Humaira, Sp.OG	116999	SC	21/12/2024	23/12/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
18	Tarista S	P/23	dr. Humaira, Sp.OG	202207	SC	21/12/2024	23/12/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
19	Santi Supriatin	P/47	dr. Fachry, Sp. BS	224293	Hydrocephalus	21/12/2024	24/12/2024	4	Ceftriaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Clindamycin po		4x0,6	7,2	1,2	6
20	Sudi Winarti	P/79	dr. Pradana, Sp.U	224481	Hematuri	24/12/2024	26/12/2024	3	Ceftizoxime	1	2x2	2	4	0,5

3.2.2.1.3 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Januari 2025

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Evani Sanchia	P/35	dr. Humaira, Sp.OG	216894	Pre Eklamsia Ringan	31/12/2024	02/01/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
2	Rifa Kumala	P/48	dr. Pradana, Sp. U	194596	Cystoscopy	02/01/2025	04/01/2025	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
3	Badariyah	P/55	dr. Ardhi, Sp.Pd	220134	DM type 2	02/01/2025	06/01/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	9	2	4,5
									Levofloxacin po		1x0.5	1,5	0,5	3
4	Robanah	P/64	dr. Zora, Sp.PD	224961	DM Hiperglikemi	04/01/2025	08/01/2025	5	Ciprofloxacin inf	2	2x0,2	1,4	0,8	1,75
									Asam Pipemidat		2x0,4	1,6	0,8	2,5
5	Muliani	P/68	dr. Yoga, Sp.JP	149322	Dyspnea	05/01/2025	10/01/2025	6	Ceftriaxone	2	2x1	10	2	5
									Ciprofloxacin po		2x0,5	4,5	1	4,5
6	Wahyu Aris	L/27	dr. Zaki, Sp.B	225127	Hemoroid	06/01/2025	09/01/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
7	Supiani	P/44	dr. Aida, Sp.OG	223418	PRM	07/01/2025	09/01/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
8	Supriyadi	L/46	dr. Anton, Sp.B	212029	Necrotizing fasciitis	07/01/2025	09/01/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftizoxime		3x1	6	4	1,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
9	Suliana	P/34	dr. Anton, Sp.B	199917	Necrotizing fasciitis	14/01/2025	16/01/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	7	2	3.5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
10	Rara Ayu	P/29	dr. Aida, Sp.OG	156799	SC	16/01/2025	18/01/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
11	Musringatun	P/46	dr. Zaki, Sp.B	095948	Susp appendicitis acute	16/01/2025	19/01/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	7	2	3,5

12	Paeri	L/63	dr. Ardhany, Sp. Pd	225648	Systemic inflamatory	16/01/2025	19/01/2025	4	Levofloxacin inf	1	1x0,5	1,5	0,5	3
13	Desi Ayu	P/29	dr. Humaira, Sp. OG	217065	SC	17/01/2025	19/01/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
14	Sulasmini	P/57	dr. Ira, Sp. JP	225708	Angina Pectoris	17/01/2025	24/01/2025	8	Azitromycin	2	1x1	1,5	0,3	5
									Levofloxacin inf		1x0.75	3	0,5	6
15	Paini	P/58	dr. Zaki, Sp. B	213310	Cholangitis ikterik	18/01/2025	19/01/2025	2	Ciprofloxacin inf	2	2x0,2	0,8	0,8	1
									Metronidazole inf		3x0,5	3	1,5	2
16	Suryanto	L/61	dr. Farid, Sp. U	201834	CVA	18/01/2025	21/01/2025	3	Azitromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
17	Tjong Sui Lan	P/69	dr. Ardhii, Sp. Pd	174685	Colic Abdomen	19/01/2025	26/01/2025	8	Ceftiaxone	2	2x1	4	2	2
									Cefoperazone		2x1	10	4	2,5
18	Atim	P/63	dr. Zaky, Sp. B	064323	Gangren daibeticum	22/01/2025	25/01/2025	4	Ceftriaxone	3	2x1	7	2	3,5
									Cefoperazone		1x2	2	4	0,5
									Metronidazole inf		3x0,5	5	1,5	3,33
19	Ngadi	L/72	dr. Elvi, Sp. P	225992	Dyspnea	22/01/2025	25/01/2025	4	Ceftriaxone	3	2x1	4	2	2
									Levofloxacin inf		1x0,75	1,5	0,5	3
									Asam Ppipemidat		2x0,4	1,6	0,8	2,5
20	Kustinah D	P/50	dr. Heri, Sp. Pd	225997	DM type 2	22/01/2025	26/01/2025	5	Ceftiaxone	2	2x1	9	2	4,5
									Asam Pipemidat		2x0,4	3,6	0,8	4,5

3.2.2.1.4 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Februari 2025

NO	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Santoso	L/59	dr. Yoga, Sp.JP	226229	Syok Kardiogenik	27/01/2025	02/02/2025	7	Ceftriaxone	2	2x1	14	2	7
									Levofloxacin po		1x0,5	3,5	0,5	7
2	Muslica	P/64	dr. Zaki, Sp. B	226256	Necrotizing facitis	28/01/2025	02/02/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	10	2	5
									Metronidazole inf		3x0,5	7,5	1,5	5
3	M Ifham C	L/66	dr. Anton, Sp.B	226468	Ganggren Diabetic	01/02/2025	03/02/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,75	2	0,875
4	Mudjayanah	P/61	dr. Heri, Sp.Pd	226249	DM type 2	01/02/2025	05/02/2025	5	Ceftiaxone	2	2x1	9	2	4,5
									Asam Pipemidat		2x0,4	2,4	0,8	3
5	Ani Ati	P/63	dr. Heri, Sp.Pd	217025	OF	02/02/2025	05/02/2025	4	Ceftriaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Metronidazole inf		2x0,5	3,5	1,5	2,33
6	Munjiono	L/45	dr. Anton, Sp.B	226500	Necrotizing fasciitis	03/02/2025	05/02/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	6	2	3
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
7	Tasu'in	L/67	dr. Ardhany, Sp. Pd	226683	Malaise and fatigue	05/02/2025	07/02/2025	3	Levofloxacin inf	1	1x0,5	1,5	0,5	3
8	Ponimi	P/68	dr. Zaki, Sp.Pd	226831	Post of Amputasi	07/02/2025	10/02/2025	4	Ceftriaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Metronidazole inf		3x0,5	4,5	1,5	3
9	Nabilla I	P/25	dr. Ardhany, Sp.Pd	221471	Diarrhoea	07/02/2025	10/02/2025	4	Asam Pipemidat	2	2x0,4	2	8	2,5
									Metronidazole po		3x0,5	3	1,5	2
10	Sukardi	L/74	dr. Andy, Sp. P	200612	COPD, HT	08/02/2025	13/02/2025	6	Azitromycin po	1	1x0,5	2,5	0,3	8,3
11	Wahyu Saskya	P/23	dr. Aida, Sp.OG	227002	SC	10/02/2025	12/02/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67

									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
12	Shofi'i K	L/64	dr. Zaki, Sp.B	227077	Gangrene	11/02/2025	13/02/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
13	Chrismi Ismawati	P/24	dr. Humaira, Sp.OG	227058	Preamture repture	11/02/2025	13/02/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
14	Wiwik Indrayani	P/32	dr. Andi, Sp.B	226390	Abses Mamae Dextra	13/02/2025	16/02/2025	4	Ceftriaxone	2	2x1	6	2	3
									Metronidazole inf		3x0,5	4,5	1,5	3
15	Wartani	L/65	dr. Anton, Sp.B	186975	Appendicitis pedis	19/02/2025	22/02/2025	4	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	7	2	3.5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
16	Sri Mardiana	P/59	dr. Ira, Sp. Jp	113462	ADHF, Susp Pneumoni	20/02/2025	24/02/2025	5	Azitromycin po	1	1x0,5	1,5	0,3	5
17	Yossy Dwi	P/28	dr. Heri, Sp.Pd	227564	TF	22/02/2025	28/02/2025	7	Ceftriaxone	2	2x1	5	2	2,5
									Asam Pipemidat		2x0,4	2,4	0,8	3
18	Ratnawati	P/40	dr. Humaira, Sp.OG	227676	PEB	24/02/2025	26/02/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
19	Tumiasih	P/46	dr. Zaki, Sp.B	211797	Hemoroid	24/02/2025	27/02/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
20	Rosati	P/51	dr. Pradana, Sp. U	067107	Observation for susp malignant	25/02/2025	28/02/2025	4	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT

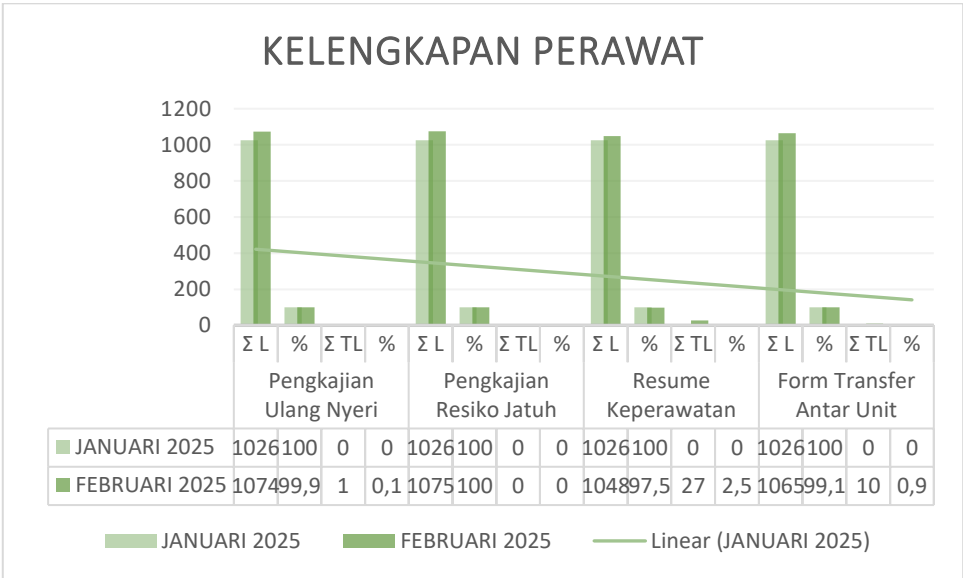
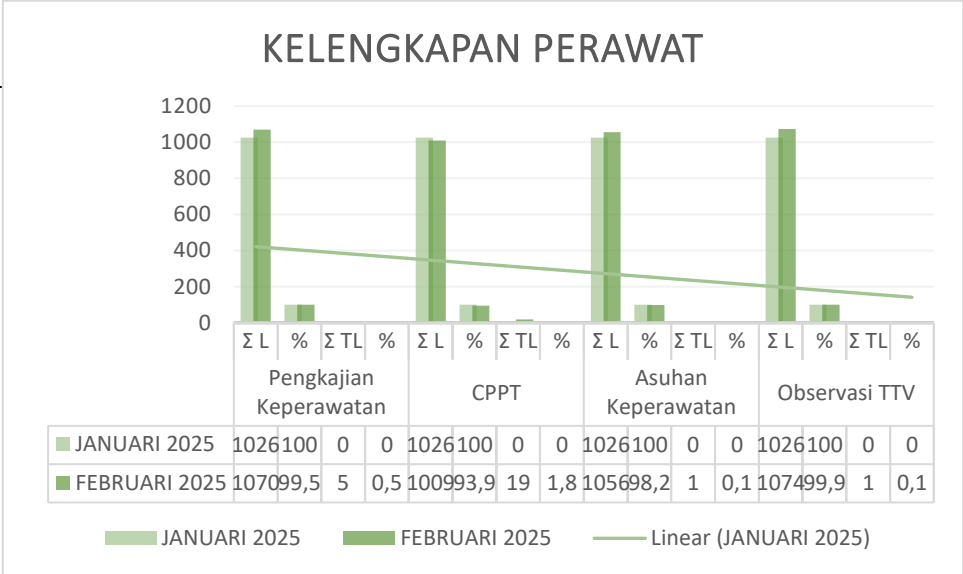
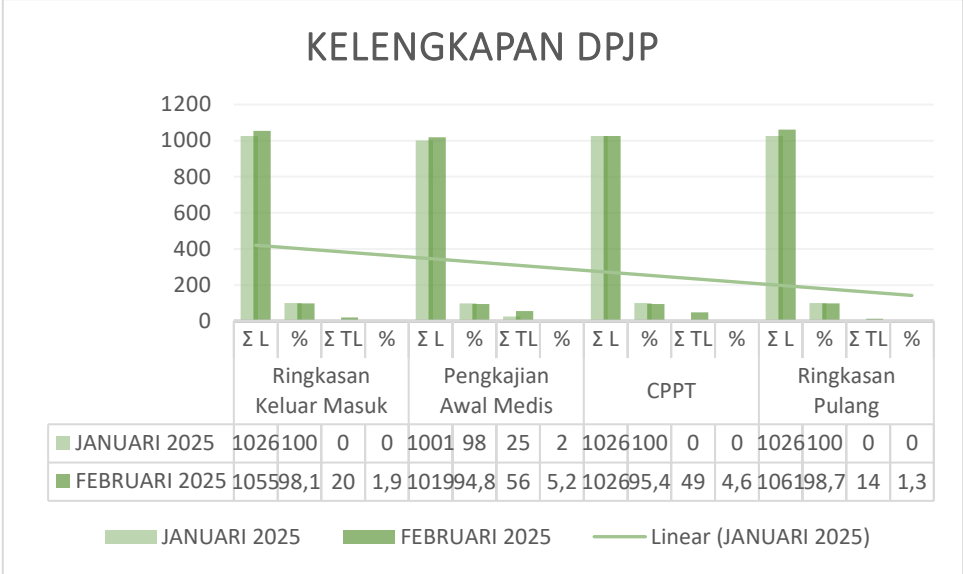
3.6.6.1 Tabel Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Februari Tahun 2025

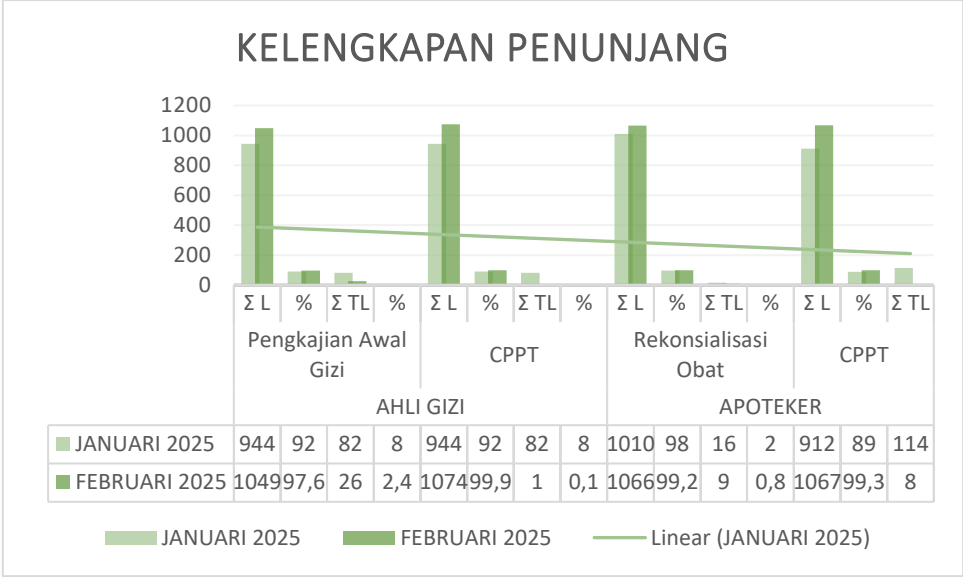
KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	1026	100	0	0	1001	98	25	2	1026	100	0	0	1026	100	0	0
Februari	1055	98.1	20	1.9	1019	94.8	56	5.2	1026	95.4	49	4.6	1061	98.7	14	1.3

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Observasi TTV			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	1026	100	0	0	1026	100	0	0	1026	100	0	0	1026	100	0	0
Februari	1070	99.5	5	0.5	1009	93.9	19	1.8	1056	98.2	1	0.1	1074	99.9	1	0.1
BULAN	Pengkajian Ulang Nyeri				Pengkajian Resiko Jatuh				Resume Keperawatan				Form Transfer Antar Unit			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	1026	100	0	0	1026	100	0	0	1026	100	0	0	1026	100	0	0
Februari	1074	99.9	1	0.1	1075	100	0	0	1048	97.5	27	2.5	1065	99.1	10	0.9

KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	944	92	82	8	944	92	82	8	1010	98	16	2	912	89	114	11
Februari	1049	97.6	26	2.4	1074	99.9	1	0.1	1066	99.2	9	0.8	1067	99.3	8	0.7

3.6.6.2 Grafik Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Februari Tahun 2025





Analisis :
Kelengkapan DRM rawat inap DPJP dan Perawat mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena perubahan alur analisa rekam medis, perawat melakukan setor terlebih dahulu ke petugas rekam medis sehingga data yang didapatkan valid.

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Menginformasikan kepada KARU hasil audit ketidaklengkapan DRM untuk melengkapi kekurangannya.
 2. Melakukan supervise secara berkala.
 3. Trial ERM Rawat Inap, diperlukan warning jika form belum terisi lengkap sehingga tidak bisa melanjutkan ke menu berikutnya.
 4. Membuat raport ketidaklengkapan dan kolaborasi dengan Kabid Keperawatan.

3.7 Permasalahan Rumah Sakit

3.7.1 Permasalahan Instalasi Kamar Operasi (IKO)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1	Penginputan sc umum di input sc eracs,sc eracs di inputkan di sc besar	P	Mensosialisasikan ke semua unit iko untuk penginputan sesuai dengan SE yang terbaru
		D	Penginputan sesuai dengan SE yang terbaru
		S	Masih menemukan kasus penginputan yang tidak sesuai
		A	Evaluasi berapa setelah dilakukan penginputan apakah ada yang tidak sesuai
2	Skiren dari unit irna masih kurang bersih	P	Berkoordinasi dengan unit irna terkait dengan skiren sebelum operasi
		D	Sosialisasi ke semua unit untuk skiren sebelum menurunkan operasi
		S	Menemukan beberapa pasien sudah di skiren tetapi masih belum bersih
		A	Menjalankan skiren yang bersih sebelum pasien di transfer ke IKO

3.7.2 Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit			
1	Penurunan kunjungan rawat inap di IGD (kunjungan rawat jalan lebih banyak dari pada rawat inap)	P	1. Identifikasi Masalah: Penurunan kunjungan rawat inap di IGD 2.Analisi Penyebab: Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kunjungan rawat inap,seperti ketersediaan fasilitas,kualitas pelayanan dan faktor lain Tujuan:Meningkatkan kunjunagn rawat inap di IGD
		D	1. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data tentang kunjungan rawat inap dan rawat jalan di IGD 2. Pengembangan strategi : Mengembangkan strategi untuk meningkatkan kunjungan rawat inap,seperti meningkatkan kualitas pelayanan,memperluas fasilitas,dan melakukan promosi
		S	1. Analisis data : Menganalisis data yang di kumpulkan untuk mengetahui efektivitas strategi yang di terapkan 2. Evaluasi hasil : mengevaluasi hasil yang di capai dan menentukan apakah strategi yang diterapkan efektif atau tidak
		A	1. Perbaiki strategi : Jika strategi yang diterapkan tidak efektif,maka perlu dilakukan perbaikan strategi 2. Penerapan strategi baru : Jika strategi yang diterapkan efektif,maka perlu dilakukan penerapan kunjungan rawat inap di IGD
2	Komplain pasien JKK harus	P	1. Identifikasi Masalah: Pelayanan yang lama di

	menulis kronologi terlebih dahulu baru bisa di daftar sehingga pelayanan jadi lama		IGD karena perawat harus menunggu kronologi baru 2. Analisis penyebab: faktor-faktor yang menyebabkan pelayanan yang lama, seperti proses penginputan data yang manual, 3. Tujuan: Mengurangi waktu tunggu pasien di IGD dan memperbaiki proses penginputan data
		D	1. Pengembangan sistem penginputan data elektronik: Mengembangkan sistem penginputan data elektronik untuk mempercepat proses penginputan data
		S	1. Pengumpulan data: mengumpulkan data tentang waktu tunggu pasien JKK di IGD 2. Analisis data: Menganalisis data untuk mengetahui jumlah pasien JKK
		A	1. Perbaiki sistem: jika evaluasi menunjukkan alurnya lebih cepat dijalankan
3	BHP IV canula no.24 dan 20 sering bocor mengakibatkan pasien harus di infus ulang (sehingga resiko komplain dan menambah biaya iv karena harus menginput ulang)	P	1. Identifikasi masalah: IV canula no.24 dan 20 sering bocor, menyebabkan pasien harus di infus ulang 2. Analisis penyebab: Faktor-faktor yang menyebabkan iv canula bocor seperti: 1. Kualitas iv canula yang kurang baik 2. teknik pemasangan iv canula yang tidak tepat 3. penggunaan iv canula yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien 3. Tujuan: Mengurangi insiden IV canula bocor dan menghemat biaya
		D	1. Penggunaan IV canula berkualitas: Menggunakan iv canula berkualitas tinggi yang telah teruji dan terbukti efektif 2. Pelatihan teknik pemasangan IV canula: Melakukan pelatihan bagi staf tentang teknik pemasangan iv canula yang tepat 3. Penggunaan iv canula yang sesuai: menggunakan iv canula yang sesuai dengan kebutuhan pasien
		S	1. Pengumpulan data: menggunakan data tentang insiden iv canula bocor sebelum dan setelah implementasi perubahan 2. Analisa Data: Menganalisis data untuk mengetahui apakah insiden iv canula bocor telah berkurang 3. Evakuasi hasil: mengevaluasi hasil untuk menentukan apakah perubahan yang dilakukan telah efektif
		A	1. Perbaiki proses: Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa insiden iv canula bocor masih tinggi, maka perlu dilakukan

			perbaiki proses 2. Pengembangan protokol: Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa insiden IV canula bocor telah berkurang, maka perlu dilakukan pengembangan protokol untuk memastikan bahwa proses pemasangan IV canula tetap efektif dan efisien
--	--	--	--

3.7.3 Permasalahan Rawat Inap

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Harga inputan breathing circuit berubah di sistem dengan sendirinya	P	- Identifikasi masalah: Harga inputan breathing circuit berubah di sistem dengan sendirinya - Analisis penyebab: Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan harga, seperti kesalahan penginputan data, perubahan harga yang tidak terkontrol dan kegagalan sistem dalam memperbarui harga - Tujuan: Mengembalikan harga inputan breathing circuit ke harga yang benar dan memastikan bahwa perubahan harga dapat di kontrol - Hipotesis; Dengan mengatur akses pengguna dan mengaktifkan log perubahan, kita dapat mengontrol perubahan harga inputan breathing circuit
		D	- Pengaturan akses: mengatur akses pengguna untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang dapat mengubah harga - Pengmeblian harga: Mengembalikan harga inputan breathing circuit ke harga yang benar - Pengaktifan log perubahan: - Mengaktifkan log perubahan untuk memantau perubahan harga dan mengidentifikasi siapa yang membuat perubahan
		S	- Pengumpulan data: mengumpulkan data tentang perubahan harga sebelum dan setelah implementasi perubahan - Analisis data: menganalisis data untuk mengetahui apakah perubahan harga di kontrol - Evaluasi hasil: Mengevaluasi hasil untuk menentukan apakah perubahan yang dilakukan telah efektif
		A	Perbaiki proses: Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa perubahan harga masih

			tidak terkendali,maka perlu dilakukan perbaikan proses 2. Pengembangan protokol: Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa perubahan harga telah dikontrol,maka perlu dilakukan pengembangan protokol untuk memastikan bahwa perubahan harga dapat di kontrol di masa depan
2	Banyaknya stok spuit di rawat inap	P	1. Identifikasi masalah: Stok spuit dan unit tidak terkontrol,sehingga menyebabkan kekurangan atau kelebihan stok 2. Analisis penyebab:faktor-faktor yang menyebabkan stok spuit tidak terkontrol, seperti: 1. Kurangnya pengawasan stok 2.Tidak ada sistem pengolahan stok yang efektif 3.Perubahan kebutuhan pasien 3. Tujuan: Mengelola stok spuit di unit dengan efektif dan efesien 4. Hipotesis: Dengan menerapkan sistem pengelolaan stok yang efektif,kita dapat mengontrol stok spuit di unit
		D	1. Pengembangan sistem pengelolaan stok: Mengembangkan sistem pengolaan stok yang efektif,seperti menggunakan aplikasi pengolahan stok atau spreadsheet 2. Pengaturan batas stok: mengatur batas stok spuit di unit untuk memastikan bahwa stok tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit 3. Pengawasan stok: mengawasi stok spuit di unit secara teratur untuk memastikan bahwa stok tidak habis atau tidak terlalu banyak
		S	1. Pengumpulan data: mengumpulkan data stok spuit di unit sebelum dan setelah implementasi sistem pengelolaan stok 2. Analisis data: Menganalis data untuk mengetahui apakah stok spuit di unit telah terkontrol 3. Evaluasi hasil: Mengevaluasi hasil untuk menentukan apakah sisitem penglolaan stok yang diterapkan telah efektif
		A	1. Perbaikan sistem: Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa stok spuit di unit masih tidak terkontrol, maka perlu dilakukan perbaikan sistem pengelolaan stok

3.7.4 Permasalahan Rawat Jalan

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Penyesuaian surat kontrol	P	Koordinasi dengan pendaftaran untuk kie jika mundur kontrol harus konfirmasi terlebih dahulu
		D	Sosialisasi ke semua pasien lewat media sosial untuk kontrol mundur tidak bisa di layani
		S	Beberapa pasien komplain terkait tidak bisa di layani dengan tidak sesuai jadwal kontrol
		A	Berkoordinasi dengan asisten dan pendafran tentang sosialisasi ini
2	Penyesuaian E-casemix,ada beberapa anamnesa dan diagnosa yang kurang sesuai	P	Rapat antara unit irja dan asuransi center
		D	Koordinasi antara verifikasi dan karu untuk di lengkapi ulang
		S	Masih ada beberapa yang tidak lengkap di poli
		A	Feriv selalu mengingatkan ke bagian asisten perawat poli jika belum lengkap langsung bisa di lengkapi
3	Rujuk Internal	P	Sosialisasikan rujuk internal dalam 1 hari dan beda hari sesuai ke advice dpjp
		D	Koordinasi dengan karu rawat jalan dan asuransi center
		S	Menemukan bebrapa kasus di rawat jalan yang ada di rujuk internal dalam 1 hari dan beda hari
		A	Kesepatan dari asuransi dan karu kain dan manajmen untuk rujuk internal sesuai dengan advice dpjp

3.7.5 Permasalahan Instalasi Farmasi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Terdapat selisih stok opname yang fluktuatif. Desember 2024 : +25.820.296 Januari 2025 : +226.818 Februari 2025 : Belum berjalan scan barcode menunggu antrian Programmer PT.	P	Perencanaan scan barcode.
		D	1. Mengajukan proposal scan barcode dan mengajukan kebutuhan alat yang menunjang pelayanan. 2. Melakukan presentasi perencanaan scan barcode beserta tujuan dan manfaatnya.
		S	Scan barcode dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan akurasi data, pengendalian stok yang lebih baik, kepatuhan terhadap regulasi, pengurangan biaya operasional, tindak lanjut yang lebih efisien, integrasi sistem yang lebih baik, peningkatan pelayanan pasien.
		A	Pengajuan software aplikasi barcode ke progamer dan pengajuan alat scanner barcode, barcode printer, thermal paper ke Pengadaan Umum PT. DPM.
2.	Pelaksanaan Stok Opname	P	Perubahan alur distribusi ODD di Bulan Februari.
		D	Membuat alur pelayanan obat berjalan saat stok opname.
		S	1. Petugas input konfirmasi ke petugas hitung yang terkadang tetap menulis di kertas/ data pengeluaran barang sehingga menimbulkan selisih saat perhitungan SO. 2. Perubahan alur distribusi ODD di bulan februari sehingga mempengaruhi stok saat stok opname.
		A	Shift sore :

			1. Resep ODD tidak dilakukan simpan penjualan farmasi. 2. Apabila terdapat resep tambahan (setelah visite)/ resep IGD dapat dilakukan sewaktu-waktu dan obat langsung diambil ke Depo Farmasi oleh perawat/ bidan. 3. Peresepan OB yang langsung diberikan ke pasien langsung diambil ke Depo Farmasi, kecuali resep ODD dipisah. 4. Lakukan pendataan nama pasien sesuai board pasien per ruangan untuk serah terima obat pasien kemudian di cetak. Shift malam : 1. Lakukan simpan penjualan farmasi, cetak resep obat dan etiket ODD setelah verifikasi SO selesai. 2. Tulis nama ruangan dan nomor urut pasien sesuai kertas serah terima obat pasien 2 ply di pojok kanan resep. 3. Lakukan penyiapan infus dan BMHP sesuai resep sekaligus dimasukkan kedalam keranjang beserta resep obat. Shift pagi : 1. Lakukan penyiapan obat sesuai resep. 2. Lakukan pengecekan kesesuaian DPO dan resep ODD serta penulisan jam obat pada etiket. 3. Lakukan penyiapan plastik klip etiket obat ODD. 4. Masukkan obat kedalam plastik klip sesuai etiket yang akan di distribusikan ke rawat inap. 5. Lakukan pemisahan resep dan obat yang perlu di rekonstitusi (oplos) oleh Apoteker. 6. Lakukan distribusi ke ruangan pukul 11.00 WIB (Obat oral pukul 12.00) dan pukul 14.00 (Obat ODD, infus, dan BMHP).
3.	Penulisan Kartu Pengambilan Obat (KPO) yang masih manual dan membuat waktu obat jadi lama. Prosentase waktu tunggu obat non racikan 61.98% dan waktu tunggu obat racikan 44.17%	P D S A	P Menggunakan KPO digital dalam pelayanan resep. D Koordinasi dengan Programmer untuk membuat fitur KPO digital di SIMRS yang bisa diakses oleh DPJP dan Apoteker. S Penulisan KPO masih manual sehingga memakan waktu dan penulisan yang tidak baku dan tidak terbaca. Komplain pasien akibat pasien tidak membawa KPO. A 1) Follow up ke Programmer. 2) Mendata KPO tertinggal sebagai bukti kuat bahwa KPO manual resiko hilang. KPO tertinggal ada 408 KPO.
4.	Alur baru paket kuret ODC di Rawat Jalan	P D S	P Menyusun alur peresepan paket kuret ODC Rawat Jalan. D Melakukan koordinasi dengan Yanmed dan Verifikator. S Tambahan alur paket kuret ODC rawat jalan yang berbeda dengan pasien rawat inap.

		A	Alur peresepan paket kuret ODC RJ disepakati diinput oleh perawat poli/ bidan IGD. Alurnya: 1. Apabila pasien berkunjung ke poli - advice tindakan kuret - resep paket kuret diinput poli - paket di ambil oleh maternitas. 2. Apabila pasien dijadwalkan kuret - px ke igd - resep paket kuret diinput igd - paket diambil bidan ponek igd. 3. Farmasi mengambil paket kuret dan menyiapkan tambahan sesuai list. 4. Retur penjualan dilakukan oleh FARMASI maka sesuaikan dengan barang yg diretur oleh bidan.
5.	Obat tertinggal 2x24 jam	P	Perbaikan kebijakan obat tertinggal.
		D	Membuat rekapan pasien yang sudah mendapat pengantaran gratis.
		S	1. Obat tertinggal bulan february sudah mengalami penurunan namun masih ditemukan pasien mengambil obat lebih 2x24 jam. 2. Program pengiriman gratis belum ada rekapan pasien oleh farmasi jadi farmasi tidak mengetahui apakah pasien tersebut tiap bulan tidak mengambil obat dan obat apakah sudah dapat pengiriman di bulan sebelumnya. 3. Primantara sudah menghubungi pasien agar obat tertinggal dikirim oleh primantara namun banyak pasien menolak karna obat diambil sendiri ke farmasi.
		A	1. Pasien yang obatnya tertinggal dimintai data agar mudah di identifikasi. 2. Jika pasien mendapatkan pengiriman gratis tapi terkadang tidak teridentifikasi primantara maka akan dimintai datanya agar mudah diketahui. Primantara membuat rekapan sendiri data obat tertinggal dan di beri keterangan apakah bulan sebelumnya sudah dilakukan pengiriman gratis. 3. Pengantaran gratis membantu farmasi agar tidak terjadi penumpukan obat tertinggal, terkadang pasien memang ada yang tidak mau tapi tetap di edukasi untuk obat diantar.
6.	Penambahan daftar obat near ED	P	Mempercepat pengeluaran barang near ED.
		D	Membuat surat edaran untuk DPJP supaya membantu mengeluarkan barang near ED dari Depo Farmasi maupun Gudang Farmasi.
		S	Obat near ED yang tidak segera dikeluarkan akan mejadi deathmoving dan menyebabkan kerugian terhadap rumah sakit.
		A	1) Kolaborasi dengan Komite Medik untuk membantu pengeluaran barang near ED. 2) Melakukan negoisasi dengan DPJP untuk menggunakan barang near ED sesuai dengan kebutuhan.

			3) Kolaborasi dengan Pengadaan PT untuk melakukan retur obat near ED kepada distributor.
7.	Tempat penyimpanan vaksin tidak sesuai dengan standar, ditemukan indicator vaksin pemerintah yang berubah warna sehingga tidak layak digunakan.	P	Mengadakan VR di Depo Farmasi sesuai dengan standar penyimpanan vaksin.
		D	1. Memperbaiki VR yang ada supaya bisa digunakan kembali. 2. Mengedukasi perawat dan petugas farmasi terkait penyimpanan yang benar.
		S	Vaksin yang tidak layak diberikan kepada pasien bisa dikembalikan ke Puskesmas Wilayah, tetapi RS harus memikirkan bagaimana vaksin tidak sampai diretur.
		A	1. Vaksin pemerintah disimpan di VR Gudang Farmasi. 2. Perubahan alur pengambilan vaksin oleh perawat poli.
8.	Fitur retur barang rusak tidak bisa mengeluarkan stok di monitoring stok.	P	Perbaikan fitur retur barang rusak.
		D	Koordinasi dengan Programmer PT.
		S	1. Barang expired date perlu dikeluarkan stoknya dari SIMRS menggunakan fitur retur barang rusak kemudian dilalukan pemusnahan obat namun fitur tersebut tidak dapat mengeluarkan stok dari sistem. 2. Sudah dilakukan receive retur namun stok masih muncul di monitoring stok, tapi di pengeluaran barang dan mutasi barang sudah 0.
		A	Follow up.
9.	Floorstok IKO	P	Mendisiplinkan perawat untuk menjalankan SPO.
		D	Koordinasi dengan Kabid Keperawatan.
		S	Kendala di FS IKO dimana perawat anestesi belum menjalankan inputan resep terlebih dahulu kemudian disiapkan oleh farmasi dikarenakan tidak menyanggupi jika operasi berlangsung berturut-turut. Dan informasi SPO sudah diedarkan dan dijelaskan namun perawat belum menjalankan sesuai SPO.
		A	Monitoring dan evaluasi.
10.	Pasien yang mendapatkan pelayanan obat kronis dengan diagnosa PRB.	P	Perbaikan alur pelayanan obat kronis dengan diagnosa PRB.
		D	Pengajuan fitur surat pengantar PRB dari poli ke IFRS di SIMRS sehingga tidak ada lagi kelolosan pasien tidak di PRB di V-Claim
		S	1. Pasien dengan pelayanan obat kronis yang sama selama 3 bulan berturut-turut otomatis masuk ke dalam Program Rujuk Balik (PRB). 2. Pasien dapat berkunjung ke FKRTL dalam kondisi kegawatdaruratan dan/atau untuk kasus sesuai indikasi medis dan ketentuan yang berlaku. Masih banyak pasien yang dirujuk internal dan di lakukan PRB namun DPJP utama tidak dilakukan PRB. 3. Jika pasien PRB dan obat ditinggal maka farmasi kesulitan konfirmasi ke pasien apakah ada surkon ke dokter lain.
		A	1. Pasien PRB : 3) Jika prb rujukan utama namun masih ada surkon (surat kontrol) internal maka surkon internal di tarik, pasien diarahkan

			untuk mengambil obat ke FKTP dan kontrol lebih lanjut disana, nanti FKTP yang memutuskan apakah lanjut kontrol ke rs atau tidak. 4) Jika prb rujukan internal namun rujukan utama belum prb maka koordinasi dengan karu poli unutm dikoordinasikan dengan DPJP agar rujukan utama dijadwalkan PRB. 2. Primantara wajib menanyakan dulu ke pasien apakah pasien ada surkon ke dokter lain. Jika pasien ambil obat yang ditinggal maka farmasi konfirmasi terlebih dahulu saat ambil obat.
--	--	--	---

3.7.6 Permasalahan Laboratorium

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	LIS belum berjalan karena menunggu bridging SIMRS	P	Membuat target pelaksanaan LIS di Labortaorium RSPH Malang.
		D	Mengingatkan programmer untuk segera menyelesaikan bridging.
		S	LIS belum bisa diaplikasikam dikarenakan belum bridging dengan SIMRS.
		A	Follow up berkala ke Programmer.
2.	Petugas belum kompeten dalam pelaksanaan crossmatch labu darah	P	Mendaftarkan pelatihan/magang secara bergilir.
		D	1) Melakukan pendampingan terhadap petugas yang melakukan crossmatch. 2) Melakukan pelatihan dengan vendor.
		S	Hasil crossmatch menentukan apakah labu darah bisa diberika kepada pasien atau tidak, jika hasil aglutinasi positif maka tidak bisa diberikan.
		A	1) Melakukan pencatatan pengulangan kegiatan crossmatch. 2) Permintaan labu darah cito ketika malam hari sementara permintaan ke PMI Lawang terlebih dulu. 3) Petugas magang secara bergilir setiap 2 minggu sekali.
3.	Tidak ada fitur nilai normal pada Billing SIMRS sehingga petugas melakukan klik manual.	P	Mengajukan fitur pengisian nilai normal kepada Programmer PT.
		D	Membuat surat pengajuan fitur batas atas dan batas bawah nilai normal untuk dilakukan pengisian oleh petugas laboratorium.
		S	Dengan adanya batas atas dan batas bawah yang ditentukan, system akan membaca hasil laboratorium setiap pasien apakah berada pada nilai normal atau tidak.
		A	Follow up ke Programmer PT.
4.	Reagen kadaluarsa dan datang terlambat.	P	Memperbaiki pengadaan reagen di Laboratorium.
		D	Melakukan analisa keterlambatan. Koordinasi dengan Kabid Pelayanan..
		S	Terdapat reagen yang kosong nasional seperti CKMB, DPJP memutuskan untuk menggunakan pemeriksaan Troponin.
		A	1. Melakukan perbaikan penataan FIFO

			FEFO pada kulkas Laboratorium. 2. Menjalankan kartu stok dan perencanaan SO. 3. Menentukan stok minimal untuk order reagen.
5.	Pengadaan rectal swab di Lab RS Prima Husada Malang	P	Mengajukan TOR pelayanan rectal swab.
		D	Diskusi dengan Kains Laboratorium RS, dr Ari Putri, Sp.PA
		S	Utilitas jarang tidak direkomendasikan, kecuali jika bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk MCU.
		A	Proses perhitungan unit cost, jika sudah maka akan diajukan TOR.

3.7.7 Permasalahan Rekam Medis

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Layanan Poli yang belum masuk kedalam E-RM -Poli KIA -Poli Gizi	P	Melakukan permintaan fitur kepada Programmer PT.
		D	Membuat flow chart alur pelayanan pada Poli KIA dan Poli Gizi untuk diterapkan pada E-RM.
		S	Kekurangan jika kunjungan Poli KIA dan Poli Gizi dilakukan pencatatan secara manual maka hasil konseling tidak terekap dengan baik dan tidak bisa diakses oleh DPJP, sehingga tidak bisa dilakukan tindakan lanjutan yang terintegrasi. Pencatatan manual resiko hilangnya sangat tinggi.
		A	Follow up ke Programmer PT. Hasil konseling disampaikan kepada asisten setiap DPJP.
2.	Kebijakan baru dari BPJS Kesehatan tentang Kunjungan Kontrol Poli Rawat Jalan	P	Menjalankan kebijakan baru dengan meminimalisir complain.
		D	Melakukan pemberitahuan melalui social media sebelum kebijakan dijalankan. Kolaborasi dengan Programmer PT untuk menambahkan fitur surat control fisioterapi.
		S	Perawat fisioterapi masih belum bisa menginput surat kontrol pasien bpjs yg berasal dari surat rujukan utama, sehingga masih pasien masih diarahkan ke pendaftaran untuk mencetak surat kontrol
		A	1. Menertibkan pasien control sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 2. Follow up ke Programmer PT.
3.	Pendaftaran masih mendaftarkan pasien pada waktu jam praktik dokter sudah selesai.	P	Membuat kebijakan terkait pendaftaran pasien.
		D	Mendisplinkan petugas menjalankan SPO.
		S	Dokter spesialis Gigi Anak drg. Ajeng, Sp.KGA komplain karena ada 1 pasien yang didaftar oleh pendaftaran pada waktu jam prakteknya sudah selesai.
		A	1. Menutup pendaftaran poli spesialis di H-10menit sebelum jam praktik selesai. 2. Konfirmasi DPJP jika ada tambahan

			pasien yang mendekati jam praktik selesai.
4.	ERM Rawat Inap belum terlaksana, ERM rawat jalan masih ditemukan kendala.	P	Merealisasikan pelaksanaan ERM rawat Inap dan rawat Jalan pada tahun 2025.
		D	Kolaborasi dengan Programmer PT.
		S	ERM Rawat jalan sudah terlaksana, tetapi masih banyak ketidaklengkapan dalam penginputan ERM.
		A	1. Follow up terus menerus ke programer dengan cara screenshot permasalahan dan dikirimkan via whatsapp guna menindaklanjuti permasalahan tersebut agar proses validasi ERM berjalan lancar. 2. Trial ERM Rawat Inap Bulan Maret 2025.
5.	Pasien BPJS TK dari IGD tidak diberikan pengantar rujukan ke Poli Spesialis.	P	Perbaiki alur rujukan pasien.
		D	Mendisplinkan petugas menjalankan SPO.
		S	Ada 1 pasien dari IGD yg tidak diberikan pengantar rujukan untuk ke poli spesialis bedah plastik dan tidak diarahkan ke pendaftaran untuk informasi jadwal praktek dokter tersebut. Pasien ke pendaftaran pada hari H tidak membawa surat rujukan dan datang pada hari yang tidak ada jadwal dokter tersebut.
		A	Mengingatkan ke KARU IGD terkait alur pasien BPJS TK dan selalu mengarahkan pasien ke pendaftaran untuk informasi jadwal dokter apabila pasien ada kontrol Lanjutan.
6.	Ketidak lengkapan pengisian form rekam medis oleh PPA.	P	Perubahan alur analisa rekam medis.
		D	Mendisplinkan petugas menjalankan SPO.
		S	Ketidaklengkapan pengisian dokumen rekam medis oleh semua PPA.
		A	Sosialisasi ke semua PPA tentang ketepatan dan kelengkapan pengisian dokumen rekam medis sehingga tidak ada lagi DRM yang tidak lengkap.

3.7.8 Permasalahan CSSD

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Kebutuhan mesin steam plasma belum terpenuhi.	P	Mengajukan kebutuhan mesin ke PT.
		D	Koordinasi dengan Vendor dan DPJP terkait kebutuhan mesin steam plasma.
		S	Instrument bedah saraf memerlukan perlakuan khusus terkait cara dekontaminasi dan sterilisasinya.
		A	1) Membuat telaah terkait mesin yang saat ini digunakan dan yang dianjurkan. 2) Koordinasi dengan DPJP (dr Fachri, Sp.BS) bahwa sterilisasi alat bedah saraf menggunakan autoclave dengan cara alat dikemas satu persatu.

3.7.9 Permasalahan Laundry

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Hasil pencucian membuat kain terkena bercak putih.	P	Memperbaiki alur pencucian.
		D	Menerapkan alur baru.
		S	Monitoring dan evaluasi alur baru, mencari penyebab kerusakan.
		A	1. Melakukan pemilahan baju dan linen dari unit menggunakan handscoon baru (tidak terkena zak kimia). 2. Melakukan pemisahan pencucian antara linen dan baju IKO.
2.	Pencatatan jumlah linen tidak valid.	P	Memperbaiki pencacatan menggunakan digital.
		D	Pencatatan jumlah linen menggunakan google spreadsheet.
		S	Pencatatan manual beresiko angka tidak terbaca dengan baik sehingga jumlah linen tidak valid.
		A	Pencatatan digital akan dimulai pada awal Bulan Januari 2025, sebelumnya akan dilakukan SO. Rencana dilakukan stok opname setiap bulan. Pencatatan real per lantai.

3.7.10 Permasalahan Radiologi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Respon Time Pelayanan Radiologi	P	Memperbaiki respon time pelayanan radiologi.
		D	Kolaborasi antara perawat dan radiographer dengan DS Radiologi.
		S	Pencatatan dapat diketahui respon time pelayanan radiologi dari selesai periksa sampai dengan selesai hasil.
		A	Melakukan pencatatan waktu permintaan dan selesai hasil di Google Spreadsheet.
2.	Menerima permintaan pemeriksaan pasien IGD tanpa ada inputan di SIMRS.	P	Perbaikan alur pelayanan pemeriksaan radiologi dari unit.
		D	Mendisiplinkan petugas menjalankan sesuai SPO.
		S	Petugas IGD sering kali meminta pemeriksaan sebelum dilakukan input untuk menegaskan diagnosis. Perawat juga menghapus inputan tanpa konfirmasi petugas radiologi setelah selesai pemeriksaan dan hasil sudah dicetak.
		A	Pemeriksaan dilakukan jika sudah ada inputan di SIMRS. Pemeriksaan yang dihapus tanpa konfirmasi maka menjadi beban petugas yang menghapus.

3.7.11 Permasalahan Instalasi Gizi dan Dapur

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Pendistribusian alat makan tidak tercatat dengan baik	P	Memperbaiki alur pengecekan fasilitas RS sebelum pasien KRS.
		D	Kolaborasi Ahli Gizi dengan Pendaftaran IGD, Perawat, CS Pantry, CS Ruang dan Kasir.
		S	Fasilitas RS resiko hilang karena pasien jika tidak dibuatkan alur yang jelas. Petugas wajib memberikan edukasi untuk meminimalisir

			kehilangan/kerusakan.
		A	Membuat SPO "Pengecekan Fasilitas RS Sebelum Pasien KRS". Sosialisasi kepada Unit Terkait

3.8 Profil SDM
3.8.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Satuan Pengawas Internal	SMK	1	1	1	0	0
7	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
8	Dokter Casemix	Dokter Umum	1	1	0	1	0
9	Farmasi	Profesi Apoteker	41	13	6	7	0
		S1 Farmasi		3	2	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		20	12	8	0
		SMK		4	3	1	0
		S1 Akuntansi		0	0	0	0
10	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
11	CSSD	D3 Keperawatan	5	3	2	1	0
		SMA		1	1	1	0
		SMK		1	0	1	0
12	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
13	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	2	0	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		7	0	7	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0
14	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
15	ICU dan HCU	Profesi Ners	12	6	6	0	0
		D3		6	5	1	0

		Keperawatan					
16	IGD	Profesi Ners	25	11	8	3	0
		D3 Keperawatan		9	7	2	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
17	IKO	Profesi Ners	12	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
18	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
19	IPSR	S1 Teknik Elektro	6	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0
20	IRJA	Profesi Ners	27	8	7	1	0
		D3 Keperawatan		14	13	1	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
21	IRNA 2C	Profesi Ners	8	6	5	1	0
		D3 Keperawatan		2	2	0	0
22	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	18	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		13	7	6	0
23	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	15	6	4	0	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
24	IRNA 5C	Profesi Ners	9	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		6	4	2	0
25	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	25	12	6	6	0
		D3 Keperawatan		13	8	3	0
26	Maternitas	Profesi Kebidanan	12	2	0	2	0
		D4 Kebidanan		2	1	1	0
		D3 Kebidanan		8	8	0	0
27	Neonatologi	Profesi Ners	8	2	2	0	0
		D3 Keperawatan		5	4	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
28	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	10	2	2	0	0
		S1 Akuntansi		2	0	2	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
29	Laboratorium	D4 Analisis Kesehatan	10	2	1	1	0
		D3 Analisis Kesehatan		8	7	1	0
30	Laundry	SMK	5	1	0	1	0
		SMA		3	0	3	0
		SMP		1	0	1	0

31	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	10	10	10	0	0
32	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	18	1	1	0	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D4 Destinasi Wisata		1	0	1	0
		D3 Asuransi Kesehatan		2	0	2	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		6	4	2	0
		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		4	4	0	0
33	PIPP & MPP	Profesi Ners	5	2	1	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
34	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
35	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	5	2	0
36	SDM	S1 Psikologi	2	1	0	1	0
		S1 Ilmu Sosial		1	1	0	0
37	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
38	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
39	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
40	Cleaning Service	SMK	46	17	8	9	0
		SMA		24	20	4	0
		SMP		5	5	0	0
41	Security	SMK	12	5	2	3	0
		SMA		7	6	1	0
42	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	5	1	1	0	0
		SMA		3	2	1	0
		SMP		1	1	0	0
43	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
44	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
45	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
46	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
47	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
51	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0

52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
54	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total			461				

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

RS Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarannya. Dimana masih terdapat beberapa Sumber Daya manusia yang masih belum tertib baik dari kelompok tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang masih belum tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dengan penataan SDM yang disesuaikan dengan alur dan tata letak Gedung yang baru, maka dilakukan juga penambahan tenaga khususnya perawat untuk memenuhi kebutuhan setelah dilakukan evaluasi dan Analisa beban kerja. Proporsi antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap, dimana masih banyak karyawan kontrak/tidak tetap di RS Prima Husada Malang diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah sakit

Kepatuhan DPJP dalam memvisite pasien dan melengkapi dokumen Rekam medis yang masih jauh dari standar juga mempengaruhi kualitas pelayanan di RS Prima Husada Malang dan menghambat proses klaim. Kinerja RS dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Rumah Sakit. Jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang masih didominasi oleh kunjungan pasien lama dari BPJS Kesehatan. Pelayanan di beberapa unit yang belum optimal dikerenakan salah satu dampak kekurangan tenaga kerja membawa akibat pada pelayanan.

B. SARAN

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Unit SDM terutama ketertiban absensi dengan memanfaatkan SIM SDM yang baru
2. Membentuk dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite yang ada di RS Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta mentertribkan DPJP dalm pengisian Dokumen Rekam Medis
4. Memperbaiki proses rekrutmen staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
6. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Malang
7. Menjalin lebih banyak kerjasama dengan stakeholder dari luar RS Prima Husada Malang

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan bulan Februari 2025 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang pada bulan Januari 2025, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Malang, 10 Maret 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN

NO	NAMA PKS	JENIS INSTANSI	MULAI BERLAKU	TANGGAL EXPIRED	KETERANGAN	NOMOR PKS RUMAH SAKIT	NOMOR PKS INSTANSI
1	ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/I/2015
2	Batas Media 99	PERUSAHAAN	05 Juni 2024	05 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	158/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
3	BPJS KESEHATAN	ASURANSI	01 Januari 2025	31 Desember 2025	Pelayanan Kesehatan	2035/E-PKS/DIR/XII/2024	651/KTR/VII-05/1224
4	CV AUMERTA ANGGUN	PERUSAHAAN	28 Agustus 2023	28 Agustus 2026	PELAYANAN KESEHATAN	164.1/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	-
5	ESWEJE Aesthetic Center	INSTANSI KESEHATAN	01 Maret 2024	01 Maret 2027	Sterilisasi alat kesehatan	079/DPM/E-PKS/DIR/III/2024	9,1202E+12
6	Pelayanan Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	1754/E-PKS/DIR/XII/2022	-
7	Indonesia Smelting Technology	PERUSAHAAN	01 Juni 2024	01 Juni 2026	Rujukan Pelayanan	194/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	005/HRGA-IST/V/2024
8	Instruktur Zumba	AKRE	23 Februari 2024	23 Februari 2025	Instruktur Zumba	067/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	-
9	Klinik Mutiara Sehat (Karanglo, Lawang, Karangploso)	INSTANSI KESEHATAN	02 Agustus 2021	02 Agustus 2026	Pelayanan Laboratorium	429.77/I-PKS/DIR/VIII/2021	069/PKS/PDP/VIII/2021
10	Klinik Endisa Husada	INSTANSI KESEHATAN	01 Agustus 2023	01 Agustus 2026	Rujukan Pelayanan	148.3/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023	PK/01/VII/2023-KEH
11	Klinik Losari Medika	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2027	Rujukan Pelayanan	-	021/DPM/E-PKS/DIR/II/2024
12	Klinik Pratama Beauty Medika Singosari	INSTANSI KESEHATAN	25 Mei 2024	25 Mei 2027	Rujukan Pelayanan	145/DPM.E-PKS/DIR/V/2024	001/PKS/12/2024
13	Klinik Rawat Jalan Mitra Prima Care	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2027	Pelayanan Kesehatan	346/DPM/E-PKS/DIR/XII/2024	025/MPC/E-PKS/KA/XII/2024
14	Klinik Utama Medika	INSTANSI	24	24 September	Rujukan Pasien	299/DPM/E-	-

		KESEHATAN	September 2024	2027		PKS/DIR/IX/2024	
14	Klinik Utama Rawat Jalan Akasia	INSTANSI KESEHATAN	25 April 2024	25 April 2027	Pelayanan Kesehatan	116/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	011/KUA/E-PKS/HMS/III/2024
15	Penerjemah Bahasa Isyarat untuk Difabel	AKRE	14 September 2022	13 September 2025	Penerjemah Bahasa Isyarat Untuk Difabel	1378/E- PKS/DIR/X/2022	-
16	Penerjemah Bahasa Madura	AKRE	01 Agustus 2022	02 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Madura	1305/E- PKS/DIR/IX/2022	-
17	Penerjemah Bahasa Asing	AKRE	01 Agustus 2022	01 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Inggris	1288/E- PKS/DIR/IX/2022	-
18	Persada Hospital	INSTANSI KESEHATAN	10 Oktober 2022	10 Oktober 2027	Pelayanan Kesehatan	152.45//DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	1083.b.HS/MOU/X/PH-2022
19	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	19 Agustus 2024	19 Agustus 2026	Penyediaan Darah	246/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0904/02.06.28/UTD/VIII/2024
20	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Juni 2023	30 Juni 2023	Rujukan Pelayanan	-	768/E-PKS/DIR/V/2023
21	PMI Kota Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	01 Desember 2025	Penyediaan Darah	1790/E- PKS/DIR/XI/2023	2214/02.06.27/UTD/XI/2023
22	PRAKTEK BIDAN MANDIRI NIA IRAWATI, S.TR.KEB	INSTANSI KESEHATAN	07 Februari 2024	26 Februari 2027	Rujukan dan Pelayanan Penunjang	081/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	-
23	PT AA International Indonesia	ASURANSI	02 September 2019	02 September 2020	Pelayanan Kesehatan Grab	-	-
24	PT Administrasi Medika	ASURANSI	01 Juli 2024	01 Juli 2027	Asuransi		071/PKS/AdM/ManagedCare/VII2024
25	PT AIA Financial	ASURANSI	04 November 2020	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	No.069/DPM/E- PKS/DIR/X/2020	No. 639/AIA/-DPM/XI/2020
26	PT AJ Central Asia Raya	ASURANSI	02 Juni 2017	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	277/RSPH/E- IKS/DIR/VI/2017	DIR/PKS-RS/1455/VI/2017
27	PT AJINOMOTO SALES INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Mei 2012	30 APRIL 2013 (selanjutnya)	PELAYANAN KESEHATAN		

				perpanjang otomatis)			
28	PT Alfiza Medika Utama	INSTANSI KESEHATAN	07 Maret 2024	07 Maret 2028	Pelayanan Kesehatan	090/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	018/MOU/KAMU/07/III/2024
29	PT Aloita Prima (Harris Hotel Malang)	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	-
30	PT ANTARMITRA SEMBADA CAB. MALANG	PERUSAHAAN	01 Desember 2024	01 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	304.1.DPM/E- PKS/DIR/X/2024	344/MLG/AMS/XII/2024
31	PT APLIKANUSA LINTASARTA	ASURANSI	25 Februari 2015	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/100/II/2015	095/LA/MOU/00300/2015
32	PT ASABRI	ASURANSI	13 Desember 2023	12 Desember 2026	PELAYANAN KESEHATAN	1902/E- PKS/DIR/XII/2023	PEFJ-182/HK.02.01/HBL.H/XII/2023
33	PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA	ASURANSI	12 Oktober 2023	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/E- PKS/171/X/2013	499B/AAD-LEG-AGR/X/2013
34	PT Asuransi Allianz Life Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2017	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	729/AZLI-LGL/AG/XII/2017
35	PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA	ASURANSI	18 November 2024	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	698.21/DPM/I- PKS/DIR/IX/2024	391/ALLISYA-LGL/AG/XI/2024
36	PT ASURANSI ASTRA BUANA	ASURANSI	01 September 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN KESEHATAN	1033/RSPHS/E- PKS/DIR/VIII/2020	26/HID-PM/ASURANSIASTRA/IX/2020
37	PT ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/I/2015
38	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia	ASURANSI	01 Oktober 2023	01 Oktober 2028	Asuransi	183.3/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	157/GI/OPS/Prov-PKS/X/2023
39	PT Asuransi Jiwa In Health Indonesia (Mandiri Inhealth)	ASURANSI	01 Februari 2023	31 Januari 2025	Asuransi	028.2/DPM/E- PKS/DIRR/11/2023	0.32/AJII.KOP-SBY/PKS/0123
40	PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA	ASURANSI	01 Desember 2024	01 Desember 2025	PELAYANAN KESEHATAN	361/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	331-11/EB-CONT/2024

41	PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK (ASURANSI MAG)	ASURANSI	28 Januari 2020	27 Januari 2024	RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN	015/DPM/E- PKS/DIR/XI/2019	PKS-0097/XI/2019/MAG-R2
42	PT Asuransi Reliance Indonesia	ASURANSI	06 November 2024	06 November 2027	Asuransi	338/DPM/E- PKS/DIR/XI/2024	024/LGL-ARI/PKS-RS-IB/XI/2024
43	PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA	ASURANSI	07 September 2020	07 September 2025	PELAYANAN KESEHATAN	368/DPM/I- PKS/DIR/VIII/2020	163/LGL-ARI/PKS/RS-COB/IX/2020
44	PT ASURANSI SINARMAS	ASURANSI	01 September 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	010/DPM/E- PKS/DIR/IX/2019	364/PKS-RS/PH.RI.ASM/IX/2019
45	PT ASURANSI SINARMAS MSIG	ASURANSI	10 September 2012	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		063/PKS-AJSMSIG-RS/IX/2012
46	PT ASURANSI TAFAKUL KELUARGA	ASURANSI	02 Januari 2017	01 Januari 2020	PELAYANAN KESEHATAN	508/RSPH/E- IKS/DIR/XI/2016	0642/PKS-RS-01/I/2017
47	PT ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA	ASURANSI	30 Oktober 2021	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	612/RSPHS/E- PKS/DIR/X/2019	300/PKS/DIR/TKP/X/2019
48	PT AXA SERVICES INDONESIA (ADMEDIKA)	ASURANSI	15 Agustus 2013	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		067/AGR-LEG/ASI/VIII/2013
49	PT Bestari Murni Anugrah	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	rujukan pelayanan	159/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
50	PT BNI LIFE INSURANCE	ASURANSI	25 Juli 2016	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	082/RSPH/E- IKS/DIR/II/2016	274.PKS.BL.DIR.0716
51	PT CAKRA SURYA HUSADA	PERUSAHAAN	02 Agustus 2022	02 Agustus 2025	ASUHAN PASIEN & PELAYANAN PENUNJANG	112.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2022	138/MOU/VIII/CSH/2022
52	PT Citra Karsa Dinamika	PERUSAHAAN	01 Juli 2024	01 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	196/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
53	PT Docdoc Healthcare Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2024	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	-
54	PT Equity Life Indonesia	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	091/ELI/LGL/X/19

55	PT EQUITY LIFE INDONESIA	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		090/ELI/LGL/X/19
56	PT Fullerton Health Indonesia	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis		-	640/IP-OP/PKS/FHI/VIII/2019
57	PT Global Assistance & Healthcare	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	640/IP-OP/PKS/GAH/VIII/2019
58	PT Green Mountains Natural Food	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	225/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	01/GMN/KS/VI/2024
59	PT HANWA LIFE INSURANCE INDONESIA	ASURANSI	16 Maret 2015	15 Maret 2016	PELAYANAN KESEHATAN		0088/HLI-GH/PKS-RS/03-2015
60	PT Indo Aneka Atsiri	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	06 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	222/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	066/IAA/HRGA/VI/2024
61	PT INDOLAKTO PANDAAN	PERUSAHAAN	10 Januari 2014	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		
62	PT Indonesia Marine	PERUSAHAAN	10 September 2024	10 September 2027	Pelayanan Kesehatan	-	-
63	PT INTERNATIONAL SERVICES PASIFIC CROSS	VENDOR	03 Oktober 2022	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	150/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	953/ISPC/PKS/X/2022
64	PT JASA RAHARJA	ASURANSI	04 Juli 2022	04 Juli 2027	PENAGANAN DAN PENYELESAIAN SATUAN KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DAN LALU LINTAS JALAN	912.1/E-PKS/DIR/VII/2022	P/13/SP/2022
65	PT Java Smartindo	PERUSAHAAN	01 Agustus 2020	Perpanjangan Otomatis	Jasa Pengelolaan Administrasi Kesehatan	364/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	PKS.TPA-JSMART.290/VIII/20/RS.SW.C
66	PT JAYA OBAYASI	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	360/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	
67	PT Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	ASURANSI	17 Juli 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	034/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	092/KBM-DPM/PKS/VII/2020
68	PT LABBIOGEN ARTHA MEGA	INSTANSI KESEHATAN	02 September 2024	01 September 2027		262/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024	B-MKT 01/001/623/VII/2024

69	PT MALANG INTERMEDIA PERS	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	025/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	103.1/PKS/DIR/JPRM/VIII/2020
70	PT Medilink Digital Media	ASURANSI	22 Maret 2024	22 Maret 2027	Pelayanan Kesehatan	09/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	229/L/PKS/MDM-DPM/III/2024
71	PT MEDLINX ASIA TEKNOLOGI	ASURANSI	28 November 2016	Perpanjangan Otomatis	APLIKASI LAYANAN KESEHATAN	150/PKS- RSPRIMAHUSADA- MAT/DIR/XI/2016	
72	PT MOOR SUKSES INTERNASIONAL	ASURANSI	08 Juli 2024	08 Juli 2027	PELAYANAN KESEHATAN	200/DPM/E- PKS/DIR/2024	001/MSI/VI/2024
73	PT PAN PACIFIC INSURANCE	ASURANSI	31 Agustus 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN PERAWATAN DAN PENGOBATAN	017/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	0593-01/PKS/PRV-PANFIC/RS- PHMS/VIII/2020
74	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	12 Juni 2024	12 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	172/DPM/E- PKS/DIV/VI/2024	-
75	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	032/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	
76	PT PLN (Persero)	ASURANSI	02 Juli 2024	31 Desember 2025		261/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0017.Add/HKM.02.01/F010800300/2022
77	PT Prima Sarana Jasa - Asuransi SOS	ASURANSI	17 September 2018	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	735/E- PKS/DIR/IX/2018	296/GAN/PT-6/HOSP/SEP/2018
78	PT Prudential Life Assurance	ASURANSI	28 Januari 2021	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	047/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2020	1578/PMN-PLA/XI/2020
79	PT Suprima Mitra Adihusada	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	640/IP-OP/PKS/TIRTA/VIII/2019
80	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	11 Juni 2024	10 Juni 2026	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	110/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	JAN-09/C.5.1/2024
81	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	01 Januari 2023	31 Desember 2025	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	008/E- PKS/DIR/I/2023	JAN-01/DIR/2023
82	PT TIRTA INVESTAMA	PERUSAHAAN	31 Agustus 2020	31 Agustus 2025	PELAYANAN KESEHATAN		
83	PT Tonggak Ampuh	PERUSAHAAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	263/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	-
84	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Agustus	31 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	150.2/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	050/AK/2/VII/TBINA-Kenaf/2023

			2023				
85	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA PASURUAN PLANT	PERUSAHAAN	27 Oktober 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	1076/RSPHS/E-PKS/DIR/IX/2020	002/AK/10/V/TBINA-Kenaf/2020
86	PT Unggul Anugrah Sejahtera	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	Rujukan Pelayanan	160/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
87	PT Uniplastindo Interbuana	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2027	Pelayanan Kesehatan	224/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	-
88	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	04 Januari 2021	04 Januari 2024	PELAYANAN KESEHATAN	303/DPM/I-PKS/DIR/VI/2021	002/PKS-COB/I/2021
89	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	22 Maret 2024	22 Maret 2027	PELAYANAN KESEHATAN	183/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	014/PKS-COB/III/2024
90	PT YAMAHA MUSICAL PRODUCTS INDONESIA (YMPI)	PERUSAHAAN	01 Juni 2022	01 Juni 2025	PELAYANAN KESEHATAN	004/DPM/E-PKS/VI/2022	/YMPI/HI/PKS/VI/2022
91	PT Yanmar Diesel Indonesia	PERUSAHAAN	15 April 2024	15 April 2027	Pelayanan Kesehatan	108/DPM/E-PKS/DIR/IV/2024	107/YADIN/Pdn/Pga/IV/2024
92	PT Zurich Asuransi Indonesia TBK	ASURANSI	25 Juni 2024	24 Juni 2029	Asuransi	151/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	268/ZAI-LEG-AGR/VI/2024
93	RS Islam UNISMA Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Januari 2024	31 Desember 2026	Rujukan Pelayanan	222.11/DPM/E-PKS/DIR/XI/2023	08/PKS/RSI-4/I/2024
94	RS Lavalette	INSTANSI KESEHATAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027		236/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024	DA01-ADDNM-BB/P-B/24-07-16/138
95	RS Prima Husada Sukorejo	INSTANSI KESEHATAN	01 Oktober 2022	01 Oktober 2025	Pelayanan Kesehatan	1376/E-PKS/DIR/X/2022	1608/RSPJS/E-PKS/DIR/X/2022
96	RS Siti Miriam Lawang	INSTANSI KESEHATAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	264/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	566/HMS/RSSM/VIII/2024
97	RSIA Puri Bunda	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2026	Rujukan Pelayanan	020/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	001/PKS/PB/I/2024
98	RSUD Bangil	INSTANSI	22 Juli	22 Juli 2027	Rujukan Pelayanan	222/DPM/E-	400.7.5.2/1531.1/424.072.01/2024

		KESEHATAN	2024			PKS/DIR/VII/2024	
99	Yayasan Bhakti Luhur	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Pelayanan Rohaniawan Agama Kristen	1753/E- PKS/DIR/XII/2022	-
100	RS PANTI NIRMALA	INSTANSI KESEHATAN	07 Oktober 2022	06 Oktober 2025	PELAYANAN RUJUKAN	152.44/DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	3740/069/RSPN/X/2022
101	PKM SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	12 April 2022	12 April 2027	TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS	593/I- PKS/DIR/IV/2022	440/894/35.07.103.135.2022
102	KLINIK IDAMAMUK	INSTANSI KESEHATAN	16 Juni 2021	PERPANJANG OTOMATIS	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	347/DPM/I- PKS/DIR/VII/2021	/005/VI/2021
103	KLINIK RAWAT INAP MUSLIMAT SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	15 April 2023	15 April 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	107.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	031.A/A.1/M/RSMS/02/IV/2023
104	KLINIK TIRTO HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	18 September 2023	18 September 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	176.3/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	015.004/KTH/IX/2023
105	KLINIK UTAMA JANTUNG HUSNA MEDIKA MALANG	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	32/11/26	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	241.2/DPM/E- PKS/DIR/XII/2023	023/PKS/DIR-HMMMALANG/XII/2023
106	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR NIA ANITA	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	347/DPM/E- PKS/DIR/2024	
107	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR INDRAWAN DWANTORO	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	348/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	
108	RSJ DR RADJIMAN WEDIODONONGRAT LAWANG	INSTANSI KESEHATAN	30 Oktober 2023	30 Oktober 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	220.1/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	HK.03.01/D.XXXVII/12226A/2023
109	RSUD DR SAIFUL ANWAR	INSTANSI KESEHATAN	01 November 2024	01 November 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	234/DPM/E- PKS/VIII/2024	400.14.5/7499.1/102.7/2024
110	KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN MAWAR WASKITHA HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	23 Januari 2024	22 Januari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	001.34/DPM/E- PKS/DIR/I/2024	
111	PRAKTEK BIDAN MANDIRI RIZA KHUTMI, S.S.T	INSTANSI KESEHATAN	05 Agustus 2024	05 Februari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	
112	RSU UNIVERSITAS	INSTANSI	05	22 Agustus	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	248/DPM/E-	081/SK_PKS/RSU-UMM/VIII/2024

	MUHAMMADIYAH MALANG	KESEHATAN	Agustus 2024	2027		PKS/DIR/VIII/2024	
113	IBAZZ AESTHETIC MEDICAL CENTER BY DR UMMAH	INSTANSI KESEHATAN	14 Juni 2024	14 Juni 2027	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	180/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	
114	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MALANG	INSTANSI KESEHATAN	02 Januari 2025	02 Januari 2026	PELAYANAN KELUARGA BERENCANA IUD & IMPLANT	2053/E- PKS/DIR/XII/2024	100-3-7/103/35-07-313/2025